

УНП ООН

Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности

UNODC

Research

НАРКОТИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ

2024 год

© Организация Объединенных Наций, июнь 2024 года. Все права сохранены повсюду в мире.

Разрешается воспроизведение настоящего издания полностью или частично любым способом в образовательных или некоммерческих целях без получения особого разрешения от владельца авторских прав, при условии ссылки на источник. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) будет признательно за предоставление ему экземпляра любого издания, для которого в качестве источника использовалось настоящее издание.

При цитировании рекомендуется ссылка: УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2024 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2024 год).

Использование настоящего издания для перепродажи или извлечения иной коммерческой выгоды без письменного разрешения УНП ООН запрещается. Заявки на получение такого разрешения с указанием цели и назначения воспроизведения этого издания следует направлять в Сектор исследований и анализа тенденций УНП ООН.

ОГОВОРКИ

Информация, содержащаяся в настоящем издании, не обязательно является отражением взглядов или политики УНП ООН или организаций, внесших вклад в его подготовку, и не подразумевает официального одобрения с их стороны.

Отзывы об этом докладе приветствуются, их следует направлять по адресу:

Research and Trend Analysis Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
PO Box 500
1400 Vienna
Austria
Электронная почта: wdr@un.org

Веб-сайт: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

**УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ**
Вена

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ ЗА 2024 год

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2024 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с гордостью представляю очередное издание ведущей публикации УНП ООН — *Всемирный доклад о наркотиках*, который в 2024 году посвящен анализу основных событий в области незаконного изготовления и оборота наркотиков, а также моделей наркопотребления и связанного с этим вреда.

В этом всеобъемлющем докладе наглядно демонстрируются постоянно меняющиеся вызовы, порожденные мировой проблемой наркотиков, и представлена суровая картина страданий, смертей и насилия, связанных с незаконной торговлей наркотиками.

Организованные преступные группы используют нестабильность и пробелы в области верховенства права для расширения масштабов своей деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, нанося при этом ущерб уязвимым экосистемам и увековечивая другие формы организованной преступности, такие как торговля людьми. Производство кокаина, показатели которого приближаются к рекордно высоким отметкам, особенно в Латинской Америке, сочетается с расширением масштабов потребления и рынков наркотиков в Европе, Африке и Азии. Огромный вред людям и общинам причиняет также потребление синтетических наркотиков — метамфетамина, незаконный оборот которого растет в Юго-Западной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке и в Юго-Восточной Европе, и фентанила, случаи передозировки которого имеют место в Северной Америке. Между тем запрет на опиум, введенный фактическими властями Афганистана, серьезно сказывается на средствах к существованию и доходах фермеров, в связи с чем возникает необходимость оказания гуманитарной помощи на устойчивой основе.

В доклад за этот год включены специальные главы, посвященные последствиям запрета на опиум в Афганистане, непропорционально высокому уровню потребления синтетических наркотиков среди женщин, которые сталкиваются с проблемой ограниченного доступа к наркологической помощи, взаимосвязи между незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью в «Золотом треугольнике», а также обзору изменений в регулировании и законодательстве, касающихся каннабиса и психоделических веществ.

Впервые в доклад включена также глава, посвященная связи права на здоровье и наркопотребления, которая, как мы надеемся, послужит отправной точкой для будущих дискуссий о реализации этого права и оценки прогресса. Слишком многие люди, затронутые мировой проблемой наркотиков, лишены права на здоровье, особенно женщины, которые продолжают сталкиваться со стигматизацией и дискриминацией в связи с употреблением наркотиков. Каждый человек имеет право на здоровье, которое является всеобщим по своему характеру, и лица, употребляющие наркотики, должны пользоваться этим правом наравне со всеми членами своих общин. Это означает предоставление комплексной, эффективной, добровольной, доступной для всех без какой-либо дискриминации наркологической помощи, ухода и услуг, обеспечивающих сохранение человеческого достоинства.

Наряду с мерами по охране здоровья, в докладе содержится призыв к более стратегическим мерам в области правосудия, направленным на борьбу с незаконным рынком наркотиков. Согласно последним данным, проблемы с законом из-за правонарушений, связанных с наркотиками, две трети из которых относились к их потреблению или хранению с целью употребления, были у семи миллионов человек. Ответные меры органов правосудия должны предусматривать целенаправленные действия в отношении главных действующих лиц, играющих решающую роль в расширении масштабов наркоторговли, и привлечение к ответственности наркоторговцев, а также оказание наркологической помощи наркопотребителям.

Кроме того, долгосрочные усилия по ликвидации наркоэкономики должны не только обеспечивать социально-экономические возможности и альтернативы, не ограничивающиеся простым замещением запрещенных культур или незаконных доходов, но и должны быть направлены на

устранение коренных структурных причин культивирования запрещенных культур, таких как бедность, низкий уровень развития и отсутствие безопасности. Они также должны быть нацелены на устранение факторов, способствующих вовлечению в наркоторговлю молодых людей, которые подвергаются особому риску употребления синтетических наркотиков.

Я надеюсь, что настоящий доклад, проливающий свет на эти модели и тенденции, послужит важнейшим источником информации и доказательной базой для директивных органов, исследователей и всех заинтересованных сторон при разработке политических мер и мобилизации действий, направленных на решение вопросов, порождаемых мировой проблемой наркотиков, в ходе нашей работы по охране здоровья, обеспечению безопасности и достоинства всех людей.

Гада Вали, Директор-исполнитель
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Выражение признательности

Всемирный доклад о наркотиках за 2024 год был подготовлен Сектором исследований и анализа тенденций Отдела анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) под руководством директора Отдела Жан-Люка Лемайё и руководителя Сектора исследований и анализа тенденций Анджелы Ме. Общую координацию осуществляла руководитель Секции исследования наркотиков Хлоя Карпентье.

Обзор содержания

Хлоя Карпентье

Анджела Ме

Проведение исследований, анализ и подготовка доклада

Хусейн Алнасер

Лиз Барретт

Эрнан Эпштейн

Камран Ниас

Брайс Пардо

Томас Питшман

Элисон Риттер

Иншик Сим

Йирка Тейлор

Даница Тханки

Кевин Вудс

Соня Йи

Обработка данных и составление оценок

Соня Ариас Гарсия (ЮНЭЙДС)

Антонела Губерак

Наталья Иванова

Вирджиния Макдональд (ВОЗ)

Андреа Отерова

Антон Радинов

Умиджон Рахмонбердиев

Али Саадеддин

Кит Сабин (ЮНЭЙДС)

Марьям Салехи Алави

Маркус Швабе

Качественные интервью

Апинун Арамраттана

Пабло Карвачо

Каталина Дроппельманн

Франсуа Патюэль

Мария Прилуцкая

Анна Куарри

Сесилия Росс

Кристина Стинкамп

Майяда Вазайфи

Разработка онлайн-платформы

Джеральд Кандулу

Карты

Хуан Ардила
Кун Бюссинк
Франческа Массанелло
Ирина Цой
Лоренцо Вита
Вивиана Виверос

Дизайн и верстка

Сюзанн Куннен
Кристина Куттниг
Ивана Лазич
Мария Мозер

Редактирование

Джонатан Гиббонс

Поддержка в проведении исследований

Клеменс Бауэр-Миттерলেখнер
Дженнифер Эстигене
Лара Кушлански
Марта Проьетто

Административная поддержка

Андрада-Мария Филип
Юлия Лазар
Лука Жагар

Обзор и комментарии

Во *Всемирном докладе о наркотиках за 2024 год* использованы профессиональные знания коллег из всех отделов УНП ООН и Секретариата МККН, которые внесли ценный вклад в его подготовку.

Сектор исследований и анализа тенденций выражает признательность за неоценимый вклад и консультационную поддержку Научно-консультативному комитету по подготовке *Всемирного доклада о наркотиках*, в состав которого входят:

Джонатан Колкинс
Пол Гриффитс
Мария Хайнс
Викнасингем Б. Касинатер
Шарль Парри
Афарин Рахими-Мовагхар
Петер Рейтер
Элисон Риттер
Франциско Туми

Глава «Незаконное предложение наркотиков в “Золотом треугольнике”: слияние с другими видами преступности и последствия» была подготовлена к публикации благодаря щедрой финансовой поддержке Франции.

Глава «Гендерные и возрастные аспекты потребления синтетических наркотиков» была подготовлена к публикации благодаря щедрой финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки.

Глава «Наркопотребление и право на здоровье: на пути к разработке системы оценки» была подготовлена к публикации благодаря щедрой финансовой поддержке Нидерландов (Королевства), Норвегии, Швеции и Швейцарии.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Употребляемые обозначения и изложение материала во *Всемирном докладе о наркотиках* не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их границ.

Для обозначения стран и районов используются названия, имевшие официальный статус в период сбора соответствующих данных.

В настоящем издании *Всемирного доклада о наркотиках* под бассейном Амазонки понимается общая площадь гидрографического бассейна, биом Амазонки и относящиеся к ее бассейну административные районы, данные о границах которых предоставила Амазонская сеть социально-экологической информации (RAISG).

Поскольку существует некоторая научная и правовая неопределенность относительно различий между «употреблением» наркотических средств, их «неправильным употреблением» и «злоупотреблением» ими, во *Всемирном докладе о наркотиках* используется нейтральный термин «употребление наркотиков». Термин «неправильное употребление» используется лишь для обозначения потребления наркотических препаратов рецептурного отпуска в немедицинских целях.

Все случаи употребления слова «наркотик» и термина «употребление наркотиков» во *Всемирном докладе о наркотиках* относятся к веществам, контролируемым в соответствии с международными конвенциями о контроле над наркотиками, и их употреблению в немедицинских целях.

Термин «изъятия» используется во *Всемирном докладе о наркотиках* для обозначения количества изъятых наркотиков, если не указано иное.

Если не указано иное, то все аналитические материалы, содержащиеся во *Всемирном докладе о наркотиках*, основаны на официальных данных, представленных государствами — членами УНП ООН в ответах на вопросник к ежегодному докладу. Везде, где это возможно, аналитические материалы представлены с разбивкой по полу.

Представленные во *Всемирном докладе о наркотиках* данные о населении взяты из публикации *World Population Prospects: The 2022 Revision* (Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения).

«Долл. США» означают доллары Соединенных Штатов, если не указано иное.

«Тонны» означают метрические тонны, если не указано иное.

В настоящей брошюре используются следующие сокращения:

2С-В	4-бромо-2,5-диметоксифенэтиламин
COVID-19	коронавирусная инфекция
АКЛЕД	Проект по сбору данных о географии вооруженных конфликтов и связанных с ними событиях
альфа-ПВФ	альфа-пирролидиновалерофенон
БЗП	N-бензилпиперазин
ВВП	валовый внутренний продукт
ВГС	вирус гепатита С
ВИЧ/СПИД	вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения

га	гектары
ГБЛ	<i>гамма</i> -бутиролактон
ГОМК	<i>гамма</i> -оксимасляная кислота
ДМТ	диметилтриптамин
ЕЦМНН	Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании
ИППП	инфекция, передаваемая половым путем
КБД	каннабидиол
КККН	Канцелярия Комитета по контролю над наркотиками
КНС	Комиссия по наркотическим средствам
ЛНИ	лица, употребляющие наркотики путем инъекций
ЛСД	диэтиламид лизергиновой кислоты
МДМА	3,4-метилендиоксиметамфетамин
МДПВ	метилендиоксипировалерон
МККН	Международный комитет по контролю над наркотиками
НПВ	новые психоактивные вещества
НПО	неправительственная организация
ОЭЗ	особая экономическая зона
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
ПТСР	посттравматическое стрессовое расстройство
САР	стимуляторы амфетаминового ряда
СДВГ	синдром дефицита внимания с гиперактивностью
СИТЕС	Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
ТГК	тетрагидроканнабинол
УНП ООН	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
УНПКН	Управление национальной политики контроля над наркотиками
Ф-2-П	1-фенил-2-пропанон
ФЦП	фенциклидин
ЮНЭЙДС	Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
World WISE	Глобальная база данных об изъятиях объектов дикой природы

Координаторы вопросника к ежегодному докладу

УНП ООН с благодарностью отмечает неустанные усилия, которые прилагают координаторы вопросника к ежегодному докладу в государствах-членах, собравшие и представившие национальные данные о спросе на наркотики и их предложении, положенные в основу *Всемирного доклада о наркотиках*:

Даниэла Ходжаллари (Албания), Амина Буссаха (Алжир), Джазья Дехими (Алжир), Мохаммед Унди (Алжир), Джемма Радуан (Андорра), Джон Свифт (Антигуа и Барбуда), Адриан Бетти (Аргентина), Элиса Спровьеро (Аргентина), Давит Петросян (Армения), Эндрю Курир (Австралия), Андреа Зехнер (Австрия), Даниэль Лихтенеггер (Австрия), Рафаэль Байер (Австрия), Вольфганг Пфнайсл (Австрия), Асиман Мехдиев (Азербайджан), Азад Велиев (Азербайджан), Саид Асадли (Азербайджан), Терренс Фонтейн (Багамские Острова), Галина Пышник (Беларусь), Виталий Олегович Пручковский (Беларусь), Катя Уард (Бельгия), Ли Гremo (Бельгия), Неле Ван Томме (Бельгия), Стефани Овар (Бельгия), Латифу Сам Адекамби (Бенин), Юдит Сеньон-Аге (Бенин), Дава Дава (Бутан), Сонам Таши (Бутан), Церинг Чоден (Бутан), Карла Чоке Сото (Боливия (Многонациональное Государство)), Вильсон Салинас Оливарес (Боливия (Многонациональное Государство)), Драган Вукадин (Босния и Герцеговина), Жозе Гутемберг Лима Родригез (Бразилия), Наталья Нерси (Бразилия), Рафаэль Корасса (Бразилия), Рагнхильд Бертолини (Бразилия), Айми Джамайн (Бруней-Даруссалам), Пг Росни (Бруней-Даруссалам), Славейка Николова (Болгария), Букари Траоре (Буркина-Фасо), Сутоног Сита Сандрин Уэдраого (Буркина-Фасо), Колетт Така (Камерун), Кристина Арруда (Канада), Дженнифер Салахаб (Канада), Махамат Марк Бродэ (Чад), Эмильсе Писарро (Чили), Хосе Марин (Чили), Ян Чжэн (Китай), Чарли Чинг (Китай, САР Гонконг), Вай Хон (Китай, САР Макао), Оскар Рикардо Санта Лопес (Колумбия), Коста-риканский институт по наркотическим средствам (Коста-Рика), Эрнест Зотуа (Кот-д'Ивуар), Инносент Атсе (Кот-д'Ивуар), Роже Бадун Н'Гессан (Кот-д'Ивуар), Элиз Ира Уаттара (Кот-д'Ивуар), Суалихо Уаттара (Кот-д'Ивуар), Хрвое Палян (Хорватия), Лара Йезич (Хорватия), Мирела Ковачевич (Хорватия), Гавриэль Эфстратиу (Кипр), Иоанна Ясеми (Кипр), Катерина Хорачкова (Чехия), Ларс Петерсен (Дания), Тамми Хансен (Дания), Хильда Мария Франсиско Эспиналь (Доминиканская Республика), Мойсес Гомес Трабоус (Доминиканская Республика), Эстефанья Энкалада Сандовал (Эквадор), Вероника Куско Кинатоа (Эквадор), Раша аш-Шаркави (Египет), Альма Сесилия Эскобар де Мена (Сальвадор), Роксана Жеральдин Сигуэнса (Сальвадор), Катри Абель-Олло (Эстония), Кристиин Микко (Эстония), Пееп Раусберг (Эстония), Яри Лескинен (Финляндия), Яркко Хелин (Финляндия), Леена Кованен (Финляндия), Марья-Лииза Хелминен (Финляндия), Клэр Жуне-Арен (Франция), Жозефина Аффри (Франция), Сара Антюн (Франция), Демба Джамме (Гамбия), Майя Цоцория (Грузия), Тамта Бабунашвили (Грузия), Анна-Лена Меттерхаузен (Германия), Саския Енсен (Германия), Манджит Мумуни (Гана), Роузмонд Агбефу (Гана), Элфетерия Канаву (Греция), Иоаннис Марускос (Греция), Юлия Бафи (Греция), Хульо Кихивикс (Гватемала), Усман Янсане (Гвинея), Тьерно Бах (Гвинея), Дос Сантос (Гвинея-Бисау), Габриэль Базиль (Гаити), Жан Ален Бернадель (Гаити), Жозеф Ив Макс Габо (Гаити), Государственный секретариат (Святой Престол), Алекс Вильянуэва Меса (Гондурас), Глория Диас (Гондурас), Анна Петерфи (Венгрия), Петер Фольди (Венгрия), Бюро по контролю над наркотиками (Индия), Агус Ирианто (Индонезия), Авс Салх (Ирак), Имад Абдель Разик Абдель Гани (Ирак), Алан Белл (Ирландия), Конор Бреннан (Ирландия), Эти Кахана (Израиль), Андреа Дзаппароли (Италия), Элизабетта Симеони (Италия), Юки Маехира (Япония), Кусаинов Ке (Казахстан), Моррис Камендери (Кения), Паулин Оченг (Кения), Стивен Кимани (Кения), Чингиз Калматаев (Кыргызстан), Агнеса Зиле-Вейсберга (Латвия), Диана Ванага-Арая (Латвия), Зейнаб Аббасс (Ливан), Аушра Довидениене (Литва), Аушра Лазаускене (Литва), Бригита Расимайте (Литва), Эвелина Придоткене (Литва), Рута Лазаускене (Литва), Мишель Гёрген (Люксембург), Надин Берндт (Люксембург), Рита Кардозо Сейшас (Люксембург), Норкумала Абдул Рахман (Малайзия), Абделае Кейта (Мали), Сулейман Кулибали (Мали), Ямусса Диарра (Мали), Джон Теста (Мальта), Виктор Пейс (Мальта), Айнина Согхо (Мавритания), Корсил Севраз (Маврикий), Мангата Амреета (Маврикий), Марта Васкес (Мексика), Амарбайясгалан Чулуун (Монголия), Гордана Милутинович (Черногория), Лиляна Голубович (Черногория), Ясна Секулич (Черногория), Невена Маркович (Черногория), Абдеррахим Матрауи

(Марокко), Аюб Абужаафер (Марокко), эль-Мааруфи Абдельхафид (Марокко), Мустафа эль-Алами эль-Феллус (Марокко), Надия Чоуайб (Марокко), Жоссиель Жозе Мусса Мак Такула (Мозамбик), Орландо Карлос Алберто (Мозамбик), Зо Лин Оо (Мьянма), Йоханнес Гаесеб (Намибия), Гюс Крютс (Нидерланды (Королевство)), Софи Харви (Новая Зеландия), Мануэль Гарсия Моралес (Никарагуа), Абдул Азиз Гарба Яйе (Нигер), Иссоу Фоу Абдулайе (Нигер), Ибиба Джейн Одили (Нигерия), Даниэль Бергсвик (Норвегия), Элизабет Кваавик (Норвегия), Махмуд аль-Абри (Оман), Мохамед Амин (Оман), Сайед Сиджель Хайдер (Пакистан), Тасик Рашид (Пакистан), Арнульфо Кастильеро (Панама), Рубиэлис Саладана (Панама), Татьяна Тесис (Панама), Кристиан Гомес (Парагвай), Лаура Рейносо (Парагвай), Мануэль Бенитес (Парагвай), Матиас Хара (Парагвай), Маркос Браво (Перу), Боб Канега (Филиппины), Корасон П. Мамиго (Филиппины), Мари Грейс С. Кортес (Филиппины), Ребекка Ф. Арамбуло (Филиппины), Ивонна Б. Сан-Паскуаль (Филиппины), Лукаш Едрушак (Польша), Ана София Сантуш (Португалия), Эльза Майя (Португалия), Группа Катар АРК (Катар), Чжон Му Хон (Республика Корея), Юн Нам Кун (Республика Корея), Виктор Таку (Республика Молдова), Чипрьян Зету (Румыния), Олег Ложкин (Российская Федерация), Сауд ас-Сабхан (Саудовская Аравия), Байе Чейх Хане (Сенегал), Коммисайре Маме Ндев Сене (Сенегал), Душан Илич (Сербия), Сибилла Медерик (Сейшельские острова), Эвелин Лоу (Сингапур), Тхамараичелван Мейппан (Сингапур), Ева Дебнарова (Словакия), Ивана Букова (Словакия), Йоже Хрен (Словения), Сташа Шавели (Словения), Ватхисва Длангамандла (Южная Африка), Елена Альварес Мартин (Испания), Патрисиа Мартин (Испания), Тхамара Даршана (Шри-Ланка), Сабрина Ротарам (Суринам), Эллинор Литнер (Швеция), Дженни Хагелин (Швеция), Йоаким Страндберг (Швеция), Юлия Ахлин (Швеция), Люсьен Коллиандер (Швейцария), Сеймур Мизрахи (Швейцария), Моханнад Асбер (Сирийская Арабская Республика), Одилбекиён Сатрина Айदिмамадухт (Таджикистан), Пранг-анонг Сазнг-аркасс (Таиланд), Моузинью Т. Коррея (Тимор-Лешти), Аби Кемея-Абалло (Того), Ави Эссоссимна (Того), Надин Бика (Тринидад и Тобаго), Шина Арно (Тринидад и Тобаго), Рим Мансури (Тунис), Мохамед Али Чоуайби (Тунис), Ресул Олукман (Турция), Игорь Егоров (Украина), Александр Школяров (Украина), Владимир Литвинов (Украина), Артем Боневич (Украина), Амаль Ахмед Али аль-Зеюди (Объединенные Арабские Эмираты), Нура Абдул Латиф Саид аль-Мехри (Объединенные Арабские Эмираты), Альберто Отео (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Александра Шиафкоу (Соединенное Королевство), Джейкоб Джеффри (Соединенное Королевство), Домициан Мутайоба Доминик (Объединенная Республика Танзания), Николас Райт (Соединенные Штаты Америки), Мария Элиса Кабрера (Уругвай), Даниэль Умьеррес (Уругвай), Хатам Джалалов (Узбекистан), Карлос Хавьер Капоте (Венесуэла (Боливарианская Республика)), Йоханна Хаймес Валеро (Венесуэла (Боливарианская Республика)), Рита Каонга (Замбия), Пенни Гарсиа (Гибралтар), Анан Мохаммад Хассан Тиб (Государство Палестина).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- 01 АФГАНИСТАН: ЗАПРЕТ НА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВО И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, ВВЕДЕННЫЙ ДВИЖЕНИЕМ «ТАЛИБАН» В 2022 ГОДУ, И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ**
- 02 НЕЗАКОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»: СЛИЯНИЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ**
- 03 ГЕНДЕР, ВОЗРАСТ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ**
- 04 КАННАБИС И ПСИХОДЕЛИКИ: СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ФОРМИРОВАНИЕМ УСЛОВИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ**
- 05 НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ: РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ**

ГЛОССАРИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

**АФГАНИСТАН: ЗАПРЕТ НА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВО
И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, ВВЕДЕННЫЙ
ДВИЖЕНИЕМ «ТАЛИБАН» В 2022 ГОДУ, И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ**

АФГАНИСТАН: ЗАПРЕТ НА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВО И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, ВВЕДЕННЫЙ ДВИЖЕНИЕМ «ТАЛИБАН» В 2022 ГОДУ, И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Обстоятельства, предшествовавшие запрету 2022 года

Начиная с 1980-х годов и до недавнего времени производство и экспорт опиатов были, пожалуй, самым крупным видом незаконной экономической деятельности в Афганистане. В 2022 году доля Афганистана в общемировом незаконном производстве опия составляла около 80 процентов¹. Доходы только от культивирования опийного мака составляли 29 процентов стоимости всего сельскохозяйственного сектора страны, а в течение многих лет общая стоимость экспортируемых опиатов, включая опий и героин, превышала стоимостной объем официально зарегистрированного законного экспорта товаров и услуг^{2, 3}. Таким образом, на протяжении десятилетий опийный сектор обеспечивал значительную долю доходов сельского населения страны. По оценкам, подготовленным до прихода к власти движения «Талибан», опийный мак культивировался более чем в трети всех деревень⁴, а общий доход фермера, занимавшегося выращиванием опийного мака, в среднем был примерно на 50 процентов больше, чем у фермера, не выращивавшего мак⁵.

Афганистан также считается важной страной происхождения смолы каннабиса во всем мире, уступая лишь Марокко⁶. Более того, в последние годы расширение производства метамfetамfина дополнительно усложнило незаконную наркоэкономику страны и стало источником новых доходов от продажи наркотиков⁷.

После захвата власти движением «Талибан» в августе 2021 года в законной экономике и наркоэкономике начались резкие сдвиги. До 2021 года в Афганистан получал значительную внешнюю помощь в целях развития, за счет чего удалось увеличить ВВП на душу населения страны на 54 процента⁸ в период 2002–2020 годов⁹, однако внезапное сокращение этой помощи и введение ограничений на доступ к международным банковским и финансовым системам привели к существенному сжатию национальной экономики в целом¹⁰. В период 2020–2022 годов ВВП страны на душу населения сократился почти на 30 процентов^{11, 12, 13}, однако, несмотря на ухудшение экономической ситуации после захвата власти движением «Талибан» в августе 2021 года, обстановка в плане безопасности улучшилась, а масштабы коррупции уменьшились. В результате прекращения вооруженного конфликта, которому способствовали сформированные движением «Талибан» фактические органы власти, резко сократилось число актов насилия и смертельных случаев^{14, 15, 16}. Более того, некоторые данные свидетельствуют о том, что в 2022 году показатели коррупции и ее восприятия достигли самого низкого уровня за последнее десятилетие^{17, 18, 19, 20}, хотя в 2023 году, возможно, имело место обращение вспять этой тенденции в умеренном масштабе²¹.

Тем не менее Афганистан по-прежнему является одной из самых бедных стран мира²², которая сталкивается с острыми социальными проблемами. После прихода к власти движения «Талибан» права женщин были серьезно урезаны, в том числе в отношении образования, оплачиваемой занятости, свободы слова, самостоятельного передвижения и участия в политической жизни, и с тех пор их положение не улучшилось^{23, 24}.

В апреле 2022 года сформированные движением «Талибан» фактические власти объявили о запрете на производство всех наркотиков. Хотя на урожай 2022 года этот запрет практически не сказался, в 2023 году в стране произошел резкий спад опийной экономики, а доходы фермеров резко сократились.

РИС. 1 ВВП на душу населения в Афганистане, 2002–2022 годы

GDP per capita (\$)	ВВП на душу населения (долл. США)
Takeover by the Taliban	Захват власти движением «Талибан»

GDP per capita (current \$)	ВВП на душу населения (по текущему курсу в долл. США)
GDP per capita (constant 2015 \$)	ВВП на душу населения (при постоянном курсе на 2015 год в долл. США)

Источники: Всемирный банк, база данных «Показатели мирового развития»; и UNDP, *Two Years in Review: Changes in Afghan Economy, Households and Cross-Cutting Sectors (August 2021 to August 2023)*.

[АФГАНИСТАН: ЗАПРЕТ НА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВО И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, ВВЕДЕННЫЙ ДВИЖЕНИЕМ «ТАЛИБАН» В 2022 ГОДУ, И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ]

Запрет на культивирование опийного мака

Менее чем через год после прихода к власти в апреле 2022 года, как раз перед началом сбора урожая опийного мака, движение «Талибан» официально объявило о запрете на выращивание этой культуры. Введенный в 2022 году запрет распространяется на употребление, транспортировку, продажу, торговлю, импорт и экспорт всех видов наркотиков, в частности алкоголя, героина, шиши (метамфетамина), «таблеток К», гашиша, и всех других видов наркотиков, а также растений, используемых для производства наркотиков. Любому, кто не соблюдает запрет, грозит преследование в соответствии с шариатскими процедурами²⁵.

РИС. 2 Число зарегистрированных «событий», связанных с вооруженными конфликтами, и соответствующих смертельных случаев в Афганистане, 2019–2023 годы

Number of “events”	Число «событий»
Number of fatalities	Число смертельных случаев
Takeover by the Taliban	Захват власти движением «Талибан»
“Events”	«События»
Fatalities	Смертельные случаи
Qtr1	I кв.
Qtr2	II кв.
Qtr3	III кв.
Qtr4	IV кв.

Источник: база данных АКЛЕД.

Примечание: к зарегистрированным «событиям» относятся бои, взрывы/дистанционное насилие, насилие в отношении гражданского населения, насилие, совершаемое толпой, насильственные протесты и демонстрации.

РИС. 3 Культивирование опийного мака и производство опиума в Афганистане, 1994–2023 годы

Opium poppy cultivation (hectares)	Культивирование опийного мака (гектары)
360,000	360 000
320,000	320 000
280,000	280 000
240,000	240 000
200,000	200 000
160,000	160 000
120,000	120 000
80,000	80 000
40,000	40 000
Opium production (tons)	Производство опиума (тонны)

9,000	9 000
8,000	8 000
7,000	7 000
6,000	6 000
5,000	5 000
4,000	4 000
3,000	3 000
2,000	2 000
1,000	1 000
Cultivation	Культивирование
Production	Производство
-95 %	-95 %

Источник: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*, August 2023.

КАРТА 1 Культивирование опийного мака в Афганистане в разбивке по провинциям, 2023 год, и изменение площади культивирования опийного мака в разбивке по провинциям, 2022–2023 годы

Opium poppy cultivation, 2023	Культивирование опийного мака, 2023 год
TURKMENISTAN	ТУРКМЕНИСТАН
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
UZBEKISTAN	УЗБЕКИСТАН
TAJIKISTAN	ТАДЖИКИСТАН
CHINA	КИТАЙ
PAKISTAN	ПАКИСТАН
INDIA	ИНДИЯ
Balkh 132 ha	Балх 132 га
Badakhshan 1,573 ha	Бадахшан 1 573 га
Faryab 532 ha	Фарьяб 532 га
Saripul 318 ha	Сари-Пуль 318 га
Badghis 368 ha	Бадгис 368 га
Laghman 434 ha	Лагман 434 га
Kunar 364 ha	Кунар 364 га
Ghor 647 ha	Гор 647 га
Nangarhar 530 ha	Нангархар 530 га

Farah 127 ha	Фарах 127 га
Uruzgan 647 ha	Урузган 647 га
Zabul 882 ha	Забуль 882 га
Nimroz 101 ha	Нимроз 101 га
Helmand 142 ha	Гильменд 142 га
Kandahar 3,544 ha	Кандагар 3 544 га
Poppy cultivation at province level	Культивирование опийного мака на уровне провинций
Highest (more than 2,000 ha)	Очень высокий уровень (более 2000 га)
High (1,001 - 2,000 ha)	Высокий уровень (1001–2000 га)
Moderate (501 - 1,000 ha)	Умеренный уровень (501–1000 га)
Low (101 - 500 ha)	Низкий уровень (101–500 га)
Considered poppy-free	Опийный мак предположительно не культивируется
International boundary	Международные границы
Provincial boundary	Границы провинций

Changes in poppy cultivation, 2022–2023	Изменения в культивировании опийного мака, 2022–2023 годы
TURKMENISTAN	ТУРКМЕНИСТАН
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
UZBEKISTAN	УЗБЕКИСТАН
TAJIKISTAN	ТАДЖИКИСТАН
CHINA	КИТАЙ
PAKISTAN	ПАКИСТАН
INDIA	ИНДИЯ
Balkh -97.1%	Балх -97,1%
Badakhshan -63.5%	Бадахшан -63,5%
Faryab -92.3%	Фарьяб -92,3%
Saripul -90.8%	Сари-Пуль -90,8%
Badghis -97.4%	Бадгис -97,4%
Laghman -60.6%	Лагман -60,6%

Kunar -55.7%	Кунар -55,7%
Ghor -63.7%	Гор -63,7%
Nangarhar -89.9%	Нангархар -89,9%
Farah -99.2%	Фарах -99,2%
Uruzgan -95.6%	Урузган -95,6%
Zabul -42.4%	Забуль -42,4%
Nimroz -95.8%	Нимроз -95,8%
Helmand -99.9%	Гильменд -99,9%
Kandahar -87.9%	Кандагар -87,9%
Change	Изменение
Poppy free province	Провинция, где опийный мак не культивируется
Moderate decrease (up to -50%)	Умеренное снижение (до -50%)
Large decrease (-50% to -75%)	Значительное снижение (от -50% до -70%)
Very large decrease (-75% to -95%)	Весьма значительное снижение (от -75% до -95%)
Highest decrease (more than -95%)	Наибольшее снижение (более -95%)
International boundary	Международные границы
Provincial boundary	Границы провинций

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.

Источник: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*, August 2023.

Последующий двухмесячный льготный период практически не сказался на урожае 2022 года, однако на момент уборки урожая 2023 года, когда запрет вступил в полную силу, культивирование опийного мака и производство опия резко сократились во всех частях страны. В масштабах страны площадь посевов мака сократилась на 95 процентов и составила всего 10 800 га, что свидетельствует о том, что фермеры в основном соблюдают запрет. Поскольку нет никаких признаков, указывающих на значительные изменения в урожайности с гектара, производство опия, по оценкам, также сократится на 95 процентов — с 6200 тонн в 2022 году до 333 тонн в 2023 году. Это снижение было более значительным, чем после первого запрета на продажу опия, введенного движением «Талибан» в период 2000–2001 годов.

Помимо резкого сокращения числа полей, на которых культивируется опийный мак, средняя площадь оставшихся полей также значительно уменьшилась (на 36 процентов) — с 0,36 га в 2022 году до 0,23 га в 2023 году²⁶.

Судя по данным дистанционного зондирования и сообщениям с мест, в 2023 году культивирование опийного мака переместилось в более отдаленные и скрытые от глаз места, включая дворы и другие

огороженные территории. Возможно, это было сделано фермерами во избежание ликвидации посевов опийного мака и других потенциальных последствий. Кроме того, некоторые фермеры могли попытаться распределить риски ликвидации посевов, засеяв несколько небольших полей²⁷.

В настоящее время еще слишком рано давать надежные оценки тенденций в отношении производства опия в Афганистане в 2024 году. Однако, судя по полученным неофициальным сообщениям, афганские фермеры предпринимают попытки вырастить в 2024 году больше опийного мака, чем в предыдущем году²⁸. Имели место также сообщения об активизации в феврале и марте 2024 года усилий по ликвидации посевов опийного мака по всей стране²⁹.

Предварительная информация такого рода отнюдь не свидетельствует о возвращении к уровню культивирования опийного мака и производства опия в Афганистане, имевшего место в период до 2023 года, а указывает на то, что текущее производство опия в стране остается на низком, хотя, возможно, несколько более высоком, чем в 2023 году, уровне. Поскольку цены на опий резко взлетели вследствие дефицита и спекуляций, не исключено, что некоторые фермеры рискнут обойти запрет и вновь посеять опийный мак в 2024 году. После значительного роста в 2022 и 2023 годах цены на высушенный опий на уровне торговцев стабилизировались или даже немного снизились в 2024 году — с рекордных 802 долл. США за кг в декабре 2023 года до чуть более 700 долл. США в январе и феврале 2024 года³⁰, однако они по-прежнему были во много раз выше, чем в период до августа 2021 года, когда они постоянно находились на уровне ниже 100 долл. США за кг.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в настоящее время все признаки тенденций, о которых речь шла выше, все еще носят предварительный характер и, следовательно, могут быть изменены после получения более достоверной информации позднее в 2024 году.

РИС. 4 Площадь полей опийного мака в Афганистане в 2022 и 2023 годах

Field size in ha	Площадь поля в га
0.9	0,9
0.8	0,8
0.7	0,7
0.6	0,6
0.5	0,5
0.4	0,4
0.3	0,3
0.2	0,2
0.1	0,1

Источник: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*, August 2023.

Примечание: концы усов показывают диапазон площадей полей для каждого года. В общей сложности 50 процентов значений находятся в пределах ящиков, а линии в ящиках указывают на медиану (50 процентов значений больше и 50 процентов меньше). В целях наглядности выпадающие значения не представлены на диаграмме.

Последствия запрета 2022 года в Афганистане

Экономические потери в условиях уже обнищавшей страны

Несмотря на рост цен на опий более чем на 60 процентов с мая 2022 года по май 2023 года и более чем девятикратный рост с июля 2021 года по декабрь 2023 года³¹, сокращение производства опия в Афганистане привело к тому, что совокупный доход фермеров от производства опия уменьшился на 92 процента в период 2022–2023 годов³². Сокращение посевов опийного мака восполнялось в

первую очередь увеличением площади посевов пшеницы, других зерновых и, в гораздо меньшей степени, других культур, но это лишь незначительно смягчило общую потерю доходов.

В 2023 году совокупные экономические потери в связи с отказом от культивирования опийного мака составили примерно 1,25 млрд долл. США в сельских районах Афганистана. В четырех провинциях Фарах, Гильменд, Кандагар и Нангархар, на которые в 2022 году приходилось почти 75 процентов незаконного культивирования опийного мака, потери фермеров, перешедших с опийного мака на пшеницу, составили в 2023 году около 1 млрд долл. США³³.

Сокращение доходов фермеров происходило в условиях довольно нестабильной экономической ситуации. Несмотря на увеличение площади посевов продовольственных культур, некоторые фермеры прибегали к пагубным способам преодоления трудностей, таким как продажа активов, включая землю, скот и технику³⁴, поскольку до введения запрета доходы от продажи опиума шли в основном на питание, покрытие расходов на медицинское обслуживание и погашение долгов. Согласно сообщениям СМИ, насильственные столкновения, вызванные сопротивлением запрету 2022 года, в ходе которых порой были погибшие^{35, 36}, до сих пор носили эпизодический характер³⁷, однако по мере исчерпания сбережений и пагубных способов преодоления трудностей в сочетании с традиционно высокими ценами на опиум насилие может распространиться, что приведет к созданию нестабильности, обострению основных гуманитарных потребностей и будет препятствовать усилиям в области развития.

Окончательные оценки ВВП за 2023 год еще не опубликованы, но судя по предварительным оценочным докладам, в 2023 году ВВП на душу населения, вероятно, будет и далее сокращаться^{38, 39, 40}. Кроме того, экономическая ситуация усугубилась еще более вследствие нескольких сильных землетрясений в октябре 2023 года^{41, 42, 43} и репатриации из соседних стран афганских беженцев, не имеющих действительных документов^{44, 45}. Так, к середине января 2024 года Пакистан уже покинули более 500 000 афганских беженцев⁴⁶. Это может еще больше ухудшить и без того плохие показатели безработицы и бедности в Афганистане⁴⁷.

Происходит ли переход к изготовлению метамфетамина?

Захват власти движением «Талибан» произошел в то время, когда в Афганистане процветало производство метамфетамина. Объем изъятий метамфетамина в Афганистане и соседних странах увеличился с примерно 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021 году, причем все большая доля приходится на Афганистан. В Афганистане наблюдался стремительный рост совокупного объема ежегодных изъятий — с менее чем 100 кг в 2019 году до почти 2700 кг в 2021 году, что свидетельствует о росте производства⁴⁸, хотя в целом метамфетаминный сектор страны, по всей видимости, по-прежнему является относительно небольшим по сравнению со странами Юго-Восточной Азии и Северной Америки⁴⁹.

В отличие от опиума и героина, точно оценить масштабы производства метамфетамина невозможно, что усложняет понимание тенденций, характеризующих изготовление этого наркотика. Данные об изъятиях дают неполную картину и всегда в большей степени отражают возможности правоохранительных органов, чем реальное предложение, однако при анализе изъятий по странам и в сочетании с другими показателями они могут помочь выявить возможные тенденции. Изъятия, произведенные в Афганистане и соседних с ним странах в период с 2019 года по первый квартал 2023 года, свидетельствуют о расширении производства метамфетамина в этой стране. В период 2019–2022 годов об изъятиях метамфетамина афганского происхождения сообщили в общей сложности 17 стран Африки, Азии и Европы⁵⁰. В частности, по сообщениям Ирана (Исламская Республика) и Пакистана, большая часть метамфетамина, изъятая на их территории в последние годы, имела афганское происхождение^{51, 52}.

Если исходить из того, что динамика изъятий метамфетамина в соседних с Афганистаном странах Юго-Западной Азии отражает динамику его изготовления в Афганистане, то нет никаких оснований полагать, что запрет 2022 года оказал заметное влияние на производство этого наркотика в стране. По сообщениям, в 2022 году объемы изъятий метамфетамина в Иране (Исламская Республика) и

Пакистане продолжали расти, в то время как в Афганистане они снизились⁵³. Не совсем ясно, было ли это связано со снижением объемов производства, переносом производственных площадок во избежание обнаружения или уделением менее приоритетного внимания этим вопросам правоохранными органами.

Растение эфедры произрастает в дикой природе, и содержащийся в нем эфедрин может использоваться в качестве недорогого прекурсора при изготовлении метамфетамина⁵⁴, однако это не единственное вещество-прекурсор, которое может быть использовано. К числу других веществ относятся эфедрин, извлекаемый из противопростудных лекарственных средств, или нерасфасованный эфедрин очень высокой чистоты, изымаемый из цепочки поставок фармацевтической продукции⁵⁵. Анализ затрат и выгод, связанных с использованием тех или иных возможных прекурсоров при изготовлении метамфетамина в Афганистане, позволяет предположить, что растение эфедры вряд ли останется основным источником метамфетамина, находящегося в незаконном обороте в Афганистане и соседних с ним странах, если его производство будет продолжаться в больших масштабах. Однако затраты — это лишь один из факторов, влияющих на процесс принятия решений изготовителями, поскольку сезонные колебания в плане обеспеченности сырьем и риск обнаружения также могут сыграть свою роль⁵⁶.

Закрытие талибами в середине сентября 2023 года базара компании «Абдул Вадуд» в провинции Фарах, который, по некоторым данным, был одним из основных центров продажи дикорастущей эфедры, а также принятые властями меры по ликвидации лабораторий по изготовлению эфедрина в его окрестностях, лабораторий по изготовлению метамфетамина по всей стране и по предотвращению сбора эфедры, в частности в Бамиане, Герате, Горе, Сари-Пуле, Урузгане и Фарьябе⁵⁷, свидетельствуют о стремлении страны покончить с изготовлением метамфетамина⁵⁸.

КАРТА 2 Отдельные значительные изъятия метамфетамина в Юго-Западной Азии и соседних субрегионах, январь 2020 года – октябрь 2023 года

ARMENIA	АРМЕНИЯ
AZERBAIJAN	АЗЕРБАЙДЖАН
TÜRKIYE	ТУРЦИЯ
IRAQ	ИРАК
KUWAIT	КУВЕЙТ
SAUDI ARABIA	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
YEMEN	ЙЕМЕН
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
QATAR	КАТАР
UNITED ARAB EMIRATES	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
OMAN	ОМАН
UZBEKISTAN	УЗБЕКИСТАН
KYRGYZSTAN	КЫРГЫЗСТАН
TAJIKISTAN	ТАДЖИКИСТАН
AFGHANISTAN	АФГАНИСТАН
PAKISTAN	ПАКИСТАН
Jammu and Kashmir	Джамму и Кашмир
INDIA	ИНДИЯ
SRI LANKA	ШРИ-ЛАНКА
MALDIVES	МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Methamphetamine seizures (kg) January 2020–October 2023	Изъятия метамфетамина (кг) Январь 2020 года – октябрь 2023 года
≤1	≤1
>1 - 10	>1–10
>10 - 100	>10–100
>100 - 1,000	>100–1000
>1,000 - 2,550	>1000–2550
Excluded from analysis /no data available	Исключено из анализа/данные отсутствуют

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

РИС. 5 Объемы изъятий метамфетамина в Юго-Западной Азии, 2005–2023 годы

South-West Asia, 2005–2023	Юго-Западная Азия, 2005–2023 годы
Kilogram equivalents	Килограммы эквивалента
45,000	45 000
40,000	40 000
35,000	35 000
30,000	30 000
25,000	25 000
20,000	20 000
15,000	15 000
10,000	10 000
5,000	5 000
Afghanistan	Афганистан
Pakistan (estimate for 2022, based on 2022 data)	Пакистан (оценка за 2022 год на основе данных за 2022 год)
Pakistan (2005–2022)	Пакистан (2005–2022 годы)
Iran (Islamic Republic of)	Иран (Исламская Республика)
South-West Asia	Юго-Западная Азия
Afghanistan, 2013–2023	Афганистан, 2013–2023 годы
Kilogram equivalents	Килограммы эквивалента
3,500	3 500
3,000	3 000
2,500	2 500
2,000	2 000
1,500	1 500
1,000	1 000
500	500
Afghanistan	Афганистан

Trend	Линия тренда
-------	--------------

Источник: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*, August 2023.

По сообщениям фактических властей Афганистана, объем изъятий метамфетамина увеличился в 2023 году более чем в два раза и достиг 3,3 тонны, что является рекордно высоким показателем⁵⁹. В то же время, судя по некоторым признакам, изготовление метамфетамина по-прежнему имеет место, причем в более изолированных районах, чем это было в прошлом⁶⁰, а также продолжается контрабанда метамфетамина из Афганистана⁶¹.

За пределами страны все чаще стали появляться сообщения о метамфетамине высокой степени чистоты, который, вероятно, изготавливается из химических веществ — прекурсоров, а не из растения эфедр⁶². Исламская Республика Иран, являющаяся одной из основных стран транзита афганского метамфетамина, сообщила об участившихся случаях провоза через ее территорию по каналам незаконного оборота метамфетамина высокой степени чистоты афганского происхождения в 2023 году⁶³. Одновременно с этим поступают сообщения о том, что на юге Африки — одном из основных регионов назначения афганского метамфетамина в последние годы — качество афганского метамфетамина улучшилось и сравнялось с качеством метамфетамина из Мексики, Нигерии, Восточной и Юго-Восточной Азии⁶⁴.

В 2023 году объем изъятий метамфетамина в Исламской Республике Иран продолжал расти, увеличившись с рекордных для страны 25 тонн в 2021 году и 30 тонн в 2022 году⁶⁵ до 37 тонн в 2023 году⁶⁶, что является новым рекордным показателем, превышающим совокупный объем изъятий метамфетамина в Юго-Западной Азии в 2022 году. Наркотики перехватывали в основном в восточной части страны, недалеко от границы с Афганистаном⁶⁷. Что касается Пакистана, то анализ значительных изъятий метамфетамина также свидетельствует о заметном росте в 2023 году⁶⁸.

Анализ отдельных значительных изъятий метамфетамина в соседних с Афганистаном странах за периоды 2020–2021 и 2022–2023 годов (до и после введения запрета в отношении наркотиков) не выявил существенных изменений в структуре изъятий. Отдельные изъятия метамфетамина, произведенные в странах, где четко прослеживается их афганское происхождение, также свидетельствуют о постоянном росте после введения запрета в отношении наркотиков. Таким образом, воздействие запрета в отношении наркотиков за пределами Афганистана на производство метамфетамина в стране в целом пока имеет, по-видимому, весьма ограниченный характер. Общая доля отдельных значительных изъятий метамфетамина, произведенных в море (Индийский океан, Аравийское море и Оманский залив), среди всех изъятий метамфетамина, потенциально связанных с подпольным изготовлением метамфетамина в Юго-Западной Азии⁶⁹, выросла с 8 процентов в 2020 году до 13 процентов в 2022 году и 18 процентов в 2023 году, что явно свидетельствует о росте объемов незаконных морских перевозок метамфетамина в последние годы⁷⁰.

Однако по-прежнему трудно с какой-либо степенью уверенности определить, в какой мере растущие объемы метамфетамина, изымаемого за пределами Афганистана, связаны с метамфетаминном, изготовленным в этой стране, и продолжается ли в связи с этим рост объема метамфетамина, экспортируемого из Афганистана.

Еще предстоит выяснить, как введенный в 2022 году запрет в отношении наркотиков и резкое сокращение производства опиоидов повлияют на производство метамфетамина в Афганистане. Продолжение усилий по обеспечению соблюдения запрета в отношении метамфетамина может в конечном итоге помочь сократить его незаконный оборот, хотя это также может привести к перемещению производства метамфетамина в другие страны региона, особенно в те, где химические вещества — прекурсоры более доступны.

КАРТА 3 Отдельные значительные изъятия метамфетамина в Юго-Западной Азии и соседних субрегионах, исключая Афганистан, 2020–2023 годы

January 2020–December 2021	Январь 2020 года – декабрь 2021 года
ARMENIA	АРМЕНИЯ
AZERBAIJAN	АЗЕРБАЙДЖАН
TÜRKIYE	ТУРЦИЯ
IRAQ	ИРАК
KUWAIT	КУВЕЙТ
SAUDI ARABIA	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
YEMEN	ЙЕМЕН
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
QATAR	КАТАР
UNITED ARAB EMIRATES	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
OMAN	ОМАН
UZBEKISTAN	УЗБЕКИСТАН
KYRGYZSTAN	КЫРГЫЗСТАН
TAJIKISTAN	ТАДЖИКИСТАН
AFGHANISTAN	АФГАНИСТАН
PAKISTAN	ПАКИСТАН
Jammu and Kashmir	Джамму и Кашмир
INDIA	ИНДИЯ
SRI LANKA	ШРИ-ЛАНКА
MALDIVES	МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Methamphetamine seizures (kg) January 2020–December 2021	Изъятия метамфетамина (кг) Январь 2020 года – декабрь 2021 года
≤ 1	≤ 1
>1 - 10	>1–10
>10 - 100	>10–100
>100 - 1,000	>100–1000
>1,000 - 2,550	>1000–2550
Excluded from analysis/no data available	Исключено из анализа/нет данных
January 2022–October 2023	Январь 2022 года – октябрь 2023 года
ARMENIA	АРМЕНИЯ
AZERBAIJAN	АЗЕРБАЙДЖАН
TÜRKIYE	ТУРЦИЯ
IRAQ	ИРАК
KUWAIT	КУВЕЙТ
SAUDI ARABIA	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
YEMEN	ЙЕМЕН
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
QATAR	КАТАР
UNITED ARAB EMIRATES	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

OMAN	ОМАН
UZBEKISTAN	УЗБЕКИСТАН
KYRGYZSTAN	КЫРГЫЗСТАН
TAJKISTAN	ТАДЖИКИСТАН
AFGHANISTAN	АФГАНИСТАН
PAKISTAN	ПАКИСТАН
Jammu and Kashmir	Джамму и Кашмир
INDIA	ИНДИЯ
SRI LANKA	ШРИ-ЛАНКА
MALDIVES	МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Methamphetamine seizures (kg) January 2022–October 2023	Изъятия метамфетамина (кг) Январь 2022 года – октябрь 2023 года
≤ 1	≤ 1
>1 - 10	>1–10
>10 - 100	>10–100
>100 - 1,000	>100–1000
>1,000 - 2,526	>1000–2526
Excluded from analysis/no data available	Исключено из анализа/нет данных

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

РИС. 6 Динамика объемов изъятий метамфетамина в случаях значительных изъятий в Юго-Западной Азии, Центральной Азии и Оманском заливе, 2020–2023 годы

Quantities seized, indexed (Q1, 2020 = 100)	Объемы изъятий, проиндексированные (I кв. 2020 года = 100)
Qtr1	I кв.
Qtr2	II кв.
Qtr3	III кв.
Qtr4	IV кв.
Methamphetamine seized in South-West Asia, Central Asia and the Gulf of Oman	Изъятия метамфетамина в Юго-Западной Азии, Центральной Азии и Оманском заливе
Taliban Takeover	Захват власти движением «Талибан»
Drug ban	Запрет в отношении наркотиков
Methamphetamine - Trend	Метамфетамин – линия тренда

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

Примечание: поскольку представление информации еще продолжается, данные об отдельных значительных изъятиях метамфетамина, произведенных в четвертом квартале 2023 года, могут быть еще неполными.

Влияние запрета 2022 года: кто в выигрыше, а кто в проигрыше?

Первоначально фермеры, выращивающие опийный мак, выиграли от прихода к власти движения «Талибан» и запрета в отношении опия, о котором было объявлено в 2022 году. В 2022 году урожай опия был несколько ниже, чем в 2021 году, но цена на него быстро выросла, в результате чего совокупный доход фермеров от продажи опия увеличился более чем в три раза — с 425 млн долл. США в 2021 году до 1360 млн долл. США в 2022 году, что эквивалентно 9 процентам совокупного ВВП страны. По отношению к сельскохозяйственному ВВП страны доля производства опия увеличилась с 9 процентов в 2021 году до 29 процентов в 2022 году⁷¹. Аналогичным образом, совокупный доход от экспорта афганского опия и героина, составлявший в 2021 году порядка 1,7–2,5 млрд долл. США (12–18 процентов от совокупного ВВП)⁷³, вновь вырос в 2022 году⁷⁴.

В 2023 году, несмотря на дальнейший рост цен на опий, совокупный доход фермерских хозяйств от продажи опия по закупочным ценам снизился на 92 процента (с 1360 млн долл. США до 110 млн долл. США) из-за фактического сокращения площади культивирования опийного мака, или на 75 процентов по сравнению со средним доходом в период 2018–2021 годов⁷⁵. Впоследствии большинство выращивающих опийный мак фермеров перешли на выращивание пшеницы, что привело к большим потерям. В 2023 году доход с одного гектара, полученный от продажи пшеницы, составлял 770 долларов, что примерно на 92 процента меньше, чем доход с одного гектара, полученный от продажи опийного мака (10 000 долл. США)^{76, 77}.

Вследствие роста цен некоторые фермеры могли выгодно продать опийный мак предыдущих урожаев. Однако, судя по предыдущим исследованиям, фермеры могли не иметь больших запасов, поскольку около 80 процентов урожая опийного мака обычно продается фермерами в течение того же года⁷⁸ для удовлетворения основных потребностей, в частности в продуктах питания, покрытии медицинских расходов или выплате долгов⁷⁹. Таким образом, больше всех от резкого роста цен, вызванного радикальным сокращением площадей незаконного культивирования, выиграли, по-видимому, действующие в рамках цепи поставок наркоторговцы, имевшие запасы опия. Судя по предварительным данным об изъятиях, в 2023 году афганские торговцы экспортировали опий в крупных объемах, вероятно, в целях очистки своих запасов и получения выгоды от чрезвычайно высоких цен⁸⁰.

РИС. 7 Ежемесячные закупочные цены за килограмм высушенного опия в Афганистане в постоянных долларах США, январь 2005 года – декабрь 2023 года (с поправкой на декабрь 2023 год)

Constant \$ per kilogram	Цена за килограмм в постоянных долл. США
2011 Price hike due to a failed harvest in 2010	Скачок цен в 2011 году из-за неурожая в 2010 году
Low production in 2015 leading to high prices in 2016	Рост цен в 2016 году вследствие сокращения производства в 2015 году
Decrease in prices due to high levels of opium production in 2017	Снижение цен вследствие роста производства опия в 2017 году
Price-high mid-August 2021 (Taliban takeover)	Рост цен в середине августа 2021 года (захват власти движением «Талибан»)
Announcement of the opium cultivation ban in April 2022	Объявление о введении запрета на культивирование опийного мака в апреле 2022 года
Implementation of the opium poppy ban in 2023	Реализация запрета на культивирование опийного мака в 2023 году

Источники: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*; система мониторинга цен УНП ООН; и индекс потребительских цен, рассчитываемый Бюро статистики труда Соединенных Штатов для всех категорий городских потребителей (CPI-U).

РИС. 8 Предполагаемый доход фермеров от оптовой продажи урожая опийного мака, 2008–2023 годы

\$ (million)	Долл. США (млн)
1,800	1 800
1,600	1 600
1,400	1 400
1,200	1 200
1,000	1 000
800	800
600	600
400	400
200	200
Best estimate	Наилучшая оценка
Lower bound	Нижняя оценка
Upper bound	Верхняя оценка

Источник: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*.

Примечание: доход фермеров рассчитывается на основе средней продажной цены на опий в период сбора урожая.

РИС. 9 Культуры, возделываемые на бывших полях опийного мака в Фарахе, Гильменде, Кандагаре и Нангархаре в 2023 году

POPPY 100%	МАК 100%
Poppy, 3%	Мак, 3%
Cereak, 68.4%	Злаковые, 68,4%
Fallow, 10.8%	Пар, 10,8%
Summer crops, 15.1%	Яровые культуры, 15,1%
Perennial and other annual crops, 2.6%	Многолетние и другие однолетние культуры, 2,6%

Источник: UNODC, *Afghanistan Opium Survey 2023*.

Гораздо сложнее понять, кто выиграл, а кто проиграл от изменений, связанных с изготовлением метамфетамина. По сравнению с производством опия, в котором могут участвовать сотни тысяч

фермеров и сборщиков опийного мака, рабочая сила в афганском метамфетаминовом секторе состоит в основном из работников, собирающих дикорастущую эфедру (очень трудоемкое занятие)⁸¹, тогда как для последующего изготовления наркотика, как и в случае с другими синтетическими наркотиками, требуется гораздо меньше людей⁸². Поэтому вполне вероятно, что последствия изменений в производстве метамфетамина могут в меньшей степени ощущаться в крупных общинах и в большей степени проявляться в более мелких населенных пунктах.

Потенциальные последствия в плане наркопотребления в Афганистане

Изменения в производстве опия и метамфетамина также могут повлиять на внутренний рынок Афганистана. За последнее десятилетие наркопотребление уже диверсифицировалось, причем потребление синтетических наркотиков среди молодежи находится на более высоком уровне, чем потребление опиатов^{83, 84}. Употребление синтетических наркотиков, таких как метамфетамин, все чаще упоминается в материалах различных оценочных исследований, а также встречается среди лиц, проходящих лечение в связи с расстройствами на почве наркопотребления в Афганистане^{85, 86, 87, 88}.

Последнее исследование по вопросам наркопотребления в стране было проведено в 2018 году среди учащихся средних школ в возрасте 13–18 лет. Около 12 процентов (14 процентов мальчиков и 8,5 процента девочек) сообщили, что хотя бы раз в течение последних 12 месяцев употребляли какие-либо вещества (включая алкоголь)⁸⁹. В отличие от многих других стран, существенного различия в распространенности употребления наркотиков между городскими и сельскими жителями в возрасте 13–18 лет выявлено не было. Об употреблении каннабиса, героина и опия чаще сообщали юноши, чем девушки, тогда как употребление транквилизаторов и опиоидных лекарственных препаратов находилось на сопоставимом уровне. Распространенность употребления метамфетамина и «таблетки К» среди подростков в течение предшествующих 12 месяцев находилась на одном уровне с героином. Об употреблении героина сообщили в общей сложности 1,3 процента учащихся, такой же процент опрошенных употреблял метамфетамин, а «таблетку К» употребляли 1,8 процента.

В ходе анализа более 500 проб «таблеток К», отобранных в период с сентября 2020 года по март 2021 года в Афганистане, было выявлено наличие 26 различных веществ, однако в большинстве проанализированных проб (74 процента) был обнаружен метамфетамин, присутствовавший либо в виде основного вещества (42 процента), либо в сочетании с опиоидами (в основном героином или трамадолом; 32 процента), и лишь небольшую часть составляли пробы, в которых содержался в основном МДМА (23 процента)⁹⁰.

Радикальное снижение доступности опиатов может привести к росту спроса на другие и, возможно, более сильнодействующие синтетические опиоиды, особенно если не будут широко доступны основанные на фактических данных услуги по оказанию наркологической помощи в рамках реабилитационной поддержки. Изменения в предложении метамфетамина могут также привести к росту потребления других стимулирующих веществ.

Последствия запрета 2022 года за пределами Афганистана

До 2022 года на Афганистан приходилась основная доля (зачастую более 80 процентов) незаконно производимого опия в мире. Таким образом, если введенный в апреле 2022 года запрет в отношении наркотиков будет действовать в течение длительного времени, то, вероятно, это заметно скажется как на предложении опиатов во всем мире, так и на спросе на тех рынках, куда поставляются опиаты из Афганистана. По оценкам, в 2021 году около 80 процентов всех потребителей опиатов в мире употребляли наркотики из Афганистана⁹¹, в основном в Африке, Азии (кроме Восточной и Юго-Восточной Азии), Европе и одной стране в Северной Америке (Канаде).

На данный момент отсутствуют актуальные всеобъемлющие данные о незаконном обороте опиатов в странах транзита и об их употреблении в немедицинских целях на основных потребительских

рынках, которые позволили бы получить информацию о влиянии запрета в отношении опия в Афганистане.

КАРТА 4 Основные выявленные страны — источники опиатов на потребительских рынках, 2018–2022 годы

Opium production – Afghanistan	Производство опия – Афганистан
Origin of opiates primarily Afghanistan	Опиаты главным образом афганского происхождения
Opium production – Myanmar	Производство опия – Мьянма
Opium production – Lao People’s Democratic Republic	Производство опия – Лаосская Народно-Демократическая Республика
Origin of opiates primarily Myanmar	Опиаты главным образом мьянманского происхождения
Opium production – Americas	Производство опия – Америка
Origin of opiates primarily Mexico/Colombia	Опиаты главным образом мексиканского/колумбийского происхождения
No data	Нет данных

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается спор относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу; и УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА]

Первый запрет в отношении опия, введенный движением «Талибан» в 2000 году, и его последствия

27 июля 2000 года верховный руководитель движения «Талибан» издал указ о введении полного запрета на культивирование опийного мака в Афганистане, который сразу же вступил в силу и сказался на урожае 2001 года^а. В результате производство опия в Афганистане сократилось на 94 процента — с 3276 тонн в 2000 году до 185 тонн в 2001 году. Основная часть производства опия в Афганистане сохранилась в районах, которые в то время находились под контролем «Северного альянса»^б. Однако введенный талибами запрет на производство опия был недолгим, и в следующем году производство опия вновь стало расти^с.

За первые три квартала 2001 года объем изъятий опия в Юго-Западной Азии, Центральной Азии и Турции сократился вдвое, тогда как объем изъятий героина оставался практически неизменным, что указывает на наличие запасов опиатов в цепочке поставок^б. Однако цены на афганский опий немедленно отреагировали на запрет и за год выросли более чем в десять раз — с 28 долл. США за кг в апреле–мае 2000 года до 300 долл. США за кг в апреле 2001 года, а за неделю до 11 сентября 2001 года выросли еще больше — примерно до 700 долл. США за кг^б. В соседних странах цены также выросли, хотя и не столь значительно. В период с начала 2001 года по середину 2002 года цены на опий выросли в 5–6 раз в Иране (Исламская Республика), Пакистане и Таджикистане, а цены на героин — в 2,5–4 раза^д. Напротив, в Западной Европе рост цен в Афганистане незначительно сказался на ценах на героин; оптовые цены продолжали снижаться (примерно на 10 процентов) в 2001 году и оставались на том же уровне в 2002 году, однако начиная с 2001 года стали поступать сообщения о снижении чистоты героина во Франции, Турции и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии^б. В Соединенном Королевстве в период с первого квартала 2001 года

до середины 2002 года розничные цены на героин с поправкой на чистоту выросли примерно на 70 процентов^d.

Учитывая непродолжительный срок действия запрета в отношении опия, рост цен продлился недолго. В целом воздействие дефицита на обращаемость за наркологической помощью и смертность в Европе было не особенно заметным^e; по всей видимости, большинство рынков в регионе, за исключением Эстонии и Финляндии, оправились после первоначального шока^{f, g}.

В соседствующей с Афганистаном Исламской Республике Иран некоторые потребители опия, по-видимому, перешли на героин из-за нехватки опия на рынке, а некоторые из них перешли на считающийся более эффективным внутривенный способ введения, что повысило риск заражения передаваемыми через кровь заболеваниями^{f, h, i}.

- ^a United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Global Illicit Drug Trends 2001* (New York: ODCCP Studies on Drugs and Crime, 2001).
- ^b United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Global Illicit Drug Trends 2002*, ODCCP Studies on Drugs and Crime – Statistics (New York, 2002).
- ^c William Byrd and Christopher Ward, *Drugs and Development in Afghanistan*, 18 vols. (World Bank, Social Development Paper, 2004).
- ^d Thomas Pietschmann, “Price-Setting Behaviour in the Heroin Market”, *Bulletin on Narcotics* LVI, Nos. 1 and 2 (2004).
- ^e УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.
- ^f УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3 (Вена, 2022 год).
- ^g Jonathan P. Caulkins et al., “The Baltic and Nordic responses to the first Taliban poppy ban: implications for Europe & synthetic opioids today”, *International Journal of Drug Policy*, 124 (1 February 2024).
- ^h Afarin Rahimi-Movaghar et al., “Transition to injecting drug use in Iran: a Systematic review of qualitative and quantitative evidence”, *The International Journal on Drug Policy*, 26, no. 9 (September 2015), pp. 808–19.
- ⁱ Masoumeh Amin-Esmacili et al., “Profile of people who inject drugs in Tehran, Iran”, *Acta Medica Iranica* (2016), pp. 793–805.

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Можно утверждать, что запасы опиатов в Афганистане и на основных маршрутах незаконного оборота из Афганистана⁹² могут смягчить воздействие запрета в отношении опия в первый год после его введения, однако остается неясным, где точно находятся такие запасы и смогут ли они компенсировать 95-процентное сокращение производства наркотика, имевшее место в 2023 году.

Совокупный объем изъятий опиатов (в героиновом эквиваленте) в странах, в которые поставляется афганский опий, снизился в 2022 году (-30 процентов по сравнению с 2021 годом), то есть через год после захвата власти движением «Талибан», когда производство опия в Афганистане было все еще на высоком уровне. Это снижение за один год было самым значительным за последние три десятилетия, хотя такая понижающая тенденция была зафиксирована не во всех странах и субрегионах⁹³.

В Афганистане и многих других странах и регионах, на которых сказывается ситуация с афганскими опиатами, объем изъятий героина в 2022 году значительно снизился по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем в Западной и Центральной Европе объем изъятий героина практически не изменился, тогда как в Пакистане отмечался умеренный рост, а в Объединенных Арабских Эмиратах рост был значительным⁹⁴.

Эти изменения с трудом поддаются объяснению, и установить, отражают ли они изменение маршрутов, снижение уровня поставок и незаконного оборота или сохранение торговцами запасов в преддверии реализации введенного в 2022 году запрета и потенциального роста цен, также весьма непросто⁹⁵. Данные отдельных изъятий свидетельствуют о переориентации незаконного оборота

опиатов на морские маршруты. В период 2010–2019 годов совокупная доля изъятий героина, предназначенного для рынков Западной и Центральной Европы, на судах составляла 32 процента, а в период 2021–2023 годов она увеличилась до 59 процентов⁹⁶. Снижение объемов изъятий в Центральной Азии и Российской Федерации, с другой стороны, соответствует продолжающейся эволюции наркорынков в этой части света, где все больше людей употребляют синтетические наркотики и НПС и все меньше — опиаты⁹⁷. Кроме того, значительное снижение объемов изъятий в Восточной Европе в 2022 году могло быть связано с вооруженным конфликтом на Украине и последующей корректировкой маршрутов незаконного оборота в регионе⁹⁸.

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИЗЪЯТИЙ ГЕРОИНА, 2021–2022 ГОДЫ

INCREASE	РОСТ
United Arab Emirates +334%	Объединенные Арабские Эмираты +334%
Pakistan +24%	Пакистан +24%
STABILITY	СТАБИЛИЗАЦИЯ
Western and Central Europe +1%	Западная и Центральная Европа +1%
DECLINE	СНИЖЕНИЕ
Near and Middle East -6%	Ближний и Средний Восток -6%
Africa -18%	Африка -18%
South Asia -20%	Южная Азия -20%
Iran -32%	Иран -32%
Central Asia and Transcaucasia -42%	Центральная Азия и Закавказье -42%
Afghanistan -47%	Афганистан -47%
Eastern Europe -58%	Европа -58%
South-eastern Europe -66%	Юго-Восточная Европа -66%

РИС. 10 Динамика объемов производства опия в Афганистане и объемов изъятий героина, связанного с афганскими опиатами, 1994–2022 годы

Opium production (tons)	Производство опия (тонны)
10,000	10 000
9,000	9 000
8,000	8 000
7,000	7 000
6,000	6 000
5,000	5 000
4,000	4 000
3,000	3 000
2,000	2 000
1,000	1 000
Heroin seizures (tons)	Объем изъятий героина (тонны)
Correlation coefficient between Afghan opium production and heroin seizures related to Afghan opiates: R = 0.75	Коэффициент корреляции между производством опия в Афганистане и изъятиями героина, связанного с афганскими опиатами: R = 0,75

Volatility: standard deviation of annual growth rates of Afghan opium production: $s = 3.30$	Волатильность: стандартное отклонение годовых темпов роста производства опиума в Афганистане: $s = 3,30$
Heroin seizures related to Afghan opiates: $s = 0.18$	Изъятия героина, связанного с афганскими опиатами: $s = 0,18$
Afghan opium production	Производство опиума в Афганистане
Trend – opium production	Линия тренда – производство опиума
Heroin seizures	Изъятия героина
Trend – heroin seizures	Линия тренда – изъятия героина

Источники: UNODC, *Opium Cultivation in Afghanistan*, 2023 и издания за другие годы; и УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

Примечание. Регионы/субрегионы изъятий героина, связанного в основном с афганскими опиатами (на основе данных вопросника к ежегодному докладу): а) Юго-Западная Азия/Ближний и Средний Восток; б) Центральная Азия и Закавказье; в) Южная Азия; г) Африка; д) Европа.

РИС. 11 Изъятия героина в регионах/субрегионах, в которые в основном поставляются афганские опиаты, 2019–2022 годы

Heroin seizures related to Afghan opium production in kg	Объем изъятий героина, связанного с производством опиума в Афганистане, кг
100,000	100 000
80,000	80 000
60,000	60 000
40,000	40 000
20,000	20 000
Africa	Африка
Central Asia and Transcaucasia	Центральная Азия и Закавказье
South Asia	Южная Азия
Near and Middle East/South-West Asia	Ближний и Средний Восток/Юго-Западная Азия
Eastern Europe	Восточная Европа
South-Eastern Europe	Юго-Восточная Европа
Western and Central Europe	Западная и Центральная Европа
Estimates for non-reporting countries	Оценки для стран, не представляющих данные

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

РИС. 12 Ежеквартальные отдельные изъятия героина в регионах/субрегионах, в которые в основном поставляются афганские опиаты, 2020–2023 годы

Index (1st quarter of 2019 = 100)	Индекс (I квартал 2019 года = 100)
Qtr1	I кв.
Qtr2	II кв.
Qtr3	III кв.
Qtr4	IV кв.

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

РИС. 13 Распределение объемов изъятий героина, связанного с производством опиоя в Афганистане, фигурирующих в сообщениях об отдельных значительных изъятиях героина, 2019–2023 годы

Distribution	Распределение
Africa	Африка
Eastern Europe	Восточная Европа
South-Eastern Europe	Юго-Восточная Европа
Western and Central Europe	Западная и Центральная Европа
Oceans and Seas	Океаны и моря
Central Asia and Transcaucasia	Центральная Азия и Закавказье
South Asia	Южная Азия
South-West Asia	Юго-Западная Азия
Near and Middle East	Ближний и Средний Восток

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

Примечание: к океанам и морям относятся Оманский залив, Аравийское море и Индийский океан.

Данные о произведенных в прошлом изъятиях свидетельствуют о том, что для транспортировки опиатов афганского происхождения в страны назначения может потребоваться от нескольких месяцев до полутора лет, в зависимости от расстояния от Афганистана и используемого вида транспорта. Так, сокращение производства опиоя в Афганистане приведет к дефициту предложения в течение нескольких месяцев в Юго-Западной Азии, тогда как в случае транспортировки по суше на рынках назначения в Западной Европе этот дефицит может ощущаться в течение года (или чуть дольше)⁹⁹.

Сводные данные об изъятиях во всем мире за 2023 год отсутствуют, однако данные по отдельным изъятиям героина свидетельствуют о том, что в 2023 году в большинстве субрегионов продолжилось снижение, наблюдавшееся в 2022 году, за исключением Центральной Азии, Закавказья и Восточной Европы, где объем отдельных изъятий вырос¹⁰⁰. Неясно, является ли этот рост, который идет в разрез со снижением, наблюдаемым в большинстве других субрегионов, признаком того, что наркоторговцы пытаются переправить контрабандным путем больше опиатов по северному маршруту (проходящему из Афганистана через Центральную Азию в Восточную Европу).

На момент подготовки доклада явных признаков дефицита героина на крупных рынках Западной Европы не наблюдалось, однако, судя по неофициальной информации, возникали ситуации, когда сокращение производства опиоя в Афганистане, возможно, уже привело к последствиям.

В частности, нитазены, представляющие собой группу синтетических опиоидов, которые появились несколько лет назад на рынках Соединенных Штатов Америки¹⁰¹ и Западной Европы¹⁰², а также в Южной Америки и Океании¹⁰³, по всей видимости, получают все более широкое распространение¹⁰⁴. Некоторые нитазены являются более сильнодействующими, чем фентанил^{105, 106}, и с их употреблением связаны случаи с летальным исходом в Западной и Центральной Европе и Северной Америке¹⁰⁷. С 2009 года на европейском рынке было выявлено в общей сложности 78 новых неконтролируемых опиоидов, включая 13 сильнодействующих бензимидазольных (нитазеновых) опиоидов¹⁰⁸. Одновременно с этим в последние годы появляется все больше новых нитазенов. Количество новых уникальных нитазенов в мире в настоящее время приближается к количеству аналогов фентанила¹⁰⁹, а количество новых уникальных нитазенов, зарегистрированных в Европе, превышает количество аналогов фентанила с 2021 года¹¹⁰.

Возможно, из-за уменьшения предложения героина на местных рынках Ирландии в конце 2023 года на улицах Дублина и Корка под видом героина начали продаваться этонитазепин (N-пирролидин-этонитазен)¹¹¹ и протонитазепин (N-пирролидин протонитазен), что привело к

волне передозировок: по данным средств массовой информации^{112, 113}, в этих двух городах в ноябре и декабре 2023 года было зарегистрировано в общей сложности 77 таких случаев¹¹⁴. Значительное число случаев передозировки в связи с употреблением этонитазепина было зарегистрировано только в Соединенных Штатах¹¹⁵ и, в меньшей степени, в Канаде¹¹⁶; кроме того, это вещество было обнаружено в Бельгии, Словении и Соединенном Королевстве¹¹⁷.

РИС. 14 Число уникальных аналогов фентанилов и нитазенов, о которых имеются сведения на Консультативном портале раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН, на глобальном уровне, 2012–2023 годы

Number	Число
Fentanyl analogues	Аналоги фентанила
Nitazenes	Нитазены

Источник: UNODC, Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances, Nitazenes – a new group of synthetic opioids emerges (February 2024).

Примечание: данные за 2023 год все еще носят предварительный характер.

Судя по сообщениям из Соединенного Королевства, в 2023 году на рынке страны появились сильнодействующие нитазены¹¹⁸. Поскольку эти вещества продавались под видом или в смеси с другими веществами, такими как прочие опиоиды, бензодиазепины и синтетические каннабиноиды¹¹⁹, многие потребители не знали о том, что употребляют нитазены, что привело к 54 случаям смерти в период с 1 июня по 7 декабря 2023 года¹²⁰. Однако по состоянию на декабрь 2023 года Национальное агентство по борьбе с преступностью не обнаружило доказательств связи между нынешней волной смертей, связанных с нитазенами, и запретом в отношении опия в Афганистане. Тем не менее Агентство предупредило о том, что дальнейшее распространение нитазенов с фатальными последствиями все еще возможно в будущем после исчерпания существующих запасов героина¹²¹.

Данные по странам Балтии также свидетельствуют о том, что появление нитазенов может быстро повлиять на тенденции смертности на почве наркопотребления. Изотонитазен обнаруживается в Эстонии с 2019 года, а другие нитазены все чаще выявляются при патологоанатомическом анализе случаев смерти от наркотиков с 2022 года. В 2023 году, по предварительным данным, нитазены уже были выявлены в 48 процентах всех случаев смерти на почве наркопотребления в Эстонии, в основном связанных с протонитазеном, за которым следовал метонитазен¹²². В Латвии доля нитазенов, имеющих отношение к случаям смерти на почве наркопотребления, достигла 29 процентов в 2023 году и была связана в основном с употреблением изотонитазена¹²³.

В Исламской Республике Иран, судя по всему, доступность героина начала снижаться в результате реализации наркоторговцами стратегии по переориентации экспорта этого наркотика на более прибыльные рынки за рубежом, а цены на героин на внутреннем рынке выросли за последние несколько месяцев 2023 года. По неофициальным данным, это привело к росту спроса на незаконном рынке настойки опия, которая используется в качестве неофициальной формы опиоидной заместительной терапии в Исламской Республике Иран¹²⁴.

Возможные долгосрочные последствия запрета 2022 года

Сдвиги в предложении опиатов в сторону других стран

Сокращение производства опия в Афганистане может компенсироваться, по крайней мере частично, увеличением производства в других местах, в том же субрегионе или за его пределами, возможно, в странах, где опий уже производится или производился в прошлом и где контроль над территорией может быть затруднен вследствие повстанческой деятельности или конфликтов.

Например, возможны некоторые сдвиги, связанные с перемещением культивирования из восточного Афганистана в соседние регионы в районах проживания племен Пакистана. Рост производства опиума возможен также в Мьянме, различные районы которой затронуты рядом конфликтов (см. главу о «Золотом треугольнике»). Производство опиума в Мьянме уже увеличилось с 423 тонн в 2021 году до 790 тонн в 2022 году и 1080 тонн в 2023 году, то есть в 2,5 раза за два года¹²⁵. Однако маловероятно, что такой рост производства сможет в краткосрочной перспективе компенсировать дефицит опиума порядка 6000 тонн в Афганистане.

Изменения в спросе на опиаты, включая переход на другие наркотики, снижение чистоты героина и рост обращаемости за наркологической помощью

Влияние нехватки афганского героина на структуру наркопотребления в странах назначения непредсказуемо и, скорее всего, будет зависеть от местных рыночных условий и уровня оказания наркологической помощи и других услуг. Анализ последствий запрета 2001 года в отношении опиума в Афганистане для стран Северной Европы показал, что резкий дефицит героина привел к переходу на употребление других веществ. Например, в Эстонии героин был в значительной степени заменен фентанилом и его производными, а в Финляндии — бупренорфином. В Норвегии значительное сокращение числа случаев передозировки наркотиков, наблюдавшееся в период до 2001 года, совпало со снижением чистоты героина в 2001 году, расширением доступа к метадоновой терапии и относительным ростом потребления метамфетамина¹²⁶.

Одним из вероятных последствий дефицита героина станет рост цен на опиаты, в результате которого может сократиться спрос на героин. Цены на опиум и героин афганского происхождения уже начали расти, и, хотя цена на опиум составляет очень небольшой процент от цены героина на рынках стран назначения, в результате дефицита героина рост цен может в конечном итоге также иметь место и в основных странах-потребителях.

РИС. 15 Внутренние цены на опий и героин в Афганистане, январь 2021 года – декабрь 2023 года

Opium prices (\$ per kg)	Цены на опий (долл. США за кг)
1,200	1 200
1,000	1 000
800	800
600	600
400	400
200	200
Heroin prices (\$ per kg)	Цены на героин (долл. США за кг)
6,000	6 000
5,000	5 000
4,000	4 000
3,000	3 000
2,000	2 000
1,000	1 000
Jan	Янв.
Mar	Март
May	Май
Jul	Июль
Sep	Сент.
Nov	Нояб.
Dry opium prices (farmers)	Цены на высушенный опий (у фермеров)
Heroin prices (traders, best quality)	Цены на героин (у торговцев, лучшее качество)

Источник: УНП ООН, Система мониторинга цен.

Повышение цен может снизить потребление опиатов и их привлекательность для новых потребителей, выходящих на рынок, а также побудить существующих потребителей сократить потребление или уйти с рынка (например, перейти на заместительную терапию, если она доступна)¹²⁷. Проведенный в 2020 году систематический обзор эластичности цен на героин (на основе 19 исследований, проведенных в период 1995–2018 годов по всему миру) показал, что повышение цены на героин на 10 процентов с поправкой на чистоту приведет к сокращению потребления героина в среднем на 9,4 процента (диапазон: от -2 до -21 процента)¹²⁸.

Еще одним возможным результатом этого может быть переход потребителей на другие вещества, учитывая, что глобальный рынок становится все более сложным и характеризуется наличием множества наркотиков, предлагаемых во многих местах, часть из которых являются депрессантами, подобно опиоидам, или обладают схожим с опиатами действием^{129, 130}. То, какие конкретно вещества смогут прийти на смену героину, будет зависеть от динамики спроса и предложения в каждой стране, включая их доступность на законном или незаконном рынках.

КАРТА 5 Доступность метадона и бупренорфина для потребления в медицинских целях, 2020–2022 годы

S-DDD per million inhabitants per day	СУСД на миллион жителей в сутки
--	--

>10,000	>10 000
1,000 - 9,999	1000–9999
100 - 999	100–999
20 - 99	20–99
1 - 19	1–19
0	0
No data	Нет данных
Origin of opiates primarily not Afghanistan	Опиаты главным образом неафганского происхождения

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается спор относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Источник: INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2024; Statistics for 2022 (E/INCB/2023/2).

Примечание: СУСД означает статистическую условную суточную дозу, по определению МККН. Это техническая единица измерения, используемая для целей статистического анализа, и она не является рекомендованной дозой суточного приема; фактические дозы могут различаться в зависимости от необходимого лечения и медицинской практики.

Степень чистоты, по всей вероятности, снижается также на потребительских рынках, особенно на уровне розничной торговли, где наркоторговцы зачастую пытаются компенсировать имеющийся дефицит за счет добавления разбавителей и наполнителей. Добавление наполнителей может не всегда осуществляться последовательным образом, в результате чего пользователи могут сталкиваться с внезапными колебаниями чистоты и содержания, что может привести к передозировке и даже летальному исходу¹³¹. Вследствие снижения чистоты наркотиков потребители также могут перейти на более эффективные способы их введения, такие как инъекции¹³², которые при несоблюдении мер предосторожности могут повысить риск заражения заболеваниями, передающимися через кровь, такими как ВИЧ/СПИД или гепатит С¹³³.

Дефицит опиатов на потребительских рынках может также привести к росту обращаемости за наркологической помощью, включая опиоидную заместительную терапию. Данные об объемах метадона и бупренорфина, доступных для потребления, свидетельствуют о том, что опиоидная заместительная терапия в значительной степени доступна во многих странах Западной и Центральной Европы, в которые поставляются афганские опиаты, а также в Исламской Республике Иран, однако в меньшей степени в других странах, которые используются в качестве стран транзита или назначения афганских опиатов¹³⁴.

РИС. 16 Количество распространяемых игл и шприцев в расчете на одно лицо, употребляющее наркотики путем инъекций, в год и доля потребителей из группы высокого риска, проходящих опиоидную заместительную терапию, в Западной и Центральной Европе, 2019 год или последний год, за который имеются данные

Number of needle syringes per person who injects drugs per year	Количество игл и шприцев в расчете на одно лицо, употребляющее наркотики путем инъекций, в год
2020 WHO target	Целевой показатель ВОЗ на 2020 год

Finland	Финляндия
Latvia	Латвия
Lithuania	Литва
Hungary	Венгрия
Cyprus	Кипр
Luxembourg	Люксембург
Norway	Норвегия
Czechia	Чехия
Belgium	Бельгия
Spain	Испания
Greece	Греция
France	Франция
Portugal	Португалия
Croatia	Хорватия
High-risk opioid users in opioid substitution treatment (percentage)	Потребители опиоидов из группы высокого риска, проходящие опиоидную заместительную терапию (проценты)

Источники: УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 2; УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу; и EMCDDA, Elimination barometer on viral hepatitis among people who inject drugs in Europe.

РИС. 17 Охват программами обмена игл и шприцев и поддерживающей терапии опиоидными агонистами среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, в странах, не входящих в число наиболее развитых стран ОЭСР, 2018–2022 годы

Percentage of people who inject drugs receiving opioid agonist maintenance therapy	Процентная доля лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, которые проходят поддерживающую терапию опиоидными агонистами
Malaysia	Малайзия
Seychelles	Сейшельские Острова
Mauritius	Маврикий
Serbia	Сербия
Czechia	Чехия
Morocco	Марокко
North Macedonia	Северная Македония
Georgia	Грузия
Viet Nam	Вьетнам
Myanmar	Мьянма
India	Индия
Bangladesh	Бангладеш
Tajikistan	Таджикистан
Kenya	Кения
Albania	Албания
Mexico	Мексика

Ukraine	Украина
Iran (Islamic Republic of)	Иран (Исламская Республика)
Estonia	Эстония
Senegal	Сенегал
Thailand	Таиланд
Armenia	Армения
Republic of Moldova	Республика Молдова
Cambodia	Камбоджа
Togo	Того
Belarus	Беларусь
Nepal	Непал
Indonesia	Индонезия
Azerbaijan	Азербайджан
South Africa	Южная Африка
Kazakhstan	Казахстан
Needles and syringes distributed per year per person who injects drugs	Распространяемые иглы и шприцы в расчете на одно лицо, употребляющее наркотики путем инъекций, в год
2025 target	Целевой показатель на 2025 год

Источник: UNAIDS, “Global AIDS monitoring 2023”.

Одним из потенциально наиболее проблематичных последствий дефицита опиатов может стать переход от героина к другим опиоидам, а действие некоторых из них может быть более сильным, чем героина, что приведет к еще более пагубным последствиям¹³⁵. Эти вещества могут распространяться с существующих законных или незаконных рынков или появляться из абсолютно новых мест, как это произошло в случае с нитазенами в Ирландии.

В странах, где употребление опиоидных лекарственных средств в немедицинских целях распространено шире, чем употребление героина, дефицит героина может компенсироваться ростом употребления лекарственных средств в немедицинских целях. Например, во многих странах Восточной Африки, расположенных вдоль южного маршрута (проходящего из Афганистана в восточном и южном направлениях в Азию, Африку, Европу и Америку) экспорта афганских опиатов, потребление в этом субрегионе героина в целом представляется довольно ограниченным и менее распространенным, чем потребление опиоидных лекарственных средств. В Кении данные последнего национального обследования домашних хозяйств (2022 год) показывают, что употребление рецептурных препаратов в немедицинских целях, включая седативные средства, такие как бензодиазепины и опиоиды (в основном кодеин), было распространено в большей степени, чем употребление героина: 1,1 процента и 0,2 процента населения в возрасте 15–64 лет соответственно сообщили об их употреблении в немедицинских целях в течение своей жизни; что касается употребления в течение последних 12 месяцев и последнего месяца, то различия были еще более заметными¹³⁶.

В большинстве стран Западной Африки и районов Ближнего Востока употребление трамадола в немедицинских целях уже является широко распространенной практикой¹³⁷. Дефицит героина вполне может привести к росту спроса на трамадол, хотя такие сдвиги могут быть не столь значительными по масштабу, поскольку потребление героина имеет довольно ограниченный характер. Например национальное обследование по проблеме наркопотребления в Нигерии показало, что в 2018 году 4,7 процента населения в возрасте 15–64 лет злоупотребляли опиоидными лекарственными средствами (в основном трамадолом, за которым следует кодеин) против 0,1 процента потребителей героина¹³⁸.

В Индии, представляющей собой один из самых крупных мировых рынков опиия¹³⁹, снабжение которого в значительной степени осуществляется за счет поставок афганских опиатов, потребление опиоидных лекарственных средств в немедицинских целях за последние два десятилетия выросло гораздо больше, чем потребление героина, а в 2018 году было почти на том же уровне, что и потребление героина (0,96 процента и 1,14 процента населения в возрасте 10–75 лет соответственно)¹⁴⁰. Однако, несмотря на схожие показатели распространенности потребления, зарегистрированное проблемное употребление¹⁴¹ опиоидных лекарственных средств (0,23 процента) гораздо ниже, чем героина (0,57 процента)¹⁴². К опиоидным лекарственным средствам, которые нередко становятся предметом незаконного оборота в Индии и употребляются в немедицинских целях, относятся кодеин (обычно содержащийся в препаратах от кашля)^{143, 144}, трамадол^{145, 146} и бупренорфин^{147, 148}.

В регионах, где преимущественно употребляют героин, дефицит предложения может вызвать иную реакцию. Так обстоит дело в Западной и Центральной Европе, где героин до сих пор остается самым распространенным опиоидом, употребляемым в немедицинских целях, и на него приходится значительная доля нагрузки на здравоохранение, связанной с наркопотреблением^{149, 150}. Однако есть и исключения: в некоторых странах на рынке опиоидов преобладают другие опиоиды¹⁵¹.

Так, в Западной и Центральной Европе невозможно игнорировать опиоидные лекарственные средства, употребляемые в немедицинских целях, поскольку некоторые из них могут стать основными веществами, призванными восполнить дефицит героина. В некоторых странах субрегиона значительная часть (20–40 процентов в 2018 году) потребителей опиоидов, проходящих лечение, обращаются за помощью в связи с расстройствами на почве употребления опиоидов в немедицинских целях, помимо героина, таких как бупренорфин (Чехия), метадон (Дания и Германия), «компот» (Польша) и оксикодон (Кипр)¹⁵². Многофакторный анализ, проведенный в Германии, Италии, Испании и Соединенном Королевстве с целью оценки масштабов злоупотребления среди населения в целом, показал, что в период 2015–2018 годов кодеин, за которым следовали трамадол, морфин и оксикодон, были теми опиоидными лекарственными средствами, которые наиболее часто являются предметом злоупотребления¹⁵³.

КАРТА 6 Самые распространенные употребляемые в немедицинских целях опиоиды в Европе в разбивке по странам, 2022 год (или последний год, за который имеются данные)

Drugs	Наркотики
Heroin	Героин
Non-medical use of pharmaceutical opioids	Опиоидные лекарственные средства, потребляемые в немедицинских целях
Buprenorphine (non-medical use)	Бупренорфин (употребление в немедицинских целях)
Opioids NPS	Опиоидные НПВ
No data	Нет данных

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

РИС. 18 Число летальных случаев на почве наркопотребления в Европейском союзе и Соединенном Королевстве, 1985–2021 годы

Drug-related deaths	Число летальных случаев на почве наркопотребления
---------------------	---

100,000	100 000
80,000	80 000
60,000	60 000
40,000	40 000
20,000	20 000
8,663	8 663
2,762	2 762
9,463	9 463
5,488	5 488
14,218	14 218
6,535	6 535
17,415	17 415
7,730	7 730
29,813	29 813
6,556	6 556
38,329	38 329
6,823	6 823
52,404	52 404
8,248	8 248
106,699	106 699
91,799	91 799
10,431	10 431
10,751	10 751
United States – all drugs	Соединенные Штаты – все наркотики
United States – opioids	Соединенные Штаты – опиоиды
United States – synthetic opioids other than methadone (mainly fentanyl)	Соединенные Штаты – синтетические опиоиды помимо метадона (в основном фентанил)
European Union and United Kingdom – all drugs	Европейский союз и Соединенное Королевство – все наркотики

Источники: Статистический бюллетень ЕЦМНН; УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу; УНПКН; и показатели летальности от передозировки наркотиков, подготовленные Национальным институтом наркологии.

Примечание: из 106 699 человек, умерших от передозировки наркотиков в Соединенных Штатах в 2021 году, 80 411 случаев (75 процентов) были связаны с опиоидами, и большинство этих смертей (почти 88 процентов) были связаны со злоупотреблением фентанилом и его аналогами. В Европейском союзе в 2021 году 74 процента всех смертей от передозировки были связаны со злоупотреблением опиоидами.

Такие вещества могут иметь менее вредные последствия для здоровья, чем героин, однако на рынке могут появиться и новые, потенциально более вредные вещества, такие как фентанилы¹⁵⁴, нитазены¹⁵⁵ и различные другие опиоидные НПВ, которые уже были выявлены в нескольких странах мира¹⁵⁶. Пример нынешнего опиоидного кризиса в Северной Америке, который привел к рекордному числу смертей, связанных с синтетическими опиоидами, в частности фентанилом, иллюстрирует потенциальные риски такого сдвига^{157, 158}.

Несмотря на возможное отсутствие в других субрегионах обстоятельств и исходных условий, которые привели к развитию нынешнего опиоидного кризиса в Северной Америке^{159, 160}, изменения на незаконном опиоидном рынке, обусловленные дефицитом и приведшие к доминированию синтетических опиоидов, могут также довольно быстро произойти на рынках, на которые раньше поставлялись афганские опиаты, и иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

Помимо вреда здоровью, замена героина синтетическими опиоидами может повлечь другие серьезные последствия в отношении наркорынков, участников и маршрутов незаконного оборота наркотиков. Производство синтетических опиоидов может быть более дешевым, быстрым и выгодным, чем производство героина¹⁶¹, и может обеспечить возможности для новых групп, не связанных с балканским маршрутом, или побудить старые группы диверсифицировать и модифицировать свои цепочки поставок. Такие изменения могут лишь незначительно повлиять на розничное распространение, однако их воздействие на оптовую торговлю и международный незаконный оборот может оказаться более значительным, что повлечет за собой новые проблемы в области безопасности.

Примечания и ссылки

- 1 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, резюме, 2023 год.
- 2 См. например: UNODC 2021, *Afghanistan opium survey 2019: Socio-economic survey report: Drivers, causes and consequences of opium poppy cultivation*.
- 3 В 2017 году, в котором был собран самый большой урожай опийного мака с момента начала систематического мониторинга, стоимость опиатной экономики (доходы от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов) оценивалась в 4,1–6,6 млрд долл. США, или 20–32 процента ВВП Афганистана. Источник: UNODC and Government of Afghanistan, *'Afghanistan Opium Survey 2017 - Challenges to Sustainable Development, Peace and Security'*, May 2018, 207.
- 4 Government of Afghanistan, UNODC, *'Afghanistan Opium Survey 2018 - Challenges to Sustainable Development, Peace and Security'*, 2019.
- 5 UNODC and Islamic Republic of Afghanistan, *'Afghanistan Opium Survey 2019 Socio-Economic Survey Report: Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation'*, February 2021.
- 6 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, онлайн-сегмент, 2023 год.
- 7 UNODC, *'Understanding Illegal Methamphetamine Manufacture in Afghanistan'*, August 2023.
- 8 World Bank, *'World Development Indicators Database'*, n.d.
- 9 ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций), *Доклад о человеческом развитии за 2021–2022 годы*, (Нью-Йорк, 2022 год).
- 10 UNDP (United Nations Development Programme), *'Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023'*, April 2023.
- 11 World Bank, *'World Development Indicators Database'*.
- 12 UNDP (United Nations Development Programme), *'Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023'*.
- 13 UNDP, *'Two Years in Review: Changes in Afghan Economy, Households and Cross-Cutting Sectors (August 2021 to August 2023)'*, 2023.
- 14 ACLED, *'Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 24-30 July 2021 (and Previous Weeks/Months/Years)'*, 5 August 2021.
- 15 ACLED, *'Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 18-24 September 2021 (and Subsequent Weeks/Months/Years)'*, 29 September 2021.
- 16 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *'ACLED Database'*, December 2023.
- 17 UNDP (United Nations Development Programme), *'Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023'*.
- 18 Transparency International, *'Corruption Perceptions Index, 2020-2022'*, n.d.
- 19 World Bank Group, *'Afghanistan Private Sector Rapid Survey - An Assessment of the Business Environment - Round 2'*, September 2022.
- 20 Mohammad Imran Khushal, *'Corruption and Its Effects on the People of Afghanistan'*, *Modern Diplomacy*, 13 November 2022.
- 21 Transparency International, *'Corruption Perceptions Index 2023'*, 30 January 2024.
- 22 ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций), *Доклад о человеческом развитии за 2021–2022 годы*.
- 23 Heather Barr, *'The Taliban and the Global Backlash Against Women's Rights'*, *Human Rights Watch, Georgetown Journal of International Affairs*, 6 February 2024.
- 24 UN Women Asia and the Pacific, *'Statement on Afghanistan by UN Women Executive Director Sima Bahous'*, 16 August 2023.

- 25 The Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Justice, 'Decree Concerning the Prohibition on Poppy Cultivation, 5 April 2022 (Decrees, Orders and Instructions of His Excellency, Amier Al-Mu'aminin)', *Official Gazette*, no. 1432 (22 May 2023).
- 26 UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2023', August 2023.
- 27 Ibid.
- 28 UNODC, 'Reports from the Field, in Afghanistan Price Monitoring Dashboard', March 2024.
- 29 Ibid.
- 30 UNODC, 'Afghanistan Price Monitoring Dashboard', March 2024.
- 31 УНП ООН, Система мониторинга цен, дата не указана.
- 32 UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2023'.
- 33 Ibid.
- 34 'Assessment Capacities Project (ACAPS), 'Afghanistan - Coping with the Crisis: Conversations with Afghan Households in Kabul Province', 16 June 2023.
- 35 Islamic Emirate of Afghanistan Spokesman Office, 'Poppy Eradication Campaign in Badakhshan - A Committee/Delegation Appointed to Investigate Tragic Incidents', 4 May 2024.
- 36 Ariana News, 'IEA Sets up Delegation over Badakhshan Protests | Ariana News', 5 May 2024.
- 37 Yogita Limaye, 'Inside the Taliban's War on Drugs - Opium Poppy Crops Slashed', *BBC News*, 6 June 2023.
- 38 UNDP (United Nations Development Programme), 'Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023'.
- 39 The World Bank and Afghanistan Futures, 'Afghanistan Development Update - Uncertainty after Fleeting Stability', October 2023.
- 40 UNDP, 'Two Years in Review: Changes in Afghan Economy, Households and Cross-Cutting Sectors (August 2021 to August 2023)'.
- 41 Masoud Popalzai Chen Heather, 'More than 2,000 People Killed as Earthquake Strikes Western Afghanistan', *CNN*, 8 October 2023.
- 42 Christina Goldbaum and Yaqoob Akbary, 'Another Powerful Quake Hits Afghanistan, Days After Deadly Temblors', *The New York Times*, 11 October 2023, sec. World.
- 43 Al Jazeera, 'Afghanistan Hit by Another Earthquake in Herat Region', 15 October 2023.
- 44 Caroline Gluck, 'Forced Returns from Pakistan Deepen Afghanistan's Humanitarian Crisis', UNHCR, 17 November 2023.
- 45 Philippa Candler, 'UNHCR Concerned at Adverse Effects of Pakistan Orders for Undocumented Foreigners to Leave', UNHCR, 21 November 2023.
- 46 IOM, 'Afghanistan Situation Report Border - Consortium Emergency Border Operations, 14-27 January 2027', 5 February 2024.
- 47 Caroline Gluck, 'Forced Returns from Pakistan Deepen Afghanistan's Humanitarian Crisis'.
- 48 UNODC, 'Understanding Illegal Methamphetamine Manufacture in Afghanistan'.
- 49 Объем изъятий метамфетамина в Афганистане, достигший своего пика в 2021 году, составлял всего 0,7 процента от общемирового объема изъятий метамфетамина (УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу).
- 50 UNODC, 'Understanding Illegal Methamphetamine Manufacture in Afghanistan'.
- 51 УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, дата не указана.
- 52 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 53 УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

- 54 UNODC, 'Drug Situation in Afghanistan 2021: Latest Findings and Emerging Threats', November 2021.
- 55 UNODC, 'Understanding Illegal Methamphetamine Manufacture in Afghanistan'.
- 56 Ibid.
- 57 Alcis, 'Truly Unprecedented: The Taliban Drugs Ban', Alcis, 6 June 2023.
- 58 Alcis, 'An Industry and a Population under Stress: Methamphetamine Production Under Taliban Rule', 11 December 2023.
- 59 Deputy Ministry on Counter Narcotics of the DfA, 'Drug and Precursor Seizures - Afghanistan, 2021-2023', n.d.
- 60 Alcis, 'An Industry and a Population under Stress: Methamphetamine Production Under Taliban Rule'.
- 61 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 62 Похоже, что метамфетамин высокой степени чистоты довольно сложно изготовить из растения эфедры без знаний специфики химико-технологического процесса, в то время как из синтетического эфедрина или псевдоэфедрина его изготовить довольно просто.
- 63 Канцелярия Центрального управления по контролю над наркотиками Исламской Республики Иран, Комиссия по наркотическим средствам, 67-я сессия, параллельное мероприятие «Понимание меняющихся тенденций в области незаконного оборота наркотиков в Западной и Центральной Азии и разработка обоснованных, специализированных и упреждающих мер реагирования в рамках мероприятий по наращиванию потенциала», 22 марта 2024 года.
- 64 Jacon Eligh, 'Global Synthetic Drug Markets - The Present and Future'.
- 65 УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.
- 66 'Letter to UNODC from the Drug Control Headquarters, Islamic Republic of Iran, 10 January 2024', n.d.
- 67 Канцелярия Центрального управления по контролю над наркотиками Исламской Республики Иран, Комиссия по наркотическим средствам, 67-я сессия, параллельное мероприятие «Понимание меняющихся тенденций в области незаконного оборота наркотиков в Западной и Центральной Азии и разработка обоснованных, специализированных и упреждающих мер реагирования в рамках мероприятий по наращиванию потенциала».
- 68 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 69 К ним относятся изъятия, произведенные в Юго-Западной Азии, Центральной Азии и Закавказье, на Ближнем и Среднем Востоке, в Юго-Восточной Европе, на юге Африки, в Южной Азии, Оманском заливе, Аравийском море и Индийском океане.
- 70 Там же.
- 71 UNODC, 'Opium Cultivation in Afghanistan - Latest Findings and Emerging Threats', November 2022.
- 72 UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2023'.
- 73 Расчет основан на текущем ВВП в размере 14 266,5 млн долл. США, согласно данным Всемирного банка по Афганистану за 2021 год (World Bank, National Accounts Data, GDP (current US\$)).
- 74 UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2023'.
- 75 Ibid.
- 76 Ibid.
- 77 Значительные различия сохраняются даже при учете дополнительных затрат на производство опия (рабочая сила, пестициды, удобрения и т. д.).
- 78 UNODC and Islamic Republic of Afghanistan, 'UNODC, "Afghanistan Opium Survey 2019: Socio-Economic Survey Report, Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation"', February 2021.
- 79 UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2023'.
- 80 Ibid.

- 81 UNODC, 'Understanding Illegal Methamphetamine Manufacture in Afghanistan'.
- 82 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра «Наркотики: современные проблемы», 2023 год.
- 83 UNODC and Islamic Republic of Afghanistan, 'Study on Substance Use and Health among Youth in Afghanistan 2018', April 2021.
- 84 В настоящее время УНП ООН проводит оценку наркопотребления в Афганистане, в том числе потребления особо опасных наркотиков и распространенности наркопотребления. Результаты будут опубликованы позднее в 2024 году.
- 85 Global SMART Programme, *Afghanistan Synthetic Drugs Situation Assessment* (UNODC, 2017).
- 86 Abdul Suboar Mamand and Hendrée E. Jones, 'Drug Use Among Women and Children in Afghanistan: The Complexities of An Important Public Health Issue', *HSOA Journal of Addiction, Addiction Disorders*. 7, no. 1 (31 January 2020).
- 87 Dave Bewley-Taylor, Ross Eventon, and Mat Southwell, 'From Bad to Worse? Drug Use and Treatment in Afghanistan', Policy Brief 19 (Global Drug Policy Observatory, Swansea University, March 2023).
- 88 Nasar Ahmad Shayan et al., 'Epidemiology of Drug Use in Herat - Afghanistan', *Addiction & Health* 14, no. 2 (April 2022): 68–77.
- 89 UNODC and Islamic Republic of Afghanistan, 'Study on Substance Use and Health among Youth in Afghanistan 2018'.
- 90 UNODC, 'Afghanistan's "Tablet K" - a Forensic Insight into an Emerging Synthetic Drug Market' (Global SMART Update, 2022).
- 91 УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.
- 92 Результаты анализа данных за последние три десятилетия свидетельствуют о прямой зависимости между производством опиума в Афганистане и изъятиями героина на маршрутах незаконного оборота из Афганистана. Они также свидетельствуют о том, что колебания годового объема производства опиума в Афганистане были гораздо более значительными, чем колебания объема изъятий героина, что указывает на возможное существование запасов на маршрутах незаконного оборота, за счет которых обеспечивается бесперебойная поставка героина из Афганистана на рынки назначения.
- 93 УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.
- 94 Там же.
- 95 Turkish National Police, Counter Narcotics Department, 'Turkish Drug Report 2023' (Ankara, 2023).
- 96 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 97 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра «Вопросы, представляющие особый интерес», 2023 год.
- 98 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра «Наркотики: современные проблемы».
- 99 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3, 2022 год.
- 100 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 101 Alex J. Krotulski; et al., 'New High Potency Synthetic Opioid N-Pyrrolidino Etonitazene (Etonitazepyne) Linked to Overdoses Across United States', *National Institute of Justice (NIJ); Center for Forensic Science Research and Education United States*, no. NCJ Number 307414 (2021).
- 102 Isabelle Giraudon, Katri Abel-Ollo, Diāna Vanaga-Arāja, Peter Heudtlass, Paul Griffiths, 'Comment: Nitazenes Represent a Growing Threat to Public Health in Europe' 9, no. 2 (February 2024).
- 103 UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances, 'Nitazenes - a New Group of Synthetic Opioids Emerges', February 2024.
- 104 Ibid.

- 105 Adam Holland, Caroline S Copeland, Gilian W Shorter, Dea J Connolly, Alice Wiseman, John Mooney, 'Comment: Nitazenes - Heralding a Second Wave for the UK Drug-Related Death Crisis?', *Lancet Public Health* 9, no. 2 (February 2024).
- 106 World Health Organization, Expert Committee on Drug Dependence, 'Critical Review Report: Etonitazepyne (N-Pyrrolidino Etonitazene)' (Geneva, 10 October 2022).
- 107 Adam Holland, Caroline S Copeland, Gilian W Shorter, Dea J Connolly, Alice Wiseman, John Mooney, 'Comment: Nitazenes - Heralding a Second Wave for the UK Drug-Related Death Crisis?'
- 108 Paul N. Griffiths et al., 'Opioid Problems Are Changing in Europe with Worrying Signals That Synthetic Opioids May Play a More Significant Role in the Future', *Addiction*, 21 December 2023.
- 109 UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances, 'Nitazenes - a New Group of Synthetic Opioids Emerges'.
- 110 Ibid.
- 111 World Health Organization, Expert Committee on Drug Dependence, 'Critical Review Report: Etonitazepyne (N-Pyrrolidino Etonitazene)'.
- 112 Conor Pope, 'Testing Finds "Dangerous" Synthetic Opioid in Heroin Batch That Led to 44 Overdoses in Last 48 Hours', *The Irish Times*, 11 November 2023.
- 113 Ivia Kelleher, '"High-Risk" Synthetic Opioid Being Sold in Dublin and Cork as Heroin, HSE Warns', *The Irish Times*, 13 January 2024.
- 114 Cormac O'Keeffe, 'Drug Dealers "testing" Heroin Market with Dangerous Synthetics', *Irish Examiner*, 22 February 2024.
- 115 Alex J. Krotulski; et al., 'New High Potency Synthetic Opioid N-Pyrrolidino Etonitazene (Etonitazepyne) Linked to Overdoses Across United States'.
- 116 World Health Organization, Expert Committee on Drug Dependence, 'Critical Review Report: Etonitazepyne (N-Pyrrolidino Etonitazene)'.
- 117 Ibid.
- 118 Colin Davidson, 'Nitazenes: Synthetic Opioids More Deadly than Fentanyl Are Starting to Turn up in Overdose Cases', *The Conversation*, 25 September 2023.
- 119 Office for Health Improvement & Disparities, 'National Patient Safety Alert: Potent Synthetic Opioids Implicated in Heroin Overdoses and Deaths' (London, UK, 26 July 2023).
- 120 Adam Holland, Caroline S Copeland, Gilian W Shorter, Dea J Connolly, Alice Wiseman, John Mooney, 'Comment: Nitazenes - Heralding a Second Wave for the UK Drug-Related Death Crisis?'
- 121 Alex Homer and Navtej Joha, 'Street Drugs Stronger than Heroin Linked to 54 Deaths in UK', *BBC News*, 11 December 2023, sec. UK.
- 122 Isabelle Giraudon, Katri Abel-Ollo, Diāna Vanaga-Arāja, Peter Heudtlass, Paul Griffiths, 'Comment: Nitazenes Represent a Growing Threat to Public Health in Europe'.
- 123 Ibid.
- 124 Health expert from the Islamic Republic of Iran, Communication on the consequences of the Afghan opium shortage on opioids markets in the Islamic Republic of Iran, 2 February 2024.
- 125 UNODC, 'South-East Asia Opium Survey 2023', December 2023.
- 126 Jonathan P. Caulkins et al., 'The Baltic and Nordic Responses to the First Taliban Poppy Ban: Implications for Europe & Synthetic Opioids Today', *International Journal of Drug Policy* 124 (1 February 2024).
- 127 Anne Linne Bretteville-Jensen, 'Drug Demand - Initiation, Continuation And Quitting', *De Economist* 154, no. 4 (6 December 2006): 491–516.

- 128 Jason Payne et al., 'The Price Elasticity of Demand for Illicit Drugs: A Systematic Review', *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice* 606 (2020).
- 129 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра «Наркотики: современные проблемы».
- 130 Griffiths et al., 'Opioid Problems Are Changing in Europe with Worrying Signals That Synthetic Opioids May Play a More Significant Role in the Future'.
- 131 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3.
- 132 Wendy Swift, Lisa Maher, Sandra Sunjic and Vincent Doan, 'Transition among Caucasian and Indochinese Heroin Users in South-West Sydney', 1997.
- 133 Scott P. Novak and Alex H. Kral, 'Comparing Injection and Non-Injection Routes of Administration for Heroin, Methamphetamine, and Cocaine Uses in the United States', *Journal of Addictive Diseases* 30, no. 3 (2011): 248–57.
- 134 INCB, 'Narcotic Drugs 2022: Estimated World Requirements for 2023 - Statistics for 2021, (E/INCB/2022/2)' (Vienna, 2023).
- 135 Griffiths et al., 'Opioid Problems Are Changing in Europe with Worrying Signals That Synthetic Opioids May Play a More Significant Role in the Future'.
- 136 NACADA, *National Survey on the Status of Drugs and Substance Use in Kenya* (Nairobi, 2022).
- 137 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3.
- 138 UNODC and Nigeria, 'Drug Use in Nigeria 2018' (Vienna, 2019).
- 139 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, онлайн-сегмент.
- 140 Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India, 'Magnitude of Substance Use in India 2019' (New Delhi, 2019).
- 141 В исследовании сообщается о проблемном употреблении, определяемом как пагубное употребление или зависимость.
- 142 Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India, 'Magnitude of Substance Use in India 2019'.
- 143 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 144 UNODC, 'India-Bangladesh: Trafficking and Abuse of Pharmaceuticals - an Issue of Growing Public Concern', 2010.
- 145 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 146 Sophia Gorman, 'India's Dangerous New Relationship with Opioids', *France 24*, 1 September 2019.
- 147 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 148 UNODC, 'India-Bangladesh: Trafficking and Abuse of Pharmaceuticals - an Issue of Growing Public Concern'.
- 149 EMCDDA, *European Drug Report 2023: Trends and Developments* (Luxembourg, 2023).
- 150 Ibid.
- 151 Фентанилы до недавнего времени в Эстонии и Латвии, бупренорфин в Финляндии и неуточненные опиоидные лекарственные средства в ряде других европейских стран. Источник: УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3.
- 152 EMCDDA, *European Drug Report - Trends and Developments 2020* (Luxembourg, 2020).
- 153 Jannetta L. Iwanicki et al., 'Tramadol Non-Medical Use in Four European Countries: A Comparative Analysis', *Drug and Alcohol Dependence* 217 (December 2020): 108367.
- 154 UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2023'.
- 155 Davidson, 'Nitazenes'.

- 156 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 4 (Вена, Австрия: Организация Объединенных Наций, 2022 год).
- 157 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 'Provisional Data Shows U.S. Drug Overdose Deaths Top 100,000 in 2022', 18 May 2023.
- 158 Benedikt Fischer, 'The Continuous Opioid Death Crisis in Canada: Changing Characteristics and Implications for Path Options Forward', *The Lancet Regional Health – Americas* 19 (1 March 2023).
- 159 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2020 год*, брошюра 4 «Общие вопросы: меняющиеся тенденции и новые вызовы» (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год).
- 160 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3.
- 161 УНП ООН, глава «Феномен синтетических наркотиков» *Всемирного доклада о наркотиках за 2023 год*, брошюра 3 «Наркотики: современные проблемы», 2023 год.

02

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ

В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»: СЛИЯНИЕ С ДРУГИМИ

ВИДАМИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

СЛИЯНИЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Введение

«Золотой треугольник» расположен в районе, где сходятся границы трех государств — Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и Таиланда. Культивировать опий в этом регионе начали в конце XVIII века, а во второй половине XX века регион приобрел репутацию крупного мирового производителя опия и его производного продукта — героина^{1, 2}. Практика выращивания опийного мака в Юго-Восточной Азии в качестве товарной культуры и растения, применяемого в народной медицине, сложилась благодаря благоприятным для производства опия географическим особенностям региона, а именно умеренному климату на высоте более 1000 метров и наличию разбросанных, изолированных деревень³.

Однако значимость опийного мака как основного источника незаконных доходов в регионе снизилась под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. В результате вооруженных конфликтов и роста спроса на синтетические наркотики в Юго-Восточной Азии тенденции в наркоэкономике Мьянмы за последние 30 лет изменились^{4, 5}. Эти факторы способствовали тому, что преступным группам в «Золотом треугольнике» потребовалось диверсифицировать свою деятельность. В настоящее время незаконная торговля опиумом уступает изготовлению синтетических наркотиков, в частности метамфетамина, и различным видам незаконной деятельности, таким как финансовые махинации в интернете, торговля объектами дикой природы, незаконная добыча ресурсов, торговля людьми и отмывание денег⁶. В рамках своих стратегий в области производства и незаконного оборота наркотиков транснациональные организованные преступные группы порой используют казино или особые экономические зоны (ОЭЗ) для узаконивания или сокрытия истинных источников своих доходов.

Эволюция характера деятельности, связанной с наркотиками, и преступности в «Золотом треугольнике» зачастую тесно связана с давними политическими и управленческими проблемами, особенно в штате Шан в Мьянме, а также со слабым пограничным контролем в странах, расположенных в низовьях Меконга⁷. Внутренние конфликты в Мьянме, продолжающиеся с момента обретения страной независимости и значительно ускорившиеся после прихода к власти военных в феврале 2021 года, издавна тесно связаны с незаконной экономикой^{8, 9}. Ряд вооруженных групп¹⁰ получают доход от различных видов незаконной деятельности для достижения своих политических или финансовых целей¹¹, зачастую при молчаливой поддержке коррумпированных государственных институтов¹². Эта ситуация подрывает благое управление, безопасность и политическую стабильность, что имеет серьезные последствия для биоразнообразия, окружающей среды и местных общин. В свою очередь, минимальное присутствие государства и слабость верховенства права способствуют расширению разнообразия незаконной деятельности вооруженных и преступных групп.

В настоящей главе продолжается начатое во *Всемирном докладе о наркотиках за 2023 год* (глава «Связь между наркотиками и преступлениями, влияющими на окружающую среду, и конвергентной преступностью в бассейне реки Амазонки») рассмотрение проблемы слияния незаконного оборота наркотиков с другими видами незаконной деятельности и того, как это сказывается на природных экосистемах и общинах в «Золотом треугольнике». В ней также рассматриваются географические и организационные аспекты этой проблемы и дается оценка взаимосвязей производства и незаконного оборота наркотиков с другими видами незаконной экономики, которые бросают вызов верховенству права и способствуют дальнейшему разжиганию конфликтов.

Взаимосвязи между производством и оборотом наркотиков, преступлениями против окружающей среды и другими видами преступной деятельности в «Золотом треугольнике» имеют сложный, изменчивый и зачастую многовекторный характер. В данной главе представлен обзор последних тенденций и закономерностей с учетом признаваемых сложностей, связанных с мониторингом зон активных конфликтов. В ней использованы официальные данные и данные из открытых источников, материалы посещений объектов, обзор научной литературы, официальные отчеты, анализ исследований из открытых источников и качественная информация, собранная в ходе встреч с экспертами¹³.

[НЕЗАКОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»: СЛИЯНИЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ]

«Золотой треугольник»

«Золотой треугольник» не имеет согласованных или определенных границ, однако под этим термином, получившим широкое распространение в 1970-е годы, как правило, понимают штат Шан в Мьянме, несколько провинций на севере Таиланда, расположенных между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Мьянмой, и северо-западные провинции Лаосской Народно-Демократической Республики¹⁴. Сформировавшийся в долине реки Меконг район, где сходятся границы трех государств — Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и Таиланда и где ориентировочно расположен эпицентр «Золотого треугольника», находится в центре внимания настоящей главы.

В последние годы в пределах «Золотого треугольника» наблюдается укрепление промышленного производства наркотиков в находящихся под контролем вооруженных групп особых районах штата Шан, где широко присутствуют организованные преступные синдикаты, но практически отсутствует государственная власть¹⁵; правоохранные органы по всей Юго-Восточной Азии и на связанных рынках отмечают, что «Золотой треугольник» и особые районы становятся все более важным источником производства наркотиков.

Данный регион характеризуется удаленностью, малонаселенностью, биологическим разнообразием и богатыми природными ресурсами, такими как древесина, драгоценные камни и минералы, а также реки. С 1990-х годов в регионе наблюдается бурное развитие внутренней и трансграничной инфраструктуры, что способствует укреплению региональных рыночных связей и развитию торговли^{16, 17, 18}. В последние годы в нескольких приграничных районах «Золотого треугольника» были созданы казино и ОЭЗ с целью содействия экономическому росту и торговле¹⁹. Однако ряд этих объектов предположительно являются центрами преступности и в некоторых случаях были созданы с целью дальнейшего содействия незаконной деятельности^{20, 21}.

Можно привести несколько ключевых примеров таких зон региона, включая особый район 2 и особый район 4 штата Шан и отдельные части провинции Бокео в Лаосской Народно-Демократической Республике. В этих зонах нередко располагаются казино, гостиницы и предприятия, предположительно занимающиеся различными видами незаконной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков и объектов дикой природы, торговлю людьми и финансовые махинации^{22, 23}.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА]

Эволюция вооруженных групп, ведущих свою деятельность на незаконных рынках в районе «Золотого треугольника» на территории Мьянмы

Многие из групп, контролирующих сегодня наркоторговлю в «Золотом треугольнике», возникли более 30 лет назад, когда ряд вооруженных групп захватили территории в стратегически важных частях «Золотого треугольника», особенно в штате Шан в Мьянме. Тремя, пожалуй, самыми крупными и влиятельными группами являются Объединенная армия области Ва (ОАОВ), Армия Национального демократического альянса (АНДА) и Армия Национального демократического альянса Мьянмы (АНДАМ). К 1990-м годам эти вооруженные группы достигли соглашения о прекращении огня с военным правительством Мьянмы, которое предоставило им автономию и позволило не разоружаться^a. Кроме того, военное правительство выделило особые районы, разрешив вооруженным группам заниматься предпринимательской деятельностью, выдавать лицензии на добычу ресурсов, собирать налоги, набирать солдат и управлять районами с некоторой автономией от центральной власти, а в некоторых случаях также обеспечивать работу школ, клиник и местных государственных учреждений^{b, c, d}. Контролирующие эти особые районы вооруженные группы нередко занимаются самыми разными видами экономической деятельности, в том числе в экономических

зонах свободной торговли, а также незаконной деятельностью, такой как производство наркотиков и добыча ресурсов^е. Внутренние механизмы принятия решений и разделения властных полномочий в разных группах различны: в некоторых из них руководством занимаются советы, а в руководстве других групп по-прежнему преобладает горстка лиц-основателей^{д, ф}.

Самая крупная и мощная негосударственная вооруженная группа — ОАОВ насчитывает, по оценкам, от 20 000 до 30 000 бойцов^{г, h, d} и контролирует значительный участок горной территории в восточной части штата Шан, расположенный между рекой Салуин и границей с Китаем. Более чем какая-либо другая вооруженная группа в Мьянме ОАОВ ассоциируется с производством и незаконным оборотом наркотиков^{l, j}. К середине 1990-х годов ОАОВ диверсифицировала свою деятельность, помимо опиума и героина приступив к изготовлению метамфетамина^к. В последнее время ОАОВ, действуя совместно с транснациональными организованными преступными группами, расширила ассортимент незаконно изготавливаемых ею наркотиков, включив в него кетамин и другие нишевые синтетические наркотики. Примерно с 2020 года эта группа продолжила диверсифицировать свою незаконную деятельность и стала заниматься интернет-преступностью и кибермошенничеством, которые оказались прибыльными и получили большое распространение во время пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)^l.

Другой заметной вооруженной группой является АНДА, оценочной численностью более 3000 бойцов^м, базирующихся в особом районе 4, имеющем важнейшее стратегическое и логистическое значение для АНДА и ее союзников в «Золотом треугольнике». Важно отметить, что особый район 4 обеспечивает ОАОВ доступ к реке Меконг, а также в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, расположенную на противоположном берегу реки, и в Таиланд, расположенный ниже по ее течению^к. В последние годы значительное развитие получили объекты инфраструктуры в портах, которые стали пунктами транзита самых разнообразных товаров, как законных, так и незаконных, включая наркотики и химические вещества — прекурсоры^п. В 2000-х годах экономика «столицы» особого района 4 Монг Ла расширилась за счет целого ряда видов деятельности, в первую очередь за счет казино, игорных заведений и публичных домов, незаконного оборота объектов дикой природы, помимо незаконного оборота наркотиков и прекурсоров^о, и появившихся в последнее время центров онлайн-махинаций и кибермошенничества^l.

Группа АНДАМ, в которой насчитывается несколько тысяч бойцов^р, действует в особом районе 1, расположенном к северу от особого района 2 и связанным как с ним, так и с особым районом 4. Практически сразу после своего основания в 1989 году АНДАМ начала изготавливать героин и участвовать в незаконном обороте наркотиков. Вскоре группа стала заниматься еще и игорным бизнесом, превратив столицу Коканга Лауккай из маленького приграничного городка в процветающий центр игорного бизнеса, привлекающий инвесторов и все больше клиентов из Китая, а также сосредоточением лиц, ставших жертвами торговли людьми, которые зачастую работают в казино, отелях и других центрах, приносящих прибыль^l. АНДАМ была вытеснена из особого района 1 в 2009 году конкурирующими с ней пограничными силами Коканга — военизированным формированием, поддерживаемым правительством, однако, по данным ряда источников включая СМИ, она вновь взяла под свой контроль этот район в январе 2024 года^q.

^a Martin John Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (London: Zed Books, 1999).

^b Hélène Le Bail and Abel Tournier, “From Kunming to Mandalay: The New ‘Burma Road’”, *Asie, Visions* 25 (2010).

^c International Crisis Group, “Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State” (Brussels, Belgium, January 8, 2019).

^d Bertil Lintner, “The United Wa State Army and Burma’s Peace Process” (United States Institute of Peace, April 29, 2019).

^e Lintner, *Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948*; Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*.

^f John Buchanan, *Militias in Myanmar* (Asia Foundation Yangon, 2016).

^g Agence France-Presse, “‘Masters of Our Destiny’: Myanmar’s Wa Rebels in Show of Force”, *South China Morning Post*, April 17, 2019.

- ^h Myanmar Peace Monitor, “United Wa State Party (UWSP/UWSA)”, *Myanmar Peace Monitor* (blog), June 6, 2013. Размещено по адресу: <https://mmpeacemonitor.org/1600/uwsa/>.
- ⁱ Например, в 2008 году Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении связанных с ОАОВ 26 лиц и 17 компаний, внесенных в перечень специально обозначенных наркоторговцев, в соответствии с Законом о выявлении иностранных наркобаронов (Закон о выявлении наркобаронов).
- ^j US Department of the Treasury, “Treasury Action Targets Burmese Drug Cartel”, U.S. Department of the Treasury, November 13, 2008.
- ^k Интервью УНП ООН с сотрудником спецслужб страны бассейна реки Меконг, июнь 2021 года.
- ^l Kyu, Myint Myint. “Gambling as Development: A Case Study of Myanmar’s Kokang Self-Administered Zone.” Chiang Mai, Thailand: International Development Research Centre, 2018.
- ^m Myanmar Peace Monitor, “National Democratic Alliance Army-Eastern Shan State (NDAA-ESS)”, *Myanmar Peace Monitor* (blog), June 6, 2013.
- ⁿ Интервью УНП ООН с сотрудником спецслужб страны бассейна реки Меконг, февраль 2021 года.
- ^o Vincent Nijman and Chris R. Shepherd, “Emergence of Mong La on the Myanmar–China Border as a Global Hub for the International Trade in Ivory and Elephant Parts”, *Biological Conservation* 179 (2014): 17–22.
- ^p Myanmar Peace Monitor, “Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA)”, *Myanmar Peace Monitor* (blog), June 6, 2013.
- ^q Peck, Grant. “Armed Ethnic Alliance in Northern Myanmar Is Said to Have Seized a City That Was a Key Goal.” *Associated Press*, January 5, 2024.

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

КАРТА 7 Район «Золотого треугольника»

INDIA	ИНДИЯ
MYANMAR	МЬЯНМА
CHINA	КИТАЙ
VIET NAM	ВЬЕТНАМ
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
THAILAND	ТАИЛАНД
S.R.1	ОР1
S.R.2	ОР2
S.R.4	ОР4
International boundaries	Международные границы
Golden Triangle	«Золотой треугольник»
Shan State	Штат Шан
Special Regions	Особые районы

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА

Роль особых экономических зон

Многие финансируемые частным сектором ОЭЗ были созданы в приграничных районах региона для развития торговли и привлечения инвестиций путем предоставления налоговых льгот, предусмотренных соответствующими соглашениями (например, об освобождении от уплаты таможенных пошлин), установления особых административных и трудовых правил для привлечения конкретных коммерческих или промышленных секторов (например, обрабатывающей промышленности, туризма и игорного бизнеса), создания ключевой инфраструктуры (например, портов, складов и автомагистралей) и установления других правил и процедур, которые снижают требования к документации и направлены на содействие торговле или экономической деятельности, не осуществляемой на остальной территории страны^a. Однако ОЭЗ в районе «Золотого треугольника», как правило, финансируются частным образом и плохо регламентированы, а некоторые из них расположены в приграничных и портовых районах, которые, как известно, используются группами наркоторговцев для содействия незаконной торговле наркотиками и химическими веществами — прекурсорами, а также для перемещения других контрабандных товаров^b.

Одной из самых крупных и скандально известных ОЭЗ в «Золотом треугольнике» является ОЭЗ «Золотой треугольник» на восточном берегу реки Меконг в Лаосской Народно-Демократической Республике в районе, прилегающем к границам Мьянмы и Таиланда, где расположено казино «Кингз Романз», представляющее собой комплекс игорных заведений. ОЭЗ «Золотой треугольник» была основана в 2007 году правительством и частной китайской компанией для развития ряда видов экономической деятельности, включая туризм^c. По мнению сотрудников региональных и международных правоохранительных органов и служб финансовой разведки, казино «Кингз Романз» является центром самой различной преступной деятельности, включая поставку прекурсоров по каналам незаконного оборота в Мьянму и наркотиков в Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Таиланд, торговлю людьми в целях принуждения к участию в кибермошенничестве и онлайн-играх, а также контрабанду продуктов дикой природы^{d,e}. Помимо тесной связи с ОЭЗ «Золотой треугольник», ОАОВ и АНДА также контролируют ряд ОЭЗ или аналогичные механизмы в Мьянме, где источниками дохода являются кибермошенничество и незаконный онлайн-игорный бизнес^f.

Стремительное развитие изощренной индустрии онлайн-азартных игр привело к необходимости создания подпольных банковских систем и систем отмыwania денег, обеспечивающих возможность для осуществления финансовых операций и перемещения крупных денежных сумм. Вооруженные группы и связанные с ними транснациональные организованные преступные группы в Восточной и Юго-Восточной Азии также диверсифицировали свою хозяйственную деятельность, занимаются отмыwанием денег и прикрывают свою преступную деятельность, зачастую используя казино или вспомогательные отрасли, обслуживающие ОЭЗ^b.

^a Gokhan Akinci and James Crittle, “Special Economic Zone: Performance, Lessons Learned, and Implication for Zone Development” (The World Bank, 2008).

^b UNODC, “Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat”.

^c Investment Promotion Department, “Golden Triangle Special Economic Zone”, accessed February 22, 2024.

^d Переписка УНП ООН с сотрудниками спецслужб стран бассейна реки Меконг, февраль 2021 года.

^e US Department of the Treasury, “Treasury Sanctions the Zhao Wei Transnational Criminal Organization”.

^f Например, в ОР2 есть две зоны экономического развития (ЗЭР) — в Моунг Пинге на юго-восточной границе с Китаем и Нам Денге в северной части страны, — в которых также расположены казино. В ОР4 находится ОЭЗ «Йонгбанг», расположенная вдоль границы с Китаем.

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Производство и незаконный оборот наркотиков в «Золотом треугольнике»

Опий и героин издавна были основой наркоэкономики «Золотого треугольника». До 1990-х годов, пока Афганистан не стал ведущим мировым производителем, большая часть опия, потребляемого в мире в виде героина, поступала из «Золотого треугольника»²⁴. Производство опийного мака и героина по-прежнему является важной частью незаконной хозяйственной деятельности многих вооруженных и преступных групп в «Золотом треугольнике», однако в 1990-х годах все большее значение стало приобретать изготовление метамфетамина, которое в последние годы превратилось в ценный источник дохода²⁵. В то время как в 1990-е годы спрос на героин и опий в регионе в целом снизился, рынки метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Океании и Южной Азии продолжали расти, в результате чего этот наркотик стал еще одним прибыльным товаром в регионе²⁶. Традиционно ограниченный централизованный государственный контроль над обширными территориями²⁷, близость к большому количеству доступных химических веществ — прекурсоров, продолжающиеся внутренние конфликты и рост потребления метамфетамина в более широком регионе Юго-Восточной Азии²⁸ способствовали тому, что «Золотой треугольник» стал региональным центром производства метамфетамина, а затем занял ведущее положение в этой сфере.

К 2010 году производство наркотиков в штате Шан в Мьянме сместилось в основном в сторону метамфетамина: началось масштабное производство таблеток метамфетамина (также известного как «яба») для регионального потребления, а несколько лет спустя — кристаллического метамфетамина, предназначенного как для региона, так и для рынков других стран²⁹. В последующие годы объемы и число изъятий и степень чистоты увеличились, особенно после того, как власти соседнего Китая сосредоточили свои усилия на сокращении подпольного внутреннего производства метамфетамина примерно в период 2013–2014 годов³⁰. В совокупности эти показатели предложения указывают на рост производства метамфетамина в регионе. С тех пор поставщики из «Золотого треугольника» и Юго-Восточной Азии в целом продолжали расширять производство других синтетических наркотиков, включая МДМА и кетамин^{31, 32}, причем химические вещества, необходимые для производства наркотиков, поставлялись из соседних стран, включая Китай и Индию и, в меньшей степени, Таиланд и Вьетнам³³.

Это привело к значительному увеличению объема изъятий, что свидетельствует о значительном увеличении потоков метамфетамина, а в последнее время и кетамина, поставляемых из «Золотого треугольника» в Юго-Восточную Азию и за ее пределы: по сообщениям, поступающим из стран этого региона (например, Индонезии и Филиппин) и других регионов (например, Австралии, Бангладеш, Индии, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии), с середины 2010-х годов объем изъятий наркотиков, поступающих из «Золотого треугольника» резко увеличился³⁴. В период 2013–2022 годов объем изъятий метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии увеличился почти в четыре раза — с 39 тонн до 150 тонн. За тот же период объем изъятий данного наркотика, ввозимого из стран этого региона, таких как Австралия, Бангладеш, Индия и Новая Зеландия, также значительно увеличился — с 7,2 до 20,4 тонны³⁵.

Стремительный рост изъятий метамфетамина и кетамина отчасти объясняется тем, что производство синтетических наркотиков может быть перенесено и не зависит от географических или временных факторов или сезонных условий, в отличие от наркотиков растительного происхождения³⁶. Данные изъятий, произведенных непосредственно в регионе в период 1998–2022 годов, свидетельствуют о быстром росте объемов изъятий метамфетамина после 2016 года, в то время как объемы изъятий героина оставались сравнительно неизменными.

Анализ отдельных изъятий в радиусе 750 км от эпицентра «Золотого треугольника»³⁷ показывает аналогичную тенденцию к увеличению медианного веса изъятий метамфетамина, который с 2015 по 2023 год вырос почти в 12 раз — с 10 до 120 кг, в то время как медианный вес изъятий героина за этот период снизился — с 12 кг до 8,4 кг. Вместе с тем важно также отметить, что средняя оптовая цена на героин в Таиланде (за 700 г) выросла с примерно 8000 долларов в 2015 году до 11 400 долларов в 2022 году³⁸. С начала XXI века совокупные объемы и число изъятий, связанных с метамфетамином, впервые стали превышать показатели изъятий, связанных с опиумом и героином, что указывает на возможность быстрого масштабирования подпольного изготовления

синтетических наркотиков и потенциальную готовность поставщиков адаптироваться к внешним обстоятельствам и сигналам рынка, несмотря на то, что культивирование опийного мака имеет глубокие исторические корни.

Цена, чистота и другие показатели, связанные с метамфетамином, также указывают на более широкое и разнообразное предложение этого наркотика. В последние годы цены в целом снизились по всему региону, причем наибольшее снижение розничных цен на таблетированный метамфетамин произошло в Мьянме — с примерно 2,50 долл. США за таблетку в 2020 году до примерно 1 долл. США в 2022 году³⁹. Цены на оптовые партии таблеток (например, 2000 таблеток) в Таиланде недавно снизились с примерно 900 долл. США в 2020 году до 350 долл. США в 2022 году. Однако это снижение цен не было связано с колебаниями степени чистоты, которая в целом остается неизменной в регионе^{40, 41}. Увеличение объемов и числа изъятий, снижение цен и неизменная чистота указывают на устойчивый рост предложения метамфетамина в целом и его доступность на местных наркорынках, на которые практически не оказывают влияния высокие показатели изъятий в регионе⁴².

РИС. 19 Изъятия метамфетамина и кетамина в Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Таиланде, 2013–2022 годы

Methamphetamine seizures (kg)	Изъятия метамфетамина (кг)
140,000	140 000
120,000	120 000
100,000	100 000
80,000	80 000
60,000	60 000
40,000	40 000
20,000	20 000
Ketamine seizures (kg)	Изъятия кетамина (кг)
7,000	7 000
6,000	6 000
5,000	5 000
4,000	4 000
3,000	3 000
2,000	2 000
1,000	1 000
Methamphetamine	Метамфетамин
Ketamine	Кетамин

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу; Азиатско-тихоокеанская информационная сеть по вопросам злоупотребления наркотиками (ДАЙНАП).

РИС. 20 Динамика объемов изъятий героина и метамфетамина в странах и территориях в «Золотом треугольнике» и вокруг него, индексированные по отношению к 2010 году, 1998–2021 годы

Indexed to 2010	Индексированные показатели по отношению к 2010 году
Heroin	Героин

Methamphetamine	Метамфетамин
Opium	Опий

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

Примечание: данные относятся к Вьетнаму, Гонконгу (Китай), Камбодже, китайской провинции Тайвань, Китаю, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии, Макао (Китай), Мьянме и Таиланду. Данные за 2022 год по всем странам и территориям являются неполными.

РИС. 21 Тенденции в распределении объемов отдельных изъятий героина и метамфетамина в радиусе 750 км от эпицентра трехгранного района, 2010–2023 годы

Kilograms (log-scaled)	Килограммы (логарифмическая шкала)
Heroin	Героин
Methamphetamine	Метамфетамин

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

Примечание: без учета изъятий розничных партий объемом не более 50 г.

Криминалистический анализ изъятий метамфетамина, произведенных в последние годы в Таиланде, свидетельствует об увеличении доли исходных материалов на основе Ф-2-П (включая не только Ф-2-П, но и различные родственные химические вещества, некоторые из которых не находятся под контролем), что говорит о большей изощренности и разнообразии средств производства⁴³. В совокупности относительная стабильность чистоты и снижение цен в сочетании с растущей долей маркировки на упаковках или «брендов» указывают на то, что на рынок может выйти больше производителей. Эти изменения усугубились после прихода к власти военных в Мьянме, что вызвало кризис управления на значительной части страны, которая традиционно является основным источником подпольного изготовления метамфетамина в регионе.

С точки зрения географии, производство наркотиков в «Золотом треугольнике» в основном сосредоточено в штате Шан, судя по частоте изъятий в этом штате. В отличие от культивирования опийного мака, масштабы которого можно оценить по спутниковым снимкам, надежных данных для количественной оценки масштабов производства синтетических наркотиков не существует. Проблемы, связанные с качеством данных, более ярко выражены в штате Шан, чем в других районах «Золотого треугольника», поскольку значительные участки территории находятся под фактическим контролем вооруженных групп. Вместе с тем в районе «Золотого треугольника» был обнаружен ряд подпольных лабораторий по изготовлению метамфетамина, в том числе крупные цеха по изготовлению таблеток в южной части штата Шан и в провинции Бокео в Лаосской Народно-Демократической Республике у границы с Таиландом⁴⁴. Эти события свидетельствуют о сосредоточении производства метамфетамина в «Золотом треугольнике». Эта тенденция распространилась и на другие синтетические наркотики. Например, объем изъятий кетамина в Мьянме в период 2021–2022 годов увеличился более чем в три раза — с 762 кг до 2329 кг; судя по сообщениям из Лаосской Народно-Демократической Республики и Таиланда, также увеличились объемы кетамина, поступающего из Мьянмы⁴⁵.

РИС. 22 Доля проб кристаллического метамфетамина, проанализированных в Таиланде, в разбивке по основным прекурсoram, 2017–2022 годы

Proportion (per cent)	Доля (процент)
37.3	37,3
15.5	15,5

47.2	47,2
35.5	35,5
20.4	20,4
44.1	44,1
45.2	45,2
30.2	30,2
24.6	24,6
49.4	49,4
27.2	27,2
23.4	23,4
48.4	48,4
22.1	22,1
29.5	29,5
30.9	30,9
40.9	40,9
28.2	28,2
Ephedrine/pseudoephedrine-based methods	Методы на основе эфедрина/псевдоэфедрина
P-2-P-based methods	Методы на основе Ф-2-П
Unknown	Сведения отсутствуют

Источник: КККН Таиланда.

КАРТА 8 Частота изъятий метамфетамина в «Золотом треугольнике», 2020–2023 годы

INDIA	ИНДИЯ
MYANMAR	МЬЯНМА
CHINA	КИТАЙ
VIET NAM	ВЬЕТНАМ
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
THAILAND	ТАИЛАНД
<i>S.R.1</i>	<i>OP1</i>
<i>S.R.2</i>	<i>OP2</i>
<i>S.R.4</i>	<i>OP4</i>
Methamphetamine seizures	Частота изъятий метамфетамина
Low	Низкая
High	Высокая
International boundaries	Международные границы
Golden Triangle	«Золотой треугольник»
Shan State	Штат Шан
Special Regions	Особые районы

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

Примечание: показатели частоты изъятий метамфетамина основаны на данных наблюдений за случаями изъятий, представленных на Платформе мониторинга наркотиков УНП ООН. Это характерные районы, где наиболее часто производятся изъятия наркотиков.

За последние несколько лет также увеличилась частота и объем изъятий метамфетамина на севере Лаосской Народно-Демократической Республики, неподалеку от эпицентра трехграничного района, что свидетельствует о сдвиге в операциях по незаконному обороту и указывает на географическую взаимосвязь между сетями наркоторговцев в регионе⁴⁶. Судя по карте отдельных изъятий, число изъятий метамфетамина резко возросло в эпицентре трехграничного района в период 2021–2023 годов, то есть примерно после захвата власти военными в Мьянме в феврале 2021 года, а также о распространении этой тенденции на северные районы Лаосской Народно-Демократической Республики вблизи границы с Таиландом.

Начиная с 2021 года расчетные показатели УНП ООН в отношении культивирования опийного мака, основанные на данных спутниковой съемки, и производства опия, подтвержденные данными наблюдений на местах, в «Золотом треугольнике» ежегодно растут, главным образом за счет увеличения в штате Шан, на который в 2023 году, по оценкам, приходилось 87 процентов площади культивирования и 83 процента урожая опийного мака по всей стране⁴⁷. Наблюдаемый в последние годы в Мьянме рост производства опия в основном обусловлен увеличением урожайности опийного мака. Площадь культивирования увеличилась незначительно, что говорит о переходе фермеров от преимущественно экстенсивных к более передовым интенсивным методам культивирования, таким как загущение посевов, использование ирригационных систем и внесение удобрений⁴⁸. За счет этого урожайность опийного мака с гектара в Мьянме увеличилась, по оценкам УНП ООН, с 14 кг в 2020 году до почти 23 кг в 2023 году, что является рекордным показателем с момента начала наблюдений за урожайностью в 2002 году. Этот рост был наиболее заметным в восточных районах штата Шан, где только с 2022 по 2023 год урожайность увеличилась на 58 процентов⁴⁹. Использование более сложных средств и методов производства может привести к более тесной координации действий вооруженных и преступных групп, стремящихся получить больший доход⁵⁰. Трудно определить, каким образом захват власти военными в 2021 году сказался на производстве наркотиков в штате Шан, где наблюдается рост нескольких показателей как в отношении культивирования мака, так и производства опия.

Хотя опийный мак культивируется в Лаосской Народно-Демократической Республике, на ее долю приходится незначительная часть площади незаконного культивирования этого растения в регионе⁵¹. Наиболее продуктивные районы культивирования мака и производства опия в стране находятся в «Золотом треугольнике», а именно в северных провинциях, граничащих с Китаем и Мьянмой, главным образом в провинции Пхонгсали, которая издавна является важным центром заготовки опийного мака в стране⁵².

Пространственный анализ отдельных изъятий⁵³ свидетельствует о наличии убывающей связи между расстоянием от эпицентра трехграничного района и весом изъятий, что еще раз подтверждает важность «Золотого треугольника» для производства и незаконного оборота наркотиков. Эта связь значима даже с учетом сезонных колебаний.

КАРТА 9 Частота изъятий героина и посевов опийного мака, 2020–2023 годы

2020–2021	2020–2021 годы
INDIA	ИНДИЯ
MYANMAR	МЬЯНМА
CHINA	КИТАЙ
VIET NAM	ВЬЕТНАМ
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
THAILAND	ТАИЛАНД
S.R.1	ОР1
S.R.2	ОР2
S.R.4	ОР4
2020–2023	2020–2023 годы
INDIA	ИНДИЯ
MYANMAR	МЬЯНМА
CHINA	КИТАЙ
VIET NAM	ВЬЕТНАМ
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
THAILAND	ТАИЛАНД
S.R.1	ОР1
S.R.2	ОР2
S.R.4	ОР4
Heroin seizures	Частота изъятий героина
Low	Низкая
High	Высокая
Poppy density Myanmar	Плотность посевов опийного мака в Мьянме
Low	Низкая
High	Высокая
International boundaries	Международные границы
Golden Triangle	«Золотой треугольник»
Shan State	Штат Шан
Special Regions	Особые районы

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источники: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков; и УНП ООН, Программа мониторинга запрещенных культур.

Примечание: показатели частоты изъятий героина основаны на данных наблюдений за случаями изъятий, представленных на Платформе мониторинга наркотиков УНП ООН. Это характерные районы, где наиболее часто производятся изъятия наркотиков. УНП ООН не проводит наблюдения за урожайностью в особых районах штата Шан.

РИС. 23 Снижение веса изъятых наркотиков по мере удаленности от эпицентра трехграничного района, 2010–2023 годы

Kilograms (log–scale)	Килограммы (логарифмическая шкала)
Distance (km) from the tri–border epicentre	Расстояние от эпицентра трехграничного района (км)

Heroin	Героин
Methamphetamine	Метамфетамин

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков. *Примечание: без учета изъятий розничных партий объемом не более 50 г.*

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА

Изменения в наркоэкономике Мьянмы после военного переворота в 2021 году

Исторически сложилось так, что многие участники конфликтов, включая как государственные, так и негосударственные структуры, получали доход от сборов с незаконного изготовления наркотиков и торговли ими или непосредственно от доходов от их продажи^a. Это относится и к внутреннему конфликту в Мьянме, который еще больше обострился после прихода к власти военных в феврале 2021 года. Согласно оценкам, по состоянию на декабрь 2023 года 2,3 миллиона человек (или около 4 процентов населения страны) были перемещены в результате столкновений и отсутствия безопасности вследствие переворота^b. Производство опия в стране после переворота, особенно в части урожайности опийного мака, возросло. По оценкам, в 2023 году в Мьянме было произведено 1080 тонн опия, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия^c. Рост наблюдался в районах, неподконтрольных центральным властям, в основном в штате Шан.

Еще одно заметным изменением является появление все большего числа различных «брендов» таблеток метамфетамина, изготавливаемых в «Золотом треугольнике». В 2020 году на два основных бренда, которые, как известно, изготавливаются вооруженными группами в Мьянме, приходилось более 96 процентов всех случаев изъятия в Таиланде. К 2022 году эта доля снизилась до 6 из 10 случаев изъятия, а доля «других» брендов выросла с чуть менее 3 процентов в 2020 году до более 25 процентов в 2022 году, что свидетельствует об увеличении разнообразия поставщиков после военного переворота в Мьянме^d.

Недавнее обострение конфликта в Мьянме могло привести к приостановке и перемещению операций правоохранительных органов или незаконного оборота наркотиков в стране. 27 октября 2023 года несколько действующих в стране вооруженных групп начали совместную военную кампанию против мьянманских военных властей и их союзников в нескольких районах, в том числе на севере штата Шан. В ходе этой кампании, известной как «Операция 1027», с момента ее начала до конца 2023 года произошло более 600 различных вооруженных столкновений и взрывов в северной части штата Шан^{e, f}. Здесь базируются многие из сформировавшихся вооруженных групп и, по-видимому, расположены крупные производства наркотиков, для которых характерно кластерное размещение^{g, h}. Тем не менее за тот же период поступило лишь одно сообщение об изъятии наркотиков в северной части штата Шан, в ходе которого было изъято менее 30 000 таблеток метамфетаминаⁱ. За тот же период 2020 года, в течение которого произошло значительно меньше вооруженных столкновений, напротив, в этом районе был зафиксирован 41 случай изъятия наркотиков или связанных с ними химических веществⁱ.

Пока преждевременно судить о том, как конфликт на местах скажется на незаконном обороте наркотиков в будущем, поскольку это может зависеть от исхода внутреннего конфликта в стране.

^a Svante E. Cornell, “The Interaction of Narcotics and Conflict”, *Journal of Peace Research* 42, no. 6 (2005): 751–60.

^b UNOCHA, “Myanmar Humanitarian Update No. 35 | 2023 Year in Review”, January 12, 2024.

^c UNODC, “Southeast Asia Opium Survey 2023”, 2023.

^d UNODC, “Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges”, 2023.

^e Communications ACLED, “Myanmar: Momentum from Operation 1027 Threatens Military Rule”, *ACLED* (blog), February 1, 2024.

^f ACLED, “Conflict Watchlist 2024 | Myanmar: Resistance to the Military Junta Gains Momentum”, *ACLED* (blog), January 17, 2024. Размещено по адресу: <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2024/myanmar/>.

- ^g Например в начале 2018 года в волости Куткай на севере штата Шан был проведен ряд правоохранительных операций, в ходе которых было изъято около 193 миллионов таблеток и 500 кг кристаллического метамфетамина, а также лабораторное оборудование.
- ^h ACLED, “Conflict Watchlist 2024 | Myanmar: Resistance to the Military Junta Gains Momentum”, *ACLED* (blog), January 17, 2024. Размещено по адресу: <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2024/myanmar/>.
- ⁱ Например в начале 2018 года в волости Куткай на севере штата Шан был проведен ряд правоохранительных операций, в ходе которых было изъято около 193 миллионов таблеток и 500 кг кристаллического метамфетамина, а также лабораторное оборудование.

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Слияние с другими видами преступной деятельности

Включение в другие виды преступной деятельности и проникновение на другие незаконные рынки

Как правило, преступные организации и вооруженные группы способны вступать во взаимовыгодные отношения, в рамках которых они полагаются друг на друга и на свои частично совпадающие политические и экономические цели, связанные с незаконной экономикой⁵⁴. Порой эти цели также совпадают с целями военного правительства Мьянмы, которое традиционно использовало военизированные группы для укрепления национальной безопасности в своей борьбе против этнических повстанческих организаций и содействия в государственном строительстве в отдаленных районах, делегируя им соответствующие полномочия. В обмен на это вооруженным группам зачастую разрешается заниматься различными видами незаконной деятельности при условии, что они будут подчиняться требованиям правительства, когда к ним обращаются^{55, 56, 57}.

Начиная с 1990-х годов вооруженные группы и преступные организации начали изменять стратегии в направлении диверсификации источников доходов. Помимо изготовления различных синтетических наркотиков, в середине 2000-х годов вооруженные группы начали заниматься нелегальной или нерегулируемой добычей природных ресурсов и агробизнесом в целях получения дохода и приобретения земель стратегической значимости^{58, 59, 60}. Примером связи между вооруженными группами, имеющими заявленную политическую цель или идеологию, и преступными группами, не имеющими какой-либо политической ориентации, в «Золотом треугольнике» является казино «Кингз Романз», расположенное в ОЭЗ «Золотой треугольник» на северо-западе Лаосской Народно-Демократической Республики на берегу реки Меконг. Группа, владеющая ОЭЗ «Золотой треугольник», имеет тесные связи с влиятельными вооруженными группами в Мьянме, включая ОАОВ и АНДА, основанные на общих деловых интересах, и, по сообщениям, занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, незаконным оборотом объектов дикой природы, отмыванием денег и подкупом⁶¹.

Участие преступных организаций и вооруженных групп в незаконной добыче ресурсов усилилось в 2000-х годах по мере расширения трансграничных рынков и инфраструктуры. Некоторые вооруженные группы, занимающиеся масштабными лесозаготовками в приграничных районах штата Шан в Мьянме, превратились, по сути, в предпринимательские структуры с армиями⁶². Другие виды деятельности по добыче ресурсов, в частности добыча нефрита, рубинов, золота и редкоземельных металлов, также стали важнейшим источником дохода для наиболее известных вооруженных групп и преступных организаций, которые обладали капиталом и политическим влиянием для получения концессий на добычу полезных ископаемых. Например группа, ранее известная как Новая демократическая армия Качина, или НДА-К, в особом районе 1 в штате Качин на границе с провинцией Юньнань поставяет китайским покупателям большое количество редкоземельных элементов; есть также сообщения о том, что эта группа занимается лесозаготовками и добычей нефрита⁶³.

Находящиеся под угрозой исчезновения виды, численность которых уменьшается во всем мире, все чаще привлекают внимание организованных преступных групп, занимающихся наряду с традиционной контрабандой диверсификацией своей деятельности за счет участия в таком весьма

прибыльном бизнесе, как незаконный оборот объектов дикой природы; такие случаи все чаще отмечаются в «Золотом треугольнике». Здесь было произведено несколько крупных и беспрецедентных изъятий объектов живой природы или их дериватов, в том числе находящихся под угрозой исчезновения животных из Африки⁶⁴. Объем и масштабы таких изъятий указывают на изощренность деятельности организованных преступных групп, способных доставлять значительные партии продуктов дикой природы из Африки вглубь «Золотого треугольника», где они конфискуются на пути к другим рынкам Азии.

Исследования показывают, что большинство преступных групп высокого уровня в «Золотом треугольнике» скорее занимаются контрабандой ценных объектов дикой природы, таких как исчезающие виды из Африки, нежели браконьерством или распределением среди конечных покупателей^{65, 66}. Данные изъятий объектов дикой природы, содержащие сведения о стране происхождения, свидетельствуют о том, что большинство изъятых объектов дикой природы поступает из Азии, за которой следует Африка.

Браконьерской добычей и транспортировкой местных диких животных и растений занимаются, как правило, более мелкие местные преступные группы или индивидуальные предприниматели на условиях подряда с действующими по всему региону транснациональными преступными организациями⁶⁷. Взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков и объектов дикой природы не столь прямолинейна и тесна. Одни и те же преступные группы или лица могут заниматься отдельно незаконным оборотом наркотиков и объектов дикой природы в одних и тех же или схожих местах, однако эта взаимосвязь, по всей видимости, имеет скорее конъюнктурный характер. Незаконный оборот объектов дикой природы, судя по всему, не вытесняет незаконный оборот наркотиков в «Золотом треугольнике», но его наличие свидетельствует о диверсификации деятельности, в рамках которой порой используются стратегии и тактика, применяемые в области незаконного оборота наркотиков. Такая тактика предполагает использование одних и тех же пограничных переходов или маршрутов провоза контрабанды⁶⁸. Тем не менее, для некоторых криминальных структур в отдельных случаях переход к незаконному обороту объектов дикой природы может быть стратегией снижения рисков ареста и судебного преследования в связи с участием в наркоэкономике, учитывая устойчивый спрос на продукты дикой природы в регионе и сосредоточенность правоохранительных органов на борьбе с наркотиками, которые могут порой не обращать внимание на поставки дериватов животных⁶⁹.

В других случаях преступные группы, по сообщениям, сотрудничают с государственными чиновниками или вооруженными группами и торговцами по всему региону. Согласно исследованиям, в ходе которых были опрошены участники незаконного оборота объектов дикой природы, между транснациональными преступными группировками, действующими в регионе, и лидерами вооруженных групп на севере Мьянмы, по-видимому, существует взаимная связь. Например, что касается незаконного оборота продуктов дикой природы и незаконной торговли ими, вооруженные группировки облагают налогом крупные партии продуктов дикой природы, контрабандой ввозимые в Китай, взимая плату с местных жителей, занимающихся браконьерством или контрабандой других дорогостоящих продуктов дикой природы, поставляемых из других регионов, например бивней африканских слонов или рогов носорогов⁷⁰.

РИС. 24 Распределение изъятий млекопитающих, произведенных в «Золотом треугольнике», в разбивке по регионам происхождения животных, 2006–2022 годы

Bear	Медведи
Deer	Олени
Elephant	Слоны
Large cat	Большие кошки
Pangolin	Панголины
Rhinoceros	Носороги

Other mammal	Другие млекопитающие
Percentage	Процентная доля
Africa	Африка
Asia	Азия
Other	Другие регионы
Unknown	Сведения отсутствуют

Источник: база данных WISE CITEC.

Примечание: изъятия в радиусе 750 км от эпицентра трехграничного района.

Слияние на географическом уровне

География мест производства наркотиков, таких как героин и метамфетамин, в «Золотом треугольнике» в значительной степени совпадает с географией мест их контрабанды. Это наиболее заметно на территориях, находящихся под контролем вооруженных групп в штате Шан, но также справедливо в отношении других приграничных городов и ОЭЗ. Ряд вооруженных групп прямо или косвенно занимаются деятельностью в сфере незаконной наркоэкономики, которую они осуществляют на контролируемых территориях благодаря относительной самостоятельности в плане своей экономической деятельности⁷¹. Аналогичным образом осуществляется торговля другими контрабандными товарами в некоторых частях «Золотого треугольника» с ограниченным присутствием национального правительства. Многие из этих территорий примыкают к национальным границам, что обеспечивает стратегические преимущества. Прежде всего, наркоторговцы могут избежать ареста, пересекая эти границы через нелегальные пограничные переходы. Некоторые приграничные города, особенно те, в которых расположены ОЭЗ, обладают развитой транспортной и логистической инфраструктурой, обслуживающей основные региональные транспортные маршруты, включая речные порты, аэропорты и автомагистрали. В региональном плане близость «Золотого треугольника» к крупным производителям химических веществ обеспечивает наркоторговцам доступ ко многим необходимым материалам, таким как химические вещества — прекурсоры^{72, 73}. Кроме того, приграничные регионы расположены вблизи конечных рынков сбыта наркотиков, продуктов дикой природы и добываемых ресурсов. То есть в Юго-Восточной Азии существует мощный внутренний региональный рынок наркотиков, резко отличающийся от гораздо более удаленных крупных рынков, на которые поступает, например, кокаин из Америки.

Группы, занимающиеся незаконным оборотом, также иногда имеют доступ к государственной инфраструктуре и торговым маршрутам, что облегчает контрабанду различных незаконных товаров или торговлю ими⁷⁴. Существуют опасения, что инфраструктурные проекты, финансируемые за счет незаконных доходов преступных организаций или национальными правительствами, могут способствовать дальнейшей активизации незаконной экономики за счет улучшения сообщения и торговли. Например известно, что находящаяся в частной собственности и управлении ОЭЗ «Золотой треугольник» была создана за счет средств, полученных от незаконного оборота наркотиков⁷⁵. В этой зоне продолжается реинвестирование в крупные инфраструктурные проекты, включая строительство автомобильных путей сообщения и аэропорта, способного принимать большие коммерческие пассажирские самолеты. Несколько других ОЭЗ и приграничных промышленных зон расположены либо внутри территорий, находящихся под контролем вооруженных групп в штатах Качин, Шан и Ракхайн, в которых важную роль играют вооруженные конфликты, транснациональная преступность и незаконная экономика, либо их пересекают⁷⁶.

В географическом плане незаконная наркоэкономика региона во многом совпадает с другими видами незаконной экономики, управляемой вооруженными и транснациональными преступными группами, с точки зрения способов и направлений деятельности. Хотя большинство видов незаконной экономической деятельности осуществляется на территориях, находящихся под контролем вооруженных групп, в некоторых случаях добыча ресурсов ведется и в других местах.

Например разработка ресурсной концессии предусматривает строительство дорог вглубь лесов, что порой приводит к расширению доступа к ресурсам дикой природы, являющимся предметом браконьерства и незаконного оборота, а также позволяет возделывать поля опийного мака в еще менее доступных для властей районах⁷⁷. В Лаосской Народно-Демократической Республике примерно 44 процента обнаруженных участков мака находились на территории охраняемых районов и заповедников или в радиусе 10 км от них⁷⁸, что свидетельствует об использовании отдаленных районов для сокрытия незаконной деятельности.

Судя по данным о незаконной торговле объектами дикой природы, продукты, изготовленные из дериватов ценных видов животных, таких как медведи и слоны, чаще всего встречаются вблизи трехграничного района в центре «Золотого треугольника» и вдоль границы с южной китайской провинцией Юньнань. Некоторые из этих продуктов, такие как медвежья желчь, части туш и бивни слонов, могут быть направлены на удовлетворение различных потребностей внутри региона^{79, 80}. В целом это совпадает с приведенными справочными данными, за исключением случаев изъятия больших кошек и их дериватов, включая тигров, которые, по сообщениям, часто становятся предметом незаконного оборота в ОЭЗ «Золотой треугольник» и за ее пределами⁸¹.

КАРТА 10 Частота изъятий объектов дикой природы, включающих дериваты медведей, 2006–2022 годы

INDIA	ИНДИЯ
MYANMAR	МЬЯНМА
CHINA	КИТАЙ
VIET NAM	ВЬЕТНАМ
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
THAILAND	ТАИЛАНД
S.R.1	OP1
S.R.2	OP2
S.R.4	OP4
Concentration of bear seizure events	Частота изъятий дериватов медведей
Low	Низкая
High	Высокая
International boundaries	Международные границы
Golden Triangle	«Золотой треугольник»
Shan State	Штат Шан
Special Regions	Особые районы

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: база данных WISE CITEC.

КАРТА 11 Частота изъятий объектов дикой природы, включающих дериваты слонов, 2006–2022 годы

INDIA	ИНДИЯ
MYANMAR	МЬЯНМА
CHINA	КИТАЙ
VIET NAM	ВЬЕТНАМ
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
THAILAND	ТАИЛАНД
S.R.1	OP1
S.R.2	OP2
S.R.4	OP4
Concentration of elephant seizure events	Частота изъятий дериватов слонов
Low	Низкая
High	Высокая
International boundaries	Международные границы
Golden Triangle	«Золотой треугольник»
Shan State	Штат Шан
Special Regions	Особые районы

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: база данных WISE CITEC.

Воздействие на общины и окружающую среду

Наркоэкономика и диверсификация деятельности вооруженных и преступных групп за счет участия в других секторах незаконной экономики в «Золотом треугольнике» усилили роль транснациональных преступных сетей и вооруженных групп в региональной экономике, что в некоторых случаях привело непосредственно к ухудшению ситуации в плане безопасности и здоровья людей, а также к дестабилизации общин. Внутренний конфликт в Мьянме затягивает общины в порочный круг нищеты и способствует незаконному производству наркотиков или причиняющей вред добыче ресурсов. В некоторых частях региона преступные группы нередко привлекают на свою сторону или захватывают часть государственного аппарата путем принуждения, коррупции или насилия^{82, 83}.

В некоторых случаях, как, например, в Мьянме, существует более тесная и прямая связь между незаконной экономикой и конфликтом. Длющиеся в стране десятилетиями боевые действия между вооруженными группами и против военных привели к массовому перемещению населения. Беженцы, страдающие от повальной нищеты и подвергающиеся повышенному риску стать жертвами вооруженных групп и преступных организаций, зачастую вынуждены заниматься добычей ресурсов или выращивать опиный мак, чтобы просто прокормиться^{84, 85}. В некотором смысле культивирование мака создает экономическую зависимость между сельскими общинами и вооруженными группировками, которые предоставляют «право» на выращивание мака, зачастую за плату, и иногда связывают фермеров с торговцами опием, предоставляющими им ростовщические кредиты, еще больше загоняя их в долги⁸⁶. По сообщениям, загнанные в долговую яму сельские домохозяйства, занимающиеся культивированием мака в штате Шан, вынуждены и далее выращивать эту культуру^{87, 88, 89}.

Проблема наркотиков, особенно наркопотребление, негативно сказалась и на других аспектах жизни сельских общин^{90, 91}. Употребление метамфетамина в отдаленных районах Мьянмы связано

с близостью к местам производства наркотиков⁹². По сообщениям, рабочие иногда употребляют этот стимулятор, чтобы увеличить добычу ресурсов за счет более продолжительного рабочего дня. Его употребление также связано с другими формами эксплуатации, такими как проституция^{93, 94}. В свою очередь, это связано с другими видами вреда, включая передачу инфекционных заболеваний⁹⁵. В ходе проведенных УНП ООН обследований домохозяйств, занимающихся культивированием мака в штате Шан, было установлено, что показатели потребления наркотиков, особенно опия и героина, в этих домохозяйствах выше, чем в домохозяйствах штата Шан, не занимающимися культивированием мака, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между наркопотреблением и близостью к местам их производства⁹⁶.

Вооруженные группы в Мьянме все чаще прибегают к различным видам экономической деятельности, включая добычу ресурсов, для финансирования своих действий⁹⁷. Места интенсивной добычи природных ресурсов одновременно являются эпицентрами наркопотребления. В лагерях по добыче полезных ископаемых и лесозаготовке в рамках культуры быстрорастущих поселений и из-за продолжительного рабочего дня, изнурительных условий труда и конечного получаемого дохода среди мигрантов формируется повышенный спрос на контролируемые наркотики⁹⁸. Наркопотребление и наркомания зачастую выходят за пределы лагерных поселений, что приводит к продаже и употреблению наркотиков в близлежащих деревнях и городах, а также к передаче заболеваний, в частности ВИЧ и вируса гепатита С^{99, 100}.

Рост незаконной или нерегламентированной добычи ресурсов и культивирования наркотикосодержащих растений зачастую связан с конфликтами. Давно известно о том, что экономические концессии, предоставляемые вооруженным группам, и другие крупномасштабные мероприятия в области развития связаны с насильственным перемещением местных общин¹⁰¹. В некоторых случаях сельские жители переселяются в близлежащие деревни, где у них мало возможностей для получения средств к существованию, связанных с сельским хозяйством или другими секторами. Жители деревень, перемещенные в соответствии с концессионными договорами или погрязшие в долгах из-за выращивания товарных культур, используют различные механизмы преодоления трудностей. Миграция в поисках работы по найму в сельском хозяйстве или неофициальном секторе добычи ресурсов, в данном случае — кустарной добычи нефрита и золота и лесозаготовки, является популярной стратегией среди молодых мужчин — членов домохозяйств. Однако в других случаях жители деревень, расположенных вблизи районов производства опия, прибегают к культивированию опийного мака как к одному из последних возможных вариантов получения средств к существованию^{102, 103}. Этот вариант становится все более привлекательным вследствие совершенствования инфраструктуры и расширения доступа к районам культивирования опийного мака, в том числе за счет добычи ресурсов¹⁰⁴.

Вследствие нехватки альтернативных источников средств к существованию, отсутствия надежного государственного управления, а также защиты и безопасности члены сельских общин могут подвергаться большому риску стать жертвами торговли людьми, выполнять опасные работы в шахтах и на лесозаготовках, заниматься браконьерством и контрабандой наркотиков под руководством преступных групп. Конфликт в Мьянме связан с увеличением численности перемещенных лиц и жертв торговли людьми в регионе, вынужденных заниматься в том числе самыми разными и все более разнообразными видами неправомерной или незаконной деятельности, включая работу в центрах онлайн-мошенничества¹⁰⁵.

Помимо этих негативных последствий для общин, окружающей среде также наносится ущерб, связанный с наркоэкономикой и диверсификацией других незаконных или нерегламентируемых видов деятельности. В частности, окружающей среде причиняется вред вследствие сброса химических веществ, используемых при производстве наркотиков. Кроме того, осуществляемая наркоторговцами диверсификация путем освоения других видов деятельности, таких как незаконный оборот объектов дикой природы или браконьерство, может иметь серьезные и прямые негативные последствия для исчезающих видов. В основном это касается животных из региона, однако небольшая доля изъятий приходится на части туш слонов и носорогов из Африки. Нерегламентируемая добыча полезных ископаемых также наносит вред местным экосистемам

вследствие выброса токсичных химических веществ в окружающую среду, что негативно сказывается на местных общинах^{106, 107}.

РИС. 25 Распределение участков культивирования опийного мака по степени обезлесения с 2000 года (процент от площади)

Lao People's Democratic Republic	Лаосская Народно-Демократическая Республика
5%	5%
4%	4%
91%	91%
Myanmar	Мьянма
10%	10%
8%	8%
82%	82%
Transition to poppy within three years of deforestation	Переход к культивированию опийного мака в течение трех лет после вырубке леса
Transition to poppy in areas felled in three or more years	Переход к культивированию опийного мака в районах вырубке леса в течение трех или более лет
Poppy outside of forest	Культивирование опийного мака на нелесных землях

Источник: анализ УНП ООН на основе данных из Глобальной базы данных об изменении лесного покрова и данных обследования по вопросам опия, приведенных в публикации M. C. Hansen et al., "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change", Science 342, No. 6160 (November 15, 2013): 850–53.

Культивирование опийного мака в районе «Золотого треугольника» зачастую осуществляется на уже расчищенных участках или на участках, которые использовались для другой сельскохозяйственной деятельности. Что касается Лаосской Народно-Демократической Республики, то около 9 процентов участков культивирования мака, обнаруженных с 2000 года, были расположены на обезлесенных территориях, а остальные участки — на территориях, которые использовались в других сельскохозяйственных целях. С 2000 года в Мьянме эта доля увеличилась почти в два раза — до 18 процентов, причем большая часть обезлесенных земель в стране приходится на штат Шан^{108, 109}. Культивирование мака сосредоточено на относительно небольших территориях и, по-видимому, не является основным фактором обезлесения в обеих странах, однако более половины участков, где для культивирования мака потребовалась рубка лесов, были расчищены менее чем за три года до посева опийного мака, что позволяет предположить наличие связи между обезлесением и появлением новых участков. В течение последних двух десятилетий в Мьянме были вырублены обширные лесные угодья, а расчистка земель осуществлялась в основном в целях сельскохозяйственного использования и добычи полезных ископаемых¹¹⁰. Увеличение площади обезлесения может привести к тому, что освободится много земли для новых посевов мака. Тенденция к интенсификации культивирования опийного мака за счет более широкого применения удобрений и пестицидов также может нанести вред окружающей среде и здоровью лиц, непосредственно занимающихся применением и хранением химических веществ¹¹¹.

Однако воздействие производства и изготовления наркотиков на окружающую среду выходит за рамки рубки лесов или расчистки земель под запрещенные культуры. Так, о масштабах воздействия подпольного производства синтетических наркотиков на окружающую среду известно не слишком много, но эта деятельность приводит к образованию большого количества опасных отходов. Маловероятно, что отходы утилизируются должным образом; скорее всего, их выбрасывают или сбрасывают в окружающую среду. По данному региону отсутствуют систематические исследования по оценке воздействия подпольного производства синтетических

наркотиков на окружающую среду. Вместе с тем, судя по оценкам объема отходов, образующихся при производстве метамфетамина в других регионах, объемы отходов и побочных продуктов, скорее всего, велики.

Согласно имеющимся справочным данным, на каждый килограмм готового продукта приходится порядка 5–10 кг токсичных отходов при использовании наиболее распространенных способов синтеза и прекурсоров (как правило, на основе эфедринов и Ф-2-П)¹¹². В состав отходов входят побочные продукты, катализаторы, прекурсоры и другие растворители. Если предположить, что такие химические вещества не перерабатываются и не используются повторно, то в 2022 году при изготовлении 83 тонн «ябы» и 68 тонн кристаллического метамфетамина, которые были изъяты в Восточной и Юго-Восточной Азии за этот год, могло образоваться около 365–729 тонн отходов, с учетом того, что, по данным последних изъятий, средняя степень чистоты для таблеток составляет 15 процентов, а для кристаллического метамфетамина — 90 процентов¹¹³. Учитывая существование, несомненно, большого количества неизъятых метамфетамина, попадающего на рынок, фактический объем токсичных отходов, образующихся в «Золотом треугольнике» в результате его производства, скорее всего, превышает расчетные показатели, основанные только на данных изъятий. По последним оценкам, годовой объем потребления метамфетамина в ближайших и соседних регионах¹¹⁴, который, вероятно, поступает из «Золотого треугольника», составляет почти 308 чистых метрических тонн^{115, 116}. При изготовлении такого количества продукции образуется 1500–3100 метрических тонн отходов и побочных продуктов. Если взять средние данные по изъятиям за последние пять лет и прибавить их к объему потребления, исчисленному на основе последних оценочных данных, то объем химических отходов, образующихся при производстве метамфетамина, в «Золотом треугольнике» может составлять от 1900 до 3800 тонн в год¹¹⁷.

Некоторые химические вещества, используемые при изготовлении метамфетамина, могут нанести вред окружающей среде, особенно в непосредственной близости от места производства, а также окружающей среде в других местах в случае их сброса в водотоки или сжигания. Изготовление метамфетамина не регламентируется никакими нормативными положениями и осуществляется без соблюдения каких-либо мер безопасности в силу его неофициального характера. Причиняемый окружающей среде вред может быть кратковременным или постоянным, также являясь источником дополнительного косвенного воздействия. Например, подкисление почвы в результате вымывания химических веществ может привести к гибели растительности, что приведет к эрозии почвы и повышению риска оползней. Сброс отходов в водотоки может привести к загрязнению питьевой воды, воды для купания и систем орошения сельскохозяйственных культур, а также к биоаккумуляции в пищевой цепи¹¹⁸.

Документально подтверждено, что подпольное изготовление метамфетамина, например в некоторых районах Мексики¹¹⁹ и в других регионах мира¹²⁰, наносит прямой и непосредственный вред окружающей среде, в частности в виде загрязнения местных водотоков и эрозии почвы. УНП ООН не смогло документально подтвердить прямое воздействие на окружающую среду ненадлежащей утилизации химических веществ, используемых при подпольном изготовлении метамфетамина в «Золотом треугольнике», что неудивительно, учитывая недостаточную информированность об изготовлении метамфетамина в регионе, особенно в штате Шан¹²¹. Маловероятно, что при изготовлении синтетических наркотиков незаконные группы утилизируют отходы экологически безопасными способами, и обнаружение такого вреда может стать лишь вопросом времени. По данным отделений УНП ООН на местах, безопасная утилизация изъятых химических веществ по-прежнему является проблемой, поскольку власти не всегда располагают надлежащим оборудованием и подготовкой, необходимыми для безопасной утилизации химических веществ, которые могут нанести вред окружающей среде. Например, только в 2022 году в ходе скоординированной операции по борьбе с наркотиками на нескольких объектах в Камбодже было изъято около 277 тонн химических веществ и соединений, используемых при незаконном изготовлении кетамина¹²². Надлежащая утилизация больших объемов химических веществ, в том числе летучих, может занять годы и оставляет возможность их утечки на незаконные рынки или загрязнения местной окружающей среды в результате неправильного обращения или хранения.

РИС. 26 Расчетный объем химических отходов, образующихся в «Золотом треугольнике», по отношению к объему изъятий метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии, 2010–2022 годы

Tons	Тонны
------	-------

Источник: ДАЙНАП.

Примечание: предполагается, что средняя степень чистоты таблеток составляет 15 процентов, а кристаллического метамфетамина — 90 процентов. Приведенные на диаграмме значения верхних и нижних границ исчислены с учетом поправок на среднюю чистоту по составу и с использованием предполагаемого диапазона отходов в 5–10 кг на 1 кг метамфетамина. Информация о чистоте основана на данных о средних объемах изъятий метамфетамина с поправкой на чистоту в Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Таиланде. К странам региона относятся Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Япония.

Примечания и ссылки

- 1 Martin Booth, *Opium: A History* (St. Martin's Griffin, 2013).
- 2 Gracie Lee, "Chasing the Dragon: The Scourge of Opium," October 1, 2015.
- 3 Booth, *Opium: A History*.
- 4 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact," 2019.
- 5 UNODC, "Southeast Asia Opium Survey 2023", 2023.
- 6 International Crisis Group, "Transnational Crime and Geopolitical Contestation along the Mekong" (Brussels, Belgium, August 18, 2023).
- 7 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact."
- 8 Martin John Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (London: Zed Books, 1999).
- 9 U.S. Department of State, "International Narcotics Control Strategy Report 2000" (Washington, D.C., 2001).
- 10 В настоящем докладе под «вооруженными группами» понимаются различные группы, сформированные по этническому признаку, общим деловым интересам и с учетом других факторов. Эти группы могут быть, а могут и не быть связаны с вооруженными силами Мьянмы. Дополнительную информацию см. во вставке 1.
- 11 John Buchanan, *Militias in Myanmar* (Asia Foundation Yangon, 2016).
- 12 Mathias Bak, *Overview of Corruption and Anti-Corruption in Myanmar* (JSTOR, 2019).
- 13 В октябре 2023 года УНП ООН провело встречу с сотрудниками тайских и иностранных правоохранительных органов, которые работают в Таиланде и отвечают за мониторинг незаконного оборота наркотиков и связанных с ним тенденций в области преступности в «Золотом треугольнике» и соседних с ним районах.
- 14 Booth, *Opium: A History*.
- 15 Buchanan, *Militias in Myanmar*.
- 16 Vanthana Nolintha, "Triangle Area Development: Prospects and Challenges for Lao PDR," *Five Triangle Areas in The Greater Mekong Subregion*, 2012.
- 17 Nucharee Supatn, "Regional Development of the Golden and Emerald Triangle Areas: Thai Perspective," *Five Triangle Areas in the Greater Mekong Subregion, Edited by Masami Ishida, BRC Research Report*, no. 11 (2012).
- 18 Masami Ishida, "Development of Five Triangle Areas in the Greater Mekong Subregion," *Five Triangle Areas in the Greater Mekong Subregion*, 2012, 1–31.
- 19 Juan Zhang, *Casinos as Special Zones*, ed. M Chettri and M Eilenberg (Amsterdam University Press, 2021).
- 20 International Crisis Group, "Transnational Crime and Geopolitical Contestation along the Mekong."
- 21 UNODC, "Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat," January 2024.
- 22 UNODC, "UNODC Hosts Financial Investigations Techniques Course," United Nations: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, September 20, 2019.
- 23 US Department of the Treasury, "Treasury Sanctions the Zhao Wei Transnational Criminal Organization," U.S. Department of the Treasury, January 30, 2018.
- 24 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2010 год* (Вена, Австрия, 2010 год).
- 25 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact."
- 26 Bertil Lintner and Michael Black, *Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle* (Silkworm Books, 2009).

- 27 Lionel Beehner, "State-Building, Military Modernization and Cross-Border Ethnic Violence in Myanmar," *Journal of Asian Security and International Affairs* 5, no. 1 (2018): 1–30.
- 28 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год).
- 29 International Crisis Group, "Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar's Shan State" (Brussels, Belgium, January 8, 2019).
- 30 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact."
- 31 UNODC, "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges," 2023.
- 32 Dublin Group, "Regional Report on South East Asia" (Brussels, Belgium, October 2019).
- 33 UNODC, "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges."
- 34 Ibid.
- 35 Ibid.
- 36 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год* (Вена, Австрия, 2023 год).
- 37 Анализ был ограничен 750 км, с тем чтобы изучить события в пределах и за пределами «Золотого треугольника». Максимальное расстояние в 750 км от эпицентра трехгранного района включает крупные международные портовые города, такие как Бангкок и Янгон. Это позволяет более четко проанализировать события в области незаконного оборота наркотиков, связанные с действующими в регионе незаконными субъектами, а также учесть события, которые могут иметь отношение к экспортным рынкам за пределами Юго-Восточной Азии.
- 38 Данные о ценах за 2015 год взяты из ответов на вопросник к ежегодному докладу УНП ООН; данные за 2022 год получены от Азиатско-тихоокеанской информационной сети по вопросам злоупотребления наркотиками (ДАЙНАП).
- 39 UNODC, "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges."
- 40 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact."
- 41 UNODC, "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges."
- 42 Ibid.
- 43 Ibid.
- 44 Ibid.
- 45 Ibid.
- 46 Ibid.
- 47 UNODC, "Southeast Asia Opium Survey 2023."
- 48 Ibid.
- 49 Ibid.
- 50 Ibid.
- 51 Ibid.
- 52 Ibid.
- 53 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 54 William D Moreto and Daan P van Uhm, "Nested Complex Crime: Assessing the Convergence of Wildlife Trafficking, Organized Crime and Loose Criminal Networks," *The British Journal of Criminology* 61, no. 5 (September 1, 2021): 1334–53.
- 55 Buchanan, *Militias in Myanmar*.

- 56 Patrick Meehan, "Drugs, Insurgency and State-Building in Burma: Why the Drugs Trade Is Central to Burma's Changing Political Order," *Journal of Southeast Asian Studies* 42, no. 3 (2011): 376–404.
- 57 Patrick Meehan and Seng Lawn Dan, "Drugs and Extractivism: Opium Cultivation and Drug Use in the Myanmar-China Borderlands," *The Journal of Peasant Studies* 0, no. 0 (2023): 1–38.
- 58 Kevin Woods, "Rubber out of the Ashes: Locating Chinese Agribusiness Investments in 'Armed Sovereignities' in the Myanmar–China Borderlands," *Territory, Politics, Governance* 7, no. 1 (January 2, 2019): 79–95.
- 59 Juliet N. Lu, "Tapping into Rubber: China's Opium Replacement Program and Rubber Production in Laos," *The Journal of Peasant Studies* 44, no. 4 (July 4, 2017): 726–47.
- 60 Xiaobo Su, "Repositioning Yunnan: Security and China's Geoeconomic Engagement with Myanmar," *Area Development and Policy* 1, no. 2 (2016): 178–94.
- 61 US Department of the Treasury, "Treasury Sanctions the Zhao Wei Transnational Criminal Organization."
- 62 Global Witness, "A Conflict of Interests The Uncertain Future of Burma's Forests," October 2003.
- 63 Global Witness, "Myanmar's Poisoned Mountains," Global Witness, August 9, 2022.
- 64 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact."
- 65 Moreto and van Uhm, "Nested Complex Crime."
- 66 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact."
- 67 Daan P. van Uhm and Rebecca WY Wong, "Chinese Organized Crime and the Illegal Wildlife Trade: Diversification and Outsourcing in the Golden Triangle," *Trends in Organized Crime* 24, no. 4 (2021): 486–505.
- 68 Ibid.
- 69 Ibid.
- 70 Moreto and van Uhm, "Nested Complex Crime."
- 71 International Crisis Group, "Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar's Shan State."
- 72 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2014 год*, глава 2 «Контроль над прекурсорами» (издание Организации Объединенных Наций, 2014 год).
- 73 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2023 год).
- 74 Meehan, "Drugs, Insurgency and State-Building in Burma: Why the Drugs Trade Is Central to Burma's Changing Political Order."
- 75 International Crisis Group, "Transnational Crime and Geopolitical Contestation along the Mekong."
- 76 SiuSue Mark, Indra Overland, and Roman Vakulchuk, "Sharing the Spoils: Winners and Losers in the Belt and Road Initiative in Myanmar," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (December 1, 2020): 381–404.
- 77 Meehan and Dan, "Drugs and Extractivism."
- 78 UNODC, "Southeast Asia Opium Survey 2023."
- 79 Lalita Gomez and Chris R. Shepherd, "Trade in Bears in Lao PDR with Observations from Market Surveys and Seizure Data," *Global Ecology and Conservation* 15 (July 1, 2018): e00415.
- 80 Daan P. van Uhm and Mingxia Zhang, "Illegal Wildlife Trade in Two Special Economic Zones in Laos: Underground–Open-Sale Fluctuations in the Golden Triangle Borderlands," *Frontiers in Conservation Science* 3 (2022): 1030378.
- 81 van Uhm and Wong, "Chinese Organized Crime and the Illegal Wildlife Trade: Diversification and Outsourcing in the Golden Triangle."
- 82 Nickii Wantakan Arcado, "Ice and Instability: Illicit Financial Flows Along Thailand's Borders," *Center for Strategic and International Studies* (blog), September 22, 2022.

- 83 International Crisis Group, “Transnational Crime and Geopolitical Contestation along the Mekong.”
- 84 Patrick Meehan, “‘Ploughing the Land Five Times’: Opium and Agrarian Change in the Ceasefire Landscapes of South-Western Shan State, Myanmar,” *Journal of Agrarian Change* 22, no. 2 (2022): 254–77.
- 85 Meehan and Dan, “Drugs and Extractivism.”
- 86 Patrick Meehan, “Precarity, Poverty and Poppy: Encountering Development in the Uplands of Shan State, Myanmar,” *International Journal of Drug Policy* 89 (2021): 103064.
- 87 Ibid.
- 88 Meehan, “‘Ploughing the Land Five Times.’”
- 89 UNODC, “Southeast Asia Opium Survey 2023.”
- 90 Seng Lawn Dan et al., “The Pat Jasan Drug Eradication Social Movement in Northern Myanmar, Part One: Origins & Reactions,” *International Journal of Drug Policy* 89 (2021): 103181.
- 91 Patrick Meehan et al., “Young People’s Everyday Pathways into Drug Harms in Shan State, Myanmar,” *Third World Quarterly* 43, no. 11 (2022): 2712–30.
- 92 UNODC, “Southeast Asia Opium Survey 2023.”
- 93 Patrick Meehan and Seng Lawn Dan, “Drugs and Extractivism: Opium Cultivation and Drug Use in the Myanmar-China Borderlands,” *The Journal of Peasant Studies*, 2023, 1–38.
- 94 Katie Hail-Jares et al., “Occupational and Demographic Factors Associated with Drug Use among Female Sex Workers at the China–Myanmar Border,” *Drug and Alcohol Dependence* 161 (2016): 42–49.
- 95 Lucy Platt et al., “The Effect of Migration, Location in Mining or Borderland Areas on HIV Incidence among People Who Use Drugs Attending a Harm Reduction Programme in Myanmar, 2014–2021: A Retrospective Cohort Study,” *medRxiv*, 2023, 2023.12.05.23299510.
- 96 UNODC, “Southeast Asia Opium Survey 2023.”
- 97 Meehan and Dan, “Drugs and Extractivism.”
- 98 Ibid.
- 99 Platt et al., “The Effect of Migration, Location in Mining or Borderland Areas on HIV Incidence among People Who Use Drugs Attending a Harm Reduction Programme in Myanmar, 2014–2021: A Retrospective Cohort Study.”
- 100 Yan-Heng Zhou et al., “Comparison of HIV-, HBV-, HCV-and Co-Infection Prevalence between Chinese and Burmese Intravenous Drug Users of the China-Myanmar Border Region,” *PloS One* 6, no. 1 (2011): e16349.
- 101 John Buchanan, Tom Kramer, and Kevin Woods, “Developing Disparity: Regional Investment in Burma’s Borderlands,” *Amsterdam: Transnational Institute*, 2013, 23.
- 102 Kevin M. Woods, “Smaller-Scale Land Grabs and Accumulation from below: Violence, Coercion and Consent in Spatially Uneven Agrarian Change in Shan State, Myanmar,” *World Development* 127 (2020): 104780.
- 103 Woods, “Rubber out of the Ashes.”
- 104 Meehan and Dan, “Drugs and Extractivism.”
- 105 United States Department of State, “2023 Trafficking in Persons Report: Burma,” 2023.
- 106 Saeed Rahimpour Golroudbary et al., “Global Environmental Cost of Using Rare Earth Elements in Green Energy Technologies,” *Science of The Total Environment* 832 (August 1, 2022): 155022.
- 107 Global Witness, “Myanmar’s Poisoned Mountains.”
- 108 Prashanti Sharma, Rajesh Bahadur Thapa, and Mir Abdul Matin, “Examining Forest Cover Change and Deforestation Drivers in Taunggyi District, Shan State, Myanmar,” *Environment, Development and Sustainability* 22, no. 6 (August 1, 2020): 5521–38.

- 109 Global Forest Watch, “Myanmar Deforestation Rates & Statistics,” n.d., accessed February 22, 2024.
- 110 UN-REDD/Myanmar, “Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Myanmar,” December 2017, <https://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/02/Myanmar-Drivers-Report-final.pdf>.
- 111 Tristan Burns-Edel, “Environmental Impacts of Illicit Drug Production,” *Global Societies Journal* 4 (2016).
- 112 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 5 «Наркотики и окружающая среда» (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год)
- 113 UNODC, “Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges.”
- 114 К ним относятся страны Восточной и Юго-Восточной Азии.
- 115 UNODC, “Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact.”
- 116 В этих оценках учитываются самые последние представленные странами расчетные показатели распространенности потребления в течение прошлого года, которые в некоторых случаях устарели, а в большинстве случаев, вероятно, превышают расчетный совокупный объем потребления, поскольку объем потребления зависит от численности лиц, употреблявших наркотики в течение прошлого месяца. Однако в отсутствие более актуальных и точных данных о потреблении в течение прошлого месяца эти оценочные показатели представляют собой наиболее обоснованные объемы потребления в этих регионах.
- 117 Следует проявлять осторожность в отношении этих данных, поскольку некоторые из стран, включенных в эту оценку, могут получать метамфетамин не только из «Золотого треугольника» (хотя большая его часть будет поступать именно оттуда), а некоторые не включенные в расчеты страны в соседних регионах могут, помимо других источников, также получать метамфетамин из «Золотого треугольника».
- 118 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*.
- 119 Victoria Dittmar, “Methamphetamine Production in Mexico Is Toxic for the Environment,” InSight Crime, November 3, 2022.
- 120 УНП ООН, брошюра 5 «Наркотики и окружающая среда».
- 121 UNODC, “Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges.”
- 122 UNODC, “News: August 2022 – UNODC-SMART: Cambodia – a New Hot Spot for Illicit Ketamine Manufacture in South-East Asia?,” August 2022.

03

ГЕНДЕР, ВОЗРАСТ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ

ГЕНДЕР, ВОЗРАСТ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ

Введение

С начала XXI века внимание к проблематике синтетических наркотиков все время растет. По сравнению со многими традиционными наркотиками растительного происхождения контроль над этими веществами представляет собой еще более трудную задачу, что обусловлено характером и наличием возможностей для их создания и изготовления. Зачастую их можно дешево и быстро производить в любом месте, где есть доступ к необходимым химическим веществам — прекурсорам. Кроме того, факт вариативности и возрастающего с недавних пор внимания к ним означает, что о связанных с ними потенциальных рисках известно еще меньше, чем о рисках традиционных наркотиков растительного происхождения, которые изучаются гораздо дольше. Во *Всемирном докладе о наркотиках за 2023 год* рассматриваются некоторые из этих тенденций и описываются возможные пути расширения наркорынков и увеличения причиняемого вреда за счет синтеза наркотиков¹.

В этом году цель настоящей главы, подготовленной с учетом проделанной работы, заключается в анализе связи динамики спроса и предложения синтетических наркотиков и гендерной принадлежности и возраста участников рынка². В эпидемиологической литературе зафиксированы различия между мужчинами и женщинами в приобщении к пагубному употреблению синтетических наркотиков и ведущих к нему путей, а также в моделях наркопотребления. Несмотря на то, что многие гендерные различия в структуре наркопотребления характерны для всех наркотиков, отмечаются и существенные отличия, причем среди мужчин и женщин наблюдаются четкие закономерности в отношении приобретения синтетических наркотиков и связанных с ними рисков. Гендерные различия уже становились предметом изучения в контексте цепочки поставок запрещенных наркотиков³, однако их анализ с акцентом именно на синтетические наркотики практически не проводился. Поскольку синтетические наркотики распространяются в новых регионах и меняют динамику наркорынков, в настоящей главе рассматриваются современные тенденции и различия по полу и возрасту (молодые люди и подростки), особенно когда речь идет о потреблении синтетических наркотиков и их предложении, иногда в сравнении с наркотиками растительного происхождения.

Один из основных выводов, сделанных в ходе различных аналитических исследований, заключается в том, что в показателях предложения и потребления наркотиков, независимо от того, является ли наркотик веществом растительного происхождения или синтетическим, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужчины. Несмотря на некоторые существенные гендерные различия, мужчины зачастую составляют большую долю лиц, арестованных по подозрению в причастности к незаконному обороту, распространению и хранению наркотиков с целью их употребления. Кроме того, согласно данным многих обследований, они составляют большую долю лиц, добровольно сообщающих об употреблении наркотиков.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА]

Синтетические наркотики

К рассматриваемым в настоящей главе синтетическим наркотикам в основном относятся стимуляторы амфетаминового ряда (амфетамин, метамфетамин и МДМА), синтетические катиноны, синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов и широкий круг лекарственных средств, таких как бензодиазепины, транквилизаторы и синтетические опиоиды (включая опиоидные лекарственные средства), которые могут быть поддельными или выведены из законных каналов и использоваться в немедицинских целях. В разных странах и регионах распространенность различных классов синтетических наркотиков неодинакова.

Наиболее употребляемые синтетические наркотики (употребление в немедицинских целях) в разбивке по видам наркотиков, 2022 год или последний год, по которому представлены данные

Tramadol	Трамадол
Pharmaceutical opioids	Опиоидные лекарственные средства
Methamphetamine	Метамфетамин
Amphetamine	Амфетамин
Amphetamines*	Амфетамины*
“Ecstasy”-type substances	Вещества типа экстази
NPS	НПВ
Synthetic cathinones	Синтетические катиноны
Ketamine	Кетамин
Sedatives and tranquillizers	Седативные средства и транквилизаторы
No data	Нет данных
*Amphetamines include both amphetamine and methamphetamine	*Амфетамины включают как амфетамин, так и метамфетамин.

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается спор относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

Примечание: наиболее употребляемые в той или иной стране синтетические наркотики ранжированы на основе представленных той или иной страной данных по группе, классу, к которым относится тот или иной наркотик, или по конкретному наркотику. Категория амфетаминов включает метамфетамин и амфетамин, и этот термин использовался в тех случаях, когда в представленной страной отчетности конкретно не сообщалось о равном ранге метамфетамина и амфетамина как наиболее употребляемого синтетического наркотика или отсутствовали сведения об этом.

В настоящей главе, подготовленной на основе официальных данных и данных из открытых источников, интервью с 92 ключевыми респондентами, специально отобранными в семи странах, обзора научной литературы, в основном из стран с высоким уровнем дохода, а также из стран со средним и низким уровнем дохода, и официальных докладов, описываются гендерные и возрастные различия в отношении спроса на наркотики и их предложения. В целях формирования представления о гендерных и отчасти возрастных различий, касающихся разных аспектов обсуждаемых в настоящей главе синтетических наркотиков, вся информация была подвергнута перекрестному анализу.

Частью качественных тематических исследований, проведенных в семи странах, были интервью с 92 ключевыми респондентами, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, поставщики медицинских услуг (как в частном, так и государственном секторе), представители НПО, работающих с лицами, употребляющими наркотики, и лицами, имеющими опыт употребления наркотиков. Ключевые респонденты были специально отобраны с учетом их опыта и знаний о проблеме наркотиков в своих странах. Мнения, высказанные ключевыми респондентами, не обязательно отражают ситуацию в их стране в целом, не могут быть экстраполированы на другие страны и регионы; они используются для иллюстрации различных проявлений проблемы употребления синтетических наркотиков в разных регионах.

Качественные исследования, проведенные в 2023 году

REGION	РЕГИОН
Caribbean	Карибский бассейн
Central Asia	Центральная Азия
Middle East	Ближний Восток

South America	Южная Америка
South-East Asia	Юго-Восточная Азия
West Africa	Западная Африка
COUNTRY	СТРАНА
Trinidad and Tobago	Тринидад и Тобаго
Kazakhstan	Казахстан
Jordan	Иордания
Chile	Чили
Thailand	Таиланд
Nigeria and Senegal	Нигерия и Сенегал
DRUG	НАРКОТИК
Pharmaceutical stimulants	Стимулирующие лекарственные средства
<i>alpha</i> -PVP, mephedrone, synthetic cannabinoids, synthetic opioids	<i>альфа</i> -ПВФ, мефедрон, синтетические каннабиноиды, синтетические опиоиды
“Captagon”	Каптагон
Ketamine, MDMA, novel tryptamines	Кетамин, МДМА, новые триптамины
Methamphetamine	Метамфетамин
Tramadol	Трамадол

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Гендерные различия в масштабах потребления синтетических наркотиков и приобретения наркотиков

В целом уровень потребления наркотиков среди женщин остается ниже, чем среди мужчин, однако различия между ними существенно варьируют в зависимости от региона и вида наркотика. В общемировом масштабе женщины составляют почти треть потребителей каннабиса, кокаина или героина, однако, что касается употребления лекарственных средств в немедицинских целях, в частности опиоидов, седативных средств, транквилизаторов и стимуляторов, то доля женщин и мужчин практически одинакова⁴.

Качественная информация, собранная УНП ООН в разных странах и субрегионах, также подтверждает более высокий уровень потребления наркотиков среди мужчин, однако эксперты отмечают, что гендерный разрыв сокращается⁵. Например, в Чили опрошенные национальные эксперты по сокращению спроса отметили, что распространенность потребления синтетических наркотиков в некоторых возрастных когортах выше среди женщин, чем среди мужчин⁶, что согласуется с национальными данными, а синтетические наркотики рассматриваются ими как один из факторов недавнего роста потребления наркотиков среди женщин⁷. В том же ключе эксперт из сектора здравоохранения Сенегала выразил обеспокоенность по поводу «феминизации наркозависимости» в этой стране, отметив, что, хотя распространенность наркопотребления среди мужчин гораздо выше, темпы роста наркопотребления среди женщин в последнее время, по всей видимости, заметно выше, чем среди мужчин⁸. Кроме того, в Сенегале, как отметил руководитель наркологической службы, употребление в немедицинских целях трамадола по сравнению с другими наркотиками, по-видимому, более распространено среди женщин⁹. Аналогичная картина наблюдается в Казахстане и Нигерии, где, по мнению опрошенных, разрыв между мужчинами и женщинами в масштабах употребления по крайней мере некоторых видов синтетических наркотиков (синтетических стимуляторов в Казахстане и трамадола в Нигерии) гораздо меньше по сравнению с более традиционными наркотиками растительного происхождения¹⁰. Один из опрошенных в Казахстане даже предположил, что среди лиц, употребляющих синтетические наркотики, преобладают женщины¹¹.

Потребители отдельных групп наркотиков в разбивке по полу

Opiates	Опиаты
Cocaine	Кокаин
Cannabis	Каннабис
Ecstasy-type substances	Вещества типа экстази
Amphetamines	Амфетамины
Non-medical use of pharmaceutical opioids	Опиоидные лекарственные средства, употребляемые в немедицинских целях

РИС. 27 Масштабы потребления синтетических наркотиков в разбивке по гендерной принадлежности и возрасту, 2022 год

Annual prevalence (percentage)	Распространенность потребления в течение года (проценты)
Women	Женщины
Men	Мужчины
12–18 years	12–18 лет
19–25 years	19–25 лет
26–34 years	26–34 года
35–44 years	35–44 года
45+ years	45 лет и старше

Источник: пятнадцатое национальное исследование о потреблении наркотиков населением в целом Национальной реабилитационно-профилактической наркологической службы (СЕНДА).

Примечание: к категории синтетических наркотиков относятся транквилизаторы безрецептурного отпуска, обезболивающие средства безрецептурного отпуска, фентанил, синтетическая марихуана, экстази, синтетические катиноны или МДПВ, ДМТ или «лиса», крathom (Mitragna speciosa), «бурунданга», стимуляторы безрецептурного отпуска, метамфетамины, «попперсы», ЛСД, «ангельская пыль», 25B-NBOMe или 25C-NBOMe, 2C-B или «туси», другие лекарственные средства безрецептурного отпуска, кетамин, ГОМК, ФЦП, БЗП и ГБЛ.

Гендерные различия в отношении приобщения к употреблению синтетических наркотиков и мотивов их продолжающегося употребления

Нейробиологические и внутренние факторы, а также опыт физического и/или сексуального насилия в прошлом могут повлиять на приобщение к наркопотреблению и продолжение употребления наркотиков

Между мужчинами и женщинами наблюдаются различия в отношении приобщения к наркопотреблению и в мотивах для продолжения употребления наркотиков. Исследования показали, что могут существовать различия в факторах, влияющих на употребление наркотиков в зависимости от пола, а именно: нейробиологические факторы (например, нейроэндокринная адаптация к стрессу и подкрепление), а также внутренние факторы (такие как индивидуальные особенности личности и сопутствующие психические расстройства)^{12, 13, 14}. Установлено также, что гормоны яичников (эстроген и прогестерон) и их изменяющийся уровень во время менструального цикла, например, могут быть фактором того, что женщины более чувствительны к «подкрепляющему» эффекту стимуляторов^{15, 16} и обезболивающему эффекту опиоидов¹⁷. Социально-гендерные роли также взаимодействуют в процессе модулирования наркопотребления и влияют на результаты лечения лиц, употребляющих наркотики. Внешние факторы, такие как случаи жестокого обращения в прошлом (например, полученный в детстве негативный опыт и

насилие со стороны интимного партнера), употребление психоактивных веществ членами семьи, друзьями и сверстниками, также могут по-разному влиять на наркопотребление на гендерном уровне.

Самолечение и потребность в стимулировании выработки энергии для повышения работоспособности могут привести к употреблению синтетических наркотиков

В целом женщины более чувствительны к боли и чаще страдают от хронических болей, чем мужчины; поэтому вероятность назначения им опиоидов или употребления ими опиоидов в немедицинских целях в рамках самолечения (без рецепта) выше, чем среди мужчин, даже если они жалуются на боль одного и того же уровня¹⁸. Женщины также более склонны злоупотреблять опиоидными лекарственными средствами, пытаюсь самостоятельно излечиться от таких проблем, как тревога или напряжение^{19, 20}. С другой стороны, мужчины сообщают о более частом употреблении героина, что говорит о том, что женщины, возможно, более неохотно приобретают наркотики на незаконных рынках, с тем чтобы избежать риска насилия или участия в преступной деятельности²¹. Это подтверждается информацией, предоставленной медицинским персоналом в Сенегале при ответе на вопрос, о том, связано ли более частое употребление трамадола без какого-либо контроля или в немедицинских целях с различиями в чувствительности мужчин и женщин к боли, а также легкостью доступа к лекарственным препаратам через официальные и неофициальные аптеки и продавцов²².

И мужчины, и женщины могут употреблять стимуляторы с расчетом на то, что это повысит уровень их энергии. В частности, женщины могут употреблять стимуляторы (метамфетамин), чтобы преодолеть чрезмерную усталость от совмещения работы с домашними делами, уходом за детьми и другими семейными обязанностями^{23, 24}. Снижение веса — еще один мотив, особенно среди женщин, для употребления стимуляторов, включая неконтролируемое и немедицинское употребление амфетаминов (в том числе стимулирующих лекарственных средств)^{25, 26, 27}. Наконец, в научной литературе имеется немало данных об употреблении амфетамина в немедицинских целях среди молодых мужчин и женщин, особенно студентов, которые свидетельствуют о том, что амфетамины используются ими для повышения успеваемости и увеличения физической энергии и работоспособности^{28, 29, 30}.

Эти выводы также отражают данные, полученные в ходе опросов, проведенных в разных странах при подготовке настоящей главы. Хотя для приобщения к употреблению наркотиков, в том числе синтетических, и продолжения их употребления был назван целый ряд причин, присущих как женщинам, так и мужчинам, среди причин, характерных для женщин, чаще всего упоминались обезболивание и самолечение в целях устранения тревоги, депрессии и решения бытовых проблем^{31, 32}. Напротив, к мотивам употребления наркотиков, более характерным для мужчин, были отнесены повышение работоспособности и сексуальной активности, а также преодоление стресса, связанного с необходимостью обеспечения своих семей³³. Заметным исключением из этих наблюдений стали сведения, полученные из Таиланда, указывающие на то, что важным мотивом для употребления метамфетамина среди женщин является повышение работоспособности³⁴. В Сенегале респонденты отметили, что употребление трамадола в немедицинских целях женщинами — работницами секс-индустрии вызвано желанием справиться с работой, а в Нигерии респонденты из правоохранительных органов назвали желание справиться с травмой, особенно в регионах, пострадавших от действий «Боко Харам», в качестве еще одного мотива злоупотребления трамадолом³⁵. Кроме того, в Казахстане опрошенные отметили, что употребление синтетических наркотиков в целях усиления ощущений во время полового акта («химсекс») является важным мотивом как для мужчин, так и для женщин³⁶. Опрошенные в разных странах предположили, что некоторые синтетические наркотики, в том числе трамадол или амфетамины, используются для повышения работоспособности и, следовательно, могут чаще употребляться людьми, стремящимися работать дольше, расширить определенный опыт или смягчить негативные последствия жизненного опыта в других сферах.

Среди мотивов употребления синтетических наркотиков молодыми людьми, о которых упоминали опрошенные, часть из которых имели собственный опыт наркопотребления, были желание погрузиться в состояние эйфории и развлечься, а также употребление наркотиков сверстниками³⁷. Эти мотивы отличаются от мотивов, которые обычно характерны для пожилых людей, такими как самолечение в целях устранения боли и желание преодолеть усталость³⁸. Один из опрошенных также отметил, что, поскольку молодые люди больше пользуются социальными сетями, они с большей вероятностью будут осведомлены о новых синтетических наркотиках³⁹.

«В основном это расслабление, отдых, мода. Некоторые просто хотят потанцевать, повеселиться». (Интервью №27, частный поставщик услуг наркологической помощи, ноябрь 2023 года).

Употребление психоактивных веществ сверстниками и родителями, а также полученный в детстве негативный опыт являются основными факторами риска приобщения к наркопотреблению и пагубного употребления наркотиков

В ряде исследований, посвященных изучению факторов риска и прогностических факторов употребления наркотиков в целом и метамfetамfина в частности среди подростков, в том числе в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, было установлено, что экстернализирующее поведение (в частности агрессия, делинквентное поведение и гиперактивность) в основном среди мальчиков, а также употребление психоактивных веществ родителями и связь с неблагополучными сверстниками (нормативное употребление психоактивных веществ) являются наиболее важными факторами, позволяющими с наибольшей вероятностью прогнозировать употребление метамfetамfина в подростковом возрасте и его регулярное употребление во взрослой жизни. Употребляющие наркотики однополые сверстники считаются более значимым фактором риска наркопотребления для мальчиков, чем для девочек в подростковом возрасте, тогда как риск того, что девочки и женщины приобщатся к пагубному употреблению наркотиков и будут его практиковать более высок при наличии у них партнеров-наркопотребителей, с которыми они поддерживают романтические или интимные отношения. Девочки, как правило, начинают употреблять метамfetамфин позже, чем мальчики, и первое употребление зачастую происходит в местах отдыха, в клубах или при сексуальном контакте с партнером^{40, 41, 42, 43, 44}. Установлено также, что отношения с лицом, употребляющим наркотики, в значительной степени связаны с приобщением женщин к употреблению наркотиков и продолжением этой практики, а характер употребления наркотиков женщинами, зачастую определяется их интимными партнерами мужского пола, как, например, в случае употребления наркотиков путем инъекций⁴⁵.

Полученный женщинами в детстве негативный опыт связан с приобщением их к употреблению опиоидов и метамfetамfина и употреблением ими этих веществ

Одним из основных факторов, связанных с приобщением к наркопотреблению и продолжающимся употреблением наркотиков, является связь (или эффект медиации) экстернализирующих симптомов (поведенческие расстройства, такие как агрессия, антисоциальное расстройство личности, делинквентное поведение, а также гиперактивность и СДВГ) и интернализирующих симптомов (депрессия, тревога и травматический дистресс) с пагубным характером употребления наркотиков (включая синтетические наркотики) и его последствиями среди мужчин и женщин⁴⁶. Например, в случае с подростками интернализирующие симптомы чаще наблюдаются у девочек, чем у мальчиков⁴⁷.

Установлено, что неблагоприятный детский опыт, приведший к интернализирующим симптомам (депрессия, тревога и травматический дистресс) или экстернализирующим симптомам (агрессия, делинквентное поведение и гиперактивность), является важным прогностическим фактором приобщения к опиоидам, расстройств на почве употребления опиоидов и передозировки опиоидов в течение жизни^{48, 49, 50}. В ряде исследований было установлено, что вероятность множественного

негативного опыта в детстве у женщин выше, чем у мужчин, и что такой опыт связан с приобщением к употреблению опиоидов, расстройствами на почве употребления опиоидов и сопутствующими психическими заболеваниями, а также с приобщением к употреблению метамфетамина и последующей зависимостью^{51, 52, 53}. В опубликованных в научной литературе материалах исследований также сообщается, что употребление метамфетамина людьми, получившими в детстве негативный опыт, особенно женщинами, может сказаться или опосредованно повлиять на связь такого опыта с повышенным риском развития психоза и возникновения суицидальных мыслей^{54, 55}.

Наркопотребление в большей степени распространено среди групп населения более молодого возраста

Опрошенные во всех странах, как правило, считают, что молодые люди в большей степени склонны к употреблению синтетических наркотиков, чем люди старшего возраста, и эта закономерность обычно наблюдается в отношении всех наркотиков⁵⁶. Кроме того, молодые мужчины в гораздо большей степени склонны к употреблению синтетических наркотиков, чем другие группы населения, что согласуется с гендерными различиями, о которых речь шла выше⁵⁷. Один из опрошенных членов организации гражданского общества, представляющей интересы наркопотребителей в Нигерии, добавил, что, хотя потребление такого синтетического опиоида как трамадол, который издавна присутствует на национальном рынке, характерно для всех возрастных групп, молодые люди в гораздо большей степени склонны к употреблению «более новых» синтетических наркотиков, в частности различных синтетических каннабиноидов⁵⁸.

Некоторые соображения, касающиеся синтетических наркотиков

Несмотря на то, что в ходе предыдущего обсуждения был выявлен ряд сквозных тем, касающихся гендерных и возрастных различий в отношении синтетических наркотиков, важно признать, что большинство этих наблюдений не имеют непосредственного отношения к синтетическим наркотикам. Например, более высокий уровень потребления наркотиков среди мужчин, большая стигматизация женщин и более рискованное поведение среди молодежи в равной степени относятся и к наркотикам растительного происхождения. С этой точки зрения синтетические наркотики мало чем отличаются от наркотиков растительного происхождения, когда речь идет о существующих гендерных и возрастных аспектах динамики спроса на наркотики или даже их предложения. Однако существует множество факторов, которые делают синтетические наркотики особенно привлекательными для женщин и молодых людей, употребляющих наркотики.

Опрошенные отметили ряд моментов, связанных с «привлекательностью» или притягательностью синтетических наркотиков. Во-первых, некоторые опрошенные отметили, что женщины могут подвергаться меньшему риску столкнуться со стигматизацией в случае приобретения и бесконтрольного или немедицинского употребления синтетических наркотиков, которые обычно встречаются в официальных или неофициальных пунктах распространения или «аптеках»⁵⁹. Например, считается, что поведение женщин, которые заходят в аптеки или другие пункты распространения, где предлагаются поддельные или выведенные из законного оборота лекарственные препараты, является приемлемым и объяснимым, и они не подвергаются автоматически стигматизации, как это имеет место в случае лиц, употребляющих наркотики. Двое опрошенных из сектора здравоохранения в Сенегале поддержали эту точку зрения, отметив, что женщины, в частности, предпочитают продукты, которые позволяют им употреблять наркотики скрытно и не восприниматься как лицо, употребляющее наркотики⁶⁰.

«Что касается кокаина и героина... [ими] в основном злоупотребляют мужчины, а женщины, употребляющих их, очень мало. Однако, что касается трамадола...это фактически рецептурный препарат, которым люди могут действительно

злоупотреблять, поэтому женщинам гораздо легче получить доступ к нему».
(Интервью №2, психиатр, ноябрь 2023 года)

Во-первых, это касается наблюдения в отношении употребления некоторых синтетических наркотиков в качестве законных лекарственных средств, которым поделился опрошенный, являющийся сотрудником одного из правоохранительных органов Сенегала. Ключевой респондент отметил, что за участие в незаконном обороте трамадола судьи, как правило, выносят более мягкие приговоры, чем за участие в незаконном обороте традиционных наркотиков растительного происхождения, таких как каннабис. Причина кроется в том, что судьи склонны рассматривать незаконное распространение трамадола как незаконную торговлю лекарствами или деятельность «не имеющей разрешения аптеки», а не как незаконный оборот наркотиков. Относительно мягкие меры наказания, в свою очередь, способствуют привлекательности незаконного оборота опиоидных лекарственных средств⁶¹.

Во-вторых, несколько опрошенных отметили, что синтетические наркотики (в частности, таблетки или капсулы) представляют собой альтернативу традиционным наркотикам растительного происхождения, обеспечивающую большую скрытность их употребления. Некоторые ключевые респонденты в Нигерии и Сенегале, являющиеся сотрудниками наркологических служб и имеющие собственный опыт употребления наркотиков, высказали мнение о том, что поскольку синтетические наркотики (например, трамадол) позволяют скрытно употребляющим их лицам достичь желаемого эффекта эйфории без появления какого-либо запаха, эти вещества являются особенно привлекательными для молодых людей, опасаящихся, что их увидят в момент употребления наркотиков в общественных местах⁶². Двое опрошенных в Казахстане — психолог и человек из числа лиц, имеющих собственный опыт употребления наркотиков, — предположили, что некоторые люди, особенно молодежь, могут предпочитать синтетические наркотики, поскольку они считают, что их труднее обнаружить с помощью обычных тестов на наркотики⁶³. Аналогичная аргументация прослеживается и у другого опрошенного в Казахстане, являющегося сотрудником одного из правоохранительных органов, который отметил, что синтетические наркотики можно курить или вдыхать без особой подготовки, в отличие от «традиционных» наркотиков, таких как героин, для инъекций которых требуется специальное место⁶⁴.

«Так, если вы захотите принять таблетку, скажем, трамадола, никто не узнает, что именно вы приняли, хотя вы приняли что-то, что действует так же, как алкоголь. Если же я выпью стакан спиртного, а вы только что вошли в мою квартиру, то по запаху вы поймете, что я что-то выпил. А вот если я приму таблетку трамадола... вы даже не заметите, что я что-то принял». (Интервью №3, научный сотрудник правоохранительного органа, ноябрь 2023 года)

В-третьих, несколько опрошенных упомянули бесконтактное распространение синтетических наркотиков, что является нормой в некоторых странах, в качестве фактора большей привлекательности этих веществ для молодых людей и женщин. Это можно рассматривать как отражение того факта, что традиционное личное распространение на уличных рынках не является привлекательным ни для молодых людей, ни для женщин, поскольку этим в основном занимаются (более возрастные) мужчины. Однако, хотя бесконтактное распространение было отмечено как особенность рынков синтетических наркотиков, нет причин, по которым оно не могло бы применяться и к рынкам традиционных наркотиков растительного происхождения.

Женщины сталкиваются с более серьезными негативными медицинскими и социальными последствиями употребления синтетических наркотиков

Поскольку среди мужчин больше лиц, употребляющих наркотики независимо от того, являются ли они продуктами растительного происхождения или синтетическими веществами, то, по мнению опрошенных экспертов, в целом среди них показатели совокупного бремени болезней и негативных медицинских и социальных последствий наркопотребления выше⁶⁵.

Эксперты также заявили, что ассортимент новых синтетических наркотиков, представленных в настоящее время на рынке, малоизвестность или малоизученность их фармакологических свойств и потенциальная интенсивность их психоактивного воздействия могут создавать дополнительные проблемы в лечении мужчин и женщин, страдающих от острых негативных эффектов их употребления или наркологическими расстройствами⁶⁶.

Тем не менее женщины, употребляющие наркотики, сталкиваются с более серьезными негативными медицинскими и социальными последствиями, поскольку они склонны наращивать количество потребляемых ими наркотиков (например, опиоидов и амфетаминов) быстрее, чем мужчины, тем самым ускоряя развитие расстройств на почве употребления психоактивных веществ — именно такой «телескопический» эффект наблюдается среди женщин, проходящих лечение в связи с расстройствами на почве употребления опиоидов и стимуляторов^{67, 68}. Женщины, проходящие лечение в связи с расстройствами на почве наркопотребления, как правило, подвергаются более высокому, чем мужчины, риску развития сопутствующих психиатрических заболеваний и насилия со стороны интимного партнера, женщины-наркопотребители также сталкиваются с соответствующими повышенными рисками для сексуального и репродуктивного здоровья^{69, 70, 71}.

В ходе исследования, посвященного лицам, проходящим лечение в связи с расстройствами на почве употребления метамфетамина, женщины сообщили, что они сталкиваются с соответствующими проблемами в более раннем возрасте, чем мужчины; они также сообщили о том, что их проблемы более серьезные и они чаще, чем мужчины, употребляли метамфетамин путем инъекций в течение последних 12 месяцев. Кроме того, женщины испытывали большее психологическое бремя, сообщали о более частом использовании стратегий эмоциональной адаптации (использовании навыков анализа чувств, вызванных стрессовыми ситуациями, и работы над ними⁷²) и имели более высокий уровень приобретенного в детстве негативного опыта, чем мужчины⁷³. Женщины, которые являются матерями и страдают наркологическими расстройствами, подвергаются дополнительной стигматизации, а также риску потерять опеку над своими детьми, что приводит к накоплению большего количества неблагоприятных жизненных событий⁷⁴.

«Существует определенная социологическая реальность, где мужчинам дарованы свободы, которых нет у женщин». (Интервью №83, поставщик услуг информационно-просветительского центра, декабрь 2023 года)

Социальная стигматизация, более низкий уровень экономической самостоятельности женщин и патриархальные устои общества приводят к множеству негативных последствий для женщин-наркопотребителей

Представляющие различные секторы ключевые респонденты назвали несколько причин, по которым женщины, с их точки зрения, в несоизмеримо большей степени страдают от употребления наркотиков в целом. Прежде всего, ключевые респонденты из семи стран согласились с тем, что женщины в гораздо большей степени страдают от стигматизации, связанной с употреблением наркотиков⁷⁵. Наряду с социальной стигматизацией были названы и другие факторы, такие как более низкий уровень экономической самостоятельности женщин и патриархальные устои общества, которые приводят к множеству негативных последствий для женщин-наркопотребителей. Во-первых, по мнению опрошенных экспертов, по сравнению с мужчинами женщины подвергаются большему риску физического насилия, в том числе насилия со стороны интимного партнера, сексуального и психологического насилия по причине употребления ими наркотиков, их поведения, связанного с поиском наркотиков, или употребления наркотиков их партнерами и знакомыми⁷⁶. О физическом насилии после секса или во время секса также часто

сообщается в научной литературе в контексте коммерческого секса за наркотики или деньги^{77, 78}. Многие обнищавшие бездомные женщины, особенно наркозависимые, также полагаются на мужчин в плане экономической поддержки и могут обменивать секс на наркотики, такие как метамфетамин, и тем самым подвергаются жестокому обращению в многочисленных ситуациях⁷⁹.

Считается, что некоторые синтетические наркотики обладают менее продолжительным действием в организме (например, фентанил по сравнению с героином)⁸⁰, а другие (такие как метамфетамин при курении по сравнению с кокаином при вдыхании через нос или курении) действуют в течение более продолжительного времени⁸¹. Однако относительно короткая продолжительность одурманивающего действия и «приятные эффекты» метамфетамина и фентанила требуют частого приема или инъекций, что связано с вредом, характерным для небезопасной практики употребления наркотиков путем инъекций^{82, 83}.

Уязвимость женщин, обусловленная традиционными гендерными ролями и гендерными властными структурами и отношениями, также может повысить их уязвимость к рискованным моделям поведения в отношении сексуальной жизни и использования инъекций, тем самым увеличивая риск заражения ВИЧ, вирусным гепатитом и другими ИППП^{84, 85, 86, 87}. Гендерное насилие также значительно повышает риск заражения ВИЧ и другими ИППП среди женщин и девушек, употребляющих наркотики⁸⁸. Более того, из-за возросшей доступности синтетических наркотиков некоторые аспекты уязвимости и проблемы, характерные для женщин-наркопотребителей, могут еще более усугубляться.

Дискриминация, насилие и физическое надругательство также могут удерживать женщин от обращения за медицинской помощью

Многие из опрошенных, и среди имеющих опыт употребления наркотиков, и среди поставщиков наркологических услуг, подчеркивали, что повышенный риск, которому подвергаются женщины в результате употребления наркотиков, также распространяется на случаи злоупотребления со стороны властей (например, полиция арестовывает женщин за хранение наркотиков или за секс-работу) или со стороны других поставщиков наркологических услуг (например, медицинских работников), которые должны помогать людям⁸⁹. Это может, в частности, удерживать некоторых женщин от обращения за помощью или усугублять последствия ранее пережитого физического или сексуального насилия. Например, в рамках одного из исследований, проведенных в Северной Америке, живущие на улице женщины, употребляющие опиоиды, отметили, что помимо насилия и жестокости, с которыми они там сталкиваются, из-за криминализации и стигматизации, связанных с наркопотреблением и привлечением к работе сексуального характера, они неохотно сообщают о случаях передозировки, что потенциально повышает риск связанного с ней вреда, включая смерть⁹⁰. В рамках других исследований, проведенных в Северной Америке, уязвимые лица, употребляющие опиоиды, сообщали, что страх перед насилием и сексуальными надругательствами мешает им воспользоваться наркологической помощью^{91, 92}. Кроме того, в условиях, когда уличная секс-работа пересекается с рынками наркотиков, секс-работники могут сталкиваться с повышенным риском причинения вреда из-за криминализации обоих видов деятельности, особенно если наркопотребление осуществляется в рамках взаимодействия между секс-работниками и клиентами⁹³.

Более высокий уровень стигматизации употребления наркотиков женщинами зачастую означает большую вероятность того, что они будут отвергнуты своими семьями и/или общинами⁹⁴. В связи с этим некоторые опрошенные, представляющие службы психического здоровья, говорили о социальных или «родственных» последствиях наркопотребления для женщин (например, распад семьи), в отличие от экономических последствий для мужчин (например, потеря работы)⁹⁵. Сочетание стигматизации и более низкого уровня экономической самостоятельности женщин также может привести к тому, что они будут вынуждены заниматься секс-работой и предлагать услуги сексуального характера в обмен на наркотики⁹⁶. Кроме того, некоторые опрошенные, в том числе имеющие опыт наркопотребления, упомянули в качестве одного из пагубных последствий для здоровья, которые в непропорционально большей степени сказываются на женщинах, высокую

вероятность их вовлечения в рискованные сексуальные практики⁹⁷. Наконец, один из опрошенных в Казахстане, имеющий опыт употребления наркотиков, отметил, что женщины, употребляющие наркотики путем инъекций, могут подвергаться непропорционально высокому риску заражения ВИЧ, если они пользуются иглами совместно со своими партнерами⁹⁸. Данные также свидетельствуют о том, что женщины менее склонны, чем мужчины, к употреблению наркотиков путем инъекций, однако вероятность того, что женщины, употребляющие наркотики путем инъекций, являются носителями ВИЧ выше по сравнению с мужчинами, употребляющими наркотики путем инъекций⁹⁹.

«Здесь есть важная гендерная составляющая. Мужчина думает так: “Я принимаю дозу первым, поскольку меня ломит сильнее, чем мою партнершу. А она всегда после меня”. Если это происходит, то женщина подвергается более высокому риску заражения ВИЧ». (Интервью №28, человек, имеющий опыт употребления наркотиков, ноябрь 2023 года)

Молодые люди чаще вступают в контакт с системой уголовного правосудия по причине наркопотребления

Что касается возраста, то опрошенные отметили два последствия употребления наркотиков, которые в гораздо большей степени касаются молодых людей. Во-первых, считается, что из-за употребления наркотиков молодые люди гораздо чаще вступают в контакт с системой уголовного правосудия¹⁰⁰. В основном это объясняется антисоциальным, агрессивным и деструктивным поведением, наблюдаемым у молодых людей, употребляющих наркотики (экстернализирующие симптомы), хотя один из опрошенных предположил, что отмена наркотиков часто может быть причиной деструктивного или проблемного поведения среди молодых людей¹⁰¹. Во-вторых, считается, что молодые люди обладают большей склонностью к более рискованным моделям полового поведения, что сопряжено с повышенным риском заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Хотя это наблюдение применимо к большинству стран, особенно ярко оно проявляется в Казахстане, где опрошенные неоднократно указывали на практику «химсекса», которой занимаются молодые люди¹⁰². Опрошенные в Сенегале также упоминали о еще одном последствии употребления наркотиков, таком как изгнание молодых людей из дома, что, в свою очередь, затрудняет решение проблемы наркопотребления или обращение за профессиональной помощью¹⁰³.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА]

«Химсекс» и употребление синтетических наркотиков в сексуальном контексте

В научной литературе нередко упоминается одна из моделей поведения, связанная с использованием синтетических наркотиков в сексуальном контексте, особенно среди групп мужчин, практикующих секс с мужчинами, такая как «химсекс» или «употребление наркотиков в процессе сексуальной активности»; она описывается как использование конкретных веществ во время сексуальной активности для продления и усиления ощущений, раскрепощения и облегчения контактов^{a, b, c, d, e, f}. В научной литературе сообщается о трех видах синтетических наркотиков, которые употребляются как по отдельности, так и в сочетании в рамках «химсекса». К ним относятся метамфетамин, мефедрон и ГОМК или ГБЛ, которые зачастую употребляются вместе с МДМА, кетамин или кокаином и силденафилом, тадалафилом или варденафилом (препараты, которые используются для лечения эректильной дисфункции), а также с аминитритами^{g, a, b}.

Помимо повышения сексуальной активности и усиления сексуального удовольствия, существуют и другие мотивы употребления синтетических наркотиков в сексуальном контексте, к которым относятся чувство дестигматизации (сексуального поведения), чувство принадлежности, чувство эмоциональной открытости, единства, эмпатии или симпатии (энтактогенные эффекты), а также помощь в установлении отношений и

ⁿ Mostafa Shokoohi et al., 'Crystal Methamphetamine Use and Its Correlates in Women Engaged in Sex Work in a Developing Country Setting', *Drug and Alcohol Dependence* 185 (April 2018): 260–65.

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Опиоидный кризис в Северной Америке: гендерные аспекты и риски передозировки, связанные с употреблением синтетических опиоидов

Опиоидный кризис в Северной Америке, связанный с употреблением опиоидов, включая более сильнодействующие фентанил и аналоги фентанила незаконного изготовления, привел к беспрецедентному числу смертей от передозировки¹⁰⁴. В 2022 году в Канаде было зарегистрировано 7525 случаев смерти от передозировки опиоидов (скорректированный по возрасту показатель 19,6 случая на 100 тыс. человек), что больше, чем в 2016 году, в котором был зарегистрирован 2831 случай смерти от передозировки опиоидов (скорректированный по возрасту показатель 7,8 случая на 100 тыс. человек)¹⁰⁵; большинство зарегистрированных в Канаде случаев смерти от опиоидов были связаны с фентанилом (82 процента) и приходились на мужчин (70 процентов).

В Соединенных Штатах из более чем 100 000 случаев смерти от передозировки наркотиков в 2022 году 81 806 случаев были связаны с опиоидами (скорректированный по возрасту показатель 25 случаев на 100 тыс. человек). Таким образом, с 2010 года число случаев смерти от передозировки опиоидов увеличилось почти в четыре раза, хотя с 2021 года число случаев смерти от передозировки оставалось неизменным. Кроме того, в Соединенных Штатах более 70 процентов случаев смерти от передозировки опиоидов приходилось на мужчин¹⁰⁶. В период 2010—2022 годов число случаев смерти от передозировки опиоидных лекарственных средств оставалось неизменным, однако с 2014 года значительно возросло число случаев смерти от передозировки синтетических опиоидов (в первую очередь фентанила), причем в период 2010—2022 годов показатель увеличился более чем в 24 раза. Рост числа случаев смерти от передозировки синтетических опиоидов среди мужчин за этот период был почти в 2,5 раза выше, чем среди женщин. За тот же период число случаев смерти от передозировки психостимуляторов (в первую очередь метамфетамина) также увеличилось в 18 раз, хотя более 60 процентов случаев смерти от передозировки психостимуляторов были связаны с синтетическими опиоидами (фентанилом)¹⁰⁷. Вместе с тем число случаев смерти от передозировки психостимуляторов (в первую очередь метамфетамина) в период 2010—2022 годов увеличилось лишь в девять раз.

Социальные, структурные и межличностные факторы по-разному сказываются на группах населения с точки зрения их уязвимости к рискам для здоровья

Существуют социальные факторы (например, практика расизма, бедность и гендерные нормы), структурные факторы (например, политика и криминализация) и межличностные факторы (например, гендерное насилие), которые по-разному сказываются на различных группах населения с точки зрения их уязвимости к перекрестным рискам для здоровья (таким как передозировка) и ограниченного доступа к медико-санитарному обслуживанию¹⁰⁸.

В Соединенных Штатах рост числа случаев смертей от передозировки опиоидов среди представителей разных рас и гендерных групп происходит по-разному. В период 2013—2020 годов национальные показатели передозировки синтетических опиоидов выросли на 2209 процентов среди мужчин и на 991 процент среди женщин. Однако общие показатели передозировки синтетических опиоидов выросли на 6890 процентов среди чернокожих мужчин и на 2140 процентов среди чернокожих женщин, что выше показателей смертности от передозировки синтетических опиоидов среди белокожих женщин (840 процентов) и белокожих мужчин (2022 процента)¹⁰⁹.

В Северной Америке также существуют заметные различия между мужчинами и женщинами в плане уязвимости к вреду, связанному с наркотиками, а также риска передозировки с летальным исходом и без него. Например, в рамках исследования о наркопотреблении на общинном уровне женщины, употребляющие опиоиды, по некоторым данным, в два с лишним раза чаще сообщали о непреднамеренном контакте с фентанилом и риске передозировки, чем мужчины¹¹⁰. Женщины, которые ежедневно принимали героин или употребляли его путем инъекций, реже сообщали о непреднамеренном контакте с фентанилом, поскольку, по-видимому, они подразумевали его содержание в героине¹¹¹. Аналогичным образом, в рамках другого исследования и женщины, и мужчины называли передозировку «хроническим» состоянием и, вероятно, они были менее чувствительными к риску. Женщины и мужчины называли и другие риски, связанные со здоровьем, безопасностью и доступом к услугам наркологической помощи, которые зачастую вытесняли их страх или опасения по поводу передозировки. Женщины опасались физического и сексуального насилия больше, чем риска передозировки, и ставили на первое место заботу о детях и поддержание отношений со службами защиты детей, в то время как мужчины опасались насилия, связанного с приобретением и употреблением уличных наркотиков, и тюремного заключения больше, чем риска передозировки¹¹². Страх перед насилием и жестоким обращением также не позволял женщинам обращаться в службы наркологической помощи. Поэтому женщины, употребляющие опиоиды, могут воспринимать повышенный риск вреда, связанного с опиоидами, в рамках занимаемого ими маргинализированного пространства в местных точках употребления наркотиков¹¹³.

РИС. 28 Случаи смерти от передозировки опиоидов в разбивке по гендерному признаку, Соединенные Штаты, 2010–2022 годы

Number of overdose deaths	Число случаев смерти от передозировки
Any opioid overdose deaths	Случаи смерти от передозировки любых опиоидов
90,000	90 000
80,000	80 000
70,000	70 000
60,000	60 000
50,000	50 000
40,000	40 000
30,000	30 000
20,000	20 000
10,000	10 000
Overdose any opioid men	Передозировка любых опиоидов среди мужчин
Overdose any opioid women	Передозировка любых опиоидов среди женщин
Number of overdose deaths	Число случаев смерти от передозировки
Overdose deaths attributed to synthetic opioids	Случаи смерти от передозировки синтетических наркотиков
80,000	80 000
70,000	70 000
60,000	60 000
50,000	50 000
40,000	40 000
30,000	30 000
20,000	20 000
10,000	10 000
Women	Женщины

Мен	Мужчины
-----	---------

Источник: национальные данные о случаях смерти от передозировки наркотиков Центра по контролю заболеваний; данные системы WONDER ЦКПЗ о случаях смерти по множественным причинам за 2024 год.

Женщины в несоизмеримо большей степени сталкиваются с препятствиями в плане доступа к наркологической помощи и другим услугам

Ключевые респонденты, опрошенные в семи странах, были единодушны в том, что женщины в целом в несоизмеримо большей степени сталкиваются с препятствиями в плане доступа и пользования медицинскими и социальными услугами, предлагаемыми наркопотребителям. Упомянутые опрошенными причины такой гендерной асимметрии можно разделить на четыре общие категории. Во-первых, зачастую наблюдается недостаточная осведомленность о доступных услугах по оказанию наркологической помощи, особенно среди женщин¹¹⁴. Во-вторых, часто отмечается отсутствие гендерно ориентированных учреждений и служб¹¹⁵. Это означает, что женщины не могут найти услуги, соответствующие их потребностям, и вынуждены пользоваться теми, которые созданы без учета их потребностей, и поэтому могут им не подходить или их не устраивать. В-третьих, стигматизация в связи с употреблением наркотиков, от которой, как упоминалось выше, в несоизмеримо большей степени страдают женщины-наркопотребители, способствует нежеланию женщин обращаться в существующие службы¹¹⁶. По этой причине один из опрошенных предположил, что оценки в отношении женщин-наркопотребителей на основе данных в отношении лиц, обращающихся за наркологической помощью, могут ввести в заблуждение, поскольку это, скорее всего, приведет к занижению показателей в отношении женщин, употребляющих наркотики или страдающих наркологическими расстройствами. Четвертая отмеченная категория причин — это стоимость услуг, которая может быть слишком высокой для женщин в силу их очевидно более уязвимого социально-экономического или финансового положения¹¹⁷. Признавая, что стоимость услуг является препятствием, один из опрошенных в Сенегале тем не менее упомянул, что секс-работникам, обращающимся за наркологической помощью в поликлиники, предлагали услуги со скидкой или даже бесплатно¹¹⁸.

«К мужчинам [и их наркопотреблению] относятся с определенной степенью терпимости. Однако когда речь идет о женщинах, терпимости нет вообще, и женщины принимают это близко к сердцу». (Интервью №83, поставщик услуг информационно-просветительского центра, декабрь 2023 года)

«Они [женщины] боятся ходить в медицинские учреждения, боятся стигматизации, боятся услышать что-то, что им не понравится, боятся, что их осудят... Этот страх мешает им ходить туда». (Интервью №84, представитель женской организации гражданского общества, декабрь 2023 года)

По мнению нескольких опрошенных, важные причины большой диспропорции в доступе к услугам касаются не только отсутствия специализированных услуг по лечению наркологических расстройств. Они также касаются широкого спектра услуг (например, приютов для жертв домашнего насилия), которыми наркопотребители могли бы пользоваться в условиях стигматизации наркопотребления. Например, двое опрошенных в Казахстане, имеющих опыт употребления наркотиков, отметили, что женщинам-наркопотребителям не разрешается посещать кризисные центры для жертв насилия¹¹⁹. Это подтверждается результатами исследований, которые указывают на существование гендерных различий и препятствий в плане доступа к ряду наркологических услуг и их наличия^{120, 121, 122}.

«В нашей стране женщина, страдающая поведенческим расстройством, не имеет права получать социальную помощь в кризисных центрах или консультации по вопросам насилия». (Интервью №32, представитель сети наркопотребителей, декабрь 2023 года)

Наркологическая помощь подросткам, как правило, не оказывается

Что касается возрастных различий, то молодые люди, особенно несовершеннолетние, по мнению экспертов, также как и женщины, в несоизмеримо большей степени сталкиваются с препятствиями. К ним относятся отсутствие услуг, соответствующих возрасту или рассчитанных на конкретный возраст, недостаточная осведомленность о существующих услугах и стоимости предлагаемых услуг, которая зачастую является неподъемной¹²³. Также, как и в случае с женщинами, роль стигматизации и связанное с ней нежелание обращаться за помощью были упомянуты в качестве факторов, препятствующих доступу молодых людей к наркологической помощи, например в ситуациях, когда родителям становится известно о том, что их ребенок подлежит постановке на наркологический учет¹²⁴. Во многих странах несовершеннолетние, то есть лица в возрасте до 18 лет, не могут получить доступ к наркологической помощи или другим медицинским услугам без согласия родителей^{125, 126, 127}. Несколько опрошенных также упомянули о получении согласия родителей и оформлении юридических документов для несовершеннолетних, страдающих наркологическими расстройствами, необходимых для начала лечения, что может стать серьезным препятствием в отношении доступа к наркологической помощи¹²⁸. По мнению некоторых опрошенных экспертов, можно не добиться согласия родителей, если они опасаются стигматизации со стороны общества в связи с наличием в семье ребенка-наркопотребителя, а также проведения юридических процедур по постановке на наркологический учет, или если сами родители подвергаются стигматизации в связи с употреблением наркотиков. Некоторые эксперты из стран, где за оказание наркологической помощи отвечают национальные «наркологические департаменты», сообщили, что, хотя подростки, арестованные по обвинению в употреблении и хранении наркотиков, содержатся в «исправительных учреждениях для несовершеннолетних», при необходимости они проходят лечение в медицинских учреждениях для взрослых¹²⁹.

«Подросток или молодой человек думает: “Я приду поговорить с наркологом, но об этом сразу же сообщат моим родителям”». (Интервью №32, представитель сети наркопотребителей, декабрь 2023 года)

Различия в приобретении наркотиков

Опрошенные, как правило, отмечали, что женщины обычно приобретают наркотики с помощью лиц из своего ближайшего социального окружения, таких как партнеры и друзья¹³⁰. В тех случаях, когда женщины непосредственно сами приобретали наркотики, среди упомянутых опрошенными способов приобретения были доставка на дом, покупка в клубах, а в случае секс-работников — через их закупщиков¹³¹. Поэтому считается, что женщины реже посещают уличные рынки или известные «горячие точки», чем мужчины, которые зачастую покупают товары у незнакомцев или торговцев на уличных рынках¹³². Главной причиной такого различия является тот факт, что уличные покупки считаются сопряженными с заметным риском для безопасности женщин¹³³. Еще одной причиной, которую назвали опрошенные сотрудники медико-санитарных служб и аптек в Сенегале, является наличие культурных ожиданий и социальных норм, в соответствии с которыми женщинам, особенно молодым, не рекомендуется посещать определенные общественные места, например бары, по крайней мере без сопровождения мужчины¹³⁴. Поэтому приобретение синтетических наркотиков, в том числе лекарственных препаратов для неконтролируемого или немедицинского употребления, по почте, через контейнеры-закладки, неформальные сети и пункты распространения

(например, неформальные аптеки в Западной и Центральной Африке) обеспечивает женщинам определенные преимущества.

Предоставление услуг сексуального характера в обмен на деньги для покупки наркотиков обстоятельно изучалось в контексте употребления синтетических наркотиков¹³⁵. Приобретение метамфетамина или других синтетических наркотиков женщинами, в том числе девочками-подростками в рамках предоставления сексуальных услуг за вознаграждение также обсуждалось в научной литературе, особенно в контексте гендерной динамики властных полномочий и культурно подчеркнутой женственности, то есть социально одобренной модели женственности, которая позиционирует женщин как лиц, созданных в дополнение к мужчинам и занимающих более низкое положение по сравнению с ними^{136, 137, 138}.

Что касается возрастных различий, связанных с приобретением синтетических наркотиков, то, по свидетельствам опрошенных, молодые люди наиболее склонны отходить от традиционной модели очных продаж, особенно на уличных рынках или в «горячих точках». Вместо этого они предпочитают такие способы, как доставка на дом (оформленная через интернет или по телефону) и приобретение наркотиков у друзей и знакомых¹³⁹. По сообщениям, важным каналом приобретения наркотиков в Казахстане и в меньшей степени в Сенегале и Таиланде являются также платформы социальных сетей¹⁴⁰. Причины этого, по мнению опрошенных, кроются в знакомстве молодых людей с новыми технологиями, а также в том, что на традиционных рынках преобладают люди более старшего возраста, и поэтому они могут быть не очень привлекательными для молодежи¹⁴¹.

«Теперь не нужно обращаться к наркодилерам, как в случае с распространением опиоидов. Раньше все делалось через одного человека (и у тебя должен быть доступ к этому дилеру), а теперь все происходит через “Телеграм”». (Интервью №32, представитель сети наркопотребителей, декабрь 2023 года)

Гендерные различия в количестве арестов и контактов с системой уголовного правосудия из-за правонарушений, связанных с наркотиками

Анализ данных, связанных с предложением наркотиков (например, количество арестов за правонарушения, связанные с наркотиками, с разбивкой по гендерной принадлежности и отдельных случаев изъятий с указанием гендерной принадлежности преступника), свидетельствует о наличии различий между мужчинами и женщинами.

Судя по общим данным по миру, представленным государствами-членами¹⁴², подавляющее большинство лиц, столкнувшихся с системой уголовного правосудия из-за правонарушений, связанных с наркотиками, составляют мужчины. В период 2010–2022 годов почти 90 процентов всех арестов за правонарушения, связанные с наркотиками (включая как правонарушения, связанные с производством и незаконным оборотом наркотиков, так и правонарушения, связанные с хранением наркотиков для личного потребления), приходилось на мужчин. Хотя в период 2010–2022 годов доля женщин в разных странах мира варьировала от 0 до 37 процентов, ни в одной стране женщины не превосходили мужчин по числу официальных контактов с полицией в связи с правонарушениями, связанными с наркотиками. Со временем стала наблюдаться некоторая тенденция к увеличению доли женщин, совершивших правонарушения, связанные с наркотиками: с 8,6 процента в 2010 году до 10,8 процента в 2022 году. Однако пробелы в сборе данных и отчетности заставляют с осторожностью подходить к толкованию этих общемировых оценок. Что касается синтетических наркотиков, то пробелы в данных могут быть еще более актуальными, учитывая, насколько быстро новые синтетические наркотики могут появляться на рынке или, в случае с НПВ, исчезать с него, а также могут быть неверно идентифицированы лицами, занимающимися сбором или представлением данных об арестах или изъятиях.

Данные о лицах, имевших официальные контакты с органами полиции из-за правонарушений, связанных с наркотиками, свидетельствуют о том, что доля женщин среди таких лиц в целом выше

в случае синтетических наркотиков (15,1 процента в период 2015–2019 годов), чем в случае наркотиков растительного происхождения (10 процентов в тот же период). Это относится как к хранению, так и к незаконному обороту. В то же время данные показывают, что доля женщин, арестованных за хранение наркотиков, в целом выше, чем в связи с незаконным оборотом наркотиков, независимо от категории наркотиков¹⁴³.

Тем не менее существуют различия внутри каждой категории наркотиков, а именно между наркотиками растительного происхождения и синтетическими наркотиками. В среднем доля женщин, арестованных за правонарушения, связанные с наркотиками, варьирует в зависимости от конкретного наркотика: от 1,1 до 15,6 процента в случае наркотиков растительного происхождения и от 3,7 до 27,5 процента в случае синтетических наркотиков (в период 2015–2019 годов)¹⁴⁴.

Существуют также различия между странами. В период 2015–2019 годов в Северной Америке, Океании, Европе и Восточной Азии за правонарушения, связанные с синтетическими наркотиками, арестовывали больше женщин, чем за правонарушения, связанные с наркотиками растительного происхождения, в то время как в ряде стран Латинской Америки, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии наблюдалась обратная картина¹⁴⁵.

РИС. 29 Доля женщин среди лиц, имевших официальные контакты с органами полиции из-за правонарушений, связанных с наркотиками, 2010–2019 годы

Proportion of women (percentage)	Доля женщин (проценты)
Synthetic	Синтетические наркотики
Plant-based	Наркотики растительного происхождения

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

Примечание: данные охватывают 98 стран; процентные доли представляют собой примерные расчетные средние величины.

РИС. 30 Доля женщин среди лиц, имевших официальные контакты с органами полиции из-за правонарушений, связанных с наркотиками, в разбивке по категориям правонарушений, связанных с наркотиками, 2015–2019 годы

Proportion of women (percentage)	Доля женщин (проценты)
Possession	Хранение
10.4%	10,4%
16.1%	16,1%
Trafficking	Незаконный оборот
9%	9%
13.4%	13,4%
Possession and/or trafficking	Хранение и/или незаконный оборот
10%	10%
15.1%	15,1%
Plant-based drugs	Наркотики растительного происхождения
Synthetic drugs	Синтетические наркотики

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

Примечание: информация основана на данных, представленных в период 2015–2019 годов 64 странами и территориями, из которых 13 находятся в Африке, 15 — в Азии, 15 — в Северной и Южной Америке, 19 — в Европе и 2 — в Океании.

КАРТА 12 Категории наркотиков, на которые приходится наибольшая доля женщин, совершивших правонарушения, связанные с наркотиками*, 2019 год или последний год, за который имеются данные (2015–2018 годы)

Drug category with highest proportion of women	Категория наркотиков, на которую приходится наибольшая доля женщин
Plant-based drugs	Наркотики растительного происхождения
Synthetic drugs	Синтетические наркотики
No data	Нет данных

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается спор относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Источник: УНП ООН, данные опросника к ежегодному докладу.

Примечание: карта подготовлена на основе информации, полученной от 61 страны и территории, из которых 12 находятся в Африке, 14 — в Азии, 15 — в Северной и Южной Америке, 18 — в Европе и 2 — в Океании. В целом в 44 странах и территориях более высокая доля женщин приходилась на синтетические наркотики, чем на наркотики растительного происхождения, а в 17 странах и территориях доля женщин была выше в случае наркотиков растительного происхождения, чем в случае синтетических наркотиков.

**Категории наркотиков, на которые приходится наибольшая доля женщин, имевших официальные контакты с органами полиции из-за правонарушений, связанных с наркотиками (хранение и незаконный оборот).*

РИС. 31 Доля женщин среди лиц, имевших официальные контакты с органами полиции из-за правонарушений, связанных с наркотиками, в разбивке по виду наркотиков, 2015–2019 годы

Proportion of females in offences (percentage)	Доля женщин-правонарушителей (проценты)
Other plant-based substances 15.6%	Другие вещества растительного происхождения 15,6%
Heroin 14.9%	Героин 14,9%
Cocaine 14.6%	Кокаин 14,6%
AVERAGE 10%	СРЕДНЕЕ 10%
Cannabis-type 9.7%	Вещества каннабисной группы 9,7%
Plant-based NPS 1.1%	НПВ растительного происхождения 1,1%
27.5% Methamphetamine	27,5% Метамфетамин
24.8% Miscellaneous	24,8% Различные вещества
23.4% Pharmaceutical opioids	23,4% Опиоидные лекарственные средства
19.2% Other substances not under international control	19,2% Прочие вещества, на которые не распространяется международный контроль
19.0% GHB	19,0% ГОМК
17.4% ATS	17,4% САР
17.2% Sedatives and tranquillizers	17,2% Седативные средства и транквилизаторы
16.7% Synthetic drugs	16,7% Синтетические наркотики

15.7% Hallucinogens	15,7% Галлюциногены
15.1% AVERAGE	15,1% СРЕДНЕЕ
14.3% Synthetic opioids	14,3% Синтетические опиоиды
10.6% Other NPS	10,6% Другие НПВ
8% Other stimulants	8% Другие стимуляторы
5.1% “Ecstasy”	5,1% Экстези
3.7% Psychotropic substances	3,7% Психотропные вещества
Plant-based drugs	Наркотики растительного происхождения
Synthetic drugs	Синтетические наркотики

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу.

Согласно информации, представленной государствами-членами¹⁴⁶, доля женщин, подвергшихся уголовному преследованию, осужденных или приговоренных за преступления, связанные с наркотиками, ниже, чем доля мужчин, возможно, потому, что большее число женщин подвергается уголовному преследованию, осуждается или приговаривается за преступления, связанные с хранением наркотиков, чем за преступления, связанные с их незаконным оборотом. Однако насколько эти различия связаны с видом наркотиков, в незаконном обороте которых участвуют мужчины и женщины, определить пока сложно из-за отсутствия соответствующих данных по видам наркотиков. Тем не менее женщины, сталкивающиеся с системой уголовного правосудия из-за преступлений, связанных с наркотиками, зачастую ранее подвергались жестокому обращению и имеют проблемы с психическим здоровьем; они могут быть жертвами торговли людьми или торговли сексуальными услугами и принуждаться к провозу наркотиков, а находясь под стражей, часто подвергаются еще большему насилию и жестокому обращению¹⁴⁷.

Различия в участии в поставках синтетических наркотиков

В ходе исследований, в том числе при подготовке предыдущих изданий *Всемирного доклада о наркотиках*, были выявлены существенные различия, касающиеся роли, которую играют мужчины и женщины в незаконном распространении и приобретении наркотиков¹⁴⁸. Мужчины зачастую чрезмерно представлены в наиболее заметных и рискованных сферах предложения наркотиков, таких как незаконный оборот и распространение. Они более склонны заниматься деятельностью, связанной с организованной преступностью, крупномасштабными операциями по производству и распространению наркотиков, а также совершать акты насилия¹⁴⁹. Женщины же, напротив, занимают, как считается, менее заметное положение в цепочке поставок наркотиков: им отводится роль курьеров, они занимаются сокрытием наркотиков или участвуют в деятельности менее заметных небольших сетей¹⁵⁰. Мотивы участия в поставках наркотиков также различаются на гендерном уровне: на мужчин зачастую влияют экономические факторы и иерархические структуры, женщины же могут вовлекаться в торговлю по причине межличностных отношений, принуждения или экономической уязвимости. Как это ни парадоксально, но некоторые женщины, занимающиеся незаконной наркоторговлей, подчеркивают, что участие в незаконном производстве или распространении наркотиков порой позволяет им достичь экономической самостоятельности или получить более широкие права и возможности^{151, 152}.

Производство синтетических наркотиков не имеет географической привязки, однако оно может быть связано с каналами распространения (такими как, например, почтовая система, социальные сети или неформальные рынки, на которых продаются лекарственные препараты, ставшие объектом утечки), что позволяет снизить степень вовлеченности субъектов, прибегающих к насилию¹⁵³. Пока неясно, могут ли эти особенности объяснить более активное участие женщин в незаконных поставках синтетических наркотиков (особенно если женщины руководствуются такими

соображениями, как экономические стимулы, самостоятельность или расширение прав и возможностей) по сравнению с незаконной экономикой, в которой преобладают традиционные наркотики растительного происхождения и которая зачастую опирается на вооруженных или прибегающих к насилию субъектов, действующих на нескольких уровнях цепочки поставок.

Различия в структуре незаконного оборота

Анализ нескольких сотен тысяч случаев изъятия отдельных особо крупных партий наркотиков¹⁵⁴ подтверждает, что поставками наркотиков главным образом занимаются мужчины, что согласуется с ранее сделанными выводами, основанными на агрегированных данных, представленных государствами-членами. Информация об арестованных в ходе мероприятий по изъятию наркотиков свидетельствует о некоторых гендерных и возрастных различиях, когда речь идет о синтетических наркотиках и наркотиках растительного происхождения. В целом арестованные в связи с синтетическими наркотиками являются лицами более молодого возраста, а размер партии зависит от вида соответствующего синтетического наркотика, причем доля женщин среди арестованных в связи с синтетическими наркотиками гораздо больше, чем среди арестованных в связи с наркотиками растительного происхождения.

В период 2013–2023 годов мужчины были причастны к почти 92 процентам всех случаев изъятий. Однако, как свидетельствуют данные по всем трем рассматриваемым весовым классам (изъятия весом менее 1 кг, изъятия весом более 1 кг и изъятия в единичном или поштучном выражении), доля женщин, которые, по сообщениям, были причастны к случаям изъятия синтетических наркотиков, была более высокой, чем в случаях, связанных с наркотиками растительного происхождения. Наиболее высокая доля приходилась на изъятия весом 1 кг и более (соответственно 14 процентов в случае синтетических наркотиков и 9 процентов в случае наркотиков растительного происхождения).

РИС. 32 Доля арестованных женщин, причастных к отдельным значительным изъятиям во всем мире, в разбивке по весовым классам и категориям наркотиков, 2013–2023 годы

Percentage	Процентная доля
<1kg	< 1 кг
1kg+	1 кг+
Plant-based	Наркотики растительного происхождения
Synthetic	Синтетические наркотики

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

Примечание: пунктирная горизонтальная линия соответствует совокупной средней доле. Для четкого разделения крупных изъятий, связанных с незаконным оборотом, и более мелких изъятий, связанных поставками и хранением, использовался вес изъятия в 1 кг.

РИС. 33 Доля женщин, причастных к отдельным значительным изъятиям во всем мире, в разбивке по категориям наркотиков и весовым классам, 2013–2023 годы

<1kg	< 1 кг
1kg+	1 кг+
Percentage	Процентная доля
Fentanyl-type	Вещества фентанилового ряда
Methadone	Метадон
Poppy seeds	Семена мака
Khat (Catha edulis)	Кат (Catha edulis)

Amphetamine-type	Вещества амфетаминового ряда
Heroin	Героин
Cocaine-type	Вещества кокаиновой группы
Psilocybin	Псилоцибин
Ketamine	Кетамин
Tramadol	Трамадол
Synthetic cathinones	Синтетические катиноны
MDMA-type	Продукты типа MDMA
Sedative/Tranquillizer	Седативные средства/транквилизаторы
Poppy straw	Маковая солома
Synthetic cannabinoid	Синтетические каннабиноиды
GBL	ГБЛ
Cannabis-type	Вещества типа каннабиса
Opium	Опий
LSD	ЛСД

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

Примечание: включены категории наркотиков, по которым имеется по меньшей мере 30 наблюдений. Пунктирная линия соответствует средней доле каждой весовой категории изъятий. Вещества фентанилового ряда — это фентанил и аналоги фентанила, как указано в вопроснике к ежегодному докладу. К амфетаминам относятся амфетамин и метамфетамин. К продуктам типа MDMA относятся MDMA и МДА, а также другие аналоги.

Как и в случае с данными о правонарушениях, связанных с наркотиками, из сводной отчетности государств-членов¹⁵⁵, доля арестованных женщин варьирует в зависимости от вида наркотика. Хотя в целом среди лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, преобладают мужчины, на женщин приходится наибольшая доля лиц, участвующих в незаконном обороте ряда синтетических опиоидов, таких как фентанил и метадон. Наибольшая доля арестов женщин приходилась на изъятия веществ фентанилового ряда весом не более 1 кг. При этом почти каждый пятый из арестованных в связи с изъятием партий фентанила весом менее 1 кг и каждый четвертый из арестованных в связи с партий более 1 кг были женщинами. Это примерно в два раза больше средней доли этих весовых классов. По сообщениям, ни одна женщина не была арестована в связи с изъятием менее распространенных НПВ растительного происхождения, таких как кратор (*Mitragyna speciosa*), других опиатов или дезоморфина.

В целом аресты мужчин и женщин были связаны с изъятиями партий примерно одинакового веса. Вместе с тем женщины были причастны к изъятиям более крупных партий стимуляторов амфетаминового ряда (медианный вес партии 10,3 кг в случае женщин и 5,76 кг в случае мужчин соответственно), а также каннабиса или продуктов на основе каннабиса (3,26 кг и 3 кг соответственно). Аресты мужчин были связаны с изъятиями значительно более крупных партий трамадола (медианный вес партии 3 кг и 1,6 кг соответственно). Что касается изъятий весом от 50 г до 1 кг, то среди женщин значительно более крупные по весу изъятия были только в случае каннабиса (200 г и 178 г соответственно) и кокаина (243 г и 150 г соответственно), тогда как вес изъятий опия, к которым причастны мужчины, был статистически значимо выше (350 г и 132 г соответственно). В этой категории в отношении веса синтетических наркотиков различий между полами не наблюдалось.

Что касается возраста, то, судя по данным изъятий, лица, занимающиеся незаконным оборотом синтетических наркотиков, несколько моложе лиц, арестованных за участие в поставках наркотиков растительного происхождения. Различия были незначительными, но статистически значимыми (медианный возраст арестованных за участие в поставках синтетических наркотиков составлял 30 лет, тогда как средний возраст поставщиков наркотиков растительного происхождения был 32 года). Что касается пола и возраста, то женщины, арестованные в ходе отдельных изъятий, были в

среднем старше мужчин. Однако эти различия не являются значимыми в отношении всех наркотиков. При сравнении изъятий наркотиков растительного происхождения и синтетических наркотиков оказалось, что межполовые различия по медианному возрасту в случае синтетических наркотиков являются более значительными, чем в случае наркотиков растительного происхождения. По медианному возрасту женщины статистически значимо старше мужчин в случае героина (34 года для женщин и 32 года для мужчин соответственно), кокаина (33 года и 32 года соответственно), каннабиса (33 года и 31 год соответственно), трамадола (32 года и 28 лет соответственно), синтетических каннабиноидов (32 года и 27 лет соответственно) и седативных средств/транквилизаторов (33 года и 28 лет соответственно). Разница в возрасте между мужчинами и женщинами была более значительной в случае изъятий синтетических наркотиков, чем в случае изъятий наркотиков растительного происхождения.

РИС. 34 Весовая структура отдельных значительных изъятий объемом более 1 кг во всем мире в разбивке по категориям наркотиков и полу причастных лиц, 2013–2023 годы

Opium	Опий
Heroin	Героин
Cocaine-type	Вещества кокаиновой группы
Cannabis-type*	Вещества типа каннабиса*
Tramadol*	Трамадол*
Synthetic cathinones	Синтетические катиноны
Synthetic cannabinoid	Синтетические каннабиноиды
Sedative/Tranquillizer	Седативные средства/транквилизаторы
MDMA-type	Продукты типа МДМА
Ketamine	Кетамин
Fentanyl-type	Вещества фентанилового ряда
Amphetamine-type*	Вещества амфетаминового ряда
Weight (kg)	Вес (кг)
Women	Женщины
Men	Мужчины

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

*Примечание: крестиком отмечены средние значения. *указывает на значительную разницу в медианных весах при $p < 0,05$ с использованием критерия Уилкоксона. Вещества фентанилового ряда — это фентанил и аналоги фентанила, как указано в вопроснике к ежегодному докладу. К амфетаминам относятся амфетамин и метамфетамин. К продуктам типа МДМА относятся МДМА и МДА, а также другие аналоги.*

РИС. 35 Возрастная структура лиц, причастных к изъятиям, указывающим на их участие в незаконном обороте, в разбивке по их полу и категориям наркотиков во всем мире, 2013–2023 годы

Opium	Опий
Heroin*	Героин*
Cocaine-type*	Вещества кокаиновой группы*
Cannabis-type*	Вещества типа каннабиса*
Tramadol*	Трамадол*

Synthetic cathinones	Синтетические катиноны
Synthetic cannabinoid*	Синтетические каннабиноиды*
Sedative/Tranquillizer*	Седативные средства/транквилизаторы*
MDMA-type	Продукты типа МДМА
Ketamine	Кетамин
Fentanyl-type	Вещества фентанилового ряда
Amphetamine-type*	Вещества амфетаминного ряда
Age	Возраст
Women	Женщины
Men	Мужчины

Источник: УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков.

*Примечание: крестиком отмечены средние значения. *указывает на значительную разницу в медианных весах при $p < 0,05$ с использованием критерия Уилкоксона. Вещества фентанилового ряда — это фентанил и аналоги фентанила, как указано в вопроснике к ежегодному докладу. К амфетаминам относятся амфетамин и метамфетамин. К продуктам типа МДМА относятся МДМА и МДА, а также другие аналоги.*

Основные выводы о низкой вовлеченности женщин в незаконный оборот наркотиков по сравнению с мужчинами и большем размере партий в случае арестованных мужчин, о которых говорилось выше, в значительной степени соответствуют результатам опросов, проведенных в семи странах. Не было получено никаких свидетельств о заметном участии женщин в изготовлении синтетических наркотиков (например, синтезе), и, по общему мнению опрошенных, в незаконном обороте синтетических наркотиков преобладают мужчины, хотя несколько опрошенных в Казахстане предположили, что женщины нередко участвуют в распространении¹⁵⁶. Опрошенные заявили, что женщины, участвующие в распространении наркотиков, обычно занимают весьма рядовые должности в предпоследних или последних звеньях цепочки поставок¹⁵⁷. Приведенные опрошенными примеры деятельности женщин включают распространение наркотиков путем закладок, продажу из частных домов, организацию передачи наркотиков клиентам, а также привлечение клиентов и рекламу¹⁵⁸. Иногда применяется стратегия, в рамках которой женщины являются хранителями крупных тайников наркотиков. Ее отражением могут быть случаи, когда у таких женщин, составляющих, согласно данным отдельных изъятий и о правонарушениях, связанных с наркотиками, 10 процентов арестованных, обнаруживают более крупные по весу партии синтетических наркотиков.

«Женщины не являются владельцами магазинов, женщины не занимают высокооплачиваемые должности на вершине цепочки. Женщины выполняют роль тех, кто подсаживает вас на наркотики. Они похожи на сетевых менеджеров, рекламных агентов. Самая низкооплачиваемая и самая неприятная работа — это для женщин».
(Интервью №31, специалист по профилактике, декабрь 2023 года)

Опрошенные сошлись во мнении, что женщин обычно нанимают на должности, связанные с распространением, через родственников и знакомых¹⁵⁹. В некоторых случаях женщин могут принуждать к выполнению этих функций или они могут не знать о том, что речь идет о наркотиках¹⁶⁰; с другой стороны, как отметил один из опрошенных в Сенегале, от женщин ожидается соблюдение принятым в некоторых обществах культурных и социальных норм, согласно которым, они не могут не подчиниться указаниям своего партнера-мужчины распространять наркотики¹⁶¹. Кроме того, в качестве факторов, способствующих вовлечению женщин в незаконный оборот, были названы неблагополучие и низкий социально-экономический статус¹⁶².

«Необходимо слушаться мужа, чтобы не прослыть “плохой женой”». (Интервью №80, правоохранительный орган, декабрь 2023 года)

Опрошенные из разных стран назвали две причины, по которым женщины могут быть более привлекательным вариантом для организации сетей сбыта, чем мужчины. Во-первых, считается, что женщины чаще избегают задержания полицией. Это связано с тем, что полиция может быть настроена на поиск мужчин в рамках своих мероприятий по пресечению преступлений, а женщины в целях сокрытия и увливания могут прибегать к уловкам (например, симулировать беременность), которыми не могут воспользоваться мужчины¹⁶³. Во-вторых, хотя высказанное ранее мнение о повышенном риске злоупотреблений со стороны властей, с которым сталкиваются женщины, остается в силе, желание наркоторговцев вовлекать женщин в свои схемы распространения, может быть обусловлено тем, что власти могут относиться к ним более снисходительно¹⁶⁴. Как показало проведенное в Китае качественное исследование по вопросам, касающимся женщин, употребляющих и продающих наркотики, женщины, продающие наркотики, ограничивают продажи своим социальным кругом, придерживаясь ближнего круга лиц, употребляющих наркотики¹⁶⁵. Вместо того чтобы получать большую прибыль, женщины, продававшие наркотики, стремились помочь друзьям и в процессе этого приобретали наркотики для собственного употребления.

Растущий спрос на метамфетамин также привел к разработке индивидуальных, недорогих и низкотехнологичных процессов изготовления наркотиков на дому. Так обстоит дело в Соединенных Штатах, где эту практику принято называть методом shake and bake («сделать на коленке»)¹⁶⁶. Хотя некоторые женщины могут работать вместе с мужчинами, выполняя «традиционные функции по уходу или поддержке» при изготовлении метамфетамина, другие женщины, по некоторым данным, работают самостоятельно или играют ведущую роль. Это обеспечило женщинам, употребляющим или продающим наркотики, относительную независимость как в финансовом плане, так и в плане того, что они меньше зависят от оказания сексуальных услуг в обмен на наркотики или в меньшей степени подвергаются сексуальному насилию^{167, 168}.

Один из опрошенных даже предположил, что, подобно данным об оказании наркологической помощи, о которых говорилось выше, данные системы уголовного правосудия могут занижать истинные масштабы участия женщин в незаконном обороте наркотиков¹⁶⁹. Аналогичным образом, другой опрошенный предположил, что женщины, употребляющие наркотики, могут быть недостаточно представлены в данных полиции, потому что они стараются скрывать свое наркопотребление, учитывая тот факт, что они не в соразмерно большей степени, подвергаются стигматизации, чем мужчины¹⁷⁰.

РИС. 36 Пример схемы поставки и приобретения синтетических наркотиков

Manufacture in clandestine laboratories	Изготовление в подпольных лабораториях
Transportation in bulk between or to cities	Оптовые перевозки между городами или в города
Storage of products in large batches, known as “bombs”, in the suburbs or forest belt around cities	Хранение крупных партий продуктов под названием «бомбы» в пригородах или лесополосах вокруг городов
Client	Клиент
Distribution of retail quantities, known as “mines”, in cities	Распространение розничных партий под названием «мины» в городах
Online drug marketing and transactions	Сбыт наркотиков и коммерческие операции с ними в интернете
PURCHASE	ПОКУПКА

Источник: интервью в Казахстане.

Что касается возраста, то картина вовлечения молодых людей в незаконный оборот синтетических наркотиков весьма схожа с той, что наблюдается среди женщин. По мнению всех опрошенных, молодежь не принимает какого-либо заметного участия в производстве, а ее участие в незаконном обороте, как правило, рассматривается ими как ограниченное¹⁷¹. Молодые люди, участвующие в цепочке поставок, занимают весьма рядовые должности в конечных ее звеньях, выполняя такие функции, как конечное распространение среди клиентов и устройство закладок¹⁷². Как и в случае с женщинами, в качестве важного канала вербовки в ряды распространителей наркотиков были названы семьи¹⁷³, хотя один из опрошенных в Казахстане также упомянул о вербовке молодых людей через социальные сети¹⁷⁴. Жители Таиланда, имеющие опыт употребления наркотиков и проходящие реабилитацию, отметили, что участие детей и подростков в распространении наркотиков, как правило, в рамках эксплуататорской схемы под надзором взрослых, не является редкостью¹⁷⁵. В связи с этим двое опрошенных в Таиланде отметили, что дети не всегда понимают, что им поручают перевозить¹⁷⁶. Кроме того, один из опрошенных в Таиланде упомянул о роли детей и подростков в продаже наркотиков своим сверстникам¹⁷⁷. В сведениях из Казахстана говорится об участии молодых людей в распространении наркотиков как о заметном явлении, причем в качестве основного мотива указывается быстрый и хороший заработок от наркоторговли по сравнению с законной работой¹⁷⁸. Получение дохода также упоминалось в качестве мотива в Иордании¹⁷⁹. Кроме того, в Иордании и Таиланде опрошенные прямо указывали на более мягкие наказания, применяемые к детям/молодым людям, признанным виновными в связи с участием в незаконном обороте наркотиков, как на важный фактор, способствующий их вербовке в сети наркоторговцев¹⁸⁰. В Казахстане более мягкие уголовные наказания также назывались в качестве фактора, способствующего заинтересованности несовершеннолетних в распространении наркотиков¹⁸¹. В этой связи один из опрошенных, являющийся сотрудником правоохранительного органа, добавил, что вербовщики могут намеренно вводить молодых людей в заблуждение, заставляя их поверить в то, что статус несовершеннолетнего полностью освобождает их от уголовной ответственности¹⁸². Наконец, в Таиланде человек, имеющий опыт употребления наркотиков, предположил, что молодые люди хорошо работают в качестве розничных распространителей наркотиков, поскольку они способны в случае необходимости опередить полицию и скрыться от нее¹⁸³.

Выводы и последствия

Наличие гендерных различий в области спроса на наркотики были давно установлены в ходе исследований. На мужчин приходится более значительная доля наркопотребителей. Они также подвергаются более высоким рискам и вреду, связанным с употреблением наркотиков, поскольку вероятность их вовлечения в опасные модели поведения, такие как употребление наркотиков путем инъекций или интенсивное потребление наркотиков, выше. Тем не менее, женщины, употребляющие наркотики, причиняют больший вред своему здоровью и сталкиваются с более серьезными социальными проблемами, чем мужчины, поскольку они чаще заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков путем инъекций, у них быстрее развиваются наркологические расстройства, они чаще подвергаются стигматизации, жестокому обращению и насилию, а также имеют более ограниченный доступ к наркологической помощи и медицинскому обслуживанию, чем мужчины. Синергетическая связь гендерного насилия, ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, среди женщин и девочек, употребляющих наркотики, подтверждена многочисленными документальными свидетельствами¹⁸⁴. Более того, документально подтверждено, что показатели наркопотребления в форме неконтролируемого или немедицинского употребления лекарственных средств среди женщин практически такие же, как и среди мужчин. Причины этих различий многочисленны и могут быть связаны с социальными установками или

внутренними различиями между полами. Онлайн-платформы обеспечивают более широкий доступ к синтетическим наркотикам и возможности для их употребления, особенно для молодежи.

Гендерные различия, связанные с предложением наркотиков, могут быть обусловлены целым рядом факторов, включая гендерные роли и ожидания. В целом незаконное предложение наркотиков — это сфера деятельности, в которой преобладают мужчины. Мужчины представлены на всех уровнях цепочки поставок и, как правило, считаются более склонными к насильственному поведению, когда речь идет о незаконном обороте и распространении наркотиков, а также мотивированными побуждениями экономического и социально-иерархического характера^{185, 186}. Зачастую считается, что женщины, занимающиеся незаконной поставкой наркотиков, подвергаются принуждению к участию в преступной деятельности и большему риску насилия и жестокого обращения, хотя исследования документально подтверждают тот факт, что некоторые женщины могут использовать участие в незаконной экономике для достижения экономической самостоятельности или расширения своих прав и возможностей¹⁸⁷.

Полученные от опрошенных ответы и анализ данных о лицах, имевших официальный контакт с полицией из-за правонарушений, связанных с наркотиками, в целом свидетельствуют о схожих закономерностях. Хотя показатели участия в поставках наркотиков в целом свидетельствуют о преобладании мужчин в этой сфере, женщины также занимаются этой деятельностью, и степень их участия в ней может варьировать в зависимости от вида наркотиков. Установлено, что зачастую на женщин приходится более высокая доля, когда речь идет об участии в поставках синтетических наркотиков, а не наркотиков растительного происхождения. Анализ случаев изъятий в разбивке по полу наркоторговцев показывает, что среди мужчин, занимающихся незаконным оборотом, размер партии существенно не отличается в зависимости от того, является ли наркотик синтетическим или растительного происхождения. В отличие от них женщины, занимающиеся незаконным оборотом, участвуют, согласно оценкам, в поставках более крупных по весу партий синтетических наркотиков по сравнению с наркотиками растительного происхождения. В рамках цепочки поставок наркотиков молодые люди зачастую занимаются распространением и сбытом на низовом уровне или продажей наркотиков через интернет. Кроме того, считается, что по сравнению со взрослыми молодые люди реже сталкиваются с системой уголовного правосудия в связи с правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотиков, за исключением правонарушений, связанных с хранением наркотиков для личного потребления.

Эти различия трудно объяснить без дополнительных исследований. Более крупный размер партий можно объяснить с помощью ряда гипотез. Например, различия в размерах партий в зависимости от категорий наркотиков могут быть связаны с ролью, которую женщины играют в сетях поставок (зачастую они являются курьерами или хранителями более крупных тайников), или, возможно, с тем, что правоохранительные органы уделяют основное внимание мужчинам. Более высокий уровень стигматизации женщин, употребляющих наркотики, может также способствовать употреблению женщинами лекарственных средств, полученных из незаконных источников или ставших предметом утечки, большинство из которых являются синтетическими, в целях сокрытия своего поведения, связанного с употреблением наркотиков.

По мере развития мировых рынков наркотиков и распространения производства синтетических наркотиков на новых и формирующихся рынках, а также по мере активизации участия женщин в экономической деятельности, роль женщин, которую они играют в проблеме наркотиков, может возрастать. Например, отказ от производства наркотиков растительного происхождения может затронуть многих женщин в сельских домохозяйствах, занимающихся культивированием опийного мака и кокаинового куста. Кроме того, вследствие синтеза наркотиков в некоторых случаях может сократиться цепочка поставок, а также уменьшиться зависимость от групп наркоторговцев, применяющих насилие. Это может привлечь больше женщин к участию в незаконных поставках наркотиков, если они смогут получать их по онлайн-каналам или непосредственно синтезировать их вблизи рынков конечного потребления.

Примечания и ссылки

- 1 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год* (Вена, Австрия 2023 год).
- 2 Большинство аналитических исследований по вопросам возраста относится к молодым людям (или молодежи), определяемым как лица в возрасте 15–24 лет.
- 3 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год*, брошюра 5 «Женщины и наркотики: наркопотребление, наркоснабжение и их последствия» (издание Организации Объединенных Наций, 2018 год).
- 4 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2023 год).
- 5 Интервью №2, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №6, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №22, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №24, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №25, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №32, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №8, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №34, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №38, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №47, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №48, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №64, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №65, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №33, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №82, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №85, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №89, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №88, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 6 Интервью №12, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №9, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года.
- 7 Интервью №12.
- 8 Интервью №82.
- 9 Интервью №85.
- 10 Интервью №3, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №6, интервью №26, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года.
- 11 Интервью №30, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года.
- 12 Liana Fattore et al., ‘Sex and Gender Differences in the Effects of Novel Psychoactive Substances’, *Brain Sciences* 10, no. 9 (3 September 2020): 606.
- 13 Cynthia Kuhn, ‘Emergence of Sex Differences in the Development of Substance Use and Abuse during Adolescence’, *Pharmacology & Therapeutics* 153 (September 2015): 55–78.
- 14 Francina Fonseca et al., ‘A Gender Perspective of Addictive Disorders’, *Current Addiction Reports* 8, no. 1 (March 2021): 89–99.
- 15 Angela J. H. Justice and Harriet de Wit, ‘Acute Effects of D-Amphetamine During the Early and Late Follicular Phases of the Menstrual Cycle in Women’, *Pharmacology Biochemistry and Behavior* 66, no. 3 (2000): 509–15.
- 16 Justin J. Anker and Marilyn E. Carroll, ‘Females Are More Vulnerable to Drug Abuse than Males: Evidence from Preclinical Studies and the Role of Ovarian Hormones’, in *Biological Basis of Sex Differences in Psychopharmacology*, ed. Jo C. Neill and Jayashri Kulkarni, vol. 8 (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010), 73–96.
- 17 Kaitlyn M. Little and Therese A Kosten, ‘Focus on Fentanyl in Females: Sex and Gender Differences in the Physiological and Behavioral Effects of Fentanyl’, *Frontiers in Neuroendocrinology* 71 (October 2023): 101096.
- 18 Mirsada Serdarevic, Catherine W. Striley, and Linda B. Cottler, ‘Sex Differences in Prescription Opioid Use’, *Current Opinion in Psychiatry* 30, no. 4 (July 2017): 238–46.
- 19 Committee on Pain Management and Regulatory Strategies to Address Prescription Opioid Abuse et al., *Pain Management and the Opioid Epidemic: Balancing Societal and Individual Benefits and Risks of Prescription Opioid Use*, ed. Richard J. Bonnie, Morgan A. Ford, and Jonathan K. Phillips (Washington, D.C.: National Academies Press, 2017).
- 20 Björn Gerdle et al., ‘Prevalence of Widespread Pain and Associations with Work Status: A Population Study’, *BMC Musculoskeletal Disorders* 9, no. 1 (December 2008): 102.

- 21 R. Kathryn McHugh et al., 'Gender Differences in the Prevalence of Heroin and Opioid Analgesic Misuse in the United States, 2015–2019', *Drug and Alcohol Dependence* 227 (1 October 2021): 108978.
- 22 Интервью №85.
- 23 National Institute on Drug Abuse, 'Sex and Gender Differences in Substance Use', 4 May 2022.
- 24 Mary-Lynn Brecht et al., 'Methamphetamine Use Behaviors and Gender Differences', *Addictive Behaviors* 29, no. 1 (January 2004): 89–106.
- 25 Liu Liu et al., 'Using Illicit Drugs to Lose Weight among Recovering Female Drug Users in China: An Exploratory Qualitative Study', *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 5 (24 February 2022): 2626.
- 26 Yu Mon Saw et al., 'Gender Difference in Early Initiation of Methamphetamine Use among Current Methamphetamine Users in Muse, Northern Shan State, Myanmar', *Harm Reduction Journal* 14, no. 1 (December 2017): 21.
- 27 Amy J. Jeffers and Eric G. Benotsch, 'Non-Medical Use of Prescription Stimulants for Weight Loss, Disordered Eating, and Body Image', *Eating Behaviors* 15, no. 3 (August 2014): 414–18.
- 28 Stephen F. Butler et al., 'Non-Medical Use of Prescription Stimulants Among College Students: Non-Oral Routes of Administration, Risk Factors, Motivations, and Pathways', *Frontiers in Psychiatry* 12 (16 August 2021): 667118.
- 29 Robert T. Fairman et al., 'Prescription Stimulant Use among Young Adult College Students: Who Uses, Why, and What Are the Consequences?', *Journal of American College Health* 69, no. 7 (3 October 2021): 767–74.
- 30 Jayne Lucke et al., 'Non-Medical Prescription Stimulant Use to Improve Academic Performance among Australian University Students: Prevalence and Correlates of Use', *BMC Public Health* 18, no. 1 (December 2018): 1270.
- 31 Интервью №2, интервью №6, интервью №14, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №16, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года.
- 32 Интервью №14.
- 33 Интервью №23, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №80, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №81, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №83, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №90, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 34 Интервью №92, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 35 Интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №80, интервью №81, интервью №84, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №85, интервью №90.
- 36 Интервью №24, интервью №25, интервью №26, интервью №27, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №32.
- 37 Интервью №19, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №20, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №21, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №69, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №23, интервью №26, интервью №27, интервью №28, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №32, интервью №7, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №69, интервью №84, интервью №85, интервью №88, интервью №90.
- 38 Интервью №2, интервью №92, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 39 Интервью №24.
- 40 Joseph M. Boden et al., 'Predictors of Methamphetamine Use in a Longitudinal Birth Cohort', *Addictive Behaviors* 144 (September 2023): 107714.
- 41 Saw et al., 'Gender Difference in Early Initiation of Methamphetamine Use among Current Methamphetamine Users in Muse, Northern Shan State, Myanmar'.
- 42 Oralia Loza, Priscilla Guevara, and Amir Hernandez, 'Gender Differences in Methamphetamine Use Initiation and Trajectory of Use Among People Who Use Methamphetamine in a Mexico-US Border City', *Addictive Disorders & Their Treatment* 20, no. 4 (December 2021): 288–302.

- 43 Serena Yunran Zhang and Jakob Demant, 'Effects of Self-control, Drug-use Peers and Family Attachment on Drug Use among Chinese Users: A Gender-specific Analysis', *Drug and Alcohol Review* 40, no. 7 (November 2021): 1369–76.
- 44 Azam Rastegari et al., 'Identifying the Factors Affecting Methamphetamine Use: A Scoping Review', *Medical Journal of The Islamic Republic of Iran*, 20 October 2023.
- 45 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год*, брошюра 5 «Женщины и наркотики: наркопотребление, наркоснабжение и их последствия» (издание Организации Объединенных Наций, 2018 год).
- 46 Shichao Tang et al., 'Adverse Childhood Experiences, Internalizing/ Externalizing Symptoms, and Associated Prescription Opioid Misuse: A Mediation Analysis', *Preventive Medicine* 134 (May 2020): 106034.
- 47 Roger J. R. Levesque, 'Externalizing and Internalizing Symptoms', in *Encyclopedia of Adolescence*, ed. Roger J. R. Levesque (Cham: Springer International Publishing, 2018), 1274–77.
- 48 Sanjaya Regmi et al., 'Association Between Adverse Childhood Experiences and Opioid Use-Related Behaviors: A Systematic Review', *Trauma, Violence, & Abuse*, 3 November 2023.
- 49 Elizabeth A. Swedo et al., 'Adolescent Opioid Misuse Attributable to Adverse Childhood Experiences', *The Journal of Pediatrics* 224 (September 2020): 102-109.e3.
- 50 Ekamjit Deol et al., 'Exploring the Link between ACEs and Opioid Use: A Systematic Review', *Journal of Opioid Management* 19, no. 4 (11 August 2023): 343–64.
- 51 Tang et al., 'Adverse Childhood Experiences, Internalizing/Externalizing Symptoms, and Associated Prescription Opioid Misuse'.
- 52 Yingying Ding et al., 'Adverse Childhood Experiences and Interaction with Methamphetamine Use Frequency in the Risk of Methamphetamine-Associated Psychosis', *Drug and Alcohol Dependence* 142 (September 2014): 295–300.
- 53 Thanh Luan Pham et al., 'Screening for Adverse Childhood Experiences among Young People Using Drugs in Vietnam: Related Factors and Clinical Implications', *Journal of Public Health* 45, no. 3 (28 August 2023): e400–408.
- 54 Wan-Chen Lee et al., 'Exploring the Mediating Role of Methamphetamine Use in the Relationship between Adverse Childhood Experiences and Attempted Suicide', *Addictive Behaviors* 123 (December 2021): 107060.
- 55 Ding et al., 'Adverse Childhood Experiences and Interaction with Methamphetamine Use Frequency in the Risk of Methamphetamine-Associated Psychosis'.
- 56 Интервью №1, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №23, интервью №24, интервью №25, интервью №30, интервью №10, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №11, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №7, интервью №83, интервью №84, интервью №87, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №90.
- 57 Интервью №60, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 58 Интервью №1.
- 59 Интервью №2, интервью №6.
- 60 Интервью №82, интервью №83.
- 61 Интервью №81.
- 62 Интервью №1, интервью №6, интервью №3, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №84, интервью №85.
- 63 Интервью №23, интервью №32.
- 64 Интервью №33.
- 65 Интервью №6, интервью №92, декабрь 2023 года.
- 66 Интервью №6, интервью №92.
- 67 Eleanor Blair Towers et al., 'Sex/Gender Differences in the Time-Course for the Development of Substance Use Disorder: A Focus on the Telescoping Effect', ed. Michael Nader, *Pharmacological Reviews* 75, no. 2 (March 2023): 217–49.

- 68 Celestina Barbosa-Leiker et al., 'Opioid Use Disorder in Women and the Implications for Treatment', *Psychiatric Research and Clinical Practice* 3, no. 1 (March 2021): 3–11.
- 69 Towers et al., 'Sex/Gender Differences in the Time-Course for the Development of Substance Use Disorder'.
- 70 Barbosa-Leiker et al., 'Opioid Use Disorder in Women and the Implications for Treatment'.
- 71 Dean E. Dluzen and Bin Liu, 'Gender Differences in Methamphetamine Use and Responses: A Review', *Gender Medicine* 5, no. 1 (2008): 24–35.
- 72 Согласно гипотезе о том, что люди, которые в основном занимаются эмоциональной адаптацией, с большей вероятностью будут употреблять наркотики как способ облегчения симптомов, связанных с проблемой (проблемами).
- 73 Jamie L. Simpson et al., 'Psychological Burden and Gender Differences in Methamphetamine-Dependent Individuals in Treatment', *Journal of Psychoactive Drugs* 48, no. 4 (7 August 2016): 261–69.
- 74 Fonseca et al., 'A Gender Perspective of Addictive Disorders'.
- 75 Интервью №1, интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №13, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №24, интервью №82, интервью №83, интервью №85.
- 76 Интервью №5, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №59, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №25, интервью №26, интервью №27, интервью №30, интервью №31, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №81, интервью №84.
- 77 Melissa H. Watt et al., 'Intimate Partner Violence among Men and Women Who Use Methamphetamine: A Mixed-methods Study in South Africa', *Drug and Alcohol Review* 36, no. 1 (January 2017): 97–106.
- 78 Miriam T.H. Harris et al., 'Competing Risks of Women and Men Who Use Fentanyl: "The Number One Thing I Worry about Would Be My Safety and Number Two Would Be Overdose"', *Journal of Substance Abuse Treatment* 125 (June 2021): 108313.
- 79 Shirley J. Semple et al., 'Correlates of Trading Sex for Methamphetamine in a Sample of HIV-Negative Heterosexual Methamphetamine Users', *Journal of Psychoactive Drugs* 43, no. 2 (April 2011): 79–88.
- 80 Barrot H. Lambdin et al., 'Associations between Perceived Illicit Fentanyl Use and Infectious Disease Risks among People Who Inject Drugs', *International Journal of Drug Policy* 74 (December 2019): 299–304.
- 81 Veronica M. Chiu and James O. Schenk, 'Mechanism of Action of Methamphetamine within the Catecholamine and Serotonin Areas of the Central Nervous System', *Current Drug Abuse Review* 5, no. 3 (1 October 2012): 227–42.
- 82 Lambdin et al., 'Associations between Perceived Illicit Fentanyl Use and Infectious Disease Risks among People Who Inject Drugs'.
- 83 Rebecca McKetin et al., 'Patterns of Smoking and Injecting Methamphetamine and Their Association with Health and Social Outcomes', *Drug and Alcohol Review* 40, no. 7 (November 2021): 1256–65.
- 84 Renee Zahnow et al., 'Injecting Drug Use: Gendered Risk', *International Journal of Drug Policy* 56 (June 2018): 81–91.
- 85 Karla D. Wagner et al., 'Control over Drug Acquisition, Preparation, and Injection: Implications for HIV and HCV Risk among Young Female Injection Drug Users', *ISRN Addiction* 2013 (3 June 2013): 1–9.
- 86 Louisa Gilbert et al., 'Targeting the SAVA (Substance Abuse, Violence, and AIDS) Syndemic Among Women and Girls: A Global Review of Epidemiology and Integrated Interventions', *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes* 69, no. Supplement 2 (1 June 2015): S118–27.
- 87 Nabila El-Bassel et al., 'Intimate Partner Violence and HIV Among Drug-Involved Women: Contexts Linking These Two Epidemics — Challenges and Implications for Prevention and Treatment', *Substance Use & Misuse* 46, no. 2–3 (10 January 2011): 295–306.
- 88 Louisa Gilbert et al., 'Targeting the SAVA (Substance Abuse, Violence, and AIDS) Syndemic Among Women and Girls: A Global Review of Epidemiology and Integrated Interventions', *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes* 69, no. Supplement 2 (1 June 2015): S118–27.

- 89 Интервью №1, интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №28, интервью №90.
- 90 Jennifer Lavalley et al., 'Negotiating Sex Work and Client Interactions in the Context of a Fentanyl-Related Overdose Epidemic', *Culture, Health & Sexuality* 23, no. 10 (1 October 2021): 1390–1405.
- 91 Alexandra B. Collins et al., 'Gender and the Overdose Crisis in North America: Moving Past Gender-Neutral Approaches in the Public Health Response', *International Journal of Drug Policy* 69 (July 2019): 43–45.
- 92 Harris et al., 'Competing Risks of Women and Men Who Use Fentanyl'.
- 93 Lavalley et al., 'Negotiating Sex Work and Client Interactions in the Context of a Fentanyl-Related Overdose Epidemic'.
- 94 Интервью №1.
- 95 Интервью №2, интервью №82.
- 96 Интервью №2, интервью №6, интервью №25, интервью №30, интервью №53, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №61, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 97 Интервью №1, интервью №28, интервью №30, интервью №31, интервью №85.
- 98 Интервью №28, ноябрь 2023 года.
- 99 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, (2023 год).
- 100 Интервью №1, интервью №2, интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №28, интервью №84, интервью №90.
- 101 Интервью №85.
- 102 Интервью №24, интервью №25, интервью №27, интервью №31, интервью №32.
- 103 Интервью №83, интервью №88, интервью №90.
- 104 Daniel Ciccarone, 'The Triple Wave Epidemic: Supply and Demand Drivers of the US Opioid Overdose Crisis', *International Journal of Drug Policy* 71 (September 2019): 183–88.
- 105 Federal, provincial, and territorial Special Advisory Committee on the Epidemic of Opioid Overdoses, 'Opioid- and Stimulant-Related Harms in Canada' (Ottawa: Public Health Agency of Canada, December 2023).
- 106 'National Drug Overdose Deaths', CDC WONDER, Multiple Causes of Death (Detailed Mortality) (Centre for Disease Control, 2024).
- 107 Ibid.
- 108 Jade Boyd et al., 'Gendered Violence and Overdose Prevention Sites: A Rapid Ethnographic Study during an Overdose Epidemic in Vancouver, Canada', *Addiction* 113, no. 12 (December 2018): 2261–70.
- 109 Maria R. D'Orsogna, Lucas Böttcher, and Tom Chou, 'Fentanyl-Driven Acceleration of Racial, Gender and Geographical Disparities in Drug Overdose Deaths in the United States', ed. Jose Ignacio Nazif-Munoz, *PLOS Global Public Health* 3, no. 3 (22 March 2023): e0000769.
- 110 Sanjana Mitra et al., 'Elevated Prevalence of Self-Reported Unintentional Exposure to Fentanyl among Women Who Use Drugs in a Canadian Setting: A Cross-Sectional Analysis', *International Journal of Drug Policy* 83 (September 2020): 102864.
- 111 Ibid.
- 112 Harris et al., 'Competing Risks of Women and Men Who Use Fentanyl'.
- 113 Mitra et al., 'Elevated Prevalence of Self-Reported Unintentional Exposure to Fentanyl among Women Who Use Drugs in a Canadian Setting'.
- 114 Интервью №1, интервью №83.
- 115 Интервью №1, интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №6, интервью №25, интервью №27, интервью №28, интервью №80, интервью №83, интервью №85.

- 116 Интервью №2, интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №6, интервью №27, интервью №31, интервью №32, интервью №83, интервью №84, интервью №85.
- 117 Интервью №2, интервью №83.
- 118 Интервью №90.
- 119 Интервью №28, интервью №32.
- 120 Carla A. Green, 'Gender and Use of Substance Abuse Treatment Services', *Alcohol Research & Health: The Journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism* 29, no. 1 (2006): 55–62.
- 121 Davinia Rizzo et al., 'Barriers to Accessing Addiction Treatment for Women at Risk of Homelessness', *Frontiers in Global Women's Health* 3 (2022): 795532.
- 122 Tichaenzana Nyashanu and Herbert Zirima, 'Treatment Barriers and Gender-based Perceptions: Establishing Gender-based Treatment Specialty Facilities as a Strategy to Motivate South African Young Women to Seek Treatment for Substance Use Disorders', *Journal of Community Psychology* 51, no. 1 (January 2023): 182–200.
- 123 Интервью №18, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №25, интервью №28, интервью №83, интервью №85, интервью №90.
- 124 Интервью №26, интервью №32.
- 125 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом результатов полевых испытаний» (Женева, 2020 год).
- 126 WHO, 'HIV and Young People Who Inject Drugs: A Technical Brief' (World Health Organization, 2015).
- 127 WHO, 'WHO Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights' (World Health Organization, 2018).
- 128 Интервью №84, интервью №90.
- 129 Интервью №90, интервью №18, интервью №23.
- 130 Интервью №14, интервью №15, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №1, интервью №5, интервью №61, интервью №90.
- 131 Интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №6, интервью №90.
- 132 Интервью №15, интервью №17, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №1, интервью №2, интервью №82, интервью №90.
- 133 Интервью №1.
- 134 Интервью №89, интервью №82.
- 135 Semple et al., 'Correlates of Trading Sex for Methamphetamine in a Sample of HIV-Negative Heterosexual Methamphetamine Users'.
- 136 Vera Lopez, Nancy Jurik, and Stacia Gilliard-Matthews, 'Gender, Sexuality, Power and Drug Acquisition Strategies Among Adolescent Girls Who Use Meth', *Feminist Criminology* 4, no. 3 (July 2009): 226–51.
- 137 Loza, Guevara, and Hernandez, 'Gender Differences in Methamphetamine Use Initiation and Trajectory of Use Among People Who Use Methamphetamine in a Mexico-US Border City'.
- 138 Ryan R. Lion et al., 'Gender and Sex Trading Among Active Methamphetamine Users in Cape Town, South Africa', *Substance Use & Misuse* 52, no. 6 (12 May 2017): 773–84.
- 139 Интервью №1, интервью №3, ноябрь 2023 года.
- 140 Интервью №26, интервью №29, интервью УНП ООН, ноябрь 2023 года; интервью №32, интервью №37, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №61, интервью №81.
- 141 Интервью №1.

- 142 В ответах на вопросник к ежегодному докладу.
- 143 УНП ООН, данные вопросника к ежегодному докладу, дата не указана.
- 144 Там же.
- 145 Там же.
- 146 В ответах на вопросник к ежегодному докладу.
- 147 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2020 год*, брошюра 6 «Другие вопросы наркополитики» (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год)
- 148 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год*, брошюра 5 «Женщины и наркотики: наркопотребление, наркоснабжение и их последствия» (издание Организации Объединенных Наций, 2018 год).
- 149 B Denton and P O'Malley, 'Gender, Trust and Business: Women Drug Dealers in the Illicit Economy', *The British Journal of Criminology* 39, no. 4 (1 September 1999): 513–30.
- 150 Heidi Grundetjern and Sveinung Sandberg, 'Dealing with a Gendered Economy: Female Drug Dealers and Street Capital', *European Journal of Criminology* 9, no. 6 (1 November 2012): 621–35.
- 151 María Mónica Parada-Hernández and Margarita Marín-Jaramillo, 'Cocalero Women and Peace Policies in Colombia', *International Journal of Drug Policy*, Special Issue: Drugs, Conflict and Development, 89 (1 March 2021): 103157.
- 152 Heidi Grundetjern and Jody Miller, "'It's Not Just the Drugs That Are Difficult to Quit': Women's Drug Dealing as a Source of Empowerment and Its Implications for Crime Persistence", *The British Journal of Criminology*, 1 October 2018.
- 153 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*.
- 154 УНП ООН, Платформа мониторинга наркотиков, дата не указана.
- 155 В ответах на вопросник к ежегодному докладу.
- 156 Интервью №1, интервью №2, интервью №3, ноябрь 2023 года; интервью №28, интервью №29, интервью №34, интервью №60, интервью №80, интервью №81.
- 157 Интервью №5, интервью №13, интервью №80, интервью №12, интервью №59.
- 158 Интервью №6, интервью №31, интервью №37, интервью №41, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №33, интервью №80.
- 159 Интервью №13, интервью №27, интервью №12, интервью №80, интервью №81.
- 160 Интервью №59.
- 161 Интервью №80.
- 162 Интервью №81, интервью №12.
- 163 Интервью №5, интервью №27, интервью №28, интервью №29, интервью №31, интервью №60, интервью №81.
- 164 Интервью №36, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №59, интервью №80, интервью №81.
- 165 Liu Liu and Xuemeng Li, 'An Exploratory Study of Women Who Use and Sell Drugs in China', *International Journal of Drug Policy* 97 (November 2021): 103408.
- 166 Jessica R. Deitzer, Lindsay Leban, and Heith Copes, "'The Times Have Changed, the Dope Has Changed': Women's Cooking Roles and Gender Performances in Shake Methamphetamine Markets', *Criminology* 57, no. 2 (May 2019): 268–88.
- 167 Jennifer Fleetwood and Lindsay Leban, 'Women's Involvement in the Drug Trade: Revisiting the Emancipation Thesis in Global Perspective', *Deviant Behavior* 44, no. 2 (1 February 2023): 238–58.
- 168 Deitzer, Leban, and Copes, "'The Times Have Changed, the Dope Has Changed'".
- 169 Интервью №5.
- 170 Интервью №33.

- 171 Интервью №80.
- 172 Интервью №61, интервью №60, интервью №27.
- 173 Интервью №18, интервью №19.
- 174 Интервью №33.
- 175 Интервью №35, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №37, интервью №40, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года; интервью №41, интервью №61.
- 176 Интервью №59, интервью №61.
- 177 Интервью №59.
- 178 Интервью №28, интервью №29, интервью №30, интервью №33.
- 179 Интервью №18, интервью №19.
- 180 Интервью №18, интервью №19, интервью №59, интервью №60, интервью №61.
- 181 Интервью №29.
- 182 Интервью №33.
- 183 Интервью №39, интервью УНП ООН, декабрь 2023 года.
- 184 Louisa Gilbert et al., ‘Targeting the SAVA (Substance Abuse, Violence, and AIDS) Syndemic Among Women and Girls: A Global Review of Epidemiology and Integrated Interventions’, *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes* 69, no. Supplement 2 (1 June 2015): S118–27.
- 185 Sophia De Seranno and Charlotte Colman, ‘It’s a Man’s World but It Would Be Nothing without a Woman: The Involvement of Women in Belgian Synthetic Drugs Trafficking’, *Trends in Organized Crime*, 20 October 2023.
- 186 Molly Moloney, Geoffrey Hunt, and Karen Joe-Laidler, ‘Drug Sales, Gender, and Risk: Notions of Risk From the Perspective of Gang-Involved Young Adults’, *Substance Use & Misuse* 50, no. 6 (12 May 2015): 721–32.
- 187 Grundetjern and Miller, “‘It’s Not Just the Drugs That Are Difficult to Quit’”.

04

**КАННАБИС И ПСИХОДЕЛИКИ: СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ФОРМИРОВАНИЕМ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В
НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ**

КАННАБИС И ПСИХОДЕЛИКИ: СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ФОРМИРОВАНИЕМ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

За последнее десятилетие Канада, Уругвай и некоторые юрисдикции в Соединенных Штатах пересмотрели свою политику, легализовав всю цепочку производства и сбыта (культивирование, производство и продажу) каннабиса для немедицинского использования взрослым населением. Вслед за политическими изменениями в этих юрисдикциях перемены в политике произошли и в других регионах.

В Северной Америке перемены в политике происходили на фоне бурного развития рынка медицинского каннабиса и лоббирования со стороны групп активистов, что привело к притуплению восприятия риска, связанного с употреблением каннабиса, в обществе. Коммерческие интересы как производственной сфере, так и некоторых юрисдикций, вероятно, также сыграли свою роль в изменении политики¹.

В последние два десятилетия возобновился затихший в 1970-х годах интерес к терапевтическому применению психоделических веществ и инвестированию в клинические исследования по их применению для лечения ряда психических заболеваний². Некоторые из этих научных разработок являются весьма передовыми, но пока не привели к созданию научных стандартных рекомендаций для их применения в медицине. Однако обнадеживающие результаты текущих медицинских исследований уже повлекли за собой изменения в политике, которые позволили обеспечить доступность психоделиков для «квазипрактического» применения³ в нескольких юрисдикциях Соединенных Штатов⁴ и для медицинского применения в Австралии и в одной юрисдикции Канады⁵. Кроме того, в рамках более широкого «психоделического ренессанса»^{6, 7, 8} происходят события, которые могут опережать научные терапевтические данные и разработку рекомендаций по медицинскому использованию, и привести к формированию условий для обеспечения широкого неконтролируемого «квазипрактического» и немедицинского использования психоделиков, которое, согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года, разрешено только в научных и в очень ограниченных медицинских целях должным образом уполномоченными лицами⁹. Наряду с растущим коммерческим интересом к психоделикам эти события являются зеркальным отражением тех событий, которые привели к расширению доступа к немедицинскому каннабису в некоторых юрисдикциях, хотя в случае с психоделиками они, похоже, происходят быстрее и в более крупных масштабах.

КАРТА 13 Административно-территориальные единицы Соединенных Штатов, в которых разрешено использование каннабиса в медицинских и немедицинских целях и в которых использование каннабиса запрещено, декабрь 2023 года

<i>Pacific Ocean</i>	<i>Тихий океан</i>
Alaska	Аляска
CANADA	КАНАДА
<i>Gulf of Alaska</i>	<i>Аляскинский залив</i>
Hawaii	Гавайи
Washington	Вашингтон
Oregon	Орегон
California	Калифорния
Nevada	Невада
Montana	Монтана
Idaho	Айдахо

Utah	Юта
Arizona	Аризона
Wyoming	Вайоминг
Colorado	Колорадо
New Mexico	Нью-Мексико
North Dakota	Северная Дакота
South Dakota	Южная Дакота
Nebraska	Небраска
Kansas	Канзас
Oklahoma	Оклахома
Texas	Техас
Minnesota	Миннесота
Iowa	Айова
Missouri	Миссури
Arkansas	Арканзас
Louisiana	Луизиана
Wisconsin	Висконсин
Illinois	Иллинойс
Tennessee	Теннесси
Mississippi	Миссисипи
Michigan	Мичиган
Indiana	Индиана
Kentucky	Кентукки
Alabama	Алабама
Ohio	Огайо
West Virginia	Западная Виргиния
Virginia	Виргиния
North Carolina	Северная Каролина
South Carolina	Южная Каролина
Georgia	Джорджия
Florida	Флорида
Maine	Мэн
Vermont	Вермонт
New Hampshire	Нью-Хэмпшир
Massachusetts	Массачусетс
Rhode Island	Род-Айленд
Connecticut	Коннектикут
New York	Нью-Йорк
Pennsylvania	Пенсильвания
New Jersey	Нью-Джерси
District of Columbia	Округ Колумбия
Maryland	Мэриленд
Delaware	Делавэр
<i>Atlantic Ocean</i>	<i>Атлантический океан</i>
MEXICO	МЕКСИКА
<i>Gulf of Mexico</i>	<i>Мексиканский залив</i>

CUBA	КУБА
Puerto Rico	Пуэрто-Рико
<i>Caribbean Sea</i>	<i>Карибское море</i>
Comprehensive medical cannabis programme	Комплексная программа медицинского использования каннабиса
CBD/Low THC programme	Программа использования каннабиса с высоким содержанием КБД и низким содержанием ТГК
Non-medical use for adults and medical use regulated programme	Использование взрослым населением в немедицинских целях и программа по регулированию медицинского использования
No public access to cannabis	Отсутствие доступа к каннабису для населения

Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: Национальная конференция законодательных собраний штатов, декабрь 2023 года.

Примечание: каннабис по-прежнему является запрещенным веществом в Соединенных Штатах Америки на федеральном уровне.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА

Медицинский каннабис

По состоянию на 2020 год 64 страны включили в свое национальное законодательство положения или разработали рекомендации, разрешающие медицинское использование каннабиноидных фармацевтических препаратов и/или продуктов на основе каннабиса при ряде заболеваний^a. В разных странах применяются различные подходы к регулированию доступа пациентов к медицинским продуктам на основе каннабиса. На одном конце спектра находятся подходы, при которых пациенты, страдающие весьма конкретными заболеваниями, могут получить доступ только к тем продуктам каннабиса, которые разрешены к распространению на рынке. Это основанный на критериях качества, эффективности и безопасности процесс обзора и оценки доказательств в поддержку выпуска лекарственного препарата в обращение, по итогам которого выдается лицензия на его продажу при определенных обстоятельствах в определенных дозах и при наличии показаний к применению. На другом конце спектра находятся подходы, при которых любое лицо с заявленным заболеванием может получить доступ к продуктам каннабиса (включая продукты с высоким содержанием ТГК и низким содержанием КБД), изготовленным при ограниченном контроле качества, через пункт отпуска при медицинском учреждении по рекомендации врача или по усмотрению консультанта, или путем выращивания растений каннабиса для использования в медицинских целях^a.

Следствием открытия эндоканнабиноидной системы в середине 1980-х годов и развития более четкого представления о функционировании этой системы на протяжении 1990-х годов, стало возобновление интереса к возможности терапевтического использования каннабиса и его экстрактов^{b, c}. Однако достаточных доказательств эффективности каннабиноидов при лечении определенных заболеваний до сих пор не получено, и каннабиноиды обычно рекомендуются к назначению после того, как лечение этих заболеваний обычными методами не дало положительных результатов, или в качестве вспомогательной терапии^{d, e}. Имеются убедительные или существенные данные, подтверждающие эффективность применения каннабиса и каннабиноидов для лечения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, хронической боли у взрослых с симптомами спастичности при рассеянном склерозе, а также эпилепсии^{f, g, h}. На данный момент данные, подтверждающие эффективность применения каннабиса для лечения других заболеваний, являются неполными, недостаточными или неубедительными^f.

^a УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра 2 «Наркотики: современные проблемы», 2023 год.

- ^b Roger G Pertwee, “Cannabinoid Pharmacology: The First 66 Years: Cannabinoid Pharmacology”, *British Journal of Pharmacology* 147, No. S1 (January 2006): S163–71.
- ^c Vincenzo Di Marzo and Stefania Petrosino, “Endocannabinoids and the Regulation of Their Levels in Health and Disease”, *Current Opinion in Lipidology* 18, No. 2 (April 2007): 129–40.
- ^d Вспомогательное лечение (вспомогательная терапия) предполагает добавление некоторых лекарственных средств к другим методам лечения, а не их использование в качестве самостоятельных средств.
- ^e European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, *Medical Use of Cannabis and Cannabinoids: Questions and Answers for Policymaking* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018).
- ^f National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine and Board on Population Health and Public Health Practice, *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research*, The National Academies Collection: Reports Funded by National Institutes of Health (Washington D.C.: National Academies Press, 2017).
- ^g Anne Katrin Schlag, “An Evaluation of Regulatory Regimes of Medical Cannabis: What Lessons Can Be Learned for the UK?”, *Medical Cannabis and Cannabinoids* 3, No. 1 (15 January 2020): 76–83 годы.
- ^h Penny F. Whiting et al., “Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-Analysis”, *JAMA* 313, No. 24 (23 June 2015): 2456.

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Эти вопросы рассматриваются в настоящей главе, где представлен обзор многочисленных изменений в нормативно-правовой базе, выходящих за рамки легализации или регулирования всей цепочки поставок немедицинского каннабиса, и приводится обновленная информация по отдельным количественным показателям воздействия легализации всей цепочки поставок немедицинского каннабиса в Канаде, Соединенных Штатах и Уругвае. Параллельно с событиями, имеющими отношение к доступу к каннабису для немедицинского использования, в последней части главы рассматриваются различные события, связанные с формированием благоприятных условий с учетом коммерческих интересов, выходящие за рамки клинических испытаний и медицинских исследований, которые могут способствовать дальнейшему расширению возможностей неконтролируемого доступа к психоделическим веществам вне медицинских учреждений.

Изменения в нормативно-правовой базе, обеспечивающие возможность доступа к использованию каннабиса в немедицинских целях

По состоянию на январь 2024 года законодательные нормы, разрешающие производство и сбыт каннабиса для использования в немедицинских целях, действовали в Канаде¹⁰, Уругвае¹¹ и 27 юрисдикциях в Соединенных Штатах (23 штата, 3 территории и округ Колумбия)^{12, 13}, которые были приняты либо посредством всенародного референдума, либо в рамках законодательных процедур. Помимо этих юрисдикций, в 15 других штатах США действуют положения о программах, в рамках которых в той или иной степени разрешается использование каннабиса в медицинских целях, а в 9 юрисдикциях разрешается использование продуктов с «низким содержанием ТГК и высоким уровнем КБД» в медицинских целях только в отдельных случаях. В большинстве юрисдикций Канады и Соединенных Штатов, в которых было легализовано использование каннабиса в немедицинских целях, коммерческим предприятиям разрешается заниматься его производством и продажей, в то время как в Уругвае существует частично контролируемый и регулируемый государством розничный рынок с ограниченным участием коммерческих структур¹⁴. В Канаде и различных юрисдикциях Соединенных Штатов, в которых была легализована цепочка поставок каннабиса немедицинского назначения, легализации предшествовали предусматривающие разный уровень контроля и регламентации меры, разрешающие использовать каннабис в медицинских целях при целом ряде заболеваний. Различные подходы к регулированию, способы реализации¹⁵ и управления цепочкой поставок в разных юрисдикциях оказали неодинаковое влияние на рынок

каннабиса немедицинского назначения, особенно в том, что касается общественного здравоохранения и общественной безопасности^{16, 17, 18, 19}.

Помимо событий, приведших к легализации или регулированию всей цепочки поставок каннабиса для использования в немедицинских целях в Канаде, Соединенных Штатах и Уругвае, в других странах появились и другие законодательные подходы, разрешающие выращивание и продажу каннабиса для использования в немедицинских целях при различных обстоятельствах. Эти подходы предусматривают регулируемый в той или иной степени доступ к каннабису, предназначенному для использования в немедицинских целях.

Резюме последних изменений в политике стран, разрешающих культивирование и продажу каннабиса в различных объемах для использования в немедицинских целях

Summary measures for regulating non-medical use of cannabis	Резюме мер, регулирующих использование каннабиса в немедицинских целях
Germany	Германия
The Cannabis Act came into force in April 2024; it regulates the controlled access to non-medical cannabis among adults, allowing home cultivation for personal consumption and non-commercial cultivation of cannabis within cannabis associations or clubs. Pillar 2 of the Act envisages setting up regional pilot projects for commercial supply chains for cannabis for non-medical use.	Закон о каннабисе вступил в силу в апреле 2024 года; он регламентирует контролируемый доступ к каннабису немедицинского назначения среди взрослых и разрешает выращивание каннабиса в домашних условиях для личного потребления и некоммерческое выращивание каннабиса в рамках ассоциаций или клубов сторонников каннабиса. На втором этапе реализации этого закона предусматривается разработка региональных экспериментальных проектов по созданию цепочек поставок каннабиса для использования в немедицинских целях.
Luxembourg	Люксембург
Since June 2023, legalization of the non-medical cultivation and possession of cannabis at home and reduced penalties for small amounts of cannabis possession in public.	С июня 2023 года легализовано выращивание и хранение каннабиса в домашних условиях для использования в немедицинских целях, а также снижены штрафы за хранение небольшого количества каннабиса в общественных местах.
Malta	Мальта
Since 2021, legalization of the non-medical use, home cultivation and cultivation by licensed non-profit associations of cannabis for adults.	С 2021 года легализованы использование в немедицинских целях, выращивание в домашних условиях и выращивание лицензированными некоммерческими ассоциациями сторонников каннабиса для взрослых.
Netherlands (Kingdom of the)	Нидерланды (Королевство)
The controlled cannabis supply chain experiment in 10 municipalities starting with the municipalities of Breda and Tilburg, allowing the cultivation of non-medical cannabis with formalized and controlled supply. Aimed at examining the possible decriminalization of good-quality cannabis supply, reviewing the most suitable implementation methods, and assessing the ensuing effects of such decriminalization on public health and safety.	В рамках эксперимента по созданию контролируемой цепочки поставок каннабиса в 10 муниципалитетах (начиная с муниципалитетов Бреда и Тилбург) разрешается культивировать каннабис для использования в немедицинских целях и осуществлять в официальном порядке его контролируемые поставки. Эксперимент проводится в целях изучения возможности декриминализации поставок качественного каннабиса, анализа наиболее подходящих методов осуществления и оценки последствий такой

	декриминализации для здоровья и безопасности населения.
South Africa	Южная Африка
The Cannabis for Private Purposes Bill of 2023, setting forth legal provisions for the cultivation, possession and consumption of cannabis by adults in private dwellings: approved by the National Assembly and now with the upper body of the Parliament, where it is expected to be discussed during 2024.	Законопроект 2023 года об использовании каннабиса для личных нужд, устанавливающий правовые нормы для выращивания, хранения и потребления каннабиса взрослыми в частных домохозяйствах, одобрен Национальной ассамблеей и теперь находится в верхней палате парламента, где, как ожидается, будет обсуждаться в течение 2024 года.
Switzerland	Швейцария
Since 2021, collaborative pilot trials by local-level organizations to assess the impact of alternative regulatory strategies on non-medical cannabis use and to inform decision-making with evidence on the possibilities and limitations of regularizing the Swiss cannabis market.	С 2021 года организации местного уровня реализуют совместные пробные проекты по оценке влияния альтернативных стратегий регулирования на использование каннабиса в немедицинских целях и сбору фактических данных для обоснования процесса принятия решений в отношении возможностей и ограничений регламентации швейцарского рынка каннабиса.
Thailand	Таиланд
Lack of clarity regarding the legal status of cannabis use and supply for non-medical purposes following recent legal notifications. The removal of cannabis from the list of prohibited substances has created a legal vacuum, followed by multiple notifications to regulate its non-medical use.	Отсутствие ясности в отношении правового статуса использования и поставки каннабиса в немедицинских целях после недавних правовых уведомлений. Исключение каннабиса из списка запрещенных веществ привело к возникновению правового вакуума, за которым последовали многочисленные уведомления о регулировании его использования в немедицинских целях.

Германия

Закон о каннабисе (*Cannabisgesetz, CanG*) вступил в силу в Германии 1 апреля 2024 года, а его положения, регулирующие культивирование каннабиса населением в некоммерческих целях в рамках ассоциаций или клубов сторонников каннабиса, вступают в силу 1 июля 2024 года²⁰. В рамках первого этапа реализации закона предусматривается самостоятельное культивирование каннабиса в частном порядке взрослым населением для использования в личных целях, а также его некоммерческое культивирование в клубах или ассоциациях сторонников каннабиса. На втором этапе реализации закона предусматривается разработка региональных экспериментальных проектов по созданию цепочек поставок каннабиса для использования в немедицинских целях²¹.

Основными целями этого законодательного акта являются защита здоровья, особенно детей и молодежи, просвещение и профилактика, а также пресечение функционирования незаконного рынка каннабиса. Согласно положениям закона, взрослым разрешается иметь при себе 25 граммов каннабиса в общественных местах, выращивать до трех растений каннабиса в своем доме в качестве домашней культуры и хранить 50 граммов дома для личного пользования.

Некоммерческим клубам сторонников каннабиса разрешено выращивать и распространять каннабис среди своих членов для личного пользования. Членский состав ассоциаций по выращиванию не должен превышать 500 человек, достигших 18 лет и проживающих в Германии не менее 6 месяцев. Члены ассоциации по выращиванию могут получать не более 25 граммов каннабиса в день и не более 50 граммов каннабиса в месяц для личного потребления. На членов некоммерческих клубов каннабиса в возрасте от 18 лет до 21 года распространяются особые

положения. Количество каннабиса, которое может быть выдано таким лицам, ограничено 30 граммами в месяц, а допустимое содержание ТГК — 10 процентами. Клубы сторонников каннабиса не должны находиться ближе 200 метров от школ, детских и юношеских учреждений или игровых площадок. Места выращивания каннабиса не должны находиться на виду и должны быть защищены от доступа извне.

Не допускается употребление каннабиса в непосредственном присутствии детей и подростков, а также в запретных зонах вокруг учреждений и мест, которые регулярно посещают дети и подростки. Кроме того, рекламная и спонсорская деятельность строго запрещена как в отношении продуктов каннабиса, так и клубов. Предусмотрено также проведение информационных кампаний и профилактических мероприятий, ориентированных на лиц, употребляющих каннабис, и на конкретные группы населения. Оценка воздействия Закона о каннабисе будет проводиться поэтапно: промежуточный доклад ожидается через два года, а окончательный — через четыре года после введения его в действие.

Люксембург

В Люксембурге в соответствии с новым законодательством с июня 2023 года легализовано выращивание и хранение немедицинского каннабиса в домашних условиях. В соответствии с законопроектом № 8033, направленным на регулирование культивирования каннабиса, в закон о продаже лекарственных препаратов и борьбе с наркозависимостью от 19 февраля 1973 года были внесены поправки, разрешающие в рамках первого этапа экспериментального проекта по обеспечению легального доступа к каннабису для использования в немедицинских целях²² выращивать до четырех растений каннабиса на домохозяйство для личного потребления. Для обеспечения соблюдения и предотвращения несанкционированного культивирования действуют строгие правила. Растения должны храниться вдали от посторонних глаз, а личное потребление должно осуществляться исключительно в частных помещениях. Любые нарушения этих правил влекут за собой соответствующее уголовное наказание²³.

На фоне этих усилий по регулированию личного культивирования Люксембург ввел новые правила, изменяющие наказания, связанные с хранением каннабиса в небольшом количестве (менее 3 граммов) в общественных местах²⁴. Хотя употребление каннабиса в общественных местах по-прежнему запрещено, уголовное судопроизводство в связи с его хранением и перевозкой в количестве менее 3 граммов взрослыми теперь стало осуществляться по упрощенной и ускоренной процедуре. Размер штрафов сокращен до 25–500 евро, при этом может быть вынесено полицейское предупреждение в размере 145 евро²⁵. Легализация самостоятельного культивирования и смягчение наказаний за употребление каннабиса в небольшом количестве в общественных местах представляют собой комплекс первоначальных мер, реализуемых в рамках экспериментального проекта, целью которого является пресечение функционирования незаконного рынка и его влияния на здоровье и безопасность населения, а также регулирование предложения каннабиса для использования в немедицинских целях. Вместе с тем этот экспериментальный проект по-прежнему подлежит постоянной оценке и адаптации. В целях дополнительной защиты здоровья населения и предотвращения возникновения нерегулируемого параллельного рынка потенциально небезопасных продуктов на основе каннабиса в рамках этого экспериментального проекта предполагается в будущем ввести правила упаковки и физической продажи семян каннабиса с содержанием ТГК более 0,3 процента для частного и личного использования, как это было рекомендовано межминистерской рабочей группой по экспериментальному проекту. Эти меры направлены на обеспечение качества и безопасности немедицинских продуктов на основе каннабиса, а также на облегчение контролируемого доступа²⁶.

Мальта

В 2021 году на Мальте был принят закон о создании Управления по вопросам ответственного употребления каннабиса и внесении поправок в действующее законодательство, касающееся каннабиса, посредством которого было легализовано немедицинское использование и выращивание

этой наркосодержащей культуры в домашних условиях²⁷. Хранение до 7 граммов каннабиса и выращивание до четырех растений в безопасном и незаметном месте для личного потребления лицом старше 18 лет больше не является преступлением. Вместе с тем употребление каннабиса допускается исключительно в частных помещениях, а употребление в общественных местах может повлечь за собой административный штраф. Хранение от 7 до 28 граммов каннабиса для личного потребления теперь считается нарушением, влекущим за собой административный штраф в размере от 50 до 100 евро²⁸. Кроме того, каннабис подлежит изъятию полицией в случае его хранения в чрезмерном количестве сверх установленной нормы в 7 граммов, а также при наличии подозрений в отношении участия в его незаконном обороте или сбыте. Наконец, лицо старше 18 лет может хранить не более 50 граммов высушенного каннабиса и выращивать не более 4 растений для личного потребления в пределах собственного зарегистрированного места жительства, независимо от количества проживающих, в недоступных для посторонних местах²⁹.

Физическим лицам также разрешено создавать или вступать в ассоциации по снижению вреда от каннабиса (АСВК), которые занимаются выращиванием каннабиса исключительно для немедицинского потребления их членами. Эти лицензированные ассоциации должны придерживаться строгих правил, включая регистрацию в Управлении по вопросам ответственного употребления каннабиса. Управление отвечает за регулирование деятельности любой частной ассоциации, занимающейся выращиванием и хранением каннабиса для распространения среди своих членов, а также за консультирование правительства по вопросам национальной политики в отношении каннабиса и создание механизма контроля за использованием каннабиса в немедицинских целях. Эти ассоциации по выращиванию каннабиса должны осуществлять свою деятельность на некоммерческой основе и соблюдать положения мальтийского Закона о добровольных организациях. Распространение каннабиса допускается исключительно среди членов ассоциаций, численность которых не может превышать 500 человек, а потребители каннабиса могут быть членом не более одной такой ассоциации. В целях обеспечения отслеживаемости и подотчетности каждая партия, распространяемая ассоциацией, должна иметь отличительную маркировку. Кроме того, ассоциации обязаны вести реестр своих членов и придерживаться ежедневного лимита распространения в количестве до 7 граммов на члена и ежемесячного лимита в 50 граммов на члена³⁰.

Королевство Нидерландов

Хранение и продажа каннабиса для немедицинского использования в Королевстве Нидерландов являются уголовными преступлениями, тем не менее нидерландское законодательство допускает и его хранение, и его продажу в количестве, не превышающем 5 граммов (марихуаны или гашиша) или 5 растений³¹. Аналогичным образом, производство и распространение каннабиса в Королевстве Нидерландов по-прежнему запрещены, однако розничные торговцы каннабисом в кофейнях (в помещениях которых каннабис может употребляться только жителями страны) поставляют каннабис с незаконного рынка, и это явление нередко называют «проблемой черного хода». Недавно правительство Нидерландов инициировало эксперимент по созданию контролируемой цепочки поставок каннабиса, в рамках которого было разрешено выращивание каннабиса для немедицинского использования с официальным оформлением и контролем его поставок в десяти муниципалитетах, начиная с муниципалитетов Бреды и Тилбурга³². Цель эксперимента состоит в том, чтобы изучить возможность декриминализации поставок качественного каннабиса, определить наиболее подходящий способ осуществления такой декриминализации и оценить последствия декриминализации цепочки поставок для здоровья и безопасности населения. В частности, эксперимент направлен на то, чтобы оценить «возможность и способы осуществления и декриминализации производства и распространения прошедшего контроль качества каннабиса в рамках всей цепочки — от производства до сбыта, — а также оценить эффективность закрытой цепочки поставок»³³.

В ходе эксперимента кофейни в муниципалитетах-участниках будут по-прежнему соблюдать ряд существующих правил, таких как запрет на рекламу, максимальный допустимый вес в 5 граммов на человека в день, запрет на любые нарушения общественного порядка и запрет на продажу алкоголя

и тяжелых наркотиков³⁴. Кофейни будут обязаны закупать, хранить и продавать каннабис только у утвержденных производителей; они также должны будут вести сортовой и количественный учет каннабиса, как находящегося на хранении, так и поступившего в продажу, документацию, содержащую сведения о его поставщике и перевозчике, занимающегося транспортировкой этого наркотика. Кофейни также должны будут гарантировать, что каннабис будет продаваться только жителям Королевства Нидерландов, а их персонал должен будет пройти подготовку, с тем чтобы предоставлять клиентам информацию о немедицинском употреблении каннабиса и связанных с ним рисках³⁵.

ТАБЛИЦА 1 Пять этапов эксперимента в Королевстве Нидерландов

Phase	Этап
Preparatory phase	Подготовительный этап
Start-up phase	Начальный этап
Transitional phase	Переходный этап
Experimental phase (including an evaluation period)	Экспериментальный этап (включая период оценки)
Completion phase	Заключительный этап
Date/duration	Дата/продолжительность
From July 2020	С июля 2020 года
15 December 2023; expected to last six months maximum	15 декабря 2023 года; ожидаемая продолжительность не более шести месяцев
End of Q1 2024; expected to last for six weeks following the start-up phase	Конец первого квартала 2024 года; ожидаемая продолжительность шесть месяцев по окончании начального этапа
Expected to last a minimum of four years	Ожидаемая продолжительность не менее четырех лет
Following previous phase	После предыдущего этапа
Description	Описание
> Selection and designation of growers for licit cannabis cultivation.	> Отбор и назначение производителей для законного выращивания каннабиса.
> A minimum of two cannabis growers will supply regulated cannabis to coffee shops in Tilburg and Breda. > Cannabis offered in the participating municipalities will come from legal and illegal sources.	> Как минимум два производителя каннабиса будут осуществлять регулируемые поставки каннабиса в кофейни в Тилбурге и Бреде. > Каннабис, предлагаемый в муниципалитетах-участниках, будет поступать из законных и незаконных источников.
> The phase will start once it has been established that the quantity, quality and diversity of the cannabis produced are sufficient. > All the conditions that are important for a closed coffee shop supply chain will be met. > Both legally and illegally sourced cannabis will be available.	> Этот этап начнется после того, как будет установлено, что количество, качество и разнообразие производимого каннабиса находятся на достаточном уровне. > Будут соблюдены все условия, имеющие важное значение для закрытой цепочки поставок в кофейни. > Будет предлагаться каннабис как из законных, так и незаконных источников.
> Growers will supply the regulated cannabis to all coffee shops in the 10 participating municipalities.	> Производители будут осуществлять регулируемые поставки каннабиса во все кофейни в 10 муниципалитетах-участниках. > Ожидается, что в кофейнях будет продаваться каннабис только в рамках регулируемых

> The coffee shops will be expected to sell only the regulated cannabis to ensure uniformity in the experiment and its results. > Coffee shop owners will also be expected to reach agreements with growers regarding the assortment of products that will be offered for sale. > A monitoring mechanism is to be established to record the effects of the experiment.	поставок, с тем чтобы обеспечить единообразие эксперимента и его результатов. > Ожидается, что владельцы кофеен также должны будут договариваться с производителями об ассортименте продукции, которая будет предлагаться к продаже. > Необходимо создать механизм мониторинга для регистрации результатов эксперимента.
> A return to the application of existing Dutch laws and regulations in the 10 municipalities unless the Government decides otherwise.	> Возвращение к применению действующих в Нидерландах законов и положений в 10 муниципалитетах, если правительство не примет иного решения.

Источник: Ministerie van Algemene Zaken, 'Aanleiding en opzet experiment gesloten coffeeshopketen - Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) - Rijksoverheid.nl', onderwerp (Ministerie van Algemene Zaken).

Южная Африка

Конституционный суд Южной Африки в своем решении от 2018 года определил, что положения национального законодательства, запрещающие хранение, употребление и выращивание каннабиса взрослыми в частных домохозяйствах, противоречат конституции страны³⁶. Вместе с тем суд приостановил применение своего решения на 24 месяца, с тем чтобы дать парламенту возможность обсудить способы исправления конституционных нарушений в соответствующих законах³⁷. В течение этого периода хранение, употребление и выращивание каннабиса взрослыми в частном порядке не считались уголовными преступлениями, тогда как употребление каннабиса в общественных местах или в присутствии несовершеннолетних и взрослых без их согласия по-прежнему было запрещено³⁸.

Для решения вопросов, поднятых Конституционным судом, в 2023 году Национальная ассамблея одобрила новый законопроект о каннабисе для личного потребления; в настоящее время этот законодательный акт находится на рассмотрении в верхней палате парламента — Национальном совете провинций. В законопроекте устанавливаются правовые нормы, регулирующие выращивание, хранение и потребление каннабиса взрослыми в частных домохозяйствах. Хотя в нем не устанавливаются ограничения на количество семян и саженцев, используемых для выращивания, само выращивание ограничено четырьмя цветущими растениями или их эквивалентом на одного взрослого человека, или восемью цветущими растениями или их эквивалентом на одно жилище, занимаемое двумя или более взрослыми людьми³⁹. Хранение каннабиса для личного потребления в общественном месте ограничено 100 граммами сушеного каннабиса или его эквивалентом, или одним цветущим растением или его эквивалентом. В частных жилищах разрешается хранить не более 600 граммов каннабиса на одного взрослого или 1200 граммов на домохозяйство, в котором проживают двое или более взрослых. Согласно законопроекту, продажа каннабиса по-прежнему запрещена, однако в соответствии с некоторыми положениями разрешается передавать каннабис в дар; установленное количество для дарения (если речь идет о материалах для культивирования) составляет 30 семян или саженцев или семян и саженцев вместе в количестве, не превышающем установленного предела, то есть одно цветущее растение или его эквивалент, или 100 граммов сушеного каннабиса или его эквивалент. Кроме того, законопроект предусматривает уголовную ответственность за деятельность, связанную с выращиванием, хранением, снабжением и сбытом продуктов, полученных из сушеного каннабиса, а также растений каннабиса и материалов для выращивания, выходящую за пределы, установленные вышеупомянутыми положениями. Наказания за нарушение этих положений варьируют от штрафов (например, за курение в общественных местах) до тюремного заключения на срок от 6 до 15 лет за хранение продуктов из сушеного каннабиса в объемах, которые могут свидетельствовать об участии в незаконном обороте или коммерческой деятельности⁴⁰.

Швейцария

С 2021 года в Швейцарии в соответствии с Постановлением о пробных проектах в рамках Закона о наркотиках (BetmPV) кантонам, муниципалитетам, университетам и другим организациям разрешается сотрудничать и проводить пробные проекты для оценки влияния альтернативных стратегий регулирования на потребление каннабиса в немедицинских целях и использовать фактические данные для принятия решений о возможностях и ограничениях регулирования рынка каннабиса в Швейцарии^{41, 42}. Пробные проекты продлятся максимум пять лет с возможностью однократного продления на два года. Число участников каждого пробного проекта не должно превышать 5000 человек. К участию допускаются только совершеннолетние лица, которые могут доказать, что они уже употребляют каннабис в немедицинских целях. Каждый пробный проект направлен на изучение характерных для Швейцарии приоритетов; к ним относятся меры по укреплению здоровья каждого отдельного человека и общества в целом, укреплению общественного порядка и снижению уровня преступности, связанной с каннабисом, защите несовершеннолетних от немедицинского употребления каннабиса и созданию механизмов поддержки молодых людей, находящихся в группе риска, а также по обеспечению эффективного и справедливого управления в отношении каннабиса, направленного на создание механизма регулятивного надзора и контролируемой цепочки поставок⁴³.

В настоящее время в Швейцарии проводится семь пробных проектов по каннабису; в целом они призваны обеспечить на сопоставительной основе понимание различных моделей распространения и регулирования, с тем чтобы иметь более ясное представление о том, сказывается ли регулирование рынка каннабиса на достижении более высоких результатов в сфере здравоохранения и общественной безопасности. В кантоне Базель в рамках пробного исследования Weed Care изучается вопрос о том, как регулируемый сбыт каннабиса немедицинского назначения через аптеки сопоставим с нынешней ситуацией (когда каннабис поступает с незаконного рынка) с точки зрения моделей потребления и здоровья участников исследования⁴⁴. Реализуемые в районах городов Листаль и Альшвилль проекты Grashaus направлены на исследование того, может ли структурированная и контролируемая продажа «высококачественного, выращенного по органической технологии каннабиса» обученным торговым персоналом в специализированных магазинах привести к изменению моделей потребления, снижению вреда от немедицинского потребления каннабиса и связанных с ним проблем, сведению к минимуму потребления каннабиса, поставляемого незаконным путем, а также к укреплению в целом здоровья и благополучия населения с физической, психологической и социальной точек зрения⁴⁵. Реализуемый в Женеве проект La Cannabinothèque призван дать оценку того, в какой степени программа, обеспечивающая регулируемый доступ к каннабису немедицинского назначения, может улучшить понимание этого вещества и связанных с ним проблем, способствовать уменьшению вреда для здоровья и пагубных социальных последствий, обычно связанных с употреблением каннабиса в немедицинских целях⁴⁶. В рамках проводимого в Цюрихе пробного проекта Züri Can изучается влияние на структуру потребления и здоровье его участников поставок отдельных продуктов на основе каннабиса немедицинского назначения, культивируемого в соответствии с нормативными положениями, которые распространяются в соответствии с условиями, предусмотренными соответствующими нормативными положениями, через различные торговые точки, включая Цюрихский центр информации о наркотиках, 10 участвующих аптек и 10 социальных клубов города⁴⁷. Реализуемый в Лозанне проект Cann-L, основанный на квебекской модели регулирования рынка каннабиса немедицинского назначения, призван оценить целесообразность и потенциальные последствия некоммерческого подхода к сбыту каннабиса в качестве альтернативы поставкам с незаконного рынка⁴⁸. Наконец, в Люцерне, Биле и Берне реализуется экспериментальный проект SCRIPT, в рамках которого оценивается влияние регулируемой некоммерческой продажи каннабиса в аптеках, а также сопутствующих консультационных услуг на употребление каннабиса в немедицинских целях в этих городах⁴⁹.

Таиланд

В Таиланде в последнее время были выпущены правовые уведомления в отношении правового статуса использования каннабиса в немедицинских целях, которые не внесли какую-либо ясность в этот вопрос. Исключение каннабиса из списка запрещенных веществ породило правовой вакуум, за которым последовали многочисленные уведомления, призванные регламентировать его использование в немедицинских целях. Наряду с этими новыми уведомлениями или положениями, многие правонарушения, связанные с немедицинским использованием каннабиса, по-прежнему связаны с законодательством 1990-х годов.

В Таиланде в соответствии с законом В.Е. 2542 «Об охране и популяризации тайских традиционных медицинских знаний» каннабис является подлежащим контролю травянистым растением, соцветия которого являются предметом правового регулирования. Поэтому для проведения исследований, экспорта, продажи или переработки такого подлежащего контролю травянистого растения требуется официальное разрешение. Субъекты, получившие разрешение, должны соблюдать установленные законом условия, включая, в частности, запрет на продажу лицам моложе 20 лет, беременным или кормящим женщинам, а также учащимся без рецепта врача. Кроме того, запрещается распространение этого подлежащего контролю травянистого растения через торговые автоматы, электронные платформы или цифровые сети, а также коммерческая реклама продуктов на основе каннабиса. К экстрактам каннабиса применяются нормы регулирования, такие же как в отношении наркотиков, для производства, распространения и использования которых требуется разрешение в соответствии с Антинаркотическим кодексом. Эта нормативная база направлена на контроль их использования в медицинских целях и в составе определенных продуктов медицинского назначения, получение производителями необходимых разрешений и соблюдение ими установленных стандартов, как указано в различных уведомлениях, в целях обеспечения безопасности потребителей и предотвращения злоупотреблений⁵⁰.

Вместе с тем законодательство Таиланда в отношении каннабиса может вскоре измениться. Министерство здравоохранения представило на рассмотрение Кабинета министров проект закона о каннабисе и конопле. Данный законопроект предусматривает создание всеобъемлющих механизмов регулирования и надзора в отношении каннабиса и конопли, охватывающих их культивирование, производство, распространение, импорт и экспорт, с целью использования медицинских преимуществ, обеспечения промышленного применения (конопли) и содействия научным исследованиям каннабиса и конопли. Такие меры регулирования направлены на охрану здоровья населения и защиту уязвимых слоев населения от потенциальных негативных последствий, связанных с употреблением каннабиса и конопли. Проект закона также направлен на предотвращение злоупотребления, запрещает потребление в рекреационных целях и устанавливает условия для получения разрешения на выращивание этих растений⁵¹.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА]

Недолгий опыт декриминализации наркотиков в Орегоне

Во всем мире есть страны, которые отменили уголовное наказание (или вообще его не вводили) за несанкционированное хранение или употребление контролируемых веществ, помимо каннабиса. Несмотря на то, что федеральное законодательство Соединенных Штатов по-прежнему предусматривает уголовное наказание за хранение или распространение наркотиков, изменения в наркополитике на уровне муниципалитетов и отдельных штатов в этом отношении в основном касаются легализации предложения каннабиса для определенных целей или декриминализации или депенализации его хранения или употребления. В штате Орегон, за действиями которого следили многие, были планы распространить декриминализацию хранения наркотиков для немедицинского использования на любые наркотики. Эти усилия были в числе самых первых мер по изменению наркополитики в Соединенных Штатах, однако это не было новинкой для других стран в некоторых частях Западной Европы и Латинской Америки. События в Орегоне, где предпринимаемые меры были недавно свернуты, а также недавние изменения в Британской Колумбии (Канада), где была вновь введена уголовная ответственность за хранение наркотиков в общественных местах^a, подчеркивают тот факт, что пытаясь сделать выводы о причинно-следственной связи изменений в

наркополитике, важно не только понимать, что результаты реформ в области наркополитики могут в значительной степени зависеть от конкретных условий ее проведения, но и природу наркозависимости и сдерживающего эффекта криминализации определенных видов поведения в конкретных условиях.

Мера 110, также известная как Закон о лечении и реабилитации наркозависимых, была популярной инициативой, одобренной почти 60 процентами избирателей штата Орегон путем всенародного голосования в ноябре 2020 года^b, по переквалификации уголовных наказаний за хранение всех контролируемых наркотиков в гражданские правонарушения. Изготовление и распространение, а также хранение крупных партий контролируемых наркотиков оставались уголовно наказуемыми деяниями. В соответствии с Мерой 110 была отменена уголовная ответственность за хранение контролируемых наркотиков, включая кокаин, героин и метамфетамин, в малых количествах. Вместо ареста, уголовных обвинений и возможного тюремного заключения за совершение такого проступка, как хранение в малых количествах, лицам, уличенным в хранении этих веществ в небольших количествах (например, 1 грамма героина, 2 граммов кокаина или 2 граммов метамфетамина), отныне выносилось предостережение в соответствии с нормами гражданского права, и они должны были оплатить штраф в размере до 100 долларов, который отменялся в случае прохождения ими медицинского обследования^c.

Данной инициативой также предусматривалось учреждение Фонда по оказанию лечебно-реабилитационных услуг наркозависимым, который должен был финансироваться за счет поступлений от налогов на каннабис и средств, сэкономленных за счет сокращения расходов на поддержание правопорядка и тюремное заключение. Фонд был призван оказать поддержку расширению доступа к услугам по лечению наркозависимости путем предоставления грантов частным поставщикам, предлагающим услуги по детоксикации, консультирование, доступное лечение расстройств на почве употребления психоактивных веществ, услуги по снижению вреда, помощь в обеспечении жильем и программы взаимопомощи. Положения по переквалификации преступлений, связанных с хранением наркотиков, вступили в силу в феврале 2021 года, а в конце 2021 года законодательные органы штата приняли законы, направленные на реализацию других элементов одобренной инициативы, которые требуют предоставления медицинских услуг и расширяют доступ к другим услугам и просветительским программам^d.

С самого начала реализации инициативы в части предоставления услуг возникли серьезные проблемы, связанные с задержками ввода в действие законодательства, неэффективным управлением грантами и ограниченным финансированием наркологической помощи. Проведенная органами штата внутренняя ревизия показала, что разрозненность в предоставлении услуг и отсутствие сотрудничества между заинтересованными сторонами поставили под угрозу большую часть усилий в рамках инициативы по оказанию наркологической помощи и услуг лицам, подлежащим диспансеризации^e. Это стало предметом обеспокоенности, учитывая, что Орегон уже занимал второе место в Соединенных Штатах по заболеваемости расстройствами на почве употребления психоактивных веществ и последнее место по доступности наркологической помощи^e. Что касается количества арестов, то первые исследования показали, что изменение политики привело к снижению количества арестов за хранение наркотиков в Орегоне, при этом не произошло значительного увеличения общего количества арестов, арестов, не связанных с наркотиками, или арестов за насильственные преступления^f.

В начале 2024 года законодательное собрание штата Орегон подавляющим большинством голосов отменило действие некоторых положений Меры 110, в результате чего хранение контролируемых наркотиков стало проступком, за который полагается до шести месяцев тюремного заключения, и призвало правоохранительные органы направлять соответствующих лиц на лечение от наркозависимости^g. Поскольку изменения в законодательстве были отменены всего спустя несколько лет, точная оценка последствий политики декриминализации хранения наркотиков в Орегоне является трудной задачей. За последние несколько лет в Орегоне увеличилось число случаев передозировки наркотиков; однако в соседних штатах, не изменивших своего законодательства о наркотиках, также возросли показатели потребления наркотиков и смертности от передозировки, что указывает на глубинные изменения, происходящие на рынке наркотиков,

вызванные распространением фентанила в западной части Соединенных Штатов^{h, i}. В ходе предварительного анализа не было установлено какой-либо связи между декриминализацией в Орегоне и показателями смертности от передозировки наркотиков с учетом поправки на быстрый рост доступности фентанила незаконного изготовления^{j, k}.

По сравнению с другими юрисдикциями, где было декриминализовано хранение наркотиков, Орегон сталкивается с дополнительными проблемами, которые могли снизить эффективность этой меры и привести к ее отмене. По сравнению с многими другими юрисдикциями в Европе, где сохраняется доступ к всеобщему медицинскому обслуживанию и ниже уровень экономического неравенства, диспансеризация и лечение в Орегоне осуществляются за счет государственных средств, выделяемых частным поставщикам услуг. Действие правил, регулирующих эти услуги и определяющих порядок их финансирования, было приостановлено на несколько лет, поскольку, согласно заключению по итогам внутренней ревизии штата, они оказались неэффективными из-за дублирования контрактов и «разрозненного характера» лечения расстройств на почве употребления психоактивных веществ^l.

Пока неясно, скажется ли возврат к уголовной ответственности за хранение наркотиков для использования в немедицинских целях на наркопотреблении, включая употребление в общественных местах и связанные с ним расстройства, а также на случаях смерти от передозировки в Орегоне. Кроме того, понадобятся усилия по организации контроля за тем, как возврат к уголовной ответственности повлияет на показатели лишения свободы и взаимодействия полиции с гражданами.

^a Office of the Premier, “B.C. Moves to Ban Drug Use in Public Spaces, Taking More Steps to Keep People Safe | BC Gov News,” April 26, 2024.

^b Secretary of State of Oregon, “November 3, 2020, General Election Abstract of Votes Measure 110,” n.d., <https://sos.oregon.gov/elections/Documents/results/november-general-2020.pdf>.

^c Secretary of State of Oregon, “Drug Addiction Treatment and Recovery Act,” August 15, 2019, <https://sos.oregon.gov/admin/Documents/irr/2020/044text.pdf>.

^d Oregon Health Authority, “Oregon Health Authority: Drug Addiction Treatment and Recovery Act (Measure 110): Behavioral Health Division: State of Oregon,” n.d., accessed April 25, 2024.

^e Oregon Secretary of State, “Oregon Health Authority: Too Early to Tell: The Challenging Implementation of Measure 110 Has Increased Risks, but the Effectiveness of the Program Has Yet to Be Determined,” January 2023.

^f Corey S. Davis et al., “Changes in Arrests Following Decriminalization of Low-Level Drug Possession in Oregon and Washington,” *The International Journal on Drug Policy* 119 (September 2023): 104155, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104155>. Во всех штатах США издавна существует уголовная ответственность за хранение наркотиков. В начале 2021 года в Орегоне и Вашингтоне вступили в силу законы о декриминализации, в результате чего эти штаты стали исключением из этого правила.

^g Oregon Health Authority, “HB4002 Factsheet,” March 10, 2024.

^h FB Ahmad et al., “Provisional Drug Overdose Death Counts,” National Center for Health Statistics, April 17, 2024.

ⁱ Julie O’Donnell et al., “Drug Overdose Deaths with Evidence of Counterfeit Pill Use—United States, July 2019–December 2021,” *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report* 72, no. 35 (2023): 949–56.

^j Michael Zoorob et al., “Drug Decriminalization, the Introduction of Fentanyl to Drug Markets, and Fatal Overdose in Oregon,” *MedRxiv*, 2024, 2024.04.08.24305508.

^k Spruha Joshi et al., “One-Year Association of Drug Possession Law Change with Fatal Drug Overdose in Oregon and Washington,” *JAMA Psychiatry* 80, no. 12 (2023): 1277–83.

^l Oregon Secretary of State, “Oregon Health Authority: Too Early to Tell: The Challenging Implementation of Measure 110 Has Increased Risks, but the Effectiveness of the Program Has Yet to Be Determined.”

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Обновленная информация о последствиях легализации каннабиса

Сочетание движущих сил, вызванных проблемами в области государственной политики, в том числе по вопросам общественного здравоохранения и безопасности, а также амбиций, обусловленных соображениями получения прибыли и налоговых поступлений, привело к тому, что Канада и Уругвай и юрисдикции на уровне штатов в Соединенных Штатах легализовали цепочку поставок каннабиса и приняли меры, разрешающие производство и продажу каннабиса для употребления в немедицинских целях. Несмотря на тот факт, что оценка легализации каннабиса представляет собой сложную задачу, как сторонники, так и противники подобных изменений в политике при анализе отдачи от применения различных мер зачастую стремятся проявлять избирательность в отношении показателей или прибегают к их комбинированию, с тем чтобы сконцентрировать внимание исключительно на результатах, служащих аргументом в пользу уже сделанных ими выводов.

Накопительный эффект легализации может в полной мере проявиться спустя длительное время, также влияние любого изменения в политике, включая его непредвиденные последствия, можно в полной мере оценить в результате тщательного многолетнего мониторинга отдельных показателей, тем не менее на промежуточном этапе существует возможность наблюдать за краткосрочными изменениями этих показателей, которые позволяют сделать промежуточную количественную оценку отдачи от изменений в политике. В изданиях *Всемирного доклада о наркотиках 2020* и *2022* годов был представлен обстоятельный обзор последствий изменений в политике, разрешающих коммерческое производство и продажу каннабиса для немедицинского использования, с точки зрения здоровья населения, общественной безопасности и системы уголовного правосудия. Одна из выявленных проблем заключается в том, что реализация политики, которая привела к легализации каннабиса, должна ассоциироваться не с поворотом «переключателя», а скорее с нечто непрерывно происходящим, хотя типичный план исследования предполагает именно это. Важно также подчеркнуть наличие систематических различий между юрисдикциями, легализовавшими каннабис, и разных условий в них, что затрудняет сравнение последствий политики в отношении каннабиса между этими юрисдикциями. Таким образом, сопоставление результатов в разных юрисдикциях не дает возможности провести идеальный естественный эксперимент и не предоставляет данных о последствиях легализации каннабиса. Рассмотрение изменений показателей по сравнению с периодом до и после легализации каннабиса в юрисдикциях, где она проведена, по сравнению с теми, в которых этого сделано не было, также может ввести в заблуждение, поскольку тенденции в показателях могут не зависеть от статуса легализации; последствия легализации в одном штате могут распространиться на другие штаты, в которых немедицинское использование каннабиса, возможно, еще не легализовано.

С учетом этих оговорок и на основе раннее проведенного анализа последствий изменений в политике легализации каннабиса в Северной и Южной Америке, представленного во *Всемирном докладе о наркотиках за 2022 год*, в данном разделе приводится краткая обновленная информация о влиянии изменений в политике легализации каннабиса на состояние здоровья населения и существование незаконных рынков в юрисдикциях, легализовавших производство, продажу и потребление каннабиса.

РИС. 37 Тенденции в области потребления каннабиса среди населения в возрасте 18 лет и старше в штатах, которые легализовали употребление каннабиса в немедицинских целях и которые не сделали это, Соединенные Штаты, 2002–2022 годы

States that legalized cannabis	Штаты, легализовавшие каннабис
Index = 100 (0 is the year 2012–2013)	Индекс = 100 (0 относится к периоду 2012–2013 годов)

By 2007, 12 states had measures allowing medical use of cannabis	К 2007 году в 12 штатах были приняты меры, разрешающие употребление каннабиса в медицинских целях
By 2012, Colorado and Washington were the first states to legalize non-medical use of cannabis	К 2012 году Колорадо и Вашингтон были первыми штатами, легализовавшими употребление каннабиса в немедицинских целях.
Past-year use	Потребление в течение последних 12 месяцев
Past-month use	Потребление в течение последнего месяца
Risk perception of harm from occasional use of cannabis	Восприятие риска вреда эпизодического употребления каннабиса
States that did not legalize cannabis	Штаты, не легализовавшие каннабис
Index = 100 (0 is the year 2012–2013)	Индекс = 100 (0 относится к периоду 2012–2013 годов)
By 2007, 12 states had measures allowing medical use of cannabis	К 2007 году в 12 штатах были приняты меры, разрешающие употребление каннабиса в медицинских целях
By 2012, Colorado and Washington were the first states to legalize non-medical use of cannabis	К 2012 году Колорадо и Вашингтон были первыми штатами, легализовавшими употребление каннабиса в немедицинских целях.
Past-year use	Потребление в течение последних 12 месяцев
Past-month use	Потребление в течение последнего месяца
Risk perception of harm from occasional use of cannabis	Восприятие риска вреда эпизодического употребления каннабиса

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2022 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2023).

Последствия для здоровья населения: потребление каннабиса среди взрослого населения имеет тенденцию к росту

Немедицинское потребление каннабиса среди взрослого населения демонстрирует тенденцию к росту, которая в большей степени выражается в частом или ежедневном употреблении этого наркотика, особенно среди взрослой молодежи. Тенденция к росту потребления каннабиса прослеживается в Канаде, Уругвае и Соединенных Штатах.

В Канаде и Соединенных Штатах рост потребления каннабиса наблюдался задолго до полной легализации коммерческой деятельности, связанной с каннабисом. Что касается Соединенных Штатов, то расширение рынка каннабиса стало очевидным в период 2007–2008 годов, примерно в то время, когда в традиционных «аптеках» продавали медицинский каннабис всем желающим в Колорадо и Вашингтоне (фактическая легализация), и, следовательно, до 2012 года, когда в первых двух штатах была легализована коммерческая цепочка поставок и употребление каннабиса в немедицинских целях⁵². Рост потребления каннабиса в Соединенных Штатах можно прежде всего наблюдать на примере показателей его употребления в течение последних месяцев и ежедневного/почти ежедневного употребления среди лиц в возрасте 18 лет и старше, которые увеличились почти в три раза в период 2002–2022 годов. Хотя показатели употребления каннабиса в штатах, легализовавших немедицинское потребление, остаются значительно выше, чем в тех, которые этого не сделали, в этих двух группах штатов наблюдаются весьма схожие тенденции. Легализация немедицинского употребления каннабиса сама по себе не объясняет рост потребления каннабиса в штатах, которые его легализовали, поскольку потребление каннабиса в некоторых из штатов, сделавших это в числе первых, таких как Колорадо, традиционно является более высоким, чем в среднем по стране. Поэтому, возможно, легализация просто ускорила развитие сформировавшейся ранее тенденции и отчасти может быть результатом, а не причиной расширения рынка каннабиса.

Употребление каннабиса среди мужчин по-прежнему распространено в большей степени, чем среди женщин, однако гендерный разрыв в употреблении каннабиса в течение последнего месяца также сокращается в Канаде и Соединенных Штатах, и в меньшей степени — в Уругвае⁵³. В случае Соединенных Штатов потребление каннабиса в течение последнего месяца среди женщин увеличилось в период 2003–2022 годов более чем в три раза, что значительно выше аналогичного показателя среди мужчин⁵⁴.

РИС. 38 Гендерный разрыв в потреблении каннабиса в течение последнего месяца среди населения в возрасте 18 лет и старше, Соединенные Штаты, 2003–2022 годы

Prevalence (percentage)	Распространенность (проценты)
Ration of male to female prevalence of cannabis use	Соотношение распространенности потребления каннабиса среди мужчин и женщин
Men cannabis use in past month	Потребление каннабиса в течение последнего месяца среди мужчин
Women cannabis use in past month	Потребление каннабиса в течение последнего месяца среди женщин
Gender gap: ratio of men to women prevalence of cannabis use	Гендерный разрыв: соотношение распространенности потребления каннабиса среди мужчин и женщин
Linear (Gender gap: ratio of men to women prevalence of cannabis use)	Линейная тенденция (гендерный разрыв: соотношение распространенности потребления каннабиса среди мужчин и женщин)

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2022 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2023).

РИС. 39 Тенденции в области потребления каннабиса, Канада, 2018–2023 годы

Prevalence (percentage)	Распространенность (проценты)
Past-year use	Потребление в течение последних 12 месяцев
Past-month use	Потребление в течение последнего месяца
Daily/near-daily use	Ежедневное/почти ежедневное потребление
Daily/near-daily use among those who reported use of cannabis in the past 12 months	Ежедневное/почти ежедневное потребление среди лиц, сообщивших об употреблении каннабиса в течение последних 12 месяцев

Источник: Canadian Cannabis Survey. Cannabis use for non-medical purposes among Canadians (aged 16+). Ottawa: Health Canada; January 2024.

РИС. 40 Потребление каннабиса в разбивке по половым и возрастным группам, Канада, 2018–2023 годы

Annual prevalence (percentage)	Распространенность в течение года (проценты)
Overall	Население в целом
Men	Мужчины
Women	Женщины
Ages 16–19	В возрасте 16–19 лет
Ages 20–24	В возрасте 20–24 лет
Ages 25+	В возрасте старше 25 лет

Источник: Canadian Cannabis Survey. Cannabis use for non-medical purposes among Canadians (aged 16+). Ottawa: Health Canada; January 2024.

РИС. 41 Потребление каннабиса населением в целом, Уругвай, 2006–2018 годы

Prevalence (percentage)	Распространенность (проценты)
Regulation allowing non-medical use of cannabis introduced in 2015	Легализация употребления каннабиса в немедицинских целях в 2015 году
Lifetime prevalence	Распространенность потребления в течение жизни
Past-year prevalence	Распространенность потребления в течение последних 12 месяцев
Past-month prevalence	Распространенность потребления в течение последнего месяца

Источник: ‘VII Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas En Población General’ (Observatorio Uruguayo de Drogas, Junta Nacional de Drogas (JND) - Uruguay, 2019).

В случае Канады, несмотря на изменения в потреблении каннабиса от года к году, в первые несколько лет после легализации, особенно среди взрослой молодежи в возрасте 20–24 лет, наблюдался значительный рост показателя потребления каннабиса в течение последних 12 месяцев, в течение последнего месяца и ежедневного/почти ежедневного потребления, однако после 2020 года ситуация несколько стабилизировалась⁵⁵. Однако в 2022 году число лиц, употребляющих каннабис ежедневно/почти ежедневно, сократилось. Аналогичная тенденция прослеживается и в Уругвае, где в период 2006–2018 годов потребление каннабиса в течение последних 12 месяцев и последнего месяца среди населения в целом увеличилось в 2,5 раза.

В каждой стране и юрисдикции, легализовавших каннабис, изначально были разные уровни потребления каннабиса. Поэтому легализация может по-разному сказываться на масштабах потребления каннабиса среди взрослых. В Канаде и Уругвае, а также в юрисдикциях Соединенных Штатов потребление каннабиса начало расти задолго до его легализации. Таким образом, рост потребления каннабиса среди взрослого населения может лишь отчасти быть обусловлен

изменениями в политике, которые, возможно, лишь ускорили развитие возникшей ранее тенденции. В Северной Америке путь к легализации последовательно выстраивался на протяжении жизни нескольких поколений. В Канаде и большинстве юрисдикций Соединенных Штатов этапами на пути к легализации стали инициативы, предусматривавшие разрешение употребления каннабиса в медицинских целях, и для этих инициатив было характерно различное соотношение терпимости и ограничений. Таким образом, легальное предложение каннабиса фактически предшествовало официальной легализации, что могло сильнее повлиять на масштабы употребления каннабиса, нежели легализация.

Потребление каннабиса среди подростков, по-видимому, существенно не меняется

По всей видимости, легализация каннабиса в Канаде и Соединенных Штатах пока не сказалась на потреблении этого наркотика подростками. Хотя уровень потребления каннабиса среди подростков в этих двух странах по-прежнему гораздо выше, чем в других, в целом он не изменяется, несмотря на то что, в годы пандемии COVID-19 регистрировалось снижение потребления^{56, 57}. В Северной Америке ежедневное потребление каннабиса подростками также осталось неизменным, тогда как регулярное употребление ими каннабиса путем вейпинга увеличилось⁵⁸. Следует отметить, что доступ к каннабису лицам, не достигшим определенного возраста (от 18 лет до 21 года в зависимости от юрисдикции), по-прежнему запрещен новыми нормативными актами.

РИС. 42 Потребление каннабиса среди учащихся старших классов (совокупное), Соединенные Штаты, 2010–2022 годы

Prevalence (percentage)	Распространенность (проценты)
Lifetime	В течение жизни
Past-year	В течение последних 12 месяцев
Past-month	В течение последнего месяца
Daily	Ежедневное

Источник: The Monitoring the Future Study, University of Michigan, 2023.

РИС. 43 Потребление каннабиса среди учащихся средних классов (13–17 лет), Уругвай, 2003–2021 годы

Prevalence (percentage)	Распространенность (проценты)
Regulation allowing non-medical use of cannabis introduced in 2015	Легализация употребления каннабиса в немедицинских целях в 2015 году
Lifetime	В течение жизни
Past-year	В течение последних 12 месяцев
Past-month	В течение последнего месяца

Источник: Junta Nacional de Drogas, IX Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas En Estudiantes De Enseñanza Media Informe De Investigación, Uruguay, 2022.

РИС. 44 Тенденции в отношении восприятия риска вреда от употребления каннабиса, учащиеся 12-го года обучения, Соединенные Штаты, 2010–2023 годы

Index = 100 (2010)	Индекс (100 = 2010 год)
Try cannabis once or twice	Пробовали употреблять каннабис один или два раза
Smoke cannabis occasionally	Курят каннабис от случая к случаю
Smoke cannabis regularly	Курят каннабис регулярно

Источник: The Monitoring the Future Study, University of Michigan, 2023.

Примечание: данные за 2020 год не представлены.

Однако потребление каннабиса среди подростков все же возросло в Уругвае: в период 2003–2021 годов все показатели распространенности удвоились. Тем не менее, с 2016 года ситуация, похоже, существенно не менялась, что позволяет предположить, что за счет проведения с 2015 года новой политики, возможно, удалось остановить рост потребления каннабиса среди подростков⁵⁹.

Было установлено наличие обратной связи между восприятием риска и употреблением психоактивного вещества. Однако в случае с подростками в Соединенных Штатах, где восприятие риска, связанного с эпизодическим и регулярным употреблением каннабиса, среди подростков в целом снижается, по всей видимости, это снижение еще не сказалось на потреблении каннабиса среди подростков, если судить по распространенности употребления в течение последних 12 месяцев⁶⁰. Вместе с тем следует отметить, что в последнее время тенденция в отношении восприятия вреда от регулярного курения каннабиса изменилась: за последние два года все больше учащихся, которые регулярно употребляют этот наркотик путем курения, воспринимают его употребление как рискованное. Если эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, она может в конечном итоге повлиять на будущие модели потребления каннабиса среди подростков.

В Канаде наблюдаются различные тенденции в восприятии вреда от умеренного или регулярного употребления каннабиса после легализации, которое возросло в случае курения или вейпинга каннабиса, но стабилизировалось и, в последнее время, снизилось в случае пищевых продуктов с каннабисом. Уровень восприятия вреда значительно ниже среди лиц, сообщивших об употреблении каннабиса в течение последних 12 месяцев, чем среди лиц, не сообщивших об употреблении каннабиса в течение последних 12 месяцев⁶¹.

Злоупотребление каннабисом и его пагубные последствия для здоровья

Злоупотребление каннабисом в немедицинских целях, выражающееся в ежедневном употреблении и частом использовании продуктов, особенно с высоким содержанием ТГК и низким содержанием или почти полным отсутствием КБД⁶², связано с риском развития наркологических расстройств и сопутствующих психиатрических заболеваний, особенно психотических расстройств^{63, 64, 65, 66}. Кроме того, результаты экспериментальных и обсервационных исследований свидетельствуют о том, что лица, регулярно употребляющие каннабис, реже корректируют свои дозы при использовании продуктов каннабиса с более высоким содержанием ТГК, чем те, кто употребляет их время от времени, для достижения того же желаемого психоактивного эффекта⁶⁷.

РИС. 45 Доля лиц, воспринимающих риск, связанный с употреблением каннабиса, как «значительный» или «умеренный» в разбивке по способам употребления, Канада, 2018–2023 годы

Percentage of people responding	Доля лиц, представивших ответы
Those who eat or drink cannabis	Лица, употребляющие продукты питания или напитки с каннабисом
Those who smoke cannabis	Лица, употребляющие каннабис путем курения
Those who vape cannabis	Лица, употребляющие каннабис путем вейпинга
Overall	Население в целом
People who did not use cannabis in past 12 months	Лица, не употреблявшие каннабис в течение последних 12 месяцев
People who used cannabis in past 12 months	Лица, употреблявшие каннабис в течение последних 12 месяцев

Источник: Canadian Cannabis Survey. *Cannabis use for non-medical purposes among Canadians (aged 16+)*. Ottawa: Health Canada; январь 2024 года, а также данные за предыдущие годы.

В исследовании, посвященном определению содержания каннабиса в Соединенных Штатах, сообщается, что во многих юрисдикциях содержание ТГК в большинстве продуктов на рынке каннабиса превышает 15 процентов^{68, 69, 70}. В Соединенных Штатах в различных юрисдикциях на уровне штатов, где легализовано употребление каннабиса в немедицинских целях, также существует многообразие продуктов на основе каннабиса — от соцветий до концентратов с высоким содержанием ТГК (среднее содержание ТГК 50 процентов или более), продуктов, предназначенных для вдыхания, и пищевых продуктов⁷¹. Диверсификация продуктов каннабиса наблюдается и в Канаде, за исключением Квебека, где действуют правила, предусматривающие ограничения в отношении формы продуктов и содержания ТГК. В Квебеке не разрешено употреблять пищевые продукты, а содержание ТГК в других продуктах должно быть не более 30 процентов⁷². В Уругвае в основном наблюдается неизменно более низкое содержание ТГК и неизменно более узкий ассортимент продуктов каннабиса, чем в Канаде и Соединенных Штатах. Максимальное содержание ТГК в соцветиях каннабиса, продаваемых в аптеках Уругвая, составляет 9 процентов, но эти ограничения не распространяются на клубы сторонников каннабиса или домашнее культивирование⁷³; клубы сторонников каннабиса могут продавать продукты с содержанием ТГК до 15 процентов⁷⁴.

Что касается последствий для здоровья, связанных с легализацией каннабиса, то в штате Колорадо число обращений за неотложной помощью и госпитализаций, связанных с каннабисом (включая лечение расстройств на почве употребления каннабиса и зависимости от него), значительно возросло с 2013 года, но с 2018 года ситуация в целом не менялась. Сильнее всего выросло число обращений за неотложной помощью в связи с употреблением наркосодержащих пищевых продуктов, особенно среди детей. Кроме того, исследование, в котором использовались административные данные об обращениях за неотложной помощью в период 2013–2018 годов в штате Колорадо, показало, что с открытием розничных магазинов по продаже каннабиса в Колорадо связано значительное увеличение (в среднем на 24 процента) числа обращений за неотложной помощью в связи с психозами в округах⁷⁵. По сообщениям, основными причинами обращений за неотложной помощью в Колорадо являются тяжелая интоксикация, гиперемия, психиатрические симптомы и тяжелые сердечно-сосудистые заболевания⁷⁶. Показатели госпитализации в связи с употреблением каннабиса, несмотря на их недавнее снижение, за период 2011–2021 годов увеличились в два раза. Существует мнение, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, обращаемость за наркологической помощью снизилась, но увеличилось число препятствий для доступа к наркологической помощи в годы пандемии (2020–2021 годы)⁷⁷.

В Соединенных Штатах наблюдается тенденция к росту числа расстройств на почве употребления каннабиса, вероятно возникшая в годы, предшествовавшие легализации предложения для немедицинского потребления. Кроме того, увеличилась доля лиц с психическими расстройствами и суицидальными мыслями, увеличилось число попыток самоубийства и случаев смерти от непреднамеренной передозировки и убийств в результате регулярного употребления каннабиса, особенно среди молодых людей^{78, 79, 80}.

В Канаде стандартизированные по возрасту и полу показатели госпитализации в связи с употреблением каннабиса выросли в 1,6 раза в период с января 2015 года по март 2021 года (6,46 случая на 100 000 человек). Наибольший относительный рост числа госпитализаций был связан с психозами на почве употребления каннабиса, за которыми следовали госпитализации в связи с синдромом отмены каннабиса, пагубным употреблением и зависимостью. Треть госпитализаций пришлась на лиц в возрасте 15–24 лет⁸¹. Увеличение доступности продуктов для вейпинга, концентратов и пищевых продуктов говорит о том, что легализация открыла доступ к более вредным продуктам на основе каннабиса, в результате чего состояние здоровья населения из-за вреда, связанного с каннабисом в целом ухудшилось, как это видно на примере госпитализации в связи с расстройствами и психозами на почве употребления каннабиса⁸².

РИС. 46 Обращения за неотложной помощью и случаи госпитализации, связанные с каннабисом, в штате Колорадо, Соединенные Штаты, 2011–2021 годы

Discharge rate per 100,000 ED visits or hospitalizations	Число выписавшихся на 100 000 обращений за неотложной помощью или случаев госпитализации
Emergency department visits	Обращения за неотложной помощью
Hospitalizations	Случаи госпитализации

Источник: Colorado Department of Public Health and Environment, “Colorado Hospital Association data”, 2023.

Расширение распространенности употребления каннабиса среди взрослых, рост интенсивности (частоты и объемов) потребления, повышение содержания ТГК в продуктах каннабиса и рост числа госпитализаций в связи с употреблением каннабиса и расстройствами на почве его употребления — все это, вероятно, многократно усиливает пагубное воздействие потребления каннабиса⁸³.

Устойчивость незаконного рынка

Легализация предложения каннабиса для употребления в немедицинских целях происходила в условиях, когда уже существовал большой спрос на наркотик, который удовлетворялся через незаконные каналы. На данный момент эти каналы не полностью вытеснены законным рынком, хотя в некоторых юрисдикциях, по сообщениям, происходит сжатие пространства для нелегального рынка.

Зафиксированная доля незаконного рынка, сохранившаяся после легализации, варьирует в различных юрисдикциях. В Канаде в третьем квартале 2023 года более четверти лиц, которые представили сведения о расходах домохозяйств на каннабис, приобретали продукты каннабиса через нелегализованные источники, и этот процент продолжает снижаться с момента легализации каннабиса^{84, 85}. Удельные среднемесячные расходы потребителей на каннабис в период 2018–2023 годов снизились, хотя в 2021–2023 годах существенно не изменились; в 2023 году 73 процента жителей Канады, употреблявших каннабис в течение последних 12 месяцев, сообщили, что обычно приобретают каннабис через законный источник⁸⁶.

РИС. 47 Расходы домохозяйств на продукты каннабиса для употребления в немедицинских целях, Канада, 2018–2023 годы

In million Canadian dollars	Млн канадских долларов
Cannabis products for non-medical use (unlicensed)	Продукты каннабиса для употребления в немедицинских целях (нелегализованные)
Cannabis products for non-medical use (licensed)	Продукты каннабиса для употребления в немедицинских целях (легализованные)

Источник: Статистическое управление Канады. Таблица 36-10-0124-01. Подробные расходы на конечное потребление домашних хозяйств, Канада, ежеквартально.

В Уругвае по состоянию на январь 2023 года более 90 000 человек получили доступ к каннабису через один из трех источников поставок, доступных в стране, то есть через аптеки, выращивание в домашних условиях или клубы сторонников каннабиса. Доля этих людей составляет 30–35 процентов от предполагаемого числа взрослых, употребляющих каннабис в стране, что говорит о существенном дефиците возможностей законного рынка для удовлетворения спроса со стороны постоянных потребителей наркотика^{87, 88, 89}.

В Соединенных Штатах незаконный рынок каннабиса в разных формах существует также в Вашингтоне, Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке, Орегоне и других штатах^{90, 91}, хотя в некоторых из этих штатов большинство жителей получают каннабис из законных источников⁹². В тех штатах, где сохраняются незаконные рынки, так называемый «нелегальный каннабис» может продаваться по ценам ниже, чем на законном рынке^{93, 94}. Кроме того, для некоторых торговых точек в таких

штатах, как Калифорния, существует возможность не приобретать предусмотренную законом лицензию, с тем чтобы избежать подачи заявки и уплаты ежегодного сбора за продление лицензии, «продолжая при этом работать из магазина и представляясь лицензированным дилером»⁹⁵. Например, в Колорадо используются и другие способы, обеспечивающие процветание незаконного рынка, такие как культивирование каннабиса без лицензии, культивирование наркотика в национальном лесом фонде и контрабанда в соседние штаты, где каннабис запрещен законом⁹⁶. Кроме того, незаконный рынок, зачастую функционирующий наряду с легальными и квазилегальными рыночными структурами (под названием «параллельный рынок»), может оставаться привлекательным для потребителей и поставщиков по причинам, связанным, в частности, с ценами, качеством, доступностью, лицензированием, налогообложением, регулированием и перепроизводством^{97, 98}.

Другие последствия легализации каннабиса

Среди взрослого населения значительно снизилось число арестов за хранение каннабиса, предназначенного для личного потребления

В Соединенных Штатах, в том числе в штатах, легализовавших или декриминализировавших потребление каннабиса, с 2000-х годов прослеживается общая тенденция, выражающаяся в существенном снижении как абсолютного числа, так и процентной доли лиц, арестованных за хранение каннабиса. Эта тенденция возникла задолго до того, как штаты стали разрешать потребление каннабиса в медицинских или немедицинских целях. В штатах, где хранение каннабиса было декриминализовано, число арестов сократилось значительно больше, чем в штатах, где было легализовано употребление каннабиса в немедицинских целях^{99, 100}. Однако, несмотря на это снижение, сохраняется расовое неравенство в отношении арестов за преступления, связанные с каннабисом¹⁰¹.

Хотя декриминализация или легализация каннабиса предотвращает криминализацию в будущем, остается много вопросов, которые могут способствовать сохранению расового неравенства, включая погашение текущей судимости. Среди юрисдикций на уровне штатов, декриминализировавших или легализовавших каннабис и обеспечивающих возможность погашения судимости за правонарушения, связанные с каннабисом, большинство штатов требуют от лиц с судимостью подачи ходатайства о погашении судимости и уплаты пошлины; лишь в нескольких штатах погашение судимости происходит автоматически¹⁰². В большинстве штатов также существует период ожидания, который может длиться годами, прежде чем с человека будет снята судимость¹⁰³. Такие требования в непропорционально большей степени затрагивают экономически неблагополучные группы населения^{104, 105}.

Доходы и налоговые поступления от каннабиса увеличились в результате легализации, но остаются неизменными в последние годы

Легализация цепочки поставок каннабиса для употребления в немедицинских целях, включая коммерческое производство ряда продуктов каннабиса, создала источники значительных доходов для корпораций, осуществляющих инвестиции в индустрию каннабиса, и юрисдикций, его легализовавших. Легализация немедицинского каннабиса оказала явное влияние на объем налогов, собираемых на рынке каннабиса, и пополнила новым видом ресурсов бюджеты юрисдикций, легализовавших наркотик. Доходы, полученные от налогообложения каннабиса, могут показаться значительными в долларовом выражении, однако их доля в общих доходах штатов относительно невелика и не превышает 2 процентов от доходов штатов, легализовавших немедицинский каннабис^{106, 107}.

РИС. 48 Доходы штатов от продажи каннабиса, Соединенные Штаты, 2014–2023 годы

Millions of dollars	Млн долл. США
Washington	Вашингтон
California	Калифорния
Colorado	Колорадо
Alaska	Аляска

Источник: налоговый отдел Департамента налогов и сборов штата Аляска; Департамент администрирования налогов и сборов штата Калифорния; Управление исследований и анализа, Департамент налогов и сборов штата Колорадо; Департамент налогов и сборов штата Вашингтон, 2023 год.

Развитие событий в связи с психоделиками

Большинство известных в настоящее время психоделических веществ, таких как ЛСД, МДМА, мескалин и псилоцибин, находятся под контролем как вещества, включенные в Список I Конвенции 1971 года, с тем чтобы учесть возможность их использования в научных целях, и имеют очень ограниченное медицинское применение¹⁰⁸. В последние десятилетия, отчасти ввиду все более широкого распространения во всем мире заболеваний, связанных с психическими расстройствами¹⁰⁹, возродился интерес¹¹⁰ к терапевтическому применению различных психоделических веществ для лечения ряда психических расстройств^{111, 112}. В ходе ряда клинических исследований, проведенных относительно недавно главным образом в странах с высоким уровнем дохода, были получены первые и довольно многообещающие результаты, демонстрирующие потенциал применения некоторых психоделиков в сочетании с психотерапией для лечения ряда психических расстройств, которые не поддаются традиционному лечению^{113, 114}. До сих пор ни в одной стране мира не выдано ни одного разрешения¹¹⁵ на реализацию психоделиков на рынке медицинской продукции, и многие клинические испытания, как правило, не приводят к получению такого разрешения. По состоянию на февраль 2024 года насчитывалось более тысячи зарегистрированных клинических испытаний различных методик психоделической терапии с использованием МДМА, псилоцибина, ЛСД и кетамина, находящихся на разных этапах разработки. Однако, несмотря на первые результаты, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем будут разработаны терапевтические рекомендации, в том числе по обследованию лиц, инструктажу и контролю за приемом психоделиков, а такие методы лечения будут регламентированы и интегрированы в медицинскую практику¹¹⁶. Тем не менее в 2017 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Соединенных Штатов присвоило статус «революционного метода лечения» психотерапии с использованием МДМА для лечения посттравматического стрессового расстройства¹¹⁷, а в 2024 году — аналога псилоцибина для вспомогательного лечения большого депрессивного расстройства¹¹⁸ и одной из форм ЛСД для лечения генерализованного тревожного расстройства¹¹⁹.

Следует отметить, что в ходе двух последних обзоров публикаций, посвященных клиническим испытаниям психоделиков, были выявлены некоторые проблемы и выражена обеспокоенность по поводу проведения таких клинических испытаний. К этим проблемам, среди прочего, относятся небольшой размер выборки, отсутствие контрольных групп, необъективный отбор участников исследований, короткая продолжительность исследований, отсутствие информации о неблагоприятных событиях^{120, 121}.

Недавно экспертный консультативный комитет Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами Соединенных Штатов также выразил аналогичную обеспокоенность по поводу недавно проведенного третьего этапа испытаний МДМА, обратив при этом особое внимание на проблемы, касающиеся возможной необъективности испытаний, в том числе на проблему двойной анонимности, а также на непрозрачность информации о злоупотреблениях, мерах предосторожности и эффективности последующего лечения. Еще одна проблема последнего времени связана с вопросом полномочий органа по регулированию лекарственных средств на одобрение медикаментозной психотерапии, выходящей за рамки его компетенции по утверждению

лекарственных средств и медицинских препаратов. Это подчеркивает сложность и ограничения медицинской терапии, которая в конечном итоге может выйти за рамки экспериментов и открыть параллельные рынки психоделиков, употребляемых по причине их якобы медицинской пользы вне официального контекста, одобренного медициной.

ТАБЛИЦА 2 Краткая информация о клинических испытаниях психоделиков, 2024 год

STAGE OF CLINICAL TRIALS	СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Phase 1	Этап 1
Phase 2	Этап 2
Phase 3	Этап 3
Phase 4	Этап 4
LSD	ЛСД
MDMA	МДМА
Psilocybin	Псилоцибин
Ketamine	Кетамин
FUNDED BY	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
United States National Institute of Health	Национальный институт Соединенных Штатов по охране здоровья
United States federal agency	Федеральное агентство Соединенных Штатов
Industry	Промышленность
Individual universities, organizations	Отдельные университеты, организации

Источник: ClinicalTrials.gov.

Примечание: в таблицу включены испытания, проводимые в разных странах, в основном в странах с высоким уровнем дохода.

Потенциал терапевтического использования психоделиков также пробудил коммерческий интерес и обеспечил стимул для инвестиционной деятельности, в которой венчурные компании видят возможности для вложения средств и получения прибыли, что можно наблюдать по растущему числу клинических испытаний, финансируемых отдельными организациями и промышленностью. Коммерческий интерес к психоделикам также прослеживается и в других сферах в рамках более широкого явления, именуемого «психоделическим ренессансом»^{122, 123}, способствующего формированию благоприятных условий для неконтролируемого доступа к психоделикам.

Хотя перспективы получения пользы от использования психоделиков в терапевтических целях могут быть привлекательными, утверждается, что слишком быстрая коммерциализация, изменения в нормативно-правовой базе в некоторых юрисдикциях и практика немедицинского использования могут помешать их разумному терапевтическому использованию, в том числе в плане обеспечения надлежащего медицинского обследования, инструктажа и контроля, что негативно сказывается на качестве и строгости клинических исследований, которые обычно ассоциируются с разработкой методов лечения с применением «нового» класса препаратов^{124, 125}.

Изменения в нормативно-правовой базе, связанные с психоделиками

Последние изменения в политике привели к упрощению доступа к психоделическим веществам для использования в медицинских целях в Австралии и Квебеке (Канада), а также в двух юрисдикциях Соединенных Штатов. Австралия стала первой страной, где разрешено применение псилоцибина и МДМА в медицинских целях; с июля 2023 года уполномоченные психиатры получили доступ к МДМА для контролируемого лечения посттравматического стрессового расстройства и псилоцибину для лечения терапевтически резистентной депрессии¹²⁶. Однако до сих пор не разработан механизм для цепочки снабжения, и многие заинтересованные стороны в Австралии считают, что для широкого клинического применения психоделиков в этой стране не хватает фактические данных¹²⁷. Кроме того, в 2022 году в Квебеке (Канада) была одобрена медицинская страховка на психотерапевтическое лечение с использованием псилоцибина¹²⁸.

В 2020 году штат Орегон одобрил «квазипсихотерапевтическое» применение псилоцибина, включая регулирование цепочки поставок и розничной продажи и покупки препаратов с содержанием псилоцибина. В результате любому лицу старше 21 года с диагнозом психического расстройства или без него разрешается употреблять псилоцибин «под наблюдением» специалиста; для получения услуг псилоцибиновой терапии не требуется рецепт или направление, но перед употреблением псилоцибина необходимо пройти подготовительную беседу с обученным инструктором в учреждении, лицензированном штатом для предоставления услуг псилоцибиновой терапии^{130, 131, 132}. В 2022 году в штате Колорадо было декриминализовано хранение для личного потребления, выращивание, совместное использование и употребление, за исключением продажи, пяти природных психоделических веществ лицами, достигшими 21 года, и одобрено их использование в «лицензированных» учреждениях, а к 2026 году планируется расширить список разрешенных веществ, включив в него ДМТ, ибogaин и мескалин¹³³.

Благоприятные условия для употребления психоделиков, за исключением применения под медицинским контролем

На фоне «психоделического ренессанса» происходят и другие события, которые выходят за рамки клинических испытаний и отличаются от традиционного применения коренными общинами. Сообщества сторонников микродозирования¹³⁴, конференции по психоделикам, фестивали и ретриты — все это способствует созданию благоприятной среды для немедицинского применения психоделиков. Большинство из этих событий беспрецедентны по своему масштабу и охвату и, похоже, опережают научные разработки и фактические данные об эффективности применения этих веществ в рамках психоделической терапии под наблюдением врача в контролируемой среде.

PSYCHEDELIC “RENAISSANCE”	«ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС»
MICRODOSING COMMUNITIES	СООБЩЕСТВА СТОРОННИКОВ МИКРОДОЗИРОВАНИЯ
Unsupervised, self, quasi-therapeutic use of microdoses of psychedelics for mental health and well-being	Неконтролируемый самостоятельный квазипсихотерапевтический прием микродоз психоделиков в целях психического здоровья и благополучия
PSYCHEDELIC-LED TOURISM	ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Guided retreats offering an environment to engage in psychedelic experiences	Ретриты под руководством гида, в рамках которых обеспечиваются условия для психоделических переживаний
PSYCHEDELIC CONFERENCES	КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПСИХОДЕЛИКАМ
Promoting scientific research, as well as the cultural, philosophical and spiritual aspects through the intersection of psychedelics use	Содействие научным исследованиям, а также изучению культурных, философских и духовных аспектов употребления психоделиков
PSYCHEDELIC COMMUNITIES	СООБЩЕСТВА СТОРОННИКОВ ПСИХОДЕЛИКОВ
Promoting psychological well-being and social connectedness with psychedelics through the intersection of music and rituals (themed festivals)	Содействие психологическому благополучию и социальной связности с помощью психоделиков, употребляемых в ходе музыкально-ритуальных мероприятий (тематических фестивалей)
CLINICAL TRIALS	КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

В основе «психоделического ренессанса» лежит стимул к коммерциализации (особенно посредством финансовых инвестиций) усилий по разработке психоделических веществ с целью

содействия их употреблению под контролем врача или без него в ожидании результатов научных исследований^{135, 136, 137}. К марту 2020 года в Соединенных Штатах насчитывалось более 50 занимающихся разработкой или применением психоделиков компаний, акции которых свободно обращаются на рынке ценных бумаг¹³⁸. По прогнозам, к 2027 году производство психоделиков в Соединенных Штатах увеличится в пять раз по сравнению с оценочными показателями компаний за 2020 год, что свидетельствует о постоянном интересе инвесторов к сфере психоделических веществ¹³⁹. Некоторые из некоммерческих организаций, которые в числе первых занимались финансированием или проведением исследований в сфере психоделиков, стали публичными компаниями и теперь привлекают внешние инвестиции¹⁴⁰.

Еще одним примером растущего коммерческого и общественного интереса к психоделикам в последние годы является рост числа программ обучения психоделической интеграции, семинаров и сетей на основе рекомендаций, а также большое количество людей, добровольно соглашающихся на участие в клинических испытаниях психоделиков¹⁴¹.

Неконтролируемое (или немедицинское) употребление психоделиков: сообщества сторонников микродозирования

В последние годы микродозирование — практика приема малых субперцептивных доз психоделических веществ — привлекает все большее внимание из-за его якобы потенциальной пользы для психического здоровья и благополучия, что связано с появлением первых сообщений потребителей о его предполагаемом положительном воздействии и предварительных результатов клинических исследований¹⁴².

Однако результаты исследований в отношении пользы микродозирования оказались неоднозначными. В то время как наблюдательные или качественные исследования самоотчетов потребителей свидетельствуют об их удовлетворенности эффективностью микродозирования, в ходе рандомизированных контролируемых исследований какого-либо клинически значимого эффекта выявлено не было.

Некоторые исследования показали, что микродозирование потенциально может привести к улучшению настроения, снижению стресса и развитию творческого потенциала¹⁴³, однако последние крупномасштабные рандомизированные контрольные испытания с использованием микродозирования ЛСД и псилоцибина либо не продемонстрировали антидепрессивного, анксиолитического или прокогнитивного эффекта, либо показали неоптимальные результаты^{144, 145, 146}.

Последние исследования также указывают на возможность необъективности в исследованиях по микродозированию, особенно в тех, которые связаны с анонимными инициативами в рамках «гражданской науки», участники которых случайным образом определяют себя в группу плацебо или контроля; такие участники могут непреднамеренно повлиять на свои собственные оценки эффектов лечения, поскольку они подвержены искажению подтверждения и в большей степени рискуют дать ложные положительные результаты и таким образом повлиять на результаты исследования^{147, 148}. В целом практика многократного применения минимальных доз психоделических веществ до сих пор недостаточно изучена, и клинические данные о ее эффективности и безопасности ограничены^{149, 150, 151, 152}.

Несмотря на неоднозначные результаты, практика микродозирования, похоже, становится все более популярной. Онлайн-опрос, проведенный на основе акцидентной выборки из более чем 110 000 участников, для которой характерно преобладание пользователей интернета из Европы, Северной и Южной Америки и Океании, показал, что в 2020 году 5,6 процента респондентов принимали микродозы ЛСД или псилоцибина в течение последних 12 месяцев. Результаты показали, что число лиц, сообщивших о приеме микродоз ЛСД, увеличилось на 80 процентов по сравнению с 2018 годом (3,9 процента в 2018 году по сравнению с 2,2 процента в 2020 году)¹⁵³. Большинство респондентов, принимавших микродозы в 2020 году (55 процентов), сообщили, что принимали микродозы специально для самолечения диагностированного психиатрического заболевания или конкретного беспокойства или тревоги (эмоциональный дистресс), а остальные респонденты сообщили, что принимали микродозы только для улучшения общего самочувствия.

Исследования природы микродозирования свидетельствуют о настоятельной необходимости применения осторожного подхода к этой практике, особенно к проведению различия между потенциальным риском, связанным с длительным и многократным микродозированием, и более ограниченным риском физиологической безопасности, связанным с приемом нескольких «макродоз» с разницей в несколько недель или месяцев в контексте контролируемого употребления или психоделической терапии¹⁵⁴.

Конференции по психоделикам

Большое количество конференций по темам, связанным с психоделиками, в том числе и по опыту участников, также указывает на растущее разнообразие психоделиков и повышение интереса к ним. На конференциях рассматриваются не только вопросы, касающиеся научных исследований, но и более широкие культурные, философские и духовные аспекты использования психоделиков.

Увеличение числа конференций, посвященных этим темам, свидетельствует об отказе от ранее имевших место стигматизации и маргинализации в отношении психоделиков¹⁵⁵ и переходе к открытому диалогу об их потенциальном влиянии на благополучие людей. Этот растущий интерес побуждает предпринимать дополнительные шаги для учета и изучения потенциальных преимуществ психоделиков для отдельных лиц и сообществ, помимо их контролируемого терапевтического использования¹⁵⁶.

Только в 2023 году УНП ООН выявило в общей сложности 35 крупных конференций по психоделикам, из которых 14 были рассчитаны на экспертную аудиторию, как правило, академического характера. Поводом для проведения восьми из них были коммерческие интересы в сфере психоделиков; зачастую они организовывались для рассмотрения тем, касающихся психоделического «предпринимательства» или разработки новых психоделических препаратов и их экономического воздействия.

Тринадцать других конференций были рассчитаны на гораздо более широкую аудиторию, которую объединяет интерес к психоделикам и их потенциальным терапевтическим преимуществам. В одной из таких конференций приняли участие более 12 000 человек, в том числе 500 преподавателей из 52 стран, которые провели 30 семинаров, посвященных «перспективам использования психоделиков в культурном, медицинском и традиционном контексте»¹⁵⁷. Обзор содержания конференций по психоделикам показывает, что определяющими темами многих из этих конференций были, в частности, «психоделическое сознание и его коллективные аспекты», «осознанность», «самореализация» и «забота о себе», в то время как другие конференции были ориентированы на гендерные вопросы или служили местом встречи лиц с психическими расстройствами в целях изучения потенциальных терапевтических эффектов психоделиков. Центральное место на конференциях, рассчитанных на широкую аудиторию, занимают группы с определенным опытом, идентичность которых зачастую обусловлена употреблением психоделических веществ и созерцательными практиками.

Сообщества сторонников психоделиков

Психоделические ритуалы и ретриты подчеркивают важность контекстуальных элементов (так называемых «внутренних установок и внешней обстановки») в модулировании психоактивных эффектов психоделиков¹⁵⁸. Сообщается, что сообщества сторонников психоделиков содействуют психологическому благополучию и социальной сплоченности посредством использования психоделиков и влиянию музыки и ритуалов, исходя из предпосылки, что групповая обстановка может усилить действие психоделиков, способствуя развитию чувства взаимосвязанности и совместного опыта^{159, 160, 161}. Хотя такие сообщества не являются чем-то новым, в последнее время возникло новое явление — деконтекстуализация, то есть рационализация употребления психоделических веществ с опорой на новые клинические исследования, вырванные из контекста, которая зачастую мотивируется более широкими коммерческими интересами^{162, 163, 164}.

Фестивали с психоделической тематикой: трансформационные фестивали

Помимо конференций и сообществ, фестивали с психоделической тематикой служат еще одним местом сбора сообществ сторонников психоделиков, целью которых является «трансперсонализм», «коллективные экстазы», «осознанность» и «духовное здоровье»^{165, 166, 167}. Хотя фестивали с психоделической тематикой имеют долгую историю, восходящую, по крайней мере, к 1960-м годам, появилась новая разновидность фестивалей, определяющим признаком которых является предполагаемое положительное воздействие психоделических веществ. На трансформационных фестивалях, ориентированных на создание сообществ на основе общих интересов и убеждений, употребление психоделических веществ совмещается с музыкально-художественными представлениями, а также проводятся семинары и мероприятия, направленные на расширение знаний участников о духовности¹⁶⁸. Что отличает трансформационные фестивали от более ранних фестивалей сторонников психоделического транса, которые фокусировались в основном на психоделической музыке, искусстве и сообществе, так это приверженность целостному подходу,

который включает в себя духовные практики, медитацию, благополучие и осознанность, наряду с основными элементами музыки и употреблением психоделиков¹⁶⁹.

Психоделический туризм и ретриты

Фестивали, география которых охватывает Северную Америку, Латинскую Америку и Европу и становится все шире, привлекают все больше участников и посетителей, способствуя развитию психоделического туризма. Эта форма туризма рекламируется как вид путешествий, в ходе которых люди отправляются в поездки в определенные места или участвуют в структурированных ретритах, чтобы исследовать духовное, рекреационное и терапевтическое действие психоделических веществ в «благоприятной обстановке, определяемой общими убеждениями и интересами»¹⁷⁰.

Психоделический туризм включает в себя ретриты под руководством гида, представляющие собой структурированные программы или организованные мероприятия, в рамках которых людям обеспечиваются благоприятные условия для психоделических переживаний, хотя и без медицинского контроля. В таких ретритах употребление психоделиков обычно сочетаются с «квазипсихотерапевтическими» или духовными практиками, такими как медитация, групповая терапия или шаманские церемонии, предполагаемая цель которых заключается в том, чтобы способствовать личностному росту, самопознанию и исцелению под руководством инструкторов^{171, 172}.

Главным элементом этих ретритов является *аяуаска* — отвар из содержащего психоактивные вещества растения, родом из бассейнов Амазонки и Ориноко, который готовят «шаманы и народные целители»¹⁷³. Однако эти ретриты часто проводятся в формах, оторванных от их коренных истоков. Более того, ретриты с употреблением *аяуаски* и другие ретриты, проводимые в местах проживания коренных народов, стали объектом коммерциализации и колонизации или присвоения культур коренных народов в попытках адаптировать церемонии для аудитории, не имеющей отношения к коренным народам, которая сосредоточена на психоактивных элементах церемоний, а не на духовных аспектах и условиях жизни коренных народов^{174, 175}. Соответственно, такие ретриты, как правило, служат средством организации неконтролируемого, «квазипсихотерапевтического» употребления психоделиков с применением психотерапевтических методик, которые благоприятствуют использованию одних аспектов духовных практик коренных народов и отказываются от других в зависимости от потребностей участников^{176, 177}.

Вопросы, касающиеся рисков злоупотребления нерегулируемой практикой

Содействие использованию психоделиков в медицине, подкрепленному строгими научными данными, имеет важное значение, тем не менее многие вопросы, касающиеся потенциальных рисков, связанных с их употреблением, и пользы этих веществ для здоровья, остаются без ответа. Развернувшаяся на фоне «психоделического ренессанса» дискуссия вокруг доступа к психоделикам и их использования разрастается, выходя за рамки обсуждения их доказанного терапевтического применения и результатов клинических исследований. Похоже, что интерес общественности к этому вопросу и внимание частного сектора к нему сильнее, чем показывают современные научные данные об эффективности психоделиков в плане улучшения психического здоровья и когнитивных функций. К условиям проведения психоделической терапии в лечебном учреждении, обеспечивающим эффективное медицинское применение психоделиков, по всей видимости, предъявляются более высокие требования, по сравнению с теми, в которых проводятся мероприятия в рамках «психоделического ренессанса». Риск заключается в том, что представление о психоделиках как о «панацее» для лечения психических расстройств и улучшения психического или душевного благополучия в целом, за что активно выступает все большее число заинтересованных групп общественности и коммерческих структур, будет распространяться быстрее, чем научные данные, что приведет к развитию рынка неконтролируемого «квазипсихотерапевтического» употребления и использования в духовных и рекреационных целях, включая надлежащее обследование и инструктаж, до того, как может быть установлен порядок контролируемого

терапевтического применения. Это может привести к развитию небезопасного рынка психоделиков для употребления в различной обстановке, что сопряжено с неизбежными рисками злоупотребления нерегулируемой практикой. Эти риски наблюдались на начальном этапе разработки многих психоактивных веществ, таких как героин или кокаин, в связи с их сбытом, неконтролируемым самолечением и немедицинским употреблением в прошлом веке и последующем периоде^{178, 179}.

Большинство разработок, связанных с психоделиками, проводятся в либо в западных странах, либо в них участвуют выходцы в основном из этих стран. Как и в случае с любым другим наркотиком, распространение употребления психоделиков в немедицинских целях может начинаться с благополучных общин, но укоренившись, оно распространяется и среди обнищавших, маргинализированных групп и меньшинств, что может привести к увеличению совокупного вреда. Такие группы часто сталкиваются с проблемой справедливости, они могут не иметь необходимого социального капитала и ресурсов для предотвращения пагубных последствий, и поэтому в конечном итоге именно для них характерны высокие показатели, касающиеся пагубного потребления психоактивных веществ, расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, и ограниченного доступа к наркологическим услугам¹⁸⁰.

Представляется, что в развитии событий, имеющих отношение к психоделикам и каннабису, за пределами медицинской сферы есть некоторые сходства и различия. Что касается каннабиса, то импульс к изменению нормативно-правовой базы в области медицинского и немедицинского использования, начавшийся в Северной Америке, хотя и медленно, но все же распространился на Западную Европу и другие регионы. Что касается каннабиса и психоделиков, то во многих странах коммерческие интересы и средства массовой информации способствовали росту представлений об их пользе или снижению уровня восприятия риска среди населения, что, наряду с давлением со стороны групп активистов, скорее всего, повлияло на изменение нормативно-правового регулирования в отношении обоих веществ. Однако общий интерес к потенциальным терапевтическим преимуществам психоделиков и события, способствующие формированию благоприятной среды, похоже, развиваются быстрыми темпами. Игнорирование этих, очевидно не связанных между собой, инициатив, о которых говорится в данной главе, скорее всего, ускорит развитие коммерческих, направленных на извлечение прибыли механизмов цепочки поставок психоделических веществ, подобно тому, как происходило развитие коммерческих рынков каннабиса^{181, 182, 183, 184, 185, 186}.

Одно из главных отличий, по всей видимости, заключается в том, что если процессы легализации или регулирования каннабиса для употребления в немедицинских целях в основном были вызваны необходимостью нормализации его потребления в рекреационных целях, то импульс к легализации психоделиков или отмене их регулирования, по всей видимости, в большей степени вызван желанием неконтролируемого терапевтического использования в рамках всего спектра вопросов, касающихся психического здоровья, самоосознания, духовности и общего благополучия.

Давление со стороны коммерческих структур и групп активистов, которые настаивают на том, что психоделики являются решением проблемы серьезных психических расстройств и благополучия, также может повлиять на результаты текущих и будущих клинических испытаний и подорвать авторитет строгих научных исследований по определению их терапевтической пользы, применению и практике^{187, 188}. Нерегулируемое или ненадлежащим образом регулируемое коммерческое предложение психоделиков для немедицинских целей может также поставить под угрозу достижение целей общественного здравоохранения, таких как улучшение здоровья, социального благополучия и качества жизни и сведение к минимуму рисков для здоровья, связанных с употреблением психоделиков.

Примечания и ссылки

- 1 Beau Kilmer and Robert J. MacCoun, 'How Medical Marijuana Smoothed the Transition to Marijuana Legalization in the United States', *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. 1 (13 October 2017): 181–202.
- 2 Aviad Hadar et al., 'The Psychedelic Renaissance in Clinical Research: A Bibliometric Analysis of Three Decades of Human Studies with Psychedelics', *Journal of Psychoactive Drugs* 55, no. 1 (1 January 2023): 1–10.
- 3 «Квазитерапевтическими» считаются практики, вмешательства или продукты, обладающие некоторыми лечебными характеристиками, но не в полной мере отвечающие критериям официальных методов лечения. Квазитерапевтические подходы могут включать определенные оздоровительные практики, альтернативные методы лечения или мероприятия, которые способствуют хорошему самочувствию, но не являются официально признанными медицинскими или психологическими методами лечения.
- 4 Изменения в политике произошли в штатах Колорадо и Орегон. Закон штата Орегон гласит, что инструктор может предоставлять клиентам услуги с использованием псилобицина, включая, в частности, диагностику и лечение нарушений физического и психического здоровья, но не должен заниматься деятельностью, для осуществления которой требуется дополнительная профессиональная лицензия.
- 5 Изменения в политике произошли в провинции Квебек.
- 6 По всей видимости, термин «психоделический ренессанс» был введен психиатром доктором Бенем Сесса в его книге *The Psychedelic Renaissance: Reassessing the Role of Psychedelic Drugs in 21st Century Psychiatry* («Психоделический ренессанс: переоценка роли психоделических препаратов в психиатрии XXI века»), которая впервые была опубликована в 2012 году. С тех пор этот термин используется в крупных журналах, газетах, книгах и научных трудах, в которых описываются научные разработки, а также ощущения лиц, переживших состояние «психоделического трипа», и психоделическое движение в целом.
- 7 См также Richert Lucas, 'The Psychedelic Renaissance', *Psychology Today*, 14 August 2019.
- 8 Emily Witt, 'The Psychedelic Renaissance: Trip Reports from Timothy Leary, Michael Pollan, and Tao Lin', *The New Yorker*, 29 May 2018.
- 9 Конвенция о психотропных веществах 1971 года, статья 7 (дата не указана).
- 10 В июле 2018 года парламент Канады принял Закон о каннабисе, который устанавливает нормативно-правовую базу регулирования доступа к каннабису в медицинских и немедицинских целях (для взрослых в возрасте 18 лет или старше) с помощью ряда контрольных процедур, регламентирующих его производство, распространение, продажу и хранение.
- 11 В 2013 году правительство Уругвая приняло закон (Закон № 19.172), регламентирующий культивирование, производство, сбыт и потребление каннабиса в немедицинских целях.
- 12 В округе Колумбия не разрешено коммерческое производство и продажа каннабиса.
- 13 National Conference of State Legislatures, 'Cannabis Overview', n.d., accessed 29 December 2023.
- 14 Mafalda Pardal et al., 'Alternatives to Profit-Maximising Commercial Models of Cannabis Supply for Non-Medical Use' (RAND Corporation, 2023).
- 15 См. таблицы по способам реализации в онлайн-сегменте *Всемирного доклада о наркотиках*: тенденции на рынках наркотиков.
- 16 Wayne Hall and Michael Lynskey, 'Assessing the Public Health Impacts of Legalizing Recreational Cannabis Use: The US Experience', *World Psychiatry* 19, no. 2 (June 2020): 179–86.
- 17 Wayne Hall et al., 'The Implementation and Public Health Impacts of Cannabis Legalization in Canada: A Systematic Review', *Addiction* 118, no. 11 (November 2023): 2062–72.
- 18 Daniel T. Myran et al., 'Changes in Cannabis-Attributable Hospitalizations Following Nonmedical Cannabis Legalization in Canada', *JAMA Network Open* 6, no. 10 (5 October 2023): e2336113.

- 19 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год).
- 20 Bundesministerium für Gesundheit, 'Cannabis Act (CanG)', 26 March 2024.
- 21 Bundesministerium für Gesundheit, 'Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz', 18 April 2024.
- 22 Government of Luxembourg (2023, 4 April), 'Pilot Project for Legal Access to Cannabis for Non-Medical Purposes' (n.d.).
- 23 Government of Luxembourg (n.d.).
- 24 Police Lëtzebuerg, 'New Regulations For The Use And Cultivation Of Cannabis', 24 July 2023.
- 25 Government of Luxembourg.
- 26 Ibid.
- 27 Government of Malta, 'LXVI of 2021 - Authority on the Responsible Use of Cannabis Act, 2021 Government Gazette of Malta No. 20,753 - 18.12.2021', Pub. L. No. Pub. L. No. LXVI (2021).
- 28 Ibid.
- 29 Ibid.
- 30 Ibid.
- 31 Ministerie van Justitie en Veiligheid, 'Toleration Policy Regarding Soft Drugs and Coffee Shops - Drugs - Government.NL', onderwerp (Ministerie van Algemene Zaken, 28 November 2013).
- 32 Government of the Kingdom of the Netherlands (2019, 13 November), 'Controlled Cannabis Supply Chain Experiment Act' (n.d.).
- 33 J. André Knottnerus et al., 'Cannabis Policy in The Netherlands: Rationale and Design of an Experiment with a Controlled Legal ("Closed") Cannabis Supply Chain', *Health Policy* 129 (1 March 2023): 104699.
- 34 Ministerie van Algemene Zaken, 'Aanleiding en opzet experiment gesloten coffeeshopketen - Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) - Rijksoverheid.nl', onderwerp (Ministerie van Algemene Zaken, 3 April 2019).
- 35 Ministerie van Algemene Zaken.
- 36 Constitutional Court of South Africa, 'Minister of Justice and Constitutional Development and Others v Prince; National Director of Public Prosecutions and Others v Rubin; National Director of Public Prosecutions and Others v Acton and Others', 18 September 2018.
- 37 'The Concerned Acts in Violation of the South African Constitution Are the Drugs and Drug Trafficking Act 140 of 1992 (Drugs Act) and the Medicines and Related Substances Control Act 101 of 1965 (Medicines Act)', n.d.
- 38 Constitutional Court of South Africa, 'Minister of Justice and Constitutional Development and Others v Prince; National Director of Public Prosecutions and Others v Rubin; National Director of Public Prosecutions and Others v Acton and Others'.
- 39 Minister of Justice and Correctional Services, 'Cannabis for Private Purposes Bill (No 19 of 2020)' (Republic of South Africa, 27 February 2024).
- 40 Ibid.
- 41 'SR 812.121.5 - Verordnung Vom 31. März 2021 Über Pilotversuche Nach Dem Betäubungsmittelgesetz (BtmPV)', n.d., accessed 24 December 2023.
- 42 Roman Zwicky et al., 'A Research Agenda for the Regulation of Non-Medical Cannabis Use for Switzerland, Zucker Politik-Evaluationsstudien Nr. 20 (Commissioned by the Federal Office of Public Health 2021)', n.d.
- 43 Ibid.
- 44 'Weed Care – Informationen', n.d., accessed 12 December 2023.
- 45 Grashaus Projects (blog), 'Studie', n.d., accessed 12 December 2023.
- 46 Association ChanGE, 'En Savoir Plus', 28 March 2023.

- 47 'Züri Can - Cannabis Mit Verantwortung - Stadt Zürich', n.d., accessed 21 December 2023.
- 48 'Le Project | Cann-L', n.d., accessed 12 December 2023.
- 49 SCRIPT, 'Pilotstudie', n.d., accessed 21 December 2023.
- 50 Официальное сообщение для УНП ООН от 2 апреля 2024 года.
- 51 Там же.
- 52 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год, брошюра 3, 2022 год.
- 53 'VII Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas En Población General' (Observatorio Uruguayo de Drogas, Junta Nacional de Drogas (JND), Uruguay, 2019).
- 54 United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 'Results from the 2022 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables' (Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2323); и аналогичные доклады за прошлые годы.
- 55 Health Canada, 'Canadian Cannabis Survey: Cannabis Use for Non-Medical Purposes among Canadians (Aged 16+)' (Ottawa, January 2024).
- 56 Miech Johnston R A., et al., 'Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2022: Secondary School Students', Monitoring the Future Monograph Series (Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan, 2023).
- 57 Health Canada, 'Canadian Cannabis Survey: Cannabis Use for Non-Medical Purposes among Canadians (Aged 16+)'.
58 Carmen C. W. Lim et al., 'Prevalence of Adolescent Cannabis Vaping: A Systematic Review and Meta-Analysis of US and Canadian Studies', *JAMA Pediatrics* 176, no. 1 (1 January 2022): 42.
- 59 'IX Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas En Estudiantes De Enseñanza Media Informe De Investigación' (Uruguay: Junta Nacional de Drogas, 2022).
- 60 Johnston et al., 'Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2022: Secondary School Students'.
- 61 Health Canada, 'Canadian Cannabis Survey: Cannabis Use for Non-Medical Purposes among Canadians (Aged 16+)'.
62 Сбалансированное соотношение между КБД и ТГК может смягчить психоактивное воздействие ТГК.
- 63 Marta Di Forti et al., 'The Contribution of Cannabis Use to Variation in the Incidence of Psychotic Disorder across Europe (EU-GEI): A Multicentre Case-Control Study', *The Lancet Psychiatry* 6, no. 5 (May 2019): 427–36.
- 64 Arianna Marconi et al., 'Meta-Analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use and Risk of Psychosis', *Schizophrenia Bulletin* 42, no. 5 (September 2016): 1262–69.
- 65 Lindsey A. Hines et al., 'Association of High-Potency Cannabis Use With Mental Health and Substance Use in Adolescence', *JAMA Psychiatry* 77, no. 10 (1 October 2020): 1044.
- 66 Kat Petrilli et al., 'Association of Cannabis Potency with Mental Ill Health and Addiction: A Systematic Review', *The Lancet Psychiatry*, no. 9 (September 2022): 736–50.
- 67 Janni Leung et al., 'Do Cannabis Users Reduce Their THC Dosages When Using More Potent Cannabis Products? A Review', *Frontiers in Psychiatry* 12 (18 February 2021): 630602.
- 68 Mary Catherine Cash et al., 'Mapping Cannabis Potency in Medical and Recreational Programs in the United States', ed. Tally Largent-Milnes, *PLOS ONE* 15, no. 3 (26 March 2020): e0230167.
- 69 Sarah D. Pennypacker et al., 'Potency and Therapeutic THC and CBD Ratios: U.S. Cannabis Markets Overshoot', *Frontiers in Pharmacology* 13 (6 June 2022): 921493.
- 70 Однако некоторые исследования также показали, что содержание ТГК зачастую бывает неточным и значительно ниже, чем указано на этикетке.
- 71 George Sam Wang et al., 'Impact of Cannabis Legalization on Healthcare Utilization for Psychosis and Schizophrenia in Colorado', *International Journal of Drug Policy* 104 (June 2022): 103685.

- 72 Elle Wadsworth et al., 'Legal Sourcing of Ten Cannabis Products in the Canadian Cannabis Market, 2019–2021: A Repeat Cross-Sectional Study', *Harm Reduction Journal* 20, no. 1 (17 February 2023): 19.
- 73 Mafalda Pardal and Elle Wadsworth, 'Strictly Regulated Cannabis Retail Models with State Control Can Provide Lessons in How Jurisdictions Can Regulate THC', *Addiction* 118, no. 6 (June 2023): 1005–7.
- 74 Ibid.
- 75 Wang et al., 'Impact of Cannabis Legalization on Healthcare Utilization for Psychosis and Schizophrenia in Colorado'.
- 76 Andrew A. Monte et al., 'Acute Illness Associated With Cannabis Use, by Route of Exposure: An Observational Study', *Annals of Internal Medicine* 170, no. 8 (16 April 2019): 531.
- 77 Lydia Aletraris, Brian D. Graves, and Joyce J. Ndung'u, 'Assessing the Impact of Recreational Cannabis Legalization on Cannabis Use Disorder and Admissions to Treatment in the United States', *Current Addiction Reports* 10, no. 2 (10 April 2023): 198–209.
- 78 Beth Han et al., 'Associations of Suicidality Trends With Cannabis Use as a Function of Sex and Depression Status', *JAMA Network Open* 4, no. 6 (22 June 2021): e2113025.
- 79 Michael William Flores, Saul Granados, and Benjamin Lê Cook, 'US Trends in the Association of Suicide Ideation/Behaviors with Marijuana Use among Adolescents Ages 12–17 and Differences by Gender and Race/Ethnicity', *Frontiers in Psychiatry* 13 (5 January 2023): 1057784.
- 80 Cynthia A. Fontanella et al., 'Association of Cannabis Use With Self-Harm and Mortality Risk Among Youths With Mood Disorders', *JAMA Pediatrics* 175, no. 4 (1 April 2021): 377.
- 81 Myran et al., 'Changes in Cannabis-Attributable Hospitalizations Following Nonmedical Cannabis Legalization in Canada'.
- 82 Ibid.
- 83 Albert Stuart Reece and Gary Kenneth Hulse, 'Quadruple Convergence – Rising Cannabis Prevalence, Intensity, Concentration and Use Disorder Treatment', *The Lancet Regional Health - Europe* 10 (November 2021): 100245.
- 84 Health Canada, 'Canadian Cannabis Survey: Cannabis Use for Non-Medical Purposes among Canadians (Aged 16+)'.
85 Center of Alcohol & Substance Use Studies, 'Cannabis Black Market Thrives Despite Legalization'.
86 Health Canada, 'Canadian Cannabis Survey: Cannabis Use for Non-Medical Purposes among Canadians (Aged 16+)'.
87 Uruguay XXI: Investment, Export and Country Brand Promotion Agency, 'Cannabis Sector In Uruguay', April 2023.
- 88 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, брошюра 3.
- 89 Instituto de Regulación y Control del Cannabis and Observatorio Uruguayo de Drogas, 'Mercado Regulado Del Cannabis: INFORME XVI' (Junta Nacional de Drogas, 30 June 2023).
- 90 Emmanuelle Auriol, Alice Mesnard, and Tiffanie Perrault, 'Weeding out the Dealers? The Economics of Cannabis Legalization', *Journal of Economic Behavior & Organization* 216 (December 2023): 62–101.
- 91 Caroline Anders et al., 'Legalization of Marijuana and Its Effects on Licit and Illicit Markets in the United States', in *Perspectives on Black Markets v.2*, 2022.
- 92 Beau Kilmer and Samantha Pérez-Dávila, 'Nine Insights From 10 Years of Legal Cannabis for Nonmedical Purposes', *Clinical Therapeutics* 45, no. 6 (June 2023): 496–505.
- 93 Zusha and Vielkind, 'How New York and California Botched Marijuana Legalization; Steep Taxes and Heavy Regulation Are Making It Hard for Licensed Pot Sellers to Operate in Some States, Driving More Producers and Buyers to Illegal Outlets. "Our No. 1 Competitor Is the Illicit Market."'.
- 94 Cato Institute, 'Marijuana Taxes Keep Black Markets Thriving', 20 March 2023.
- 95 Center of Alcohol & Substance Use Studies, 'Cannabis Black Market Thrives Despite Legalization'.
- 96 Caroline Anders et al., 'Illicit Marijuana Grows with Colorado Legalization', in *Book Title: Perspectives on Black Markets v.2*, 2022.

- 97 Jeremias Lachman, Andrés López, and Sebastián Gómez-Roca, 'A Long and Winding Road: Making Cannabis Black Markets Legal', *Cahiers Des Amériques Latines*, no. 99 (15 December 2022): 59–80.
- 98 Caroline Anders et al., 'Legalization of Marijuana and Its Effects on Licit and Illicit Markets in the United States'.
- 99 Brynn E. Sheehan, Richard A. Grucza, and Andrew D. Plunk, 'Association of Racial Disparity of Cannabis Possession Arrests Among Adults and Youths With Statewide Cannabis Decriminalization and Legalization', *JAMA Health Forum* 2, no. 10 (29 October 2021): e213435.
- 100 Andrew D. Plunk et al., 'Youth and Adult Arrests for Cannabis Possession After Decriminalization and Legalization of Cannabis', *JAMA Pediatrics* 173, no. 8 (1 August 2019): 763.
- 101 Sheehan, Grucza, and Plunk, 'Association of Racial Disparity of Cannabis Possession Arrests Among Adults and Youths With Statewide Cannabis Decriminalization and Legalization'.
- 102 Tanner Wakefield, Stella Bialous, and Dorie E. Apollonio, 'Clearing Cannabis Criminal Records: A Survey of Criminal Record Expungement Availability and Accessibility among US States and Washington DC That Decriminalized or Legalized Cannabis', *International Journal of Drug Policy* 114 (April 2023): 103983.
- 103 Ibid.
- 104 Ibid.
- 105 Lindsay Bing, Becky Pettit, and Ilya Slavinski, 'Incomparable Punishments: How Economic Inequality Contributes to the Disparate Impact of Legal Fines and Fees', *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 8, no. 2 (January 2022): 118–36.
- 106 Adam Hoffer, 'Cannabis Taxation: Lessons Learned from U.S. States and a Blueprint for Nationwide Cannabis Tax Policy', Tax Foundation, 14 December 2023.
- 107 Tony Lange, 'These 23 States, DC Collected \$2.9 Billion in Cannabis Excise Tax Revenue in 2023', *Cannabis Business Times*, n.d., accessed 9 April 2024.
- 108 Конвенции о международном контроле над наркотиками: списки Конвенции о психотропных веществах 1971 года по состоянию на 13 ноября 2023 года (Организация Объединенных Наций, 2023 год).
- 109 GBD 2019 Mental Disorders Collaborators, 'Global, Regional, and National Burden of 12 Mental Disorders in 204 Countries and Territories, 1990–2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019', *The Lancet Psychiatry* 9, No.2, February 2022.
- 110 См. УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра «Наркотики: современные проблемы», 2023 год. Глава 2 «Последние изменения в сфере использования психоделиков».
- 111 Hadar et al., 'The Psychedelic Renaissance in Clinical Research'.
- 112 Kenneth W. Tupper et al., 'Psychedelic Medicine: A Re-Emerging Therapeutic Paradigm', *Canadian Medical Association Journal* 187, no. 14 (6 October 2015): 1054–59.
- 113 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год*, брошюра «Наркотики: современные проблемы».
- 114 Elliot Marseille, Stefano Bertozzi, and James G. Kahn, 'The Economics of Psychedelic-Assisted Therapies: A Research Agenda', *Frontiers in Psychiatry* 13 (5 December 2022): 1025726.
- 115 Процесс обзора и оценки доказательств в поддержку лекарственного препарата в связи с его распространением на рынке, завершающийся выдачей лицензии на продажу.
- 116 Joshua Phelps, Ravi N. Shah, and Jeffrey A. Lieberman, 'The Rapid Rise in Investment in Psychedelics—Cart Before the Horse', *JAMA Psychiatry* 79, no. 3 (1 March 2022): 189.
- 117 Allison A. Feduccia et al., 'Breakthrough for Trauma Treatment: Safety and Efficacy of MDMA-Assisted Psychotherapy Compared to Paroxetine and Sertraline', *Frontiers in Psychiatry*, 12 September 2019.
- 118 Diana Ernst, 'Psilocybin Analog Gets Breakthrough Tx Status for Major Depressive Disorder', MPR, 13 March 2024.
- 119 Ken Terry, 'FDA Opens the Door to Clinical Use of LSD', WebMD, n.d., accessed 11 April 2024.

- 120 Oliver Rumle Hovmand et al., 'Risk of Bias in Randomized Clinical Trials on Psychedelic Medicine: A Systematic Review', *Journal of Psychopharmacology* 37, no. 7 (July 2023): 649–59.
- 121 Michiel Van Elk and Eiko I. Fried, 'History Repeating: Guidelines to Address Common Problems in Psychedelic Science', *Therapeutic Advances in Psychopharmacology* 13 (January 2023).
- 122 По всей видимости, термин «психоделический ренессанс» был введен психиатром доктором Беном Сесса в его книге *The Psychedelic Renaissance: Reassessing the Role of Psychedelic Drugs in 21st Century Psychiatry* («Психоделический ренессанс: переоценка роли психоделических препаратов в психиатрии XXI века»), которая впервые была опубликована в 2012 году. С тех пор этот термин используется в крупных журналах, газетах, книгах и научных трудах, в которых описываются научные разработки, а также ощущения лиц, переживших состояние «психоделического трипа», или психоделическое движение в целом.
- 123 См. также Witt, 'The Psychedelic Renaissance'.
- 124 Phelps, Shah, and Lieberman, 'The Rapid Rise in Investment in Psychedelics—Cart Before the Horse'.
- 125 Suresh Muthukumaraswamy, Anna Forsyth, and Rachael L Sumner, 'The Challenges Ahead for Psychedelic “Medicine”', *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry* 56, no. 11 (November 2022): 1378–83.
- 126 Therapeutic Goods Administration (TGA), 'MDMA and Psilocybin Hub', text (Therapeutic Goods Administration (TGA), 13 February 2023).
- 127 Breanne Kunstler et al., "'We Don't Want to Run before We Walk": The Attitudes of Australian Stakeholders towards Using Psychedelics for Mental Health Conditions', *Public Health Research & Practice* 33, no. 3 (September 2023).
- 128 A. J. Herrington, 'Quebec Approves Health Coverage For Psilocybin Therapy', *Forbes*, n.d., accessed 11 April 2024.
- 129 В программах сертификации инструкторов могут принять участие все желающие, имеющие диплом о среднем образовании и прошедшие специальную проверку.
- 130 Oregon Health Authority, 'Oregon Health Authority: Oregon Psilocybin Services - Access Psilocybin Services: Prevention and Wellness: State of Oregon', March 2023.
- 131 State of Oregon, 'Psilocybin 101: What to Know about Oregon's Psilocybin Services', Oregon Health News Blog, 12 April 2023.
- 132 Oregon, 'Oregon Revised Statutes, Chapter 475A (Psilocybin Regulation).' (2020).
- 133 'Colorado Proposition 122, the Decriminalization, Regulated Distribution, and Therapy Program for Certain Hallucinogenic Plants and Fungi Initiative' (2022).
- 134 Практика использования малых субперцептивных доз психоделических веществ.
- 135 Jacob S. Aday et al., 'Psychedelic Commercialization: A Wide-Spanning Overview of the Emerging Psychedelic Industry', *Psychedelic Medicine* 1, no. 3 (1 September 2023): 150–65.
- 136 Phelps, Shah, and Lieberman, 'The Rapid Rise in Investment in Psychedelics—Cart Before the Horse'.
- 137 Rotem Petrunker, Thomas Anderson, and Norman Farb, 'Psychedelic Research and the Need for Transparency: Polishing Alice's Looking Glass', *Frontiers in Psychology* 11 (10 July 2020): 1681.
- 138 Phelps, Shah, and Lieberman, 'The Rapid Rise in Investment in Psychedelics—Cart Before the Horse'.
- 139 Ibid.
- 140 Например, некоммерческая организация «Междисциплинарная ассоциация психоделических исследований» (МАПИ) в рамках ребрендинга преобразовала свое фармацевтическое подразделение в частную коммерческую компанию и привлекла 100 млн долл. США за счет продажи привилегированных акций частным инвесторам в январе 2024 года. Источник: 'Psychedelic Therapy Developer MAPS PBC Closes \$100M Series A, Rebrands as Lykos Therapeutics', *BioSpace*, 10 January 2024.
- 141 Brian Pilecki et al., 'Ethical and Legal Issues in Psychedelic Harm Reduction and Integration Therapy', *Harm Reduction Journal* 18, no. 1 (7 April 2021): 40.

- 142 Lindsay P. Cameron, Angela Nazarian, and David E. Olson, 'Psychedelic Microdosing: Prevalence and Subjective Effects', *Journal of Psychoactive Drugs* 52, no. 2 (14 March 2020): 113–22.
- 143 Vince Polito and Paul Liknaitzky, 'The Emerging Science of Microdosing: A Systematic Review of Research on Low Dose Psychedelics (1955–2021) and Recommendations for the Field', *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 139 (August 2022): 104706.
- 144 Balázs Szigeti et al., 'Self-Blinding Citizen Science to Explore Psychedelic Microdosing', *eLife* 10 (2 March 2021): e62878.
- 145 Nadia R.P.W. Hutten et al., 'Mood and Cognition after Administration of Low LSD Doses in Healthy Volunteers: A Placebo Controlled Dose-Effect Finding Study', *European Neuropsychopharmacology* 41 (December 2020): 81–91.
- 146 Kelan Thomas, 'Safety First: Potential Heart Health Risks of Microdosing - Bill of Health', Public Health, Scientific Evidence, A Macro View of Microdosing, Pharmaceuticals, (Bill of Health, 13 April 2022).
- 147 Balázs Szigeti et al., 'The Difference between "Placebo Group" and "Placebo Control": A Case Study in Psychedelic Microdosing', *Scientific Reports* 13, No. 1 (26 July 2023): 12107.
- 148 Szigeti et al., 'Self-Blinding Citizen Science to Explore Psychedelic Microdosing'.
- 149 Martin Andersson and Anette Kjellgren, 'Twenty Percent Better with 20 Micrograms? A Qualitative Study of Psychedelic Microdosing Self-Rapports and Discussions on YouTube', *Harm Reduction Journal* 16, No. 1 (December 2019): 63.
- 150 Peter Grinspoon, MD, 'The Popularity of Microdosing of Psychedelics: What Does the Science Say?', Harvard Health, 19 September 2022.
- 151 Thomas Anderson et al., 'Microdosing Psychedelics: Personality, Mental Health, and Creativity Differences in Microdosers', *Psychopharmacology* 236, no. 2 (February 2019): 731–40.
- 152 Vince Polito and Richard J. Stevenson, 'A Systematic Study of Microdosing Psychedelics', ed. Danilo Arnone, *PLOS ONE* 14, No. 2 (6 February 2019): e0211023.
- 153 Sifan Cao, Cheneal Puljević, and Jason Ferris, 'Insights into Psychedelic Microdosing from the Global Drug Survey' (Centre for Health Services Research, The University of Queensland, 20 December 2021).
- 154 The Petrie-Flom Center Staff, 'Safety First: Potential Heart Health Risks of Microdosing - Bill of Health', 13 April 2022.
- 155 Alan K. Davis et al., 'Attitudes and Beliefs about the Therapeutic Use of Psychedelic Drugs among Psychologists in the United States', *Journal of Psychoactive Drugs* 54, no. 4 (8 August 2022): 309–18.
- 156 См., например, список и описание проводившихся в 2023 году мероприятий по психоделическим исследованиям: Psychedelic Science 2023: Full Schedule.
- 157 'Conferences That Captivate: Psychedelic Science 2023', BizBash, 13 November 2023.
- 158 H. Kettner et al., 'Psychedelic Communitas: Intersubjective Experience During Psychedelic Group Sessions Predicts Enduring Changes in Psychological Wellbeing and Social Connectedness', *Frontiers in Pharmacology* 12 (25 March 2021): 623985.
- 159 Ibid.
- 160 'Global Psychedelic Society', Global Psychedelic Society, n.d., accessed 29 December 2023.
- 161 Danielle Negrin, 'Psychedelic Societies Empowering Healing Community', no. 2 (2021).
- 162 David B. Yaden, James B. Potash, and Roland R. Griffiths, 'Preparing for the Bursting of the Psychedelic Hype Bubble', *JAMA Psychiatry* 79, no. 10 (1 October 2022): 943.
- 163 Nicolas Langlitz, 'The Making of a Mushroom People: Toward a Moral Anthropology of Psychedelics beyond Hype and Anti-hype', *Anthropology Today* 39, no. 3 (June 2023): 10–12.
- 164 James Davies, Brian A. Pace, and Neşe Devenot, 'Beyond the Psychedelic Hype: Exploring the Persistence of the Neoliberal Paradigm', *Journal of Psychedelic Studies*, 21 September 2023.

- 165 Yula Milshteyn and Moshe Bensimon, 'Exploring the Subjective Experience of Rave Party Participants in Israel Who Consume Psychedelic Drugs: A Qualitative Inquiry', *Harm Reduction Journal* 20, no. 1 (6 December 2023): 176.
- 166 Ryan Stanton | ryanstanton@mlive.com, 'Thousands Attend First-Ever Psychedelic Shroom Festival in Ann Arbor', *mlive*, 19 September 2021.
- 167 См. также Kevin Franciotti, 'The Steady Rise of the Trippy Festival', *Vice* (blog), 19 December 2018.
- 168 См. список проводившихся в 2023 году фестивалей с психоделической тематикой: Best Psychedelic Music Festivals to Check Out in 2023 – *Tripsitter*.
- 169 Andrew Johner, 'Transformational Festivals: A New Religious Movement?', in *Exploring Psychedelic Trance and Electronic Dance Music in Modern Culture*, ed. Emília Simão, Armando Malheiro Da Silva, and Sérgio Tenreiro De Magalhães (IGI Global, 2015).
- 170 Feyza Alyu Altınok, 'Drugs and Psychedelics in Tourism', in *Advances in Hospitality, Tourism, and the Services Industry*, ed. Barış Çıvık and Engin Bayraktaroğlu (IGI Global, 2023), 197–223.
- 171 Ralph Metzner, *The Ayahuasca Experience: A Sourcebook on the Sacred Vine of Spirits* (Rochester, Vermont: Park Street press, 2014).
- 172 Feyza Alyu Altınok, 'Drugs and Psychedelics in Tourism', in *Critical Social Challenges in the Tourism Industry: Labor, Commodification, and Drugs* (IGI Global, 2023), 197–223.
- 173 Edgar Antonio Estrella-Parra, Julio Cesar Almanza-Pérez, and Francisco Javier Alarcón-Aguilar, 'Ayahuasca: Uses, Phytochemical and Biological Activities', *Natural Products and Bioprospecting* 9, no. 4 (August 2019): 251–65.
- 174 Catherine Halley, 'The Colonization of the Ayahuasca Experience', *JSTOR Daily*, 4 November 2020.
- 175 Lisa Aldred, 'Plastic Shamans and Astro turf Sun Dances: New Age Commercialization of Native American Spirituality', *The American Indian Quarterly* 24, no. 3 (2000): 329–52.
- 176 Evgenia Fotiou, 'The Globalization of Ayahuasca Shamanism and the Erasure of Indigenous Shamanism', *Anthropology of Consciousness* 27, no. 2 (September 2016): 151–79.
- 177 Margit Anne Petersen, Sarah Feldes, and Victor Sacha Cova, 'Ayahuasca Calling: Sacredness and the Emergence of Shamanic Vocations in Denmark and Peru', *Anthropology of Consciousness* 33, no. 2 (September 2022): 255–78.
- 178 United Nations, 'History of Heroin', *Bulletin on Narcotics*, no. 2 (1953).
- 179 Jerrold S. Meyer and Linda F Quenzer, eds., *Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and Behavior*, Third edition (Sunderland, MA, U.S.A.: New York, NY, United States of America: Sinauer Associates; Oxford University Press, 2019).
- 180 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2020 год*. Брошюра 5 «Социально-экономические характеристики и расстройства на почве наркопотребления» (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год).
- 181 William R. Smith and Paul S. Appelbaum, 'Two Models of Legalization of Psychedelic Substances', *JAMA* 326, no. 8 (24 August 2021): 697–98.
- 182 Matthew W. Johnson and Roland R. Griffiths, 'Potential Therapeutic Effects of Psilocybin', *Neurotherapeutics* 14, no. 3 (July 2017): 734–40.
- 183 Tupper et al., 'Psychedelic Medicine'.
- 184 Robin L Carhart-Harris and Guy M Goodwin, 'The Therapeutic Potential of Psychedelic Drugs: Past, Present, and Future', *Neuropsychopharmacology* 42, no. 11 (October 2017): 2105–13.
- 185 Smith and Appelbaum, 'Two Models of Legalization of Psychedelic Substances'.
- 186 Sean J. Belouin et al., 'Policy Considerations That Support Equitable Access to Responsible, Accountable, Safe, and Ethical Uses of Psychedelic Medicines', *Neuropharmacology* 219 (November 2022): 109214.
- 187 Joshua S. Siegel et al., 'Psychedelics Drug Legislative Reform And Legalization in the US', *JAMA Psychiatry* 80, no. 1 (1 January 2023): 77–83.

188 Beau Kilmer et al., ‘Considering Alternatives to Psychedelic Drug Prohibition’ (RAND Drug Policy Research Center, 2024) (готовится к публикации).

КАННАБИС И ПСИХОДЕЛИКИ: СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ФОРМИРОВАНИЕМ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

Приложение

ТАБЛИЦА 3 Нормативные положения в отношении легализации потребления каннабиса в немедицинских целях в Канаде

Federal law	Федеральное законодательство
Legal process	Юридический процесс
Government legislation	Легализация по инициативе правительства
Title	Наименование
Cannabis Act and Cannabis Regulations	Закон о каннабисе и положения о каннабисе
Date implemented	Дата введения в действие
17 October 2018	17 октября 2018 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Health Canada	Министерство здравоохранения Канады
Minimum age	Минимальный возраст
18	18 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g dried or equivalent, i.e., 150 g of fresh cannabis 450 g of solid products 17,100 g of cannabis beverages (48 standard 355 ml cans) 2,100 g of non-solids other than cannabis beverages 7.5 g of concentrates (solid or liquid) 30 cannabis plant seeds 4 cannabis plants not budding or flowering	30 г в высушенной форме или эквивалентное количество, то есть 150 г свежего каннабиса 450 г продуктов в твердой форме 17 100 г напитков из каннабиса (48 стандартных банок объемом 355 мл) 2100 г продуктов в нетвердой форме помимо напитков из каннабиса 7,5 г концентратов (в твердой или жидкой форме) 30 семян растений каннабиса 4 растения каннабиса, которые не распускаются и не цветут
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Grow 4 cannabis plants per residence for personal use; Prepare cannabis products such as food and drink at home if organic solvents are not used	Выращивание 4 растений каннабиса на жилище для личного потребления. Изготовление продуктов каннабиса, таких как продукты питания и напитки, в домашних условиях без использования органических растворителей
Interpersonal sharing	Совместное пользование
30 g or equivalent of legal cannabis product between adults	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса для потребления взрослыми
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
-	-
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Dried cannabis/fresh cannabis: No THC or THCA can be added to dried or fresh cannabis products. Edible cannabis: 10 mg of THC per package.	Каннабис в сушеном или свежем виде: в продукты из каннабиса в сушеном или свежем виде нельзя добавлять ТГК или ТГКК. Пищевые продукты с

Cannabis extract (for ingestion or nasal, rectal or vaginal use): 10 mg of THC per unit (such as a capsule) or dispensed amount, 1000 mg of THC per package. Cannabis topical (for applying externally): 1000 mg of THC per package	каннабисом: 10 мг ТГК на упаковку. Экстракт каннабиса (для перорального, назального, ректального или вагинального применения): 10 мг ТГК на порцию (например, капсулу) или дозированное количество 1000 мг ТГК на упаковку для вдыхания паров. Продукты каннабиса для местного наружного применения: 1000 мг ТГК на упаковку.
Commercial production	Коммерческое производство
Federal processing licence is required in order to produce cannabis products and to package and label these products for sale to consumers via medical sales licence holders or provincial/territorial authorized distributors and retailers. Each province has an Excise stamp that needs to be fixed on the cannabis products.	Федеральная лицензия на переработку требуется для производства продуктов каннабиса, а также для упаковки и маркировки этих продуктов в целях продажи потребителям через держателей лицензий на продажу в медицинских целях или уполномоченных дистрибьюторов и розничных продавцов на уровне провинций/территорий. В каждой провинции имеется акцизная марка, которая должна наклеиваться на продукты каннабиса.
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution is the responsibility of provincial and territorial governments. Selling cannabis through self-service displays or vending machines is prohibited.	Распространение лежит в сфере ответственности органов власти провинций и территорий. Продажа каннабиса через стенды самообслуживания или торговые автоматы запрещена.
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edible cannabis, extracts and topicals became legal for sale 17 October 2019. Edible cannabis products must be shelf-stable and can only contain food and food additives as ingredients. If any components have a pH > 4.6 and water activity > 0.85 at a temperature of 22 ± 2°C, they must not be packaged in hermetically sealed containers. Edible cannabis must not contain meat, poultry or fish products as ingredients unless they are dried products produced in accordance with the Safe Food for Canadians Act or applicable provincial or territorial law and have a water activity equal to or less than 0.85 at a room temperature of 22 ± 2°C. Edible cannabis products must not contain any food described in a Temporary Marketing Authorization Letter under the FDR, vitamin or mineral fortification, poisonous or harmful substances, or anything considered unsafe that would cause the sale of a food to be prohibited under the Food and Drugs Act. Caffeine, ethyl alcohol and nicotine are prohibited additives except for ingredients with naturally occurring caffeine (such as chocolate, tea or coffee) provided the total amount of caffeine per package does not exceed 30 mg, and ethyl alcohol does not exceed 0.5% w/w (e.g. that might be present as a by-product in certain ingredients).	Продажа пищевых продуктов с каннабисом, экстрактов каннабиса и препаратов местного применения разрешена на законных основаниях с октября 2019 года. Пищевые продукты с каннабисом должны быть пригодными для длительного хранения и могут содержать в качестве ингредиентов только пищевые продукты и пищевые добавки. Если какие-либо компоненты имеют pH > 4,6 и значение активности воды > 0,85, то их нельзя упаковывать в герметичные контейнеры. Пищевые продукты с каннабисом не должны содержать в качестве ингредиентов мясо, птицу или рыбопродукты, если только они не являются продуктами сушильного производства, произведенными в соответствии с нормами закона о безопасных продуктах питания в Канаде или действующими провинциальными или территориальными законами, и не имеют активность воды, равную или меньшую 0,85 при комнатной температуре 22 ± 2°C. Пищевые продукты с каннабисом не должны содержать никаких пищевых добавок, указанных в письме о временном разрешении на реализацию в соответствии с положениями о продуктах питания и медикаментах, витаминных или минеральных обогатительных добавок, ядовитых или вредных веществ, а также всего того, что считается небезопасным, из-за чего продажа продукта может

	быть запрещена в соответствии с Законом о продуктах питания и медикаментах. Кофеин, этиловый спирт и никотин являются запрещенными добавками, за исключением ингредиентов с кофеином природного происхождения (таких, как шоколад, чай или кофе), при условии, что общее количество кофеина на упаковку не превышает 30 мг и содержание этилового спирта не превышает 0,5% по весу (например, если этиловый спирт содержится в некоторых ингредиентах в качестве побочного продукта).
Promotion, Packaging, and Labelling No promotion, packaging or labelling that could be considered appealing to young people, and ensuring that important product information is presented clearly. Labelling of edible products needs to have a standardized cannabis symbol for products containing THC; Health warning message; THC/CBD content; Equivalency to dried cannabis to determine public possession limit; Ingredient list, allergens; nutrition facts table, intended use.	Реклама, упаковка и маркировка Запрет на рекламу, упаковку или маркировку, которые могут быть сочтены привлекательными для молодежи, и обеспечение четкости представления информации о продукте. Маркировка пищевых продуктов должна содержать стандартизированную эмблему каннабиса для продуктов с содержанием ТГК; предупреждение о вреде здоровью; информацию о содержании ТГК/КБД; информацию об эквивалентном количестве высушенного каннабиса для определения лимита личного хранения в общественных местах; перечень ингредиентов, перечень аллергенов; таблицу пищевой ценности, целевое назначение.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada) Flower \$0.25/g Trim \$0.75/g Seed \$0.25/seed Seedling \$0.25/seedling Federal Ad Valorem Rate 2.5% of dutiable amount of cannabis product when delivered to purchaser	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады) Соцветия: 0,25 долл./г «Трим»: 0,75 долл./г Семена: 0,25 долл. за семя Саженец: 0,25 долл. за саженец Федеральный акциз по адвалорной ставке 2,5% налогооблагаемой доли цены продукта каннабиса, взимаемый при доставке покупателю
Restriction on use Provinces and territories can tailor certain rules in their own jurisdictions, such as: Licensing the distribution and retail sale in their respective jurisdictions and conducting associated compliance and enforcement activities; Setting additional regulatory requirements to address areas of local concern, such as setting more restrictive requirements than federal provisions for minimum age limits, limits on possession or personal cultivation; Establishing provincial zoning rules for cannabis-based businesses;	Ограничения в отношении потребления Провинции и территории могут адаптировать нормы в рамках своих юрисдикций, например: лицензирование распространения и розничной продажи в своих юрисдикциях и проведение соответствующих мероприятий в области соблюдения правил и обеспечения исполнения; установление дополнительных нормативных требований для решения проблем на местном уровне, например установление более строгих, чем федеральные, требований в отношении минимального возраста, ограничений на хранение или культивирование для личных целей; установление провинциальных правил зонирования для компаний, работающих с каннабисом;

Restricting where cannabis may be consumed; and Amending traffic safety laws to address driving while impaired by cannabis.	ограничение мест употребления каннабиса; и внесение поправок в законы о безопасности дорожного движения в отношении управления транспортными средствами под воздействием каннабиса.
Alberta	Альберта
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Gaming, Liquor and Cannabis Act and Gaming, Liquor and Cannabis regulation	Закон об азартных играх, крепких спиртных напитках и каннабисе и положение об азартных играх, крепких спиртных напитках и каннабисе
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Alberta Gaming Liquor and Cannabis (AGLC)	Комиссия провинции Альберта по азартным играм, крепким спиртным напиткам и каннабису (AGLC)
Minimum age	Минимальный возраст
18	18 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: private Online retail: private	Распространение: публичное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: частная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
No promotion, packaging or labelling that could be considered appealing to young people, and ensuring that important product information is presented clearly. No advertising containing testimonials or representing a way of life containing glamour, recreation, excitement,	Запрет на рекламу, упаковку или маркировку, которые могут быть сочтены привлекательными для молодежи, и обеспечение четкости представления информации о продукте. Запрет на рекламу, содержащую отзывы или представляющую образ жизни с элементами обаятельности, увеселения, возбуждения,

vitality, risk, or daring. Advertising allowed inside cannabis stores.	жизненной силы, риска или дерзновения. Реклама разрешается в помещении магазинов по продаже каннабиса.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$ 0.75/g plus 16.8% of base amount Trim: \$0.225/g plus 17.8% of base amount Seed: \$0.75/seed plus 16.8% of base amount Ad Valorem Additional Rate 7.5% plus 16.8% of deductible amount when delivered (total applicable rate 24.3%)	Соцветия: 0,75 долл./г плюс 16,8% налогооблагаемой базы «Трим»: 0,225 долл./г плюс 17,8% налогооблагаемой базы Семена: 0,75 долл. за семя плюс 16,8% налогооблагаемой базы Дополнительный акцизный сбор по адвалорной ставке 7,5% плюс 16,8% налогооблагаемой суммы, взимаемые при доставке (совокупная применимая ставка — 24,3%)
Restriction on use	Ограничения в отношении потребления
In cars, areas frequented by children, or tobacco-restricted areas.	В автомобилях, местах, часто посещаемых детьми, или местах, где запрещено курение.
British Columbia	Британская Колумбия
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis control and licensing Act (CCLA) Cannabis distribution Act (CDA)	Закон о контроле и лицензировании деятельности, связанной с каннабисом (CCLA) Закон о распространении каннабиса (CDA)
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Liquor and cannabis regulation branch	Отдел регулирования в сфере крепких спиртных напитков и каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household; Plants must be grown at home without being visible from a public place	Не более 4 растений на домохозяйство; растения должны выращиваться в доме и быть невидимыми из общественного места.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Edibles may contain up to a total of 10 mg per package, inhalable extracts (vapes/concentrates) and ingestible extracts (oils) may contain up to 1 g	Содержание ТГК в пищевых продуктах не должно превышать 10 мг ТГК на упаковку, в экстрактах, предназначенных для вдыхания паров

of THC per package, with a maximum of 10 mg of THC per unit in the case of capsules.	(вейпы/концентраты), и в экстрактах для перорального применения (масла) — 1 г ТГК на упаковку, а в капсулах — 10 мг ТГК на единицу.
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: hybrid Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: гибридная Розничная торговля через интернет: публичная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
Prohibited to advertise oneself as a licensed retailer without a license from the Liquor and Cannabis Regulation Branch. Prohibited to market, advertise or promote a location to consume cannabis or to go after consuming cannabis.	Запрещена самореклама в качестве лицензированного розничного торговца без лицензии Отдела регулирования в сфере крепких спиртных напитков и каннабиса. Запрещена реализация, реклама или пропаганда места для употребления каннабиса или для посещения после употребления каннабиса.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower \$0.75/g Trim \$0.22/g Seed and seedling: \$0.75/seed or seedling 7% provincial sale tax in addition to Federal taxes 20% provincial sale tax to liquid marijuana vaping products	Соцветия: 0,75 долл. США/г «Трим»: 0,22 долл. США/г Семена и саженцы: 0,75 долл. за семя или саженец 7%-ный провинциальный налог с продаж помимо федеральных налогов 20%-ный провинциальный налог с продаж жидких продуктов для вейпинга с содержанием марихуаны
Restriction on use	Ограничения в отношении потребления
In cars, areas frequented by children, or tobacco restricted areas.	В автомобилях, местах, часто посещаемых детьми, или местах, где запрещено курение.
Manitoba	Манитоба
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Safe and Responsible Retailing of Cannabis Act	Закон о безопасной и ответственной розничной торговле каннабисом
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba (LGCA) Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL)	Управление провинции Манитоба по крепким спиртным напиткам, азартным играм и каннабису (LGCA) Корпорация провинции Манитоба по крепким спиртным напиткам и лотереям (MBLL)
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет

Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Home cultivation not permitted	Культивирование в домашних условиях запрещено
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: private Online retail: private	Распространение: публичное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: частная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
-	-
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Wholesale mark-up on non-medical cannabis, a \$0.75/g mark-up plus 9% per cent mark-up applied on top of the \$0.75/g 6 per cent social responsibility fee	Оптовая наценка на каннабис, предназначенный к потреблению в немедицинских целях: наценка в размере 0,75 долл./г плюс 9%-ная наценка, применяющаяся помимо наценки в размере 0,75 долл./г 6%-ный сбор в рамках социальной ответственности
Restriction on use	Ограничения в отношении потребления
Smoking and vaping cannabis are illegal in public places (including enclosed public places), unless the consumption is permitted by regulation or under The Smoking and Vapour Products Control Act.	Курение каннабиса и вдыхание его паров в общественных местах (включая закрытые общественные помещения) является незаконным, если только употребление не разрешено правилами или Законом о контроле за изделиями для курения или вдыхания паров.
New Brunswick	Нью-Брансуик
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis Control Act Cannabis Management Corporation Act Cannabis Retailers Licensing Act	Закон о контроле над каннабисом Закон о Корпорации по управлению оборотом каннабиса Закон о лицензировании розничной торговли каннабисом

Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis NB	Корпорация по каннабису в Нью-Брансуике
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household; If cultivated outdoors, plants must be surrounded by a locked inclosure with a height of at least 1.52 m, and if cultivated indoors must be cultivated in a separate locked space	Не более 4 растений на домохозяйство; при культивировании в открытом грунте растения должны выращиваться в запираемом огражденном месте с высотой ограждения не менее 1,52 м, а в закрытом грунте — в отдельном запираемом помещении
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: hybrid Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: гибридная Розничная торговля через интернет: публичная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
Advertising and promotion of cannabis is prohibited except in very limited circumstances (much like tobacco).	Запрет рекламы и пропаганды каннабиса, за исключением очень ограниченного числа случаев (так же как и в отношении табака)
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim:\$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5% of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5% налогооблагаемой суммы при доставке покупателю
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except private property or residence.	Курение является незаконным везде, за исключением объектов частной собственности или места жительства.
New Foundland and Labrador	Ньюфаундленд и Лабрадор
Legal process	Юридический процесс

-	-
Title	Наименование
Newfoundland and Labrador Cannabis Regulations Control and Sale of Cannabis Act	Положение о каннабисе в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Закон о контроле над каннабисом и торговле каннабисом
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Newfoundland and Labrador Liquor Corporation (NLC)	Корпорация провинции Ньюфаундленд и Лабрадор по крепким спиртным напиткам (NLC)
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: private Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: публичная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
-	-
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim:\$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5% of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5% налогооблагаемой суммы при доставке покупателю
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except private property or residence.	Курение является незаконным везде, за исключением объектов частной собственности или места жительства.

Northwest Territories	Северо-Западные территории
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis Legalization and Regulation Implementation Act	Закон о введение в действие положений о легализации и регулировании потребления каннабиса
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
North West Territories Liquor & Cannabis Commission (NTLCC)	Комиссия Северо-Западных территорий по крепким спиртным напиткам и каннабису (NTLCC)
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
-	-
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: private Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: публичная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
-	-
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim:\$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5% of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5% налогооблагаемой суммы при доставке покупателю
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except private property where smoking tobacco is allowed; and on	Курение является незаконным везде, за исключением объектов частной собственности, где

trails, roadways (when not operating a motor vehicle), and parks when not in use for a public event.	курение разрешено, и передвижения по грунтовым и автомобильным дорогам (не во время управления транспортным средством) и парков (не во время проведения публичных мероприятий).
Nova Scotia	Новая Шотландия
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis Control Act	Закон о контроле над каннабисом
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Nova Scotia Liquor Corporation	Корпорация Новой Шотландии по крепким спиртным напиткам
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
-	-
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: public Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: публичная Розничная торговля через интернет: публичная
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
The Cannabis Act has strict rules around the promotion of cannabis (similar to those for tobacco). It is prohibited to promote cannabis or a cannabis accessory or any service related to cannabis.	Законом о каннабисе предусмотрены строгие правила рекламы каннабиса (аналогичные правилам, действующим в отношении табака). Запрещается рекламировать каннабис, аксессуары для потребления каннабиса или любые услуги, связанные с каннабисом.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim: \$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5 % of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5 % налогооблагаемой суммы при доставке покупателю

Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal everywhere except for areas where tobacco may be smoked.	Является незаконным везде, за исключением мест, где курение разрешено.
Nunavut	Нунавут
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis Act Cannabis Statutes Amendments Act	Закон о каннабисе Закон о внесении поправок в законодательные акты о каннабисе
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Nunavut Liquor and Cannabis Commission	Комиссия Нунавута по крепким спиртным напиткам и каннабису
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: private Online retail: private	Распространение: публичное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: частная
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
All cannabis products, online stores and accessories must comply with the Cannabis Act (Canada) and all applicable Nunavut and Federal legislation, regulations and by-laws pertaining to label standards, promotions, advertising, package sizes and case marking.	Все продукты каннабиса, интернет-магазины и аксессуары должны соответствовать Закону о каннабисе (Канада) и всем действующим законам Нунавута и федеральным законам, положениям и подзаконным актам, касающимся стандартов этикеток, промоакций, рекламы, размеров упаковки и маркировки.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g plus 19.3% of base amount Trim: \$0.225/g plus 19.3% of base amount	Соцветия: 0,75 долл./г плюс 19,3% налогооблагаемой базы

Seed/seedling: \$0.75 seed plus 19.3% of base amount 7.5% plus 19.3% of the dutiable amount of a cannabis product when delivered to a purchaser (total applicable rate of 26.8%)	«Трим»: 0,225 долл./г плюс 19,3% налогооблагаемой базы Семена/саженцы: 0,75 долл. за семя плюс 19,3% налогооблагаемой базы 7,5% плюс 19,3% налогооблагаемой доли цены продукта каннабиса при доставке покупателю (совокупная применимая ставка — 26,8%)
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal everywhere except for areas where tobacco may be smoked.	Является незаконным везде, за исключением мест, где разрешено курение табака.
Ontario	Онтарио
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis, Smoke-Free Ontario, and Road Safety Statute Law Amendment Act, 2017 Cannabis Statute Law Amendment Act, 2018	Закон о внесении поправок в законодательные акты о каннабисе, запрете на курение в Онтарио и о безопасности дорожного движения, 2017 год Закон о внесении поправок в законодательные акты о каннабисе, 2018 год
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Alcohol and Gaming Commission of Ontario	Комиссия Онтарио по алкогольной продукции и азартным играм
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: private Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: публичная
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
All cannabis products must comply with the Cannabis Act (Canada) pertaining to label	Все продукты каннабиса должны соответствовать Закону о каннабисе (Канада), касающемуся

standards, promotions, advertising, package sizes and case marking.	стандартов этикеток, промоакций, рекламы, размеров упаковки и маркировки.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g plus 3.9% of base amount Trim: \$0.225/g plus 19.3% of base amount Seed/seedling: \$0.75 seed plus 19.3% of base amount 7.5% plus 19.3 % of the dutiable amount of a cannabis product when delivered to a purchaser (total applicable rate of 26.8 %)	Соцветия: 0,75 долл./г плюс 3,9% налогооблагаемой базы «Трим»: 0,225 долл./г плюс 19,3% налогооблагаемой базы Семена/саженцы: 0,75 долл. за семя плюс 19,3% налогооблагаемой базы 7,5% плюс 19,3 % налогооблагаемой доли цены продукта каннабиса при доставке покупателю (совокупная применимая ставка — 26,8 %)
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal everywhere except for areas where tobacco may be smoked.	Является незаконным везде, за исключением мест, где разрешено курение табака.
Prince Edward Island	Остров Принца Эдуарда
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis Control Act Cannabis Management Corporation Act	Закон о контроле над каннабисом Закон о Корпорации по управлению оборотом каннабиса
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Provincial cannabis committee Cannabis management corporation	Провинциальный комитет по каннабису Корпорация по управлению оборотом каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
-	-
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: public Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: публичная Розничная торговля через интернет: публичная

Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
-	-
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim: \$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5 % of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5 % налогооблагаемой суммы при доставке покупателю
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except private property, some exceptions for certain public spaces.	Курение является незаконным везде, за исключением объектов частной собственности; имеется ряд исключений в отношении некоторых общественных мест.
Quebec	Квебек
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
Cannabis Regulation Act Act to constitute the Société québécoise du cannabis (SQDC)	Закон о регулировании оборота каннабиса Закон об учреждении Квебекского общества сторонников каннабиса (SQDC)
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Société québécoise du cannabis	Квебекское общество сторонников каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Home cultivation not permitted	Культивирование в домашних условиях запрещено
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent per visit at Société québécoise du cannabis	30 г высушенного каннабиса или его эквивалента за одно посещение Квебекского общества сторонников каннабиса
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
The THC concentration present in cannabis must not exceed 30% per weight. An edible cannabis product in solid form may not contain a quantity of THC greater than 10 mg per package and a maximum of 5 mg of THC is fixed per	Концентрация ТГК в каннабисе не должна превышать 30% по весу. Содержание ТГК в твердых пищевых продуктах с содержанием каннабиса не должно превышать 10 мг ТГК на упаковку и 5 мг ТГК на одну четко выделяемую

distinguishable portion unit. An edible cannabis product in liquid form may not contain a quantity of THC greater than 5 mg per container.	порционную единицу. Содержание ТГК в жидких пищевых продуктах с содержанием каннабиса не должно превышать 5 мг ТГК на контейнер.
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed producers	Лицензированные производители
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: public In-person retail: public Online retail: public	Распространение: публичное Розничная торговля: публичная Розничная торговля через интернет: публичная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
An edible cannabis product offered in Québec may not be sweets, confectionery, dessert, chocolate or any other product attractive to persons under 21 years of age.	Продаваемые в Квебеке пищевые продукты с содержанием каннабиса не могут быть сладостями, кондитерскими изделиями, десертами, шоколадом или любыми другими продуктами, привлекательными для лиц моложе 21 года.
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
No direct or indirect advertising to promote cannabis, a brand of cannabis, a cannabis producer or the SQDC. Advertising disseminated by signage may be visible only from the inside of an SQDC outlet.	Запрещается прямая или косвенная реклама каннабиса, брендов каннабиса, производителей каннабиса или Квебекского общества сторонников каннабиса. Рекламные вывески могут размещаться только внутри торговых точек Квебекского общества сторонников каннабиса.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim: \$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5 % of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5 % налогооблагаемой суммы при доставке покупателю
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except for areas where tobacco may be smoked, excluding university and CEGEP campuses.	Курение является незаконным везде, за исключением мест, где разрешено табакокурение, кроме территории университетов или профессионально-технических учебных заведений.
Saskatchewan	Саскачеван
Legal process	Юридический процесс
-	-
Title	Наименование
The cannabis control (Saskatchewan) Act The cannabis control (Saskatchewan) regulations	Закон о контроле над каннабисом (Саскачеван) Положение о контроле над каннабисом (Саскачеван)
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis Authority under the Saskatchewan Liquor and Gaming Authority	Управление по вопросам каннабиса при Управлении Саскачевана по крепким спиртным напиткам и азартным играм
Minimum age	Минимальный возраст

19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed growers	Лицензированные растениеводы
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: private In-person retail: private Online retail: private	Распространение: частное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: частная
Restriction on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
Operators of cannabis retail stores on indigenous reserves are exempt from the requirements of The Cannabis Control (Saskatchewan) Amendment Regulations, provided that they can develop their own framework of oversight.	Операторы розничных магазинов по продаже каннабиса в резервациях коренных народов освобождаются от требований Положения о контроле над каннабисом (Саскачеван) с поправками при условии, что они смогут разработать собственную систему надзора.
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g plus 6.45% of base amount Trim: \$0.225/g plus 6.45% of base amount Seed/seedling: \$0.75 seed plus 6.45% of base amount 7.5% plus 6.45% of the dutiable amount of a cannabis product when delivered to a purchaser (total applicable rate of 13.95%)	Соцветия: 0,75 долл./г плюс 6,45% налогооблагаемой базы «Трим»: 0,225 долл./г плюс 6,45% налогооблагаемой базы Семена/саженцы: 0,75 долл. за семя плюс 6,45% налогооблагаемой базы 7,5% плюс 6,45% налогооблагаемой доли цены продукта каннабиса при доставке покупателю (совокупная применимая ставка — 13,95%)
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except private property or residence.	Курение является незаконным везде, за исключением объектов частной собственности или места жительства.
Yukon	Юкон
Legal process	Юридический процесс
-	-

Title	Наименование
Cannabis control and regulation act	Закон о контроле и регулировании оборота каннабиса
Date implemented	Дата введения в действие
-	-
Regulatory authority	Регулирующий орган
Yukon Liquor Corporation Cannabis Licensing Board (2019)	Совет по лицензированию оборота каннабиса Корпорации территории Юкон по крепким спиртным напиткам (2019 год)
Minimum age	Минимальный возраст
19	19 лет
Personal public possession limit	Лимит личного хранения в общественных местах
30 g or equivalent legal cannabis product	30 г или эквивалентное количество законных продуктов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Maximum 4 plants per household	Не более 4 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
30 g dried cannabis or equivalent	30 г каннабиса в высушенной форме или эквивалентное количество
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Distribution: private In-person-retail: private Online retail: private	Распространение: частное Розничная торговля: частная Розничная торговля через интернет: частная
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Promotion, Packaging, and Labelling	Реклама, упаковка и маркировка
-	-
Taxation Cannabis excise duty rates in provinces and territories (Department of Finance, Canada)	Налогообложение Ставки акциза в провинциях и территориях (Министерство финансов Канады)
Flower: \$0.75/g Trim: \$0.225/g Seed/seedlings \$0.75 7.5% of the dutiable amount when delivered to purchaser	Соцветия: 0,75 долл./г «Трим»: 0,225 долл./г Семена/саженцы: 0,75 долл. 7,5% налогооблагаемой суммы при доставке покупателю
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Illegal to smoke everywhere except private property or residence.	Курение является незаконным везде, за исключением объектов частной собственности или места жительства.

ТАБЛИЦА 4 Нормативные положения в отношении легализации потребления каннабиса в немедицинских целях в юрисдикциях Соединенных Штатов

Alaska	Аляска
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative, state statute	Инициатива избирателей, закон штата
Title	Наименование
Ballot Measure 2	Вопрос для голосования 2
Date passed	Дата принятия
November 2014	Ноябрь 2014 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
February 2015: Personal possession, consumption, cultivation. October 2016: Retail sales.	Февраль 2015 года: хранение, потребление, культивирование в личных целях. Октябрь 2016 года: розничные продажи
Regulatory authority	Регулирующий орган
Alcohol and Marijuana Control Office	Управление по контролю за оборотом алкоголя и марихуаны
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz or less) of cannabis	28,5 г (не более 1 унции) каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants, 3 of which can be flowering; not subject to public view; within property with lawful possession or with consent of the person in lawful possession.	6 растений, 3 из которых могут быть в стадии цветения; запрещается выставлять на общественное обозрение; в месте, находящемся в законном владении, или с согласия лица, владеющего им на законных основаниях.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
28.5 g	28,5 г
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
28.5 g In addition, a store may not sell in a day: - More than 1 oz of usable cannabis - More than 7 g of cannabis concentrate for inhalation; or - More than 5,600 mg of THC in combined sales of marijuana and cannabis products.	28,5 г Кроме того, магазин не имеет права продать за один день: - более 1 унции пригодного к употреблению каннабиса; - более 7 г концентрата каннабиса для вдыхания паров; или - более 5600 мг ТГК в совокупном объеме проданных марихуаны и продуктов каннабиса.
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
The THC limit in cannabis products is 10 mg per serving. The new rules raise the allowable amount of THC per package to 100 mg.	Предельное содержание ТГК в продуктах каннабиса составляет 10 мг на порцию. Новые правила повышают допустимое содержание ТГК в одной упаковке до 100 мг.

Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cannabis producers	Лицензированные производители каннабиса
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed retail cannabis stores	Лицензированные магазины розничной торговли каннабисом
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
5 mg of THC for single serving, no more than 50 mg of homogenous THC allowed per package. Child-resistant packaging required. Separate warnings on risks, not appealing to children.	5 мг ТГК на одну порцию, разрешается не более 50 мг однородно распределенного ТГК на упаковку. Упаковка должна быть защищена от случайного вскрытия детьми. Должна содержать предупредительные надписи отдельно по каждому виду риска, должна быть непривлекательной для детей.
Advertising	Реклама
Logo or advertisement for licensed marijuana may not promote excessive consumption, depiction appealing to a person under 21 years of age. Restrictions on advertisements in school areas, public transport, and contain prescribed warning.	Логотип или реклама лицензированной марихуаны не должны пропагандировать чрезмерное употребление и содержать изображения, привлекательные для лиц моложе 21 года. Ограничения в отношении рекламы на территории школ, в общественном транспорте; реклама должна содержать предписанную законом предупредительную информацию.
Taxation	Налогообложение
\$50 excise tax per oz on sales or transfers from cultivation facility to retail store or product manufacturer; 1 January 2019, sales and transfers of marijuana are subject to new tax rates. Mature bud/flower are taxed at \$50 per oz; immature or abnormal bud is taxed at \$25 per oz; trim is taxed at \$15 per oz; and clones are taxed at a flat rate of \$1 per clone.	Акциз в размере 50 долл. США за унцию с продаж или трансфертов от хозяйств по культивированию магазинам розничной торговли или изготовителям продукта; с 1 января 2019 года продажа и трансферт марихуаны облагается по новым налоговым ставкам. Зрелые соплодия/соцветия облагаются налогом в размере 50 долл. США за унцию; незрелые или нестандартные соплодия облагаются налогом в размере 25 долл. США за унцию; «трим» облагается налогом в размере 15 долл. США за унцию; черенки облагаются налогом по единой ставке 1 долл. США за черенок.
On site consumption	Потребление на месте продажи
In-store consumption is allowed; stores can sell cannabis and cannabis products, excluding concentrates, to patrons for consumption on the licensed premises at the time of purchase only in a designated area with further conditions stipulated in the regulation.	Разрешено употребление в магазине; магазины могут продавать каннабис и продукты каннабиса, за исключением концентратов, клиентам для употребления в помещениях лицензированных предприятий в момент покупки только в специально отведенном месте с соблюдением дополнительных условий, оговоренных в нормативных актах.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Cannabis use in public is unlawful; violation punishable by a fine of up to \$100.	Потребление каннабиса в общественных местах является незаконным; нарушение наказывается штрафом в размере до 100 долл. США.
Medical cannabis	Медицинский каннабис

1998: Patient registry with a card, no dispensaries registration; out-of-state patients recognized for approved conditions but not for dispensary purchases; adults over 21 may also purchase at retail adult dispensaries.	1998 год: реестр пациентов с выдачей карт, отсутствие регистрации пунктов отпуска; признание пациентов, не являющихся жителями штата, при наличии у них утвержденных показаний для применения, за исключением покупок в пунктах отпуска; взрослые старше 21 года также могут покупать в розничных пунктах отпуска для взрослых.
Arizona	Аризона
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Proposition 207	Предложение 207
Date passed	Дата принятия
December 2020	Декабрь 2020 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Licences issued from 22 January 2021. Allow for cannabis deliveries beginning sometime between 1 January 2023 and 1 January 2025.	Лицензии, выданные с 22 января 2021 года. Разрешить начать поставки каннабиса в интервале с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Arizona Department of Health Services	Департамент здравоохранения штата Аризона
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz or less) of cannabis or 5 g or less of concentrate	28,5 г (не более 1 унции) каннабиса или не более 5 г концентрата
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants, as long as cultivation takes place within an enclosed area with a lock and is not visible from public view.	6 растений, при условии, что культивирование происходит в запертом месте, недоступном для посторонних глаз.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Yes, same as personal possession limits plus six plants	Да, на условиях тех же ограничений, что и для личного хранения, плюс шесть растений
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not specified	Не установлено
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
The potency of edible cannabis products are to be kept “at reasonable levels upon consideration of industry standards”, but no more than 10 mg of THC per serving, 100 mg of THC per package, or packages with scored servings within the limits.	Сила действия пищевых продуктов каннабиса должна поддерживаться «на разумном уровне с учетом отраслевых стандартов», но не более 10 мг ТГК на порцию, 100 мг ТГК на упаковку, и для упаковок с отмеренными порциями — в пределах установленных ограничений.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации

None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed producers	Лицензированные производители
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed stores with limitations; for example, one cannabis establishment license per 10 pharmacies or no more than two cannabis establishment licenses in counties that contain no registered non-profit medical cannabis dispensaries.	Лицензированные магазины с ограничениями; например, не более одной лицензии предприятия по торговле каннабисом на каждые 10 аптек или не более двух лицензий предприятия по торговле каннабисом в округах, где нет зарегистрированных некоммерческих пунктов отпуска каннабиса для медицинских целей
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
The potency of edible cannabis products are to be kept “at reasonable levels upon consideration of industry standards” (see above).	Сила действия пищевых продуктов каннабиса должна поддерживаться «на разумном уровне с учетом отраслевых стандартов» (см. выше).
Advertising	Реклама
Prohibits the advertisement of cannabis products to children and prohibits the advertisement or sale of cannabis products with names that resemble or imitate food or drink brands marketed to children.	Запрещена реклама продуктов каннабиса среди детей, запрещена реклама или продажа продуктов каннабиса с наименованиями, которые напоминают или имитируют бренды продуктов питания или напитков, предназначенных для детей.
Taxation	Налогообложение
Excise tax of 16% on price of cannabis and cannabis products. Cannabis products are also subject to transaction privilege tax which in 2020 was 5.6% – different jurisdictions also levy TPT retail taxes.	Акциз в размере 16% от цены на каннабис и продукты каннабиса. Продукты каннабиса также облагаются лицензионным налогом на транзакции, который в 2020 году составил 5,6%; в некоторых юрисдикциях также взимается лицензионный налог на транзакции в розничной торговле.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Cannabis smoking is illegal in public places and open spaces.	Курение каннабиса запрещено в общественных местах и на открытых пространствах.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2010: adult patients and those under 18. For patients under 18, the patient’s custodial parent or legal guardian must be designated as his/her caregiver. Patients require a qualifying patient card which is based on diagnosis with one of the debilitating medical conditions, and a written certification from a physician (medical doctor, osteopath, naturopath, or homeopath licensed to practice in Arizona) with whom the person has a physician-patient relationship.	2010 год: взрослые пациенты и пациенты до 18 лет. Для пациентов моложе 18 лет лицом, осуществляющим уход, должен быть назначен опекающий родитель или законный представитель пациента. Пациентам требуется карта отвечающего критериям пациента, сформированная на основании диагноза одного из угрожающих здоровью истощающих состояний, и письменное подтверждение от врача (медицинского врача, остеопата, натуропата или гомеопата, имеющего лицензию на практику в Аризоне), с которым такое лицо состоит в отношениях «врач–пациент».
California	Калифорния
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название

Proposition 64	Предложение 64
Date passed	Дата принятия
November 2016	Ноябрь 2016 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Licenses issued 11 January 2018	Лицензии выданы 11 января 2018 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Department of Cannabis Control	Департамент по контролю над каннабисом
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirements	Требования в отношении места проживания
Licences not issued to non-residents	Лицензии не выдаются нерезидентам
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g of cannabis plant material and 8 g of concentrated cannabis.	28,5 г растительного материала каннабиса и 8 г концентрированного каннабиса.
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Plant, cultivate, harvest, dry, or process plants in accordance with local ordinances: Plants are in a locked space, and are not visible by normal unaided vision from a public place. 6 living plants may be planted, cultivated, harvested, dried, or processed within a single private residence. Living plants and any cannabis produced by the plants in excess of 28.5 g are kept within the person's private residence, or upon the grounds of that private residence.	Сажать, выращивать, собирать, сушить или обрабатывать растения в соответствии с местными постановлениями: растения находятся в запертом месте и не видны невооруженным глазом из общественного места. В одном частном домовладении можно сажать, выращивать, собирать, сушить или обрабатывать 6 живых растений. Живые растения и любой продукт каннабиса, произведенный из этих растений, весом более 28,5 г хранятся в частном жилище лица или на земельном участке этого частного домовладения.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Yes	Да
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
28.5 g of cannabis plant material and 8 g of concentrated cannabis	28,5 г растительного материала каннабиса и 8 г концентрированного каннабиса.
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Standardized concentration of cannabinoids not to exceed 10 mg THC per serving and 100 mg per package. Topical cannabis products or a cannabis concentrate shall not contain more than 1,000 mg of THC per package.	Стандартизированная концентрация каннабиноидов не должна превышать 10 мг ТГК на порцию и 100 мг на упаковку. Содержание ТГК в продуктах каннабиса для местного наружного применения не должно превышать 1000 мг на упаковку.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
Not specified	Не установлены
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cultivators and manufacturers, varying types	Лицензированные растениеводы и изготовители различных категорий
Commercial distribution	Коммерческое распространение

Limits on market concentration	Ограничения в отношении концентрации рынка
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
10 mg THC per serving and 100 mg per package. Topical cannabis products or a cannabis concentrate shall not contain more than 1,000 mg of THC per package. Warning and potency labels. List of ingredients and cannabinoid content.	10 мг ТГК на порцию и 100 мг на упаковку. Содержание ТГК в продуктах каннабиса для местного наружного применения не должно превышать 1000 мг на упаковку. Этикетки с предупреждающей информацией и указанием силы действия активного ингредиента. Перечень ингредиентов и сведения о содержании каннабиноидов.
Advertising	Реклама
Restricted to those over 21. Restrictions on false advertisement or claims of untrue health benefits. Products cannot appeal to children. Products cannot imitate candy packaging or labelling, or alcoholic products. Advertising of free cannabis goods or accessories is prohibited.	Разрешена только для лиц старше 21 года. Ограничения в отношении лживых объявлений или не соответствующих действительности утверждений о пользе для здоровья. Продукты не должны быть привлекательными для детей. Продукты не должны имитировать упаковку или этикетки конфет или алкогольную продукцию. Реклама бесплатных товаров или аксессуаров для употребления каннабиса запрещена.
Taxation	Налогообложение
15% excise on retail, \$9.25 per dry weight ounce on flower after harvest. \$2.75 per drug weight ounce on leaves. Cultivation tax of \$2.87 per ounce of flower. Tax rates for cannabis leaves to be adjusted annually to reflect fluctuations in the relative price of cannabis flowers to cannabis leaves.	Акциз в размере 15% с розничной продажи, 9,25 долл. США — за унцию сухого веса соцветий после сбора урожая; 2,75 долл. США — за унцию веса сухого листа. Налог на культивирование в размере 2,87 долл. США за унцию соцветий. Налоговые ставки на лист каннабиса должны ежегодно корректироваться с учетом колебаний соотношения цены соцветий и листьев каннабиса.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified although they may exist in the form of microbusiness that allow on-site consumption.	Не предусмотрено, однако возможно наличие микропредприятий, в которых разрешено потребление на месте.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Cannabis use is prohibited in a public place unlicensed for such use, including near schools and other areas where children are present.	Запрещено потребление каннабиса в общественном месте, не имеющем лицензии на такое потребление, в том числе вблизи школ и других мест, где находятся дети.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
1996 and 2003: Patient registry - voluntary registration; cooperatives and collectives; State-wide licensing of dispensaries began 2018.	1996 и 2003 годы: реестр пациентов — добровольная регистрация; кооперативы и коллективы; лицензирование пунктов отпуска на всей территории штата началось в 2018 году.
Colorado	Колорадо
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative, amendment to state constitution	Инициатива избирателей, поправка к конституции штата
Title	Наименование
Amendment 64	Поправка 64
Date passed	Дата принятия

November 2012	Ноябрь 2012 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
December 2012: Personal possession, consumption, cultivation. January 2014: Retail sales.	Декабрь 2012 года: хранение, потребление, культивирование в личных целях. Январь 2014 года: розничные продажи
Regulatory authority	Регулирующий орган
Marijuana Enforcement Division (Department of Revenue)	Отдел по обеспечению соблюдения закона о марихуане (Налоговое управление)
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g	28,5 г
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants, 3 of which can be flowering; As of 1 January 2018, all residences are limited to a maximum of 12 plants unless certain requirements are met; The area for growing plants must be enclosed and locked in a separate space that minors cannot access.	6 растений, 3 из которых могут быть в стадии цветения. С 1 января 2018 года для всех частных домохозяйств установлен лимит в 12 растений, если не соблюдены определенные требования; зона выращивания растений должна быть огорожена и заперта таким образом, чтобы к ней не имели доступа несовершеннолетние.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
28.5 g	28,5 г
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Residents: 28.5 g Non-residents: 7 g	Резиденты: 28,5 г Нерезиденты: 7 г
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
The amount is 8 g total of concentrate (except vape cartridges) and 800 mg of THC in any edible product.	Общий объем концентрата — 8 г (за исключением картриджей для вейпа) и 800 мг ТГК в любом пищевом продукте.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cannabis cultivation facilities	Лицензированные хозяйства по культивированию каннабиса
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed retail cannabis stores	Лицензированные магазины розничной торговли каннабисом
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Maximum of 10 mg of THC in each individually packed serving; warning labels “keep out of reach of children”; THC symbol on labels and not attractive to children. Every single standardized serving (10 mg of THC) of an edible retail	Содержание ТГК в каждой отдельно расфасованной порции не должно быть выше 10 мг; на упаковках должны быть этикетки с предупредительной надписью «Хранить в недоступном для детей месте»; эмблема «ТГК» на

cannabis product must be individually marked, stamped or imprinted with the universal symbol. Edibles cannot be shaped like a human, animal or a fruit.	этикетках не должна быть привлекательной для детей. Каждая стандартизированная порция (10 мг ТГК) пищевого продукта каннабиса для розничного потребления должна иметь индивидуальную маркировку, штамп или отпечаток универсального символа. Пищевые продукты не могут иметь форму человека, животного или фрукта.
Advertising	Реклама
Restricted to media with no more than 30% of the audience under the age of 21. When advertising concentrate, four warning statements are required to be included.	Разрешена только для СМИ, аудитория которых не более чем на 30% состоит из лиц моложе 21 года. При рекламировании концентрата необходимо использовать четыре предупредительных надписи.
Taxation	Налогообложение
State sales tax (2.9%) on cannabis sold in stores; state retail cannabis sales tax (15%) on retail cannabis sold in stores; state retail cannabis excise tax (15%) on wholesale sales/transfers of retail cannabis.	Налог штата с продаж (2,9%) на каннабис, продаваемый в магазинах; налог штата на розничную продажу каннабиса (15%), взимаемый с розничной продажи каннабиса в магазинах; акцизный налог штата на розничную продажу каннабиса (15%), взимаемый с оптовой продажи и трансфертов розничного каннабиса.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not allowed	Запрещено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Not permitted in public places.	Не допускается в общественных местах.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2000: Patient registry, dispensaries already existed; out-of-state patients not recognized; possession, consumption; 2010: commercial production and sales.	2000 год: реестр пациентов; уже существовали пункты отпуска; непризнание пациентов, не являющихся жителями штата; хранение, потребление; 2010 год: коммерческое производство и продажа.
Connecticut	Коннектикут
Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
SB1201	Законопроект Сената 1201
Date passed	Дата принятия
June 2021	Июнь 2021 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
On 17 June 2021, the Connecticut Legislature passed the bill. The law was signed on 22 June 2021.	Законодательное собрание штата Коннектикут приняло этот законопроект 17 июня 2021 года. Закон был подписан 22 июня 2021 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Connecticut Social Equity Council	Совет по вопросам социальной справедливости штата Коннектикут
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют

Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
No more than 1.54 oz (44 g) of cannabis on their person, and no more than 5 oz (142.5 g) in their homes or locked in their car, truck or glove box.	Не более 1,54 унции (44 г) каннабиса при себе и не более 5 унций (142,5 г) дома или запертыми в автомобиле, грузовике или «бардачке».
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
As of 1 July 2023, all adults age 21 and over will be permitted to grow up to 6 cannabis plants (3 mature, 3 immature) indoors within their homes.	С 1 июля 2023 года всем взрослым в возрасте 21 года и старше будет разрешено выращивать до 6 растений каннабиса (3 зрелых, 3 незрелых) в закрытых помещениях в домашних условиях.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Allowed for people with a bona fide social relationship to one another. Not permitted if in exchange for payment or other goods.	Разрешается лицам, имеющим между собой добросовестные социальные отношения. Не допускается в обмен на денежное вознаграждение или другие товары.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Retail sales of cannabis planned to begin by the end of 2022 under a limited licensing structure determined by a lottery	Розничную продажу каннабиса планируется начать к концу 2022 года в рамках ограниченной структуры лицензирования, определяемой лотереей
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market structure	Рыночная структура
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
30% THC by weight for cannabis flower and all other products except pre-filled vape cartridges at 60% THC.	30% ТГК по весу для соцветий каннабиса и всех других продуктов, за исключением предварительно заряженных картриджей для вейпа с содержанием 60% ТГК.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
Not specified	Не установлены
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cannabis producers	Лицензированные производители каннабиса
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edible cannabis products are limited to 5 mg of THC per serving.	Содержание ТГК в каждой порции пищевого продукта каннабиса не должно превышать 5 мг.
Advertising	Реклама
Is not legal to advertise cannabis in Connecticut. Cannabis products cannot be advertised in print, television, radio or on the internet or billboards unless there is “reliable evidence” that at least 90% of the audience is 21 years or older.	Реклама каннабиса в Коннектикуте запрещена законом. Продукты каннабиса нельзя рекламировать в печати, на телевидении, радио, в интернете или на рекламных щитах, если нет «надежных доказательств» того, что аудитория по крайней мере на 90% состоит из лиц старше 21 года.
Taxation	Налогообложение
35% state sales tax, 3% sales tax dedicated to the city or town where the sale occurs. A state cannabis tax based on the amount of THC in the cannabis product: 2.75 cents per mg of THC for cannabis edibles 0.625 cents per mg of THC for	Налог штата с продаж — 35%, 3% налога с продаж предназначены для города или поселка, где происходит продажа. Налог штата на каннабис зависит от уровня содержания ТГК в продукте каннабиса: 2,75 цента за 1 мг ТГК для пищевых продуктов каннабиса, 0,625 цента за 1 мг ТГК для

cannabis flower 0.9 cents per mg of THC for all other product types	соцветия каннабиса, 0,9 цента за 1 мг ТГК для всех других видов продукции
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
It is prohibited to smoke in state parks, workplaces, hotels and within 25 feet of an entrance. Communities with a population of 50,000 or more, will have to set up one public place for individuals to be able to smoke/use cannabis.	Запрещено курить в парках штата, на рабочих местах, в гостиницах и в радиусе 25 футов от входа в гостиницы. Общины с населением 50 000 человек и более должны оборудовать одно общественное место для курения/потребления каннабиса.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Connecticut General Statutes, Chapter 420f, Section 21a-408, An Act Concerning the Palliative Use of Marijuana, was signed into law on May 31, 2012. To qualify for a medical cannabis registration certificate, a patient must be diagnosed by a physician as having one of the debilitating medical conditions set out in the law; 18 years of age; a Connecticut resident; and not an inmate in a Department of Corrections institution or facility.	Сборник законов штата Коннектикут, глава 420f, раздел 21a-408, Закон об использовании марихуаны в качестве паллиативного средства был подписан 31 мая 2012 года. Чтобы получить сертификат о регистрации медицинского каннабиса, пациент должен иметь подтвержденный врачом диагноз о наличии у него одного из угрожающих здоровью истощающих состояний, указанных в законе; должен достичь 18 лет; являться жителем штата Коннектикут; и не являться заключенным в учреждении или заведении Департамента исправительных учреждений.
Delaware	Делавэр
Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
HB 1 & HB 2	Законопроекты HB 1 и HB 2
Date passed	Дата принятия
11 and 14 April 2023, respectively	11 и 14 апреля 2023 года соответственно
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
23 April 2023	23 апреля 2023 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Division of Alcohol & Tobacco Enforcement	Отдел по обеспечению соблюдения законодательства о спиртных напитках и табачных изделиях
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
1 oz or less of cannabis flowers, 12 g of concentrated cannabis, or products with 750 g or less of delta-9 THC	Соцветия каннабиса — не более 1 унции, концентрированный каннабис — 12 г, продукты каннабиса с содержанием дельта-9-ТГК — не более 750 г
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Illegal	Незаконно
Interpersonal sharing	Совместное пользование

Gifting is prohibited, but sharing within the possession limit is allowed without advertisement	Передача в дар запрещена, однако разрешается совместное пользование в пределах установленного лимита для хранения без рекламы
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not applicable	Не применяется
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
10 mg of THC per serving	10 мг ТГК на порцию
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Cultivation facilities, product manufacturers and laboratories	Хозяйства, занимающиеся культивированием, изготовители продуктов и лаборатории
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed retail cannabis stores	Лицензированные магазины розничной торговли каннабисом
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edible cannabis products are also limited to 10 mg per serving.	Содержание в пищевых продуктах каннабиса также не должно быть более 10 мг на порцию
Advertising	Реклама
Restricted, especially mass marketing campaigns that can potentially reach minors.	Ограничена, особенно массовых маркетинговых кампаний, которые потенциально могут охватывать несовершеннолетних.
Taxation	Налогообложение
15% retail tax on cannabis sold commercially	15%-ный налог на розничную продажу каннабиса в коммерческих целях
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Consuming cannabis in public or in a moving vehicle remains illegal	Употребление каннабиса в общественных местах или транспортном средстве во время движения по-прежнему является незаконным
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2011: Patient registry and ID cards, dispensaries already exist, physician certification is required from a state-licensed practitioner, residency requirement.	2011 год: реестр пациентов и идентификационные карты; уже существуют пункты отпуска; требуется медицинская справка от врача, имеющего лицензию штата; требования в отношении регистрации.
District of Columbia	Округ Колумбия
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Initiative 71	Инициатива 71
Date passed	Дата принятия
November 2014	Ноябрь 2014 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы

February 2015: Personal possession, consumption, cultivation.	Февраль 2015 года: хранение, потребление, культивирование в личных целях.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Not applicable; separate legislation to regulate commercial production and sale to adults still not passed	Неприменимо; отдельное законодательство, регламентирующее коммерческое производство и продажу взрослым, все еще не принято.
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
2 oz (57 g) 6 plants (no more than 3 mature)	2 унции (57 г) 6 растений (не более 3 зрелых)
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants per person, 12 plants per household, 6 of which can be flowering	6 растений на человека; 12 растений на домохозяйство, 6 из которых могут быть в стадии цветения
Interpersonal sharing	Совместное пользование
28.5 g or less (transfer without payment)	28,5 г или менее (передача без оплаты)
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not applicable	Не применимо
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
No retail market	Розничный рынок отсутствует
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set initially	Изначально не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
None	Отсутствует
Commercial distribution	Коммерческое распространение
None	Отсутствует
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Currently not allowed	В настоящее время действует запрет.
Advertising	Реклама
Not applicable, no commercial market	Неприменимо, отсутствует коммерческий рынок
Taxation	Налогообложение
Not applicable, no commercial market	Неприменимо, отсутствует коммерческий рынок
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not allowed; currently under investigation by city task force.	Запрещено; в настоящее время вопрос изучается городской целевой рабочей группой.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Not permitted in public places (use on private property is permitted)	Запрещено в общественных местах (разрешено потребление на частной территории).
Medical cannabis	Медицинский каннабис
1998/2010: Patient registry; dispensaries allowed. Any adult, whether a resident or visitor of the city, can self-certify as a medical marijuana patient.	1998/2010 годы: реестр пациентов; разрешены пункты отпуска. Любой взрослый, будь то житель или гость города, может самостоятельно

	подтвердить, что он является пациентом, которому разрешается употреблять марихуану в медицинских целях.
Illinois	Иллинойс
Legal process	Юридический процесс
Approved by legislature in May 2019	Утверждено законодательным органом в мае 2019 года.
Title	Наименование
Bill HB 1438 (Public Act 101-0027)	Законопроект HB 1438 (Публичный акт 101-0027)
Date passed	Дата принятия
Signed by Governor 25 June 2019	Подписано губернатором 25 июня 2019 года.
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Effective 1 January 2020	Действует с 1 января 2020 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Department of Agriculture	Департамент сельского хозяйства
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Partially required	Установлены частично
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
30 g of cannabis flower; no more than 500 mg of THC contained in cannabis infused product; 5 g of cannabis concentrate. Half of these amounts allowed for non-residents.	30 г соцветий каннабиса; не более 500 мг ТГК, содержащегося в продукте каннабиса; 5 г концентрата каннабиса. Нерезидентам разрешается владеть в два раза меньшим количеством.
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Cultivation is allowed for qualifying persons under “Compassionate Use of Medical Cannabis Pilot Programme Act” Plants, with a limit of 5 plants that are more than 5 inches tall, per household without a cultivation centre or craft grower licence. The Illinois court has ordered a temporary freeze on the issuance of craft grower licenses as of 22/11/2022. Cannabis cultivation must take place in an enclosed, locked space. Adult registered qualifying patients may purchase cannabis seeds from a dispensary for the purpose of home cultivation. Seeds may not be given or sold to any other person. Cannabis plants shall not be stored or placed in a location where they are subject to ordinary public view.	Культивирование разрешено лицам, подпадающим под действие Закона об экспериментальной программе применения каннабиса в медицинских целях из соображений гуманности. Растения с ограничением до 5 растений высотой более 5 дюймов на домохозяйство без лицензии центра культивации или самостоятельного растениеводства. По состоянию на 22 ноября 2022 года выдача лицензий для самостоятельных растениеводов временно приостановлена постановлением суда штата Иллинойс. Выращивание каннабиса должно происходить в закрытом и запечатом месте. Совершеннолетние зарегистрированные законные пациенты могут приобретать семена каннабиса в пункте отпуска для выращивания в домашних условиях. Семена запрещается передавать или продавать другим лицам. Растения каннабиса должны храниться или размещаться в местах, недоступных для всеобщего обозрения.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not applicable	Не применяется
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен

Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Initially 100 mg of THC per package; Department of Agriculture may change maximum level of THC contained in each serving of cannabis infused product. Allow possession of cannabis infused products such as capsules, consumables, tinctures, and other edibles that contain no more than 500 mg of THC.	Первоначально 100 мг ТГК на упаковку; Департамент сельского хозяйства может изменить максимальное количество ТГК, содержащееся в каждой порции продукта с каннабисом. Разрешено хранение продуктов с содержанием каннабиса, таких как капсулы, готовые к употреблению продукты, настойки и другие пищевые продукты, содержащие не более 500 мг ТГК.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
Non-residents are allowed half the amounts allowed for residents.	Нерезидентам разрешено иметь половину количества, разрешенного резидентам.
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cultivators and craft growers (who cultivate, dry, cure and package cannabis for sale)	Лицензированные растениеводы и самостоятельные растениеводы (которые выращивают, высушивают, заготавливают и упаковывают каннабис в целях продажи)
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed dispensers both for medical and non-medical use	Лицензированные пункты отпуска для потребления как в медицинских, так и в немедицинских целях
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Allowed but with information and warning on consumption	Разрешены, но с условием информирования и предупреждения о последствиях потребления
Advertising	Реклама
Businesses cannot place advertisements that have false or misleading claims; or advertisements that promote overconsumption; depict actual consumption; depict a person under 21 consuming; make health, medicinal or therapeutic claims; contain images that can be appealing to minors or children; advertisements are not allowed within 1,000 feet of school or playground, public park or library, public transport or public property; no sales promotions are allowed; similar restrictions apply on packaging and labelling. Health warnings to be legibly displayed.	Предприятиям запрещено размещать рекламу, содержащую ложные или вводящие в заблуждение утверждения; или рекламу, пропагандирующую чрезмерное потребление; изображающую реальное потребление; содержащую изображения лиц моложе 21 года, потребляющих каннабис; содержащую заявления о пользе для здоровья, лечебных или оздоровительных свойствах; содержащую изображения, которые могут привлекать внимание несовершеннолетних или детей; запрещено размещение рекламы в радиусе 1000 футов от школы или детской площадки, общественного парка или публичной библиотеки, на общественном транспорте или объектах государственной собственности; не допускается проведение рекламных акций; аналогичные ограничения распространяются на упаковку и маркировку. Предупреждения о вреде здоровью должны быть четко обозначены.
Taxation	Налогообложение
10% sales tax on cannabis flower or products with less than 35% THC; 20% tax on cannabis-infused products such as edibles; 25% tax on products with a THC concentration higher than 35%; Illinois municipalities and counties are able to levy additional local sales taxes.	Налог 10% с продаж соцветий каннабиса или продуктов, содержащих менее 35% ТГК; налог 20% на продукты, содержащие каннабис, например пищевые продукты; налог 25% на продукты с концентрацией ТГК выше 35%; муниципалитеты и округа штата Иллинойс могут взимать дополнительные местные налоги с продаж.

6.25% State Retailers' Occupation Tax; Consumers may pay between 19.55% and 34.75% depending on a product's potency.	Налог 6,25% на лицензию розничных продавцов штата; потребители могут платить от 19,55 до 34,75% в зависимости от силы действия (концентрации действующих веществ) продукта.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Local jurisdictions and retail outlets may or may not allow; designated cannabis-centred businesses lounges.	Местные юрисдикции и торговые точки могут давать или не давать разрешения; специально отведенные помещения предприятий, специализирующихся на каннабисе.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Smoking cannabis is not allowed in any place where smoking is prohibited under the Smoke Free Illinois Act.	Курение каннабиса запрещено во всех местах, где действует запрет на курение в соответствии с Законом о запрете курения штата Иллинойс.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Compassionate use of medical cannabis pilot programme act, began in August 2013. Eligible patients with a doctor's recommendation, with a recognized debilitating condition, after registering with the state, may legally consume medical marijuana. Purchase limit is 2.5 oz of cannabis flower every 14 days. New law also allows school nurses or administrators to give cannabis products to students who are registered medical patients and permits students to medicate under the supervision of those officials.	Закон об экспериментальной программе применения каннабиса в медицинских целях из соображений гуманности, август 2013 года. Соответствующие установленным критериям пациенты с подтвержденным угрожающим здоровью состоянием и при наличии рекомендации врача могут после регистрации в органах власти штата на законных основаниях употреблять марихуану в медицинских целях. Объем покупки ограничен 2,5 унции соцветий каннабиса в каждые 14 дней. Новый закон также позволяет школьным медсестрам или администраторам выдавать продукты каннабиса учащимся, которые являются зарегистрированными терапевтическими пациентами, и разрешает учащимся принимать лекарства под наблюдением этих должностных лиц.
Maine	Мэн
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative June 27, 2019, Governor signed into law 129th LD 719	Инициатива избирателей 27 июня 2019 года губернатор подписал закон 129 LD 719
Title	Наименование
Question 1 (H.P. 1199 - L.D. 1719)	Вопрос 1 (H.P. 1199 — L.D. 1719)
Date passed	Дата принятия
November 2016	Ноябрь 2016 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Took effect on 7 January 2017; regulation for business in place August 2017. On 27 January 2017, the legislature approved a moratorium on implementing parts of the law regarding retail sales and taxation until at least February 2018. Law finally took effect on 19 September 2019.	Вступил в силу 7 января 2017 году; нормативная база для бизнеса принята в августе 2017 года. 27 января 2017 года законодательный орган утвердил мораторий на применение отдельных частей закона, касающихся розничных продаж и налогообложения, по меньшей мере до февраля 2018 года. Закон окончательно вступил в силу 19 сентября 2019 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган

Department of Administrative and Financial Services (Office of Marijuana Policy)	Департамент административных и финансовых услуг (Управление по политике в отношении марихуаны)
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Not specified	Не установлены
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
71.25 g (2.5 oz) concentrates up to 5 g	71,25 г (2,5 унции); концентраты до 5 г
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
3 flowering marijuana plants, 12 immature plants and unlimited seedlings. An adult may possess all of the cannabis produced by the plants. Property owners can prohibit home cultivation. Cultivation for medical purposes not subject to same restrictions. Plants must be tagged with the cultivator's name, driver's licence or ID number, and — if the plants are not on land owned by the cultivator — the name of the property owner.	3 цветущих растения марихуаны, 12 незрелых растений и неограниченное количество рассады. Совершеннолетний может владеть всем каннабисом, полученным из этих растений. Собственники жилья имеют право запретить культивирование каннабиса в домашних условиях. Эти ограничения не распространяются на культивирование в медицинских целях. Растения должны быть снабжены ярлыком с указанием имени и фамилии растениевода, номера водительских прав или удостоверения личности, а также — если растения находятся на участке, не принадлежащем растениеводу, — имени и фамилии собственника участка.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Same as personal possession limits; in addition no more than 6 seedlings or immature plants	В тех же пределах, что и для личных целей; кроме того, не более 6 саженцев или незрелых растений
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
28.5 g (1 oz); 12 seedlings	28,5 г (1 унция); 12 саженцев
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Edible marijuana products: may not contain more than 10 mg of THC per serving; may not contain more than 100 mg of THC per package	Пищевые продукты с содержанием марихуаны: могут содержать не более 10 мг ТГК на порцию и не более 100 мг ТГК на упаковку
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
A retail tobacco license is needed for a license to sell pre-rolled cannabis cigarettes, electronic smoking devices and liquid concentrates, which requires a licensee to have a physical storefront.	Лицензия на розничную продажу табачных изделий необходима для получения лицензии на продажу заранее приготовленных сигарет с каннабисом, электронных устройств для курения и жидких концентратов, что требует от лицензиата наличия физического магазина.
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cultivators; two types based on size. Dispensaries can now grow an unlimited number of mature cannabis plants.	Лицензированные растениеводы; две категории в зависимости от размера. В настоящее время в пунктах отпуска может выращиваться неограниченное количество зрелых растений каннабиса.
Commercial distribution	Коммерческое распространение

State authority may not limit total number of stores; localities may regulate number and location of establishments.	Органы штата могут не ограничивать общее количество магазинов; местные органы могут регулировать количество и место расположения заведений
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edibles may not contain more than 10 mg of THC per serving of the product and may not contain more than 100 mg of THC per package of the product.	Пищевые продукты не могут содержать более 10 мг ТГК на порцию продукта и более 100 мг ТГК на упаковку продукта.
Advertising	Реклама
Restricted to those over 21. Restrictions on false advertisement or claims of untrue health benefits. Products cannot appeal to children.	Разрешена только для лиц старше 21 года. Ограничения в отношении лживых объявлений или не соответствующих действительности утверждений о пользе для здоровья. Продукты не должны быть привлекательными для детей.
Taxation	Налогообложение
10% excise tax on retail; 15% excise tax on sale or transfer from a licensed commercial cultivation to licensed retail store.	Акцизный налог 10% с розничных продаж; акцизный налог 15% с продаж или трансферта от лицензированного коммерческого растениевода в лицензированный магазин розничной торговли.
On site consumption	Потребление на месте продажи
State-licensed clubs	Клубы, имеющие лицензию штата
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Not permitted in public places (permitted use in private property or smoking in a state-licensed marijuana social club).	Запрещено в общественных местах (разрешено потребление на частной территории или курение в лицензированном штатом социальном клубе для употребляющих марихуану).
Medical cannabis	Медицинский каннабис
1999: Patient registry or identification card; dispensaries, recognizes patients from other states but not for dispensary purchases.	1999 год: реестр пациентов или наличие идентификационной карты; пункты отпуска, пациенты из других штатов признаются соответствующими критериям, за исключением покупок в пунктах отпуска.
Massachusetts	Массачусетс
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Question 4 Mass. General Laws c.94G	Вопрос 4 Массачусетс, Общие законы c.94G
Date passed	Дата принятия
November 2016	Ноябрь 2016 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
15 September 2017. Licences issued starting 1 October 2017. Law updated on 20 June, 2019.	15 сентября 2017 года. Выдача лицензий начиная с 1 октября 2017 года. Закон обновлен 20 июня 2019 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
1) Cannabis Control Commission and Cannabis Advisory Board	1) Комиссия по контролю над каннабисом и Консультативный совет по обороту каннабиса

Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Not specified	Не установлены
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
1 oz flower (28.5 g) 5g concentrate or 10 oz at home	1 унция соцветий (28,5 г), 5 г концентрата (10 унций) в домовладении
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants, 12 in a single residence away from view; 10 oz of dried marijuana permitted at home.	6 растений, 12 растений на одно место жительства, вне поля зрения; дома разрешается хранить 10 унций высушенной марихуаны.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
1 oz of cannabis	1 унция каннабиса
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Up to 1 oz can be given to another adult 21 or older.	До 1 унции может быть продано другому взрослому человеку в возрасте 21 года или старше.
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set initially	Изначально не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
Personal data collection not required	Сбор персональных данных не требуется
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments; localities can regulate, limit or prohibit the operation of businesses.	Лицензированные заведения; местные органы власти могут регулировать, ограничивать или запрещать работу субъектов предпринимательской деятельности.
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edibles are limited to 5 mg of THC per single serving. The entire package cannot have more than 20 servings for a combined total of 100 mg of THC.	Содержание ТГК в каждой отдельно расфасованной порции пищевого продукта не должно превышать 5 мг. Одна упаковка должна содержать не более 20 порций, содержащих в общей сложности 100 мг ТГК.
Advertising	Реклама
Restricted advertising for medical and adult-use cannabis licences, prohibiting television, radio, podcast, internet, mobile app, social media, billboard and print ads unless at least 85% of the audience is reasonably expected to be 21 years of age or older.	Ограничения в отношении рекламы лицензий на каннабис, предназначенный для употребления в медицинских целях и употребления взрослыми, запрет рекламы на телевидении, радио, в подкастах, интернете, мобильных приложениях, социальных сетях, на рекламных щитах и в печатных изданиях, если имеются основания полагать, что как минимум 85% аудитории не достигли возраста 21 года или старше.
Taxation	Налогообложение
10.75% excise tax on retail sales. 6.25% state sales tax applies to retail purchases of all cannabis products.	Акцизный налог 10,75% на розничные продажи.

Up to 3% local excise tax, optional, on retail purchases of all products.	Налог с продаж штата в размере 6,25% применяется к розничным покупкам всех продуктов с каннабисом. Возможно установление местного акцизного налога до 3% на розничные покупки всех продуктов с каннабисом.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not allowed, although they may exist in establishments that allow on-site-consumption.	Не разрешается, однако может иметь место в заведениях, где такое потребление разрешается.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Cannot use cannabis in a place where smoking tobacco is prohibited	Употребление каннабиса не допускается в местах, где запрещено табакокурение
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2012/2013: Patient registry or identification cards; dispensaries, out-of-state patients not recognized.	2012–2013 годы: реестр пациентов или наличие идентификационной карты; пункты отпуска, непризнание пациентов, не являющихся жителями штата.
Michigan	Мичиган
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Proposal 18-1	Предложение 18-1
Date passed	Дата принятия
6 December 2018	6 декабря 2018 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Commercial licences application began by 6 December 2019.	Заявки на получение коммерческих лицензий принимаются с 6 декабря 2019 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Marijuana Regulatory Agency	Агентство по регулированию оборота марихуаны
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Not specified	Не установлены
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
2.5 oz (70.8 g) on person with no more than 15 g in the form of concentrate and 10 oz (283 g) at home	2,5 унции (70,8 г) на человека, не более 15 г в концентрированном виде и 10 унций (283 г) в домовладении
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Up to 12 plants per household not visible from a public place.	До 12 растений на домохозяйство, не видимых из общественного места.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
2.5 oz with a max of 15 mg of concentrate as long as money is not exchanged.	2,5 унции, а также 15 мг концентрата при условии отсутствия обмена на деньги
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Up to 2.5 oz (70 g) of cannabis flower 15 g of extract or concentrate	До 2,5 унции (70 г) соцветий каннабиса, 15 г экстракта или концентрата
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен

Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
A municipality may completely prohibit or limit the number of establishments operating.	Муниципалитет может полностью запретить или ограничить количество действующих заведений.
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Except for THC limits (see above)	За исключением ограничений по ТГК (см. выше)
Advertising	Реклама
Restrictions on public signs related to cannabis establishments.	Ограничения на публичные вывески, относящиеся к заведениям, торгующим каннабисом
Taxation	Налогообложение
10% excise tax	Акцизный налог 10%
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не установлено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Not permitted in public places or places where prohibited by person who owns, occupies or manages the property, allowed in designated public places that are not accessible to persons under 21 years of age.	Не допускается в общественных местах или местах, где это запрещено лицом, владеющим, временно владеющим или управляющим жилым имуществом; разрешается в специально отведенных общественных местах, недоступных для лиц моложе 21 года.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2008: patient registry, dispensaries can be established with local ordinances; dispensation for specific conditions, recognize out of state patients only for legal protection of possession but not for dispensary purchases.	2008 год: реестр пациентов, пункты отпуска могут создаваться в соответствии с местными постановлениями; отпуск каннабиса при определенных заболеваниях, признание пациентов из других штатов только в контексте юридической защиты при владении продуктами с каннабисом, но не для покупки в пункте отпуска.
Minnesota	Миннесота
Legal process	Юридический процесс
Legislative process	Законодательный процесс
Title	Наименование
HF100	Законопроект HF100
Date passed	Дата принятия
24 April 2023	24 апреля 2023 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
01 August 2023	1 августа 2023 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Minnesota Office of Cannabis Management	Управление по регулированию оборота каннабиса штата Миннесота
Minimum age	Минимальный возраст

21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Not specified	Не установлены
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
2 oz of cannabis flower in public, 2 lbs of cannabis flower in a private residence and 8 g of concentrate	2 унции соцветий каннабиса в общественном месте, 2 фунта соцветий каннабиса в частном домовладении и 8 г концентрата
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Up to 8 cannabis plants with no more than 4 being mature. Must be in an enclosed, locked space that is not open for public view.	До 8 растений каннабиса, из которых не более четырех могут быть зрелыми. Должно осуществляться в закрытом и запертом месте, недоступном для всеобщего обозрения.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Within the personal possession limit.	В тех же пределах, что и для владения в личных целях.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not specified	Не установлено
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
5 mg/serving and 50 mg/package for edibles	5 мг на порцию и 50 мг на упаковку пищевых продуктов
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed	По лицензии
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed	По лицензии
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
50 mg/package for edibles	50 мг на упаковку пищевых продуктов
Advertising	Реклама
Prohibition of advertising to minors; prohibition of false or misleading advertising; restrictions on advertising in places where minors are likely to be present; compliance with other advertising regulations.	Запрет на рекламу для несовершеннолетних; запрет на ложную или вводящую в заблуждение рекламу; ограничения на рекламу в местах возможного присутствия несовершеннолетних; соблюдение других положений о рекламе.
Taxation	Налогообложение
10% sales tax, in addition to state tax	10%-ный налог с продаж помимо налога штата
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Restriction on use in public schools, charter schools, school buses, state correctional facilities, in a location where the smoke, aerosol or vapor of a cannabis product could be inhaled by a minor, on federal property (such as courthouses, airports and national parks), in federally subsidized housing,	Ограничение в отношении употребления в государственных школах, уставных школах, школьных автобусах, исправительных учреждениях штата, в местах, где дым, аэрозоль или пары продукта каннабиса могут вдыхаться несовершеннолетними, на объектах, находящихся в

while on an employer's premises, or operating an employer's vehicle, machinery or equipment.	федеральной собственности (например, в зданиях судов, аэропортах и национальных парках), в субсидируемых федеральным правительством жилых помещениях, хотя и находящихся на территории работодателя, или при управлении транспортным средством, механизмами или оборудованием работодателя.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2014/2015: patient registry, health practitioner certification.	2014–2015 годы: реестр пациентов, сертификация медицинских работников.
Montana	Монтана
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Initiative 190	Инициатива 190
Date passed	Дата принятия
November 2020	Ноябрь 2020 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Application for licensure by 1 January 2022.	Заявки на получение лицензий принимаются до 1 января 2022 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Department of Revenue	Департамент государственных доходов
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
-	-
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz) or 8 g in concentrated form	28,5 г (1 унция) или 8 г в концентрированном виде
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
4 plants with only 2 mature at any time; maximum number of plants allowed in a single residence is twice the individual limit.	4 растения, из которых зрелыми в любой момент могут быть только два; максимальное количество растений, разрешенное в одном жилом помещении, в два раза превышает индивидуальный лимит.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Less than twice the amount of personal possession limit without any consideration or remuneration.	Не превышает более чем в два раза пределов хранения в личных целях без какого-либо вознаграждения или компенсации.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Under the new law customers may purchase up to 1 oz of cannabis per transaction, or the THC equivalent in other forms: 800 mg of edibles or 8 g of concentrate.	Согласно новому закону, покупатели могут приобрести до 1 унции каннабиса за одну сделку или эквивалентное количество ТГК в других формах: 800 мг настойки или 8 г концентрата.
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not specified	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации

None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed	По лицензии
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed	По лицензии
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edibles are limited to 100 mg per package, with no more than 10 mg of THC per serving, as a common industry standard. Cannabis infused products may not be in shapes or packages that are attractive to children or that are easily confused with commercially sold candy.	Согласно общепринятому отраслевому стандарту, содержание ТГК в одной упаковке пищевого продукта с каннабисом не должно превышать 100 мг, а в одной порции — 10 мг. Продукты, содержащие каннабис, не должны иметь привлекательные для детей формы или упаковки либо очень напоминать находящиеся в продаже конфеты.
Advertising	Реклама
Advertising cannabis is prohibited in any medium including electronic media.	Реклама каннабиса запрещена в любых средствах массовой информации, включая электронные.
Taxation	Налогообложение
20% of the retail price	20% от розничной цены
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Not permitted in public places where smoking tobacco is prohibited, unless allowed by the department.	Не допускается в общественных местах, где запрещено табакокурение, если отсутствует разрешение от департамента.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2004: Registered card holders; signed physician statement for a debilitating condition.	2004 год: владельцы зарегистрированных карт; подписанное врачом заключение об угрожающем здоровью истощающем состоянии.
Nevada	Невада
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Question 2 Title 56 Nevada Revised Statutes 678	Вопрос 2 Раздел 56 свода законов Невады, переработанный Законодательный акт 678
Date passed	Дата принятия
November 2016	Ноябрь 2016 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Took effect on 1 January 2017 and regulations were in place by 1 January 2018. Cannabis regulation effective 1 July 2020.	Вступил в силу 1 января 2017 года, а нормативное регулирование было введено в действие к 1 января 2018 года. Нормы регулирования оборота каннабиса действуют с 1 июля 2020 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган

Cannabis Compliance Board	Совет по соблюдению законодательства в области каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Not specified	Не установлены
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz) flower 1/8 oz or 3.5 g concentrate or edible	28,5 г (1 унция) соцветий, 1/8 унции или 3,5 г концентрата или пищевого продукта
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants, no more than 12 on property, indoors or enclosed, with permission of landlord and must be 25 miles away from retail cannabis store.	6 растений, не более 12 растений на домовладение, выращиваемых внутри помещения или на огражденном участке с разрешения собственника, на расстоянии не менее 25 миль от магазина розничной торговли каннабисом.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Presumably same as personal possession limit.	Предположительно в тех же пределах, что и для хранения в личных целях.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not specified, presumably same limits as for personal possession.	Не установлен, предположительно в тех же пределах, что и для хранения в личных целях.
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set initially	Изначально не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
Personal data collection not required	Сбор персональных данных не требуется
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments In Nevada, cannabis growers must legally account for all cannabis waste by weighing and destroying it.	Лицензированные заведения. В Неваде закон обязывает производителей каннабиса вести весовой учет всех отходов каннабиса и уничтожать их.
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Limits on market concentration by population	Ограничения в отношении концентрации рынка в зависимости от численности населения
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Single-serving edible cannabis product offered for sale to a consumer containing not more than 10 mg of THC.	Содержание ТГК в каждой отдельно расфасованной порции пищевого продукта с каннабисом, предназначенной для продажи потребителю, не должно превышать 10 мг.
Advertising	Реклама
A licensed marijuana establishment cannot engage in advertising that contains any false or misleading statements, promotes overconsumption, depicts actual consumption, or appeals to minors. Also applies 70/30 rule from Colorado.	Лицензированное заведение по продаже марихуаны не может использовать рекламу, содержащую ложные или вводящие в заблуждение заявления, пропагандирующую чрезмерное потребление, изображающую реальное потребление или

	привлекающую внимание несовершеннолетних. Также применяется правило 70/30 штата Колорадо.
Taxation	Налогообложение
15% excise on wholesale sale 10% excise tax on retail sale	Акцизный налог 15% на оптовую продажу. Акцизный налог 10% на розничные продажи
On site consumption	Потребление на месте продажи
On-site consumption lounges are permitted. Prospective licences are being awarded as of 30 November 2022. The first cannabis consumption lounge is due to open before summer 2023.	Разрешается открывать на территории предприятия помещения для потребления. Лицензии на открытие таких помещений в будущем выдаются с 30 ноября 2022 года. Первое помещение для потребления каннабиса должно открыться до лета 2023 года.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Cannabis consumption is for private use only. It is illegal to smoke in public, on federal land or in a vehicle without risking a fine.	Потребление каннабиса допускается только в личных целях. Курение в общественных местах, на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, или в автомобиле является незаконным и влечет наложение штрафа.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2000: Patient registry or identification card, No dispensaries; recognize out of state patients if other state's programmes are substantially similar; patients must fill out Nevada paper work.	2000 год: реестр пациентов или наличие идентификационной карты; пункты отпуска отсутствуют; пациенты, не являющиеся жителями штата, признаются, если в других штатах действуют аналогичные по сути программы; пациенты должны заполнить формуляры, предусмотренные в штате Невада.
New Jersey	Нью-Джерси
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Question 1 New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act (A-21 (P.L.2021,c.16))	Вопрос 1 Закон Нью-Джерси о регулировании оборота каннабиса, содействии в правоприменении и модернизации рынка (A-21 (P.L.2021, с.16))
Date passed	Дата принятия
November 2020	Ноябрь 2020 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
The Cannabis Act was signed on 22 February 2021 and went into immediate effect.	Закон о каннабисе был подписан 22 февраля 2021 года и сразу же вступил в силу.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis Regulatory Commission	Комиссия по регулированию оборота каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz) of cannabis or its equivalent or 4 g of concentrate	28,5 г (1 унция) каннабиса или его эквивалента или 4 г концентрата

Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Home cultivation is prohibited.	Культивирование в домашних условиях запрещено.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Same as personal possession limits, and only without payment or compensation.	В тех же пределах, что и для хранения в личных целях, исключительно без какого-либо вознаграждения или возмещения.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Adults can legally purchase up to 1 oz of cannabis through a licensed retailer.	Взрослые могут легально приобрести до 1 унции каннабиса у лицензированного розничного торговца.
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed	По лицензии
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edible cannabis product shall contain no more than 10 mg of active THC per unit of sale.	Пищевой продукт с каннабисом не должен содержать более 10 мг активного ТГК на единицу товара.
Advertising	Реклама
Restrict advertising of cannabis items and cannabis 41 paraphernalia in ways that target or are designed to appeal to individuals under the legal age to purchase cannabis items, includes objects, such as toys, characters, or cartoon characters suggesting the presence of a person under 21 years of age or any other depiction; also advertising on television and radio between 6:00 to 22:00 is prohibited; also prohibited to sponsor sports or cultural events.	Ограничена реклама продуктов из каннабиса и сопутствующих товаров (по пункту 41) способами, которые направлены или предназначены для привлечения лиц, не достигших установленного законом возраста для приобретения продуктов из каннабиса, с использованием игрушек, персонажей или героев мультфильмов, подразумевающих изображение лиц моложе 21 года, или любых иных изображений; также запрещена реклама на телевидении и радио с 6:00 до 22:00; запрещено также спонсировать спортивные и культурные мероприятия.
Taxation	Налогообложение
General state sales rate of 6.625%; plus a social equity excise fee of \$1.52 per oz for cultivators (starting from 1 January 2023). Annually adjusted excise fee based on average retail price: up to \$10 per oz if the average retail price of an oz was \$350 or more; up to \$30 per oz if the average retail price of an oz was less than \$350 but at least \$250; up to \$40 per oz if the average retail price of an oz was less than \$250 but at least \$200; and up to \$60 per oz if the average retail price of an oz was less than \$200.	Общая ставка налога с продаж в штате составляет 6,625% плюс акцизный сбор на обеспечение социальной справедливости в размере 1,52 долл. США за унцию для растениеводов (начиная с 1 января 2023 года). Ежегодно корректируемый акцизный сбор, основанный на средней розничной цене: до 10 долл. США за унцию, если средняя розничная цена унции составила 350 долл. США или более; до 30 долл. США за унцию, если средняя розничная цена унции составила менее 350 долл. США, но не менее 250 долл. США; до 40 долл. США за унцию, если средняя розничная цена

	унции составила менее 250 долл. США, но не менее 200 долл. США; до 60 долл. США за унцию, если средняя розничная цена унции составила менее 200 долл. США.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Allowed in designated “Cannabis Consumption Areas” (also known as “on-site consumption areas”) attached to places that sell legal cannabis.	Разрешено в специально отведенных «зонах потребления каннабиса» (также известных как «зоны потребления на месте») в местах законной продажи каннабиса.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Consumption is only permitted in a private residence.	Потребление разрешается только в частном домовладении.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2009: Medical cannabis can be purchased from any state-licensed New Jersey cannabis dispensary. Physicians determine the proper dosage allowed for the patient, with a maximum set at 3 oz for a 30-day period. Each dose is sold in 0.25 oz denominations. Visiting patients with valid medical marijuana cards from their home state are granted the same protections and allowances surrounding possession and consumption as New Jersey resident cardholders.	2009 год: медицинский каннабис можно приобрести в любом лицензированном в штате Нью-Джерси пункте отпуска каннабиса. Врачи определяют дозировку, допустимую для пациента (максимальная доза составляет 3 унции в течение 30 дней). Каждая доза при продаже отмеряется номинальными единицами по 0,25 унции. Приезжие пациенты с действующими картами на использование марихуаны в медицинских целях, выданными штатом их проживания, имеют такие же гарантии и разрешения на хранение и потребление, как и владельцы карт, проживающие в Нью-Джерси.
New Mexico	Нью-Мексико
Legal process	Юридический процесс
Legislative process	Законодательный процесс
Title	Наименование
HB 2 Cannabis regulation act passed by legislature 31 March 2021	Законопроект 2 Закона о регулировании оборота каннабиса принят законодательным органом 31 марта 2021 года
Date passed	Дата принятия
March 2021	Март 2021 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Signed by governor on 12 April 2021. Sales began in April 2022.	Подписан губернатором 12 апреля 2021 года. Продажи начались в апреле 2022 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis Control Division	Отдел по контролю над каннабисом
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
56 g (2 oz) 16 g of cannabis concentrates and 800 mg of infused edibles	56 г (2 унции), 16 г концентрированных продуктов каннабиса и 800 мг пищевых продуктов
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях

6 plants per person, or 12 per household; away from public view.	6 растений на человека или 12 растений на домохозяйство; вдали от посторонних глаз.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Same as personal possession limits. Prohibited to gift cannabis alongside a transaction or in conjunction with sale of goods and services.	В тех же пределах, что и для хранения в личных целях. Передача каннабис в дар при заключении сделки или в связи с продажей товаров и услуг запрещается.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Same as personal possession limits	В тех же пределах, что и для хранения в личных целях
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Regulated market started in April 2022	Регулируемый рынок начал функционировать в апреле 2022 года.
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not specified	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cultivation/production. Small cannabis microbusinesses can grow up to 200 plants.	Лицензированное культивирование/производство. Небольшие микропредприятия по выращиванию каннабиса могут выращивать до 200 растений.
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed	По лицензии
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Not specified	Не установлены
Advertising	Реклама
Advertising cannabis to people under 21 is prohibited, with the use of cartoon characters or other imagery likely to appeal to children forbidden. Advertisements will also be barred from billboards or other public media within 300 feet of a school, day-care centre or church.	Запрещена реклама каннабиса, ориентированная на лиц моложе 21 года, при этом запрещено использовать персонажей мультфильмов или другие образы, которые могут понравиться детям. Реклама также будет запрещена на рекламных щитах и других общественных носителях в радиусе 300 футов от школы, детского сада или церкви.
Taxation	Налогообложение
12% excise tax to be gradually increased to 18% by 2025; 5.125% gross receipts tax (sales tax).	Акцизный налог 12%, который будет постепенно увеличен до 18% к 2025 году; налог на валовый доход (налог с продаж) 5,125%.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Is allowed if businesses offer	Разрешается, если предприятия предлагают
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public consumption remains illegal, but business can offer on-site consumption if certain requirements are met.	Потребление в общественных местах по-прежнему незаконно, однако профильное предприятие может предлагать потребление на месте при условии соблюдения определенных требований.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2007: In 2020, registered patients are required to be state residents; patients need to have a certification from a prescriber with the qualifying	2007 год: в 2020 году зарегистрированные пациенты должны быть резидентами штата; пациентам необходимо иметь заключение лица, назначившего лечение, о наличии заболевания,

conditions; patients are allowed to possess no more than 230 units (approx. 8 oz of flower or buds).	соответствующего установленным критериям; пациентам разрешается хранить не более 230 единиц (примерно 8 унций соцветий или соплодий).
New York	Нью-Йорк
Legal process	Юридический процесс
Legislative process	Законодательный процесс
Title	Наименование
Assembly bill A1248 A Marijuana regulation and taxation act	Законопроект Ассамблеи A1248 А Закон о регулировании оборота и налогообложении марихуаны
Date passed	Дата принятия
31 March 2021	31 марта 2021 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Assembly bill signed by governor on 31 March 2021; Sales may begin in December 2022.	Законопроект Ассамблеи подписан губернатором 31 марта 2021 года; продажи могут начаться в декабре 2022 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis Control Board	Совет по контролю над каннабисом
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
85.5 g (3 oz) or 24 g of concentrated cannabis Up to 5 pounds at home	85,5 г (3 унции) или 24 г концентрированного каннабиса До 5 фунтов на домохозяйство
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants, 3 mature and 3 seedlings, or up to 12 per household.	6 растений (3 взрослых растения и 3 саженца) или до 12 растений на домохозяйство
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Same as personal possession limits but without compensation.	В тех же пределах, что и для хранения в личных целях, при условии отсутствия выплаты компенсации.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
To be determined	Будет определены позднее
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market/commercial	Рыночная/коммерческая
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed	По лицензии
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments. Existing medical cannabis operators will be allowed to operate three	Лицензированные заведения. Существующим операторам медицинского каннабиса будет разрешено открыть три магазина для взрослых,

adult-use stores, co-locating them with their medical dispensaries.	разместив их в тех же помещениях, где располагаются их медицинские пункты отпуска.
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
None	Отсутствуют
Advertising	Реклама
The board is authorized to promulgate rules and regulations governing the advertising	Совет уполномочен издавать нормы и положения, регулирующие рекламу
Taxation	Налогообложение
Proposed tax is 13%. Wholesale tax will be applied to products based on potency (0.5 cent per mg for flower, 8/10th of a cent per mg for concentrated cannabis and 3 cents per mg for edibles).	Предлагаемый налог составляет 13%. Налог на оптовые продажи будет применяться к продукции в зависимости от содержания действующих веществ (0,5 цента за 1 мг соцветий, 0,8 цента за 1 мг концентрированного каннабиса и 3 цента за 1 мг пищевых продуктов).
On site consumption	Потребление на месте продажи
Is allowed	Разрешается
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Smoking cannabis in any location is prohibited where smoking tobacco is prohibited.	Курение каннабиса является незаконным везде, где запрещено табакокурение.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2014: Registration and ID card, medical cannabis to be given either to a certified patient (resident of the state) or by a designated caregiver for a certified medical use for defined “severe debilitating or life threatening conditions”.	2014 год: реестр пациентов и наличие идентификационной карты; каннабис для потребления в медицинских целях отпускается только отвечающему критериям пациенту (жителю штата) либо назначенному лицу, осуществляющему уход, для сертифицированного использования в медицинских целях при определенных «тяжелых истощающих или угрожающих жизни состояниях пациента».
Ohio	Огайо
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
2023 Ohio Issue 2 (Marijuana Legalization Initiative)	Вопрос 2 референдума 2023 года в штате Огайо (Инициатива по легализации марихуаны)
Date passed	Дата принятия
7 November 2023	7 ноября 2023 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Law would become effective 30 days after the vote, 7 December 2023.	Закон вступит в силу через 30 дней после голосования, 7 декабря 2023 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Division of Cannabis Control	Отдел по контролю над каннабисом
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Not specified	Не установлены
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях

15g of extract and 2.5 oz of other forms	15 г экстракта и 2,5 унции других форм
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Up to 6 plants per adult or a maximum of 12 per household.	До 6 растений на одного взрослого или не более 12 на домохозяйство.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Not specified	Не предусмотрено
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Not specified	Не установлен
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Not specified yet	Еще не определена
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not specified	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed	По лицензии
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed	По лицензии
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Not specified	Не установлены
Advertising	Реклама
Not specified	Не предусмотрена
Taxation	Налогообложение
10% tax on marijuana sales	10%-ный налог на продажу марихуаны
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Use of marijuana in public is illegal.	Употребление марихуаны в общественных местах является незаконным.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2016: Patient registry, medical cannabis to be given either to a certified patient (resident of the state) or by a designated caregiver for a certified medical use for defined “severe debilitating or life threatening conditions”.	2016 год: реестр пациентов; каннабис для потребления в медицинских целях отпускается только отвечающему критериям пациенту (жителю штата) либо назначенному лицу, осуществляющему уход, для сертифицированного использования в медицинских целях при определенных «тяжелых истощающих или угрожающих жизни состояниях пациента».
Oregon	Орегон
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative, state statute	Инициатива избирателей, закон штата
Title	Наименование
Measure 91	Мера 91
Date passed	Дата принятия
November 2014	Ноябрь 2014 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы

July 2015: Personal possession, consumption, cultivation. October 2015 up to December 2016: Retail sales through medical dispensaries. January 2017: Retail sales through licensed retailers.	Июль 2015 года: хранение, потребление, культивирование в личных целях. Октябрь 2015 года — декабрь 2016 года: розничная торговля через пункты отпуска при медицинских учреждениях. Январь 2017 года: розничная торговля через лицензированных розничных продавцов.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Oregon Liquor Control Commission	Комиссия штата Орегон по контролю крепких спиртных напитков
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
In public: 28.5 g At home: 228 g	В общественных местах: 28,5 г В домашних условиях: 228 г
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
4 plants in flower	4 цветущих растения
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Gifts of recreational cannabis to adults 21 and older is allowed, so long as the amount gifted falls within the personal possession limits and no financial consideration is associated with the transfer.	Разрешается передавать рекреационный каннабис в дар взрослым в возрасте 21 года и старше, при условии, что количество переданного каннабиса не превышает лимит количества для хранения в личных целях и передача не предусматривает финансового вознаграждения.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
1 oz dried flower 5 g cannabinoid extracts or concentrates 16 oz edible form 72 oz cannabis in liquid form 10 cannabis seeds 4 immature cannabis plants	1 унция высушенных соцветий 5 г каннабиноидных экстрактов или концентратов 16 унций в виде пищевых продуктов 72 унции каннабиса в жидком виде 10 семян каннабиса 4 незрелых растения каннабиса
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set initially	Изначально не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cannabis producers	Лицензированные производители каннабиса
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed retail cannabis stores	Лицензированные магазины розничной торговли каннабисом
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edibles produced for recreational consumers are limited to 5 mg for a single dose and 50 mg for an entire package. Edibles concentration limits increased from 50 mg THC to 100 mg per package	Пищевые продукты, предназначенные для потребления в рекреационных целях, должны содержать не более 5 мг ТГК для разовой дозы и 50 мг ТГК для целой упаковки. С 1 апреля 2022 года и

on and after April 1, 2022. Single serving portions (of no more than 10 mg THC) is scored, to make the portion sizes obvious.	после этой даты предел концентрации ТГК в пищевых продуктах увеличилось с 50 мг до 100 мг на упаковку. Следует четко отмечать отдельные порции (не более 10 мг ТГК), чтобы наглядно обозначить размер дозы.
Advertising	Реклама
Entry sign required on exterior of dispensaries; Oregon Liquor Control Commission has authority to further regulate or prohibit advertising.	С наружной стороны пункта отпуска должен быть размещен указатель входа; Комиссия штата Орегон по контролю крепких спиртных напитков имеет право в дальнейшем регулировать или запрещать рекламу.
Taxation	Налогообложение
No tax on retail sales from October 2015 to December 2015; 25% sales tax after 5 January 2016; 17% sales tax in 2017 with options for local communities to establish local tax up to 3%.	Октябрь–декабрь 2015 года: налог на розничные продажи не взимается. После 5 января 2016 года: налог на продажи в размере 25%. 2017 год: налог на продажи в размере 17%, по усмотрению местных общин может устанавливаться местный налог в размере до 3%.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not allowed	Не разрешается
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Smoking marijuana in public is illegal.	Курение марихуаны в общественных местах является незаконным.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
1998: Patient registry, dispensaries already existed but not clearly authorized by law or regulated, possession, home cultivation.	1998 год: реестр пациентов; пункты отпуска уже существуют, но их деятельность не четко прописана в законе или не регулируется; хранение, культивирование в домашних условиях.
South Dakota	Южная Дакота
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Measure 27	Мера 27
Date passed	Дата принятия
November 2020	Ноябрь 2020 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Anticipated date of implementation was 1 April 2022. The ballot measure overturned by courts in February 2021. The ballot was defeated in the November 2022 mid-term elections.	Предполагаемая дата введения в действие — 1 апреля 2022 года. Итоги голосования по мере были отменены судами в феврале 2021 года. На промежуточных выборах в ноябре 2022 года голосование по этому вопросу было провалено.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Department of Revenue	Департамент государственных доходов
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz or less) or 8 g of concentrate	28,5 г (1 унция или менее) или 8 г концентрата

Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
3 plants with no more than 6 per household. Plants must be in a locked space and out of public view.	3 растения, но не более 6 на домохозяйство. Растения должны находиться в запертом месте и вдали от посторонних глаз.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
-	-
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
-	-
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
-	-
Commercial distribution	Коммерческое распространение
-	-
Restriction on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Advertising	Реклама
-	-
Taxation	Налогообложение
15% tax proposed	Предлагаемый налог составляет 15%
On site consumption	Потребление на месте продажи
-	-
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Prohibited in public places other than in an area licensed by the Department for consumption; smoking in a location where smoking tobacco is prohibited.	Не допускается в общественных местах, за исключением лицензированных Департаментом мест для потребления; курение каннабиса является незаконным везде, где запрещено табакокурение.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
In 2020, the voters of South Dakota passed Initiated Measure 26 and approved medical cannabis.	В 2020 году выдвинутая избирателями Южной Дакоты Инициативная мера 26 была принята, а также было одобрено потребление каннабиса в медицинских целях.
Vermont	Вермонт
Legal process	Юридический процесс
Legislative process	Законодательный процесс
Title	Наименование
No. 86 S.54 (initiated in February 2020 and went into force in October 2020 without the Governor's signature)	№ 86 S.54 (инициирован в феврале 2020 года и вступил в силу в октябре 2020 года без подписания губернатором)
Date passed	Дата принятия
January 2018	Январь 2018 года

Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
1 July 2018; Sale regulations effective October 2020.	Нормы регулирования торговли вступили в силу в октябре 2020 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis Control Board (proposed under S.54)	Совет по контролю над каннабисом (предложен в соответствии с S.54)
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
28.5 g (1 oz) or less or 5 g or less of concentrates (e.g., hashish oil)	Не более 28,5 г (1 унция) или не более 5 г концентратов (например, гашишного масла)
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
2 mature plants or 7 immature plants.	2 зрелых растения или 7 незрелых растений
Interpersonal sharing	Совместное пользование
28.5 or 1 oz or less, or 5 g or less	Не более 28,5 г (1 унция) или не более 5 г
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
1 oz or cannabis or equivalent in cannabis products	1 унция каннабиса или эквивалентное количество продуктов каннабиса
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Flower is capped at 30% THC and concentrates cannot exceed 60% THC. Edibles have a 50 mg limit per package, 5 mg per serving.	Соцветия имеют ограничение в 30% ТГК, а в концентратах не может содержаться более 60% ТГК. Для пищевых продуктов действует ограничение в 50 мг на упаковку, 5 мг на порцию.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed	По лицензии
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed	По лицензии
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Edibles can have up to 50 mg of THC with serving of no more than 5 mg of THC each.	Пищевые продукты могут содержать до 50 мг ТГК, при этом в каждой порции должно быть не более 5 мг ТГК.
Advertising	Реклама
Advertising could not be deceptive, promote overconsumption, offer free samples, or be appealing to minors. Advertising would only be allowed where the licensee can reasonably expect no more than 15% of viewers will be under 21.	Реклама не может вводить в заблуждение, способствовать чрезмерному потреблению, предлагать бесплатные образцы или быть привлекательной для несовершеннолетних. Реклама разрешена только там, где лицензированный предприниматель имеет все основания полагать, что доля зрителей моложе 21 года не будет превышать 15%.
Taxation	Налогообложение

14% of sales price of retail sale	14% от розничной цены
On site consumption	Потребление на месте продажи
Maybe allowed	Может быть разрешено
Restrictions on used	Ограничения в отношении потребления
Use is limited to individual dwellings. Prohibited in street, alley, park or sidewalk in addition to usual smoke free-places.	Пользование ограничено индивидуальными домовладениями. Запрещено на улице, на пешеходной дорожке, в парке или на тротуаре в дополнение к обычным местам, где запрещено курение.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Department of health reviews application of qualifying patients diagnosed with qualifying conditions; Department of health verifies the condition with the physician.	Департамент здравоохранения рассматривает заявления пациентов с диагнозом, отвечающим соответствующим критериям; Департамент здравоохранения получает подтверждение диагноза пациента от его лечащего врача.
Virginia	Виргиния
Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
SB 1406 Marijuana; legalization of simple possession Signed by Governor on 7 April 2021	Законопроект 1406 сената штата о марихуане, легализации хранения в личных целях. Подписан губернатором 7 апреля 2021 года.
Date passed	Дата принятия
April 2021	Апрель 2021 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
Effective July 2021; Bill provisions are subject to re-enactment by the 2022 Session of the state General Assembly. Sales beginning and regulations taking effect on 1 January 2024.	Вступившие в силу в июле 2021 года положения законопроекта подлежат повторному принятию на сессии Генеральной ассамблеи штата в 2022 году. Начало торговли и вступление в силу нормативных положений с 1 января 2024 года.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Virginia Cannabis Control Authority Cannabis Oversight Commission; Cannabis Public Health Advisory Council Cannabis Equity Reinvestment Board and Fund, and Virginia Cannabis Equity Business Loan Program and Fund	Комиссия по надзору за оборотом каннабиса Управления по контролю за оборотом каннабиса штата Виргиния; Консультативный совет по общественному здравоохранению в области каннабиса, Совет и фонд по реинвестированию капитала в области каннабиса, Программа и фонд штата Виргиния по кредитованию бизнеса в форме участия в акционерном капитале в области каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
28.5 (1 oz) or less	Не более 28,5 г (1 унция)
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях

Up to 4 plants for personal use per household. The plants should be kept away from public view, and each one should have a legible tag with owner's ID.	До 4 растений для личного пользования на домохозяйство. Растения следует содержать вдали от посторонних глаз, и каждое из них необходимо снабдить ярлыком с разборчивыми идентификационными данными владельца.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Yes, same as personal limit	Разрешено в тех же пределах, что и для хранения в личных целях.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
28.5 g (1 oz) or equivalent	28,5 г (1 унция) или эквивалентное количество
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market with limitation	Рыночная с ограничениями
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not specified	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Number of licences not to exceed: a) Marijuana manufacturing facilities, 60; and b) Marijuana cultivation facilities, 450	Максимальное количество лицензий: а) для предприятий по производству продуктов марихуаны — 60; б) для предприятий по выращиванию марихуаны — 450
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Number of licences issued shall not exceed the following limits: a) Retail cannabis stores, 400; b) Cannabis wholesalers, 25	Количество выдаваемых лицензий не должно превышать следующие лимиты: а) для магазинов розничной торговли марихуаной — 400; б) для предприятий оптовой торговли марихуаной — 25
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Not to contain more than 5 mg of THC per serving of the product; and shall not contain more than 50 mg of THC per package of the product.	Не должны содержать более 5 мг ТГК на порцию продукта и более 50 мг ТГК на упаковку продукта.
Advertising	Реклама
Board to regulate reasonable restrictions on advertising and promotion of products.	Совет должен регулировать применение разумных ограничений на рекламу и продвижение продуктов каннабиса.
Taxation	Налогообложение
21% retail sale tax. 3% local option sale tax may apply depending on the area.	Налог на розничные продажи 21% В зависимости от района по усмотрению властей может применяться местный налог на продажу в размере 3%.
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not specified	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public use of cannabis will be prohibited.	Потребление каннабиса в общественных местах будет запрещено.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
2020: Registration is based on certification from a practitioner for specified conditions.	2020 год: регистрация осуществляется на основании заключения практикующего врача с подтверждением указанных заболеваний.
Washington	Вашингтон

Legal process	Юридический процесс
Voter initiative, state statute	Инициатива избирателей, закон штата
Title	Наименование
Initiative 502	Инициатива 502
Date passed	Дата принятия
November 2012	Ноябрь 2012 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
December 2012: Personal possession, consumption July 2014: Retail sales.	Декабрь 2012 года: хранение, потребление в личных целях Июль 2014 года: розничная торговля.
Regulatory authority	Регулирующий орган
Liquor and Cannabis Board (formerly the Liquor Control Board)	Совет по крепким спиртным напитками и каннабису (ранее Совет по контролю крепких спиртных напитков)
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quality	Количество для хранения в личных целях
Flower 1 oz (28.35 g) Concentrates; 7 g Edibles 16 oz (454 g) Infused liquid 72 fl oz (2.13 l)	1 унция соцветий (28,35 г) 7 г концентратов 16 унций (454 г) пищевых продуктов 72 жидкие унции (2,13 л) с каннабисом
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Not allowed	Запрещено
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Not allowed	Не разрешается
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
28.5 g	28,5 г
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not set initially	Изначально не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed cannabis producers	Лицензированные производители каннабиса
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Cannabis can only be sold and purchased at state-licensed retail stores.	Продажа и приобретение каннабиса разрешаются только в магазинах розничной торговли с лицензией штата.
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
10 mg of THC in each individually packaged serving; child-proof packaging; THC labelling; marijuana-infused products, packages and labels to be approved by the State Liquor Control Board before sale.	Содержание ТГК в каждой отдельно расфасованной порции не должно превышать 10 мг; упаковка должна быть защищена от случайного вскрытия детьми; информация о содержании ТГК должна отражаться на этикетке; продукты, содержащие марихуану, упаковки и этикетки

	подлежат предпродажному одобрению Советом штата по контролю крепких напитков.
Advertising	Реклама
Cannabis business licensees are limited to two permanent signs on their licensed premises, and all other forms of outdoor advertisements on the premises are banned. New rules mandated that billboards and signs can no longer contain images of the cannabis plant or cannabis products. Cannot contain depictions of cartoon characters or any depictions that may be appealing to children.	Предприятия, имеющие лицензию на деятельность, связанную с каннабисом, имеют право размещать в своих лицензированных помещениях не более двух постоянных вывесок, все прочие виды наружной рекламы на этих объектах запрещены. Новые нормы более не допускают размещения на рекламных щитах и вывесках изображений растений или продуктов каннабиса. Не допускается размещение изображений мультипликационных персонажей или любых других изображений, которые могут быть привлекательными для детей.
Taxation	Налогообложение
37% cannabis excise tax; 6.5 state sales tax. Sales Tax: 7.0–10.4% (Option to apply existing local sales taxes (0.5–3.1%)).	Акцизный налог на каннабис 37%; налог штата с продаж 6,5%. Налог с продаж: 7,0–10,4% (возможно применение налогов с продаж, установленных местными органами (0,5–3,1%)).
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not allowed	Не разрешается
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
It is illegal to consume cannabis in view of the public.	Потребление каннабиса в общественных местах запрещено законом.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
1999/2010/2011: no registration or identification card; dispensaries approved as of November 2012, first stores opened in July 2014; 1999 possession; 2012 home cultivation.	1999/2010/2011 годы: отсутствие реестра или идентификационной карты; деятельность пунктов отпуска одобрена в ноябре 2012 года; первые магазины открылись в июле 2014 года. 1999 год: хранение. 2012 год: культивирование в домашних условиях.
Maryland	Мэриленд
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Question 4	Вопрос 4
Date passed	Дата принятия
9 November 2022	9 ноября 2022 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
The law takes effect on July 1 2023	Закон вступает в силу 1 июля 2023 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Natalie M. LaPrade Medical Cannabis Commission	Комиссия по медицинскому каннабису им. Натали М. Лапрейд
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях

1.5 oz of cannabis and 12 g of concentrates	1,5 унции каннабиса или 12 г концентратов
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Up to 2 plants at home, out of the public view	До 2 растений на домохозяйство и вдали от посторонних глаз
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Allowed if there is no remuneration or transfer in conjunction with sale of goods or services	Разрешается при условии отсутствия вознаграждения или передачи в связи с продажей товаров или услуг
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Retail sales regulations pending	Нормативные положения, регламентирующие розничную торговлю, находятся на рассмотрении
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Retail sales regulations pending	Нормативные положения, регламентирующие розничную торговлю, находятся на рассмотрении
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
750 mg	750 мг
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
To be decided	Будут установлены позднее
Advertising	Реклама
Regulations pending	Нормативные положения находятся на рассмотрении
Taxation	Налогообложение
Regulations pending	Нормативные положения находятся на рассмотрении
On site consumption	Потребление на месте продажи
Not stated	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public smoking prohibited	Запрещено курение в общественных местах
Medical cannabis	Медицинский каннабис
In April 2014, Hourse Bill 881 was signed, taking effect on 1 June 2014, which created a medical marijuana infrastructure. On 1 December 2017, the medical marijuana program officially began.	В апреле 2014 года был подписан законопроект 881, который вступил в силу 1 июня 2014 года и предусматривает создание инфраструктуры для отпуска медицинской марихуаны. 1 декабря 2017 года официально началась реализация программы по медицинской марихуане.
Missouri	Миссури
Legal process	Юридический процесс
Voter initiative	Инициатива избирателей
Title	Название
Amendment 3	Поправка 3
Date passed	Дата принятия

9 November 2022	9 ноября 2022 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
8 December 2022	8 декабря 2022 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Missouri Department of Health & Senior Services	Департамент здравоохранения и обслуживания престарелых штата Миссури
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
3 oz of cannabis flower or equivalent	3 унции соцветий каннабиса или эквивалентное количество
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
With a personal cultivation card, one can grow up to 6 flowering plants and up to 18 non-mature plants, in an enclosed and locked facility at home.	При наличии карты лица, занимающегося культивированием в личных целях, можно выращивать до 6 цветущих и до 18 незрелых растений в закрытом и запираемом помещении.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Presumably the same as personal possession limit	Предположительно в тех же пределах, что и для хранения в личных целях
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Retail sales regulations pending	Нормативные положения, регламентирующие розничную торговлю, находятся на рассмотрении
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Retail sales regulations pending	Нормативные положения, регламентирующие розничную торговлю, находятся на рассмотрении
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Regulations pending	Нормативные положения находятся на рассмотрении
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Microbusiness license forms will start to be reviewed by September 2023.	Формы для лицензирования микропредприятий будут рассмотрены к сентябрю 2023 года.
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Prohibited to sell edibles in shapes or packages that are attractive to children or easily confused for non-cannabis candies.	Запрещается продавать пищевые продукты, форма или упаковка которых являются привлекательными для детей, или очень напоминающие конфеты без содержания каннабиса.
Advertising	Реклама
Regulations pending	Нормативные положения находятся на рассмотрении
Taxation	Налогообложение
6% sales tax on cannabis sales	6%-ный налог на продажу каннабиса

On site consumption	Потребление на месте продажи
Not stated	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public smoking prohibited	Запрещено курение в общественных местах
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Medical cannabis dispensaries can transition to recreational sales from 6 February 2023. When possessing a medical card, one will be exempt from sales tax, and able to purchase higher THC cannabis.	С 6 февраля 2023 года пункты отпуска медицинского каннабиса могут перейти к продаже каннабиса для употребления в рекреационных целях. Лица, имеющие медицинскую карту, будут освобождены от налога с продаж и смогут приобретать каннабис с более высоким содержанием ТГК.
Rhode Island	Род-Айленд
Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
The Rhode Island Cannabis Act	Закон о каннабисе штата Род-Айленд
Date passed	Дата принятия
25 May 2022	25 мая 2022 год
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
25 May 2022	25 мая 2022 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Rhode Island Cannabis Control Commission (appointment pending)	Комиссия штата Род-Айленд по контролю над каннабисом (решение о назначениях еще не принято)
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
Possess or purchase up to 1 oz Possess up to 10 oz at home Possess up to 5 gm of concentrates	Хранение или приобретение: до 1 унции Хранение в доме: до 10 унций Хранение концентратов: до 5 гм
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Cultivate up to 3 mature plants along with 3 immature plants	Выращивание до 3 зрелых растений наряду с 3 незрелыми растениями
Interpersonal sharing	Совместное пользование
1 oz of cannabis flower or equivalent, as long as transfer is not advertised or promoted to the public	1 унция соцветий каннабиса или эквивалентное количество при условии неразмещения объявлений или публичных предложений в отношении передачи
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
Public: 1 oz Home: 10 oz	В общественных местах: 1 унция В домашних условиях: 10 унций
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
-	-
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
-	-

Registration requirements	Требования в отношении регистрации
-	-
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments; Licenced “hybrid cannabis retailers”; Compassion centres	Лицензированные заведения; лицензированные «гибридные розничные пункты по продаже каннабиса»; центры сострадания
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
None	Отсутствуют
Advertising	Реклама
A city or town can adopt ordinances governing advertisement.	В городе или поселке могут быть приняты постановления, регулирующие рекламу.
Taxation	Налогообложение
Retail excise tax 10%; 3% local sales tax; 7% normal sales tax rate	Акцизный налог 10% с розничных продаж; местный налог 3% на продажу; обычная ставка налога на продажу — 7%
On site consumption	Потребление на месте продажи
To be decided	Решение будет принято позднее
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public smoking prohibited in places where tobacco smoking is prohibited	Не допускается курение в общественных местах, где запрещено табакокурение
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Licensed medical cannabis cultivators, as of 1 August 2022, can cultivate cannabis for adult use. As of 1 December 2022, these hybrid cannabis retailers can sell adult use cannabis.	По состоянию на 1 августа 2022 года растениеводы, имеющие лицензию на культивирование медицинского каннабиса, могут выращивать каннабис для употребления совершеннолетними. По состоянию на 1 декабря 2022 года данные гибридные розничные пункты по продаже каннабиса могут продавать совершеннолетним каннабис для употребления.
Guam	Гуам
Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
The Guam Cannabis Industries Act	Закон Гуама об индустрии каннабиса
Date passed	Дата принятия
4 April 2019	4 апреля 2019 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
4 April 2019	4 апреля 2019 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
Cannabis Control Board	Совет по контролю над каннабисом
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют

Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
1 oz of cannabis flower, 8 g of cannabis concentrate	1 унция соцветий каннабиса, 8 г концентратов каннабиса
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
6 plants at home in a fully enclosed, locked facility	6 растений на домохозяйство в полностью закрытом и запираемом помещении
Interpersonal sharing	Совместное пользование
1 oz or equivalent if there is no remuneration	1 унция или эквивалентное количество при условии отсутствия вознаграждения
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
1 oz of cannabis flower, 8 grams of cannabis concentrate	1 унция соцветий каннабиса, 8 г концентратов каннабиса
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
800 mg	800 мг
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
Special packaging requirements for edibles, including specific colour requirements.	Особые требования к упаковке пищевых продуктов, включая требования в отношении использования определенных цветов.
Advertising	Реклама
Advertising must not promote over consumption, represent curative or therapeutic effects of cannabis, depict children or present images that may appeal to children.	Реклама не должна поощрять чрезмерное потребление, представлять информацию о целебном или терапевтическом действии каннабиса, изображать детей или содержать изображения, которые могут быть привлекательными для детей.
Taxation	Налогообложение
15 % excise tax	Акцизный налог 15 %
On-site consumption	Потребление на месте продажи
Not stated	Не предусмотрено
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public smoking prohibited	Запрещено курение в общественных местах
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Proposal 14-A (now, the Joaquin (KC) Concepcion II Compassionate Cannabis Use Act) was passed via voter initiative in 2014, making cannabis available for qualifying patients for medical use.	Предложение 14-А (в настоящее время — Закон Хоакина (КС) Консепсьона II о потреблении каннабиса по гуманным соображениям) было принято посредством инициативы избирателей в 2014 году, что обеспечило доступность каннабиса для пациентов, имеющих право употреблять его в медицинских целях.
Northern Mariana Islands	Северные Марианские Острова

Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
The Taulamwaar Sensible CNMI Cannabis Act	Закон Содружества Северных Марианских Островов о каннабисе (Закон Тауламваара Мудрого)
Date passed	Дата принятия
21 August 2019	21 августа 2019 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
21 August 2019	21 августа 2019 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
CNMI Cannabis Commission	Комиссия по каннабису Содружества Северных Марианских Островов
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
1 ounce of cannabis flower, 5 g of concentrate	1 унция соцветий каннабиса, 5 г концентрата
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
If on the homegrown cannabis registry, one can grow up to 6 plants in a locked, secure place, and keep no more than 8 oz of useable cannabis at a time.	Лицам, внесенным в реестр производителей каннабиса, разрешается одновременно выращивать в домашних условиях до 6 растений в запечатанном и защищенном месте и хранить не более 8 унций пригодного к употреблению каннабиса.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Same as personal possession limit. Allowed if for noncommercial purposes.	В тех же пределах, что и для владения в личных целях. Разрешено в некоммерческих целях.
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
1 ounce of cannabis flower, 5 g of concentrate	1 унция соцветий каннабиса, 5 г концентрата
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
Not stated	Не установлено
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
None	Отсутствуют
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
None	Отсутствуют
Advertising	Реклама
Advertising must not be attractive to minors.	Реклама не должна быть привлекательной для несовершеннолетних.
Taxation	Налогообложение

10% excise tax	Акцизный налог 10%
On-site consumption	Потребление на месте продажи
Permitted for establishments registered as marijuana lounges. Class 1 and Class 2 lounges are subject to different requirements and have different privileges.	Разрешается в заведениях, зарегистрированных в качестве марихуановых салонов. К салонам класса 1 и класса 2 предъявляются разные требования и предоставляются разные льготы.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Public smoking prohibited	Запрещено курение в общественных местах
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Medical cannabis made legal alongside recreation cannabis use per the Taulamwaar Sensible CNMI Cannabis Act. Personal possession and growing limits are looser for medical patients.	В соответствии с Законом Северных Марианских Островов о каннабисе (Закон Тауламваара Мудрого) использование каннабиса в медицинских целях является таким же законным, как и его употребление в рекреационных целях. Для пациентов медицинских учреждений установлены менее жесткие лимиты на хранение и выращивание в личных целях.
Virgin Islands	Виргинские острова
Legal process	Юридический процесс
Legislative	Законодательный
Title	Наименование
The Virgin Islands Cannabis Use Act	Закон Виргинских островов об употреблении каннабиса
Date passed	Дата принятия
30 December 2022	30 декабря 2022 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
18 January 2023	18 января 2023 года
Regulatory authority	Регулирующий орган
USVI Office of Cannabis Regulations	Управление Виргинских островов Соединенных Штатов по регулированию оборота каннабиса
Minimum age	Минимальный возраст
21	21 год
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
None	Отсутствуют
Personal possession quantity	Количество для хранения в личных целях
2 oz of flowers, 14 g of concentrate and 1 oz of edibles	2 унции соцветий, 14 г концентрированных продуктов и 1 унция пищевых продуктов
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
No more than 6 flowering plants and 6 immature plants per household, “with the express consent of the landowner”	Не более 6 цветущих растений и 6 незрелых растений на домохозяйство при наличии «прямо выраженного согласия домовладельца»
Interpersonal sharing	Совместное пользование
-	-
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
-	-
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Market	Рыночная
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК

100 mg of THC per unit of sale for edibles	100 мг ТГК на отдельно расфасованную порцию пищевого продукта, предназначенную для продажи потребителю
Registration requirements	Требования в отношении регистрации
Non-residents to pay cannabis fee.	Нерезиденты оплачивают сбор при покупке каннабиса.
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed establishments	Лицензированные заведения
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
No more than 10 mg of THC per unit of sale.	Не более 10 мг ТГК на отдельно расфасованную порцию, предназначенную для продажи потребителю.
Advertising	Реклама
Must be within restrictions and cannot target minors	Должна соответствовать ограничениям и не должна быть направлена на несовершеннолетних
Taxation	Налогообложение
18% sale tax	Налог на продажу 18%
On-site consumption	Потребление на месте продажи
Adult use lounges	Салоны для употребления для взрослых
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Must hold a permit	Необходимо наличие разрешения
Medical cannabis	Медицинский каннабис
Patient registry, state-licensed dispensaries, caregivers must be registered, up to 4 oz of cannabis flower.	Реестр пациентов; пункты отпуска, имеющие лицензию штата; лица, осуществляющие уход, должны быть зарегистрированы; до 4 унций соцветий каннабиса.

ТАБЛИЦА 5 Нормативные положения в отношении легализации потребления каннабиса в немедицинских целях в Уругвае

Uruguay	Уругвай
Legal process	Юридический процесс
Government initiative, national law	Инициатива правительства, национальное законодательство
Title	Название
Law No. 19.172	Закон № 19.172
Date passed	Дата принятия
December 2012	Декабрь 2012 года
Date implemented/required date of rule adoption	Дата введения в действие/требуемая дата принятия нормы
August 2014: Personal cultivation October 2014: Grower clubs Mid-2017: Pharmacy sales	Август 2014 года: культивирование в личных целях Октябрь 2014 года: объединения лиц, выращивающих каннабис Середина 2017 года: продажи через аптеки
Regulatory authority	Регулирующий орган
Institute for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA)	Институт по регулированию и контролю в области каннабиса (ИРКК)
Minimum age	Минимальный возраст
18	18 лет
Residency requirement	Требования в отношении места проживания
Uruguayan citizenship or permanent Uruguayan residency required	Уругвайское гражданство или постоянное проживание в Уругвае
Personal possession limit	Лимит количества для хранения в личных целях
Individuals can purchase up to 40 g per month; according to subsequent regulations, the limit is 10 g per week.	Физические лица могут приобрести до 40 г в месяц; согласно принятым в дальнейшем правилам, лимит составляет 10 г в неделю.
Home cultivation	Культивирование в домашних условиях
Six plants in flower. These plants are not allowed to yield more than 480 g of marijuana per year.	6 цветущих растений. Урожай с этих растений должен составлять не более 480 г марихуаны в год.
Interpersonal sharing	Совместное пользование
Allowed within the home	Разрешается в пределах домовладения
Retail transaction limit	Лимит на размер розничных сделок
40 g per month, 10 g per week (sale through pharmacies to registered users)	40 г в месяц, 10 г в неделю (продажа через аптеки зарегистрированным пользователям)
Retail pricing structure	Структура формирования розничных цен
Government price control	Контроль над ценами со стороны государства
Average retail price per gram after tax	Средняя розничная цена за грамм за вычетом налогов
265 Uruguayan pesos per 5 g (approx. \$1.2 per gram)	265 уругвайских песо за 5 г (примерно 1,2 долл. США за грамм)
Maximum THC content	Максимальное содержание ТГК
All products are required to indicate that CBD is equal to or more than 3% and THC is equal to or less than 9%.	В маркировке всех продуктов должно быть указано, что содержание КБД составляет не менее 3%, а ТГК — не более 9%.
Registration requirements	Требования в отношении регистрации

With IRCCA for any of the three modes of access	Регистрация в ИРКК для любого из трех видов доступа
Commercial production	Коммерческое производство
Licensed producers	Лицензированные производители
Commercial distribution	Коммерческое распространение
Licensed pharmacies	Лицензированные аптеки
Restrictions on edibles	Ограничения в отношении пищевых продуктов с каннабисом
-	-
Advertising	Реклама
Prohibited	Запрещена
Taxation	Налогообложение
No tax, although IRCCA can impose tax in the future.	Налог не взимается, хотя ИРКК может в будущем ввести такой налог.
Cannabis clubs	Клубы сторонников каннабиса
Clubs with 15–45 members allowed to cultivate up to 99 plants; maximum 480 g of dried product per member per year.	Клубам с членским составом 15–45 человек разрешено выращивать до 99 растений, с получением максимум 480 г сухого продукта на каждого члена в год.
Restrictions on use	Ограничения в отношении потребления
Uruguay's cannabis law forbids cannabis use in indoor public spaces where tobacco use is prohibited.	Законодательство Уругвая о каннабисе запрещает потребление каннабиса в закрытых общественных местах, где запрещено употребление табака.
Medical cannabis	Медицинский каннабис
In 2013: Passed (Law 19.172). Decree N° 46/015. Oils under prescription (CBD) and cosmetics with CBD currently for sale in pharmacies.	В 2013 году: принят (Закон 19.172). Указ № 46/015. В настоящее время в аптеках продаются масла по рецепту (КБД) и косметика с КБД.

В контексте решения мировой проблемы наркотиков в настоящей главе предлагается разработать подход, обеспечивающий рамки для изучения вопроса о праве на здоровье лиц, употребляющих наркотики, а также их детей, других членов семей и общин, которых коснулась проблема наркопотребления. Право на здоровье закреплено в целом ряде международных документов по правам человека^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года также предусматривает построение мира с равным и всеобщим доступом к здравоохранению и социальной защите, в котором будет обеспечено физическое, психическое и социальное благополучие.

В этой главе будут рассмотрены потенциальные составные элементы процесса разработки такого подхода на основе концепции права на здоровье в соответствии с определениями, приведенными в каждом из международных документов, и толкованием Комитета по экономическим, социальным и культурным правам⁸.

Введение

Право на здоровье — это международно признанное основополагающее право человека. Каждый человек имеет право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, включая полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов^{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}.

Право на здоровье признано и закреплено в международных документах по правам человека, которые представляют собой имеющие обязательную юридическую силу обязательства государств, являющихся их участниками. «Забота о здоровье и благополучии человечества» также является основополагающей целью международных конвенций о контроле над наркотиками и фигурирует в преамбуле *Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками*, внесенными Протоколом 1972 года¹⁷, и в *Конвенции о психотропных веществах 1971 года*¹⁸. Употребление наркотиков может иметь неблагоприятные последствия для здоровья наркопотребителей. Это могут быть как прямые последствия для здоровья, такие как расстройства на почве употребления наркотиков, так и косвенные последствия, связанные с формами сопряженного с риском поведения, в частности инфекции, передающиеся через кровь, или передозировка. Кроме того, дети и члены семьи употребляющего наркотики также могут страдать от соответствующих медицинских и социальных последствий. Лица, употребляющие наркотики, также могут сталкиваться с препятствиями, которые влияют на их доступ к услугам, связанным с другими проблемами со здоровьем. При рассмотрении вопроса обеспечения права на здоровье в контексте проблемы наркопотребления, затрагивающей многих участников, необходимо учитывать права не только лиц, употребляющих наркотики, но и их детей, других членов семьи и общин.

Право на здоровье в контексте наркопотребления

Вопрос осуществления права на здоровье в равной степени относится к лицам, употребляющим наркотики, их детям и другим членам семьи, а также к людям в их общинах. Право на здоровье является неотъемлемым правом всех людей, независимо от того, употребляет ли человек наркотики^{19, 20, 21, 22, 23}, находится ли он в местах лишения свободы, под стражей или в заключении²⁴.

Осуществление права на здоровье лиц, употребляющих наркотики, подразумевает наличие научно обоснованных медицинских услуг и программ, доступных и приемлемых для удовлетворения всех их потребностей в области физического и психического здоровья (независимо от того, связаны они с наркопотреблением или нет) без какой-либо стигматизации или дискриминации, а также создание условий, позволяющих реализовать наркопотребителям свое право на наивысший достижимый уровень здоровья. Лица, употребляющие наркотики, также имеют право на неприкосновенность

частной жизни и конфиденциальность информации о своем здоровье, на телесную автономию и на информированное согласие.

Право на здоровье соответствует международным документам по правам человека и общей цели международных конвенций по наркотикам в отношении «здоровья и благополучия человечества». Цель осуществления права на здоровье, сформулированная в данной главе, не препятствует достижению целей сокращения незаконного предложения наркотиков и спроса на них, и не противоречит им, а также функционированию международной системы контроля над наркотиками. На самом деле действия по всем этим направлениям одновременно могут стать частью всеобъемлющих и сбалансированных усилий по решению мировой проблемы наркотиков.

Осуществлению права людей на здоровье могут препятствовать многие факторы. Некоторые из этих сдерживающих факторов обусловлены, во-первых, самой наркоситуацией (расстройства на почве употребления наркотиков), во-вторых, — бытующими в обществе установками и мнениями (стигматизация и дискриминация), в-третьих, — сложностями в плане финансирования или перекосами в распределении ресурсов, а в-четвертых, — законами и нормативно-правовыми актами, связанными с наркотиками.

К таким препятствиям можно отнести:

- > наличие факторов, способствующих наркопотреблению и развитию расстройств на почве употребления наркотиков: отсутствие связей с семьей или общиной, нестабильность, отсутствие безопасности, травмы, ненадлежащее или халатное выполнение родителями своих обязанностей, социальные нормы, употребление наркотиков сверстниками или родственниками, проблемы с психическим здоровьем, конфликты, насилие и употребление других психоактивных веществ (например, алкоголя и табака)²⁵.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА

Что такое право на здоровье?

Государства — участники *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах* согласно статье 12 признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья^a. В понятии поступательного обеспечения реализации «наивысшего достижимого уровня здоровья» учитываются как биологическое состояние человека и его социально-экономическое положение, так и имеющиеся в распоряжении государства ресурсы.

Право на здоровье — это всеобъемлющее право, включающее в себя не только право на своевременные и адекватные услуги в области здравоохранения, но и на основополагающие предпосылки здоровья, а также доступ к просвещению и информации в области здоровья. Еще одним важным аспектом является участие населения в принятии решений по всем связанным со здоровьем вопросам на общинном, национальном и международном уровнях.

Право на здоровье не следует понимать как право быть здоровым. Государство не может обеспечить хорошее здоровье или защитить человека от всех возможных причин ухудшения здоровья. Так, генетические факторы, индивидуальная предрасположенность к заболеваниям и избрание людьми нездорового или опасного образа жизни могут существенно повлиять на здоровье человека. Следовательно, право на здоровье понимается как право на использование целого ряда учреждений, товаров, услуг и условий, необходимых для достижения наивысшего достижимого уровня здоровья.

Право на здоровье включает как свободы, так и смежные права:

- > К свободам относятся право на контроль за своим здоровьем и телом — право быть свободным от всякого вмешательства, например право быть свободным от пыток и не подвергаться без свободного согласия медицинским или научным опытам.

- > К смежным правам относится право на систему здравоохранения, обеспечивающую людям равные возможности в стремлении к наивысшему достижимому уровню здоровья.

Право на здоровье включает в себя широкий спектр социально-экономических факторов, создающих условия, при которых люди могут жить здоровой жизнью, а также основополагающие предпосылки здоровья, такие как доступ к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным услугам, достаточное снабжение безопасным продовольствием, питание и жилищные условия, безопасные условия труда и окружающей среды. Право на здоровье содержит следующие взаимосвязанные основные элементы:

- i) *наличие*. Количество функционирующих учреждений, товаров и услуг в сфере здравоохранения и медицинской помощи, а также соответствующих программ должно быть достаточным;
- ii) *доступность*. Учреждения, товары и услуги здравоохранения должны быть доступны каждому человеку без какой бы то ни было дискриминации;
- iii) доступность имеет четыре взаимосвязанных аспекта:
 - a) недискриминация — гарантированная доступность, особенно для наиболее уязвимых или социально отчужденных слоев населения;
 - b) физическая доступность — учреждения, товары и услуги здравоохранения должны находиться в физической досягаемости для всех;
 - c) экономическая доступность — гарантированная с точки зрения расходов доступность для всех, включая социально отчужденные группы населения. Схемы оплаты медицинской помощи, а также услуг, связанных с обеспечением основополагающих предпосылок здоровья, должны основываться на принципе справедливости;
 - d) доступность информации — информация и идеи, касающиеся вопросов здоровья, должны быть доступны для поиска, получения и распространения;
- iv) *приемлемость*. Все учреждения, товары и услуги здравоохранения должны соответствовать принципам медицинской этики и культурным критериям, то есть культуре отдельных лиц, меньшинств, народов и общин, учитывать требования в отношении гендерной проблематики и жизненного уклада, а также быть направленными на сохранение конфиденциальности и улучшение состояния здоровья соответствующих лиц;
- v) *качество*. Товары и услуги должны быть приемлемыми с научной и медицинской точек зрения и характеризоваться высоким качеством.

^a Право на здоровье признается в нескольких международных договорах, но в основе текста в данной вставке лежит следующий документ: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)», замечание общего порядка №14, двадцать вторая сессия, пункт 3 повестки дня (Женева: Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, май 2000 года).

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА

Право всех людей, их семей и общин на здоровье

Наркопотребление может негативно сказываться на семьях и общине в целом. Защита права на здоровье лиц, употребляющих наркотики, членов их семей и общин предусматривает наличие подхода, основанного на уважении и улучшении благополучия каждого человека без какой-либо стигматизации и дискриминации.

Во *Всеобщей декларации прав человека*^a и *Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах*^b, которые в совокупности с *Международным пактом о гражданских и политических*

правах^с составляют *Международный билль о правах человека*, а также в других основных конвенциях, договорах и декларациях Организации Объединенных Наций признается право на здоровье каждого человека и, в частности, право на здоровье конкретных групп, таких как коренные народы^д, меньшинства, лица, подвергающиеся расовой дискриминации^е, женщины^ф, дети^с и инвалиды^г.

В международных документах подчеркивается важность обеспечения наличия и доступа к медицинским услугам, профилактики заболеваний, санитарного просвещения и мер по учету социальных детерминант здоровья для осуществления права на здоровье населения во всем мире.

Правами, изложенными в международных документах по правам человека, должны пользоваться все на равноправной основе^h. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьиⁱ.

В преамбуле *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах* государства-участники признают, что у людей имеются обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому они принадлежат, и что они должны добиваться поощрения и соблюдения различных прав, включая право на здоровье, признаваемых в пакте^h.

^a Организация Объединенных Наций, *Всеобщая декларация прав человека*, резолюция 217А Генеральной Ассамблеи (Париж, 10 декабря 1948 года).

^b Организация Объединенных Наций, *Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах*, резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи (1966 год); вступил в силу 3 января 1976 года в соответствии со статьей 27.

^c Организация Объединенных Наций, *Международный пакт о гражданских и политических правах*, резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи (1966 год); вступил в силу 23 марта 1976 года в соответствии со статьей 49.

^d Организация Объединенных Наций, *Декларация о правах коренных народов*, резолюция 295А (LXI) Генеральной Ассамблеи (2007 год).

^e Организация Объединенных Наций, *Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации*, резолюция 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи (1965 год); вступила в силу 4 января 1969 года в соответствии со статьей 19.

^f Организация Объединенных Наций, *Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин*, резолюция 34 (180) Генеральной Ассамблеи (1979 год); вступила в силу 3 сентября 1981 года в соответствии с пунктом 1 статьи 27.

^g Организация Объединенных Наций, *Конвенция о правах инвалидов*, резолюция 106А (LXI) Генеральной Ассамблеи (2006 год).

^h Организация Объединенных Наций, *Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах*, статья 3, резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи (1966 год); вступил в силу 3 января 1976 года в соответствии со статьей 27.

ⁱ Организация Объединенных Наций, *Всеобщая декларация прав человека*, статья 25, резолюция 217А Генеральной Ассамблеи (Париж, 10 декабря 1948 года).

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

- > Отсутствие доступных, недорогих и приемлемых профилактических мероприятий, разработанных на основе фактических данных и с учетом возраста и гендерной идентичности²⁶.
- > Отсутствие доступа к основным лекарственным средствам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, для лечения наркологических и психических расстройств, обезболивания и оказания паллиативной помощи²⁷.

- > Наркоситуация, доступность наркотиков, высокие показатели расстройств, передозировки и смертности на почве наркопотребления.
- > Отсутствие доступных, недорогих, соответствующих возрасту и гендерной идентичности, научно обоснованных услуг по оказанию лечебной помощи и уходу при расстройствах на почве употребления наркотиков²⁸. В 2022 году во всем мире наркологическую помощь получал только 1 из 10 человек с расстройствами на почве употребления наркотиков²⁹. Услуги по оказанию наркологической помощи зачастую не являются частью усилий по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и не интегрированы в системы медицинского обслуживания³⁰.
- > Отсутствие доступных, недорогих, соответствующих возрасту и гендерной идентичности, научно обоснованных мероприятий по профилактике пагубных медико-социальных последствий расстройств на почве употребления наркотиков³¹ и лечению в случаях передозировки.
- > Неэтичные стандарты оказания услуг по оказанию наркологической помощи и уходу при проведении лечебных мероприятий, которые не основаны на научных данных, включая недобровольное или принудительное лечение наркомании или лечение, ориентированное только на абстиненцию³².
- > Стигматизация и дискриминация лиц, употребляющих наркотики и испытывающих страх перед правовыми санкциями или сталкивающиеся с угрозами их применения, что особенно актуально для групп населения с особыми потребностями, в частности для женщин, групп, находящихся в уязвимом положении, и лиц, живущих с ВИЧ, и увеличивает причиняемый им вред, а также препятствует их доступу к наркологической помощи и мерам, направленным на сведение к минимуму или предотвращению неблагоприятных медицинских и социальных последствий наркопотребления^{33, 34}.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА

Защита прав детей, подверженных риску приобщения к наркопотреблению

Конвенция о правах ребенка обязывает государства принимать все необходимые меры, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических средств. Каждый ребенок имеет право на такую заботу и защиту, которые необходимы для его благополучия, в том числе если родители ребенка употребляют наркотики или страдают расстройством на почве употребления наркотиков. В конвенции подтверждается особая роль семьи для оптимального развития ребенка и предусматривается обязательство об оказании родителям помощи в выполнении ими своих обязанностей по уходу за детьми, когда это необходимо^a.

Если у детей есть родители, употребляющие наркотики, важно отметить, что наркопотребление или расстройства на почве употребления наркотиков сами по себе не являются признаками жестокого обращения или отсутствия заботы. Это не должно быть причиной для уведомления властей.

Дети или члены семьи лиц, страдающих расстройством на почве употребления наркотиков, могут сталкиваться с такими негативными последствиями, как отсутствие заботы, ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и насилие. Эти последствия могут быть обусловлены не только наркопотреблением, но и целым рядом структурных факторов. Во всех случаях главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. Согласно *Конвенции о правах ребенка*^a, ребенок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их желанию и может быть лишен родительской опеки только в том случае, если компетентные органы, согласно судебному решению, определяют, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка^a, например в случае жестокого обращения или отсутствия заботы со стороны родителей или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами^c, первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка^b.

В Международных руководящих указаниях по альтернативному уходу за детьми говорится о том, что «государствам следует стремиться обеспечить надлежащие и культурно обусловленные меры, призванные ... оказать помощь в ситуациях ухода на базе семьи, осложняющихся такими факторами, как ... наркомания и алкоголизм». Признается важность оказания помощи родителям, употребляющим наркотики, в исполнении ими своих обязанностей по уходу за детьми путем обеспечения поддержки надлежащего исполнения родительских обязанностей и практики ухода за детьми, а также то, что программы лечения родителей с расстройствами на почве употребления наркотиков должны отражать и предусматривать возможности удовлетворять первоочередные потребности родителей и детей^d.

- ^a Организация Объединенных Наций, *Конвенция о правах ребенка*, преамбула, резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи (1989 год); вступила в силу 2 сентября 1990 года в соответствии со статьей 49.
- ^b Наилучшее обеспечение интересов ребенка, как поясняется в замечании общего порядка № 14 (2013 год), является развивающейся концепцией и может оцениваться с учетом физических, эмоциональных, социальных и образовательных потребностей ребенка, его возраста, пола, возможностей сохранения семейного окружения и при уважении права ребенка свободно выражать свои взгляды в соответствии со статьей 12 *Конвенции о правах ребенка*.
- ^c Организация Объединенных Наций, *Конвенция о правах ребенка*, пункт 1 статьи 3, резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи (1989 год); вступила в силу 2 сентября 1990 года в соответствии со статьей 49.
- ^d ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний» (Женева, 2020 год).

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Разработка комплексного подхода к обеспечению осуществления права на здоровье в контексте проблемы употребления наркотиков

Комплексный подход может быть разработан с учетом международных конвенций, правовых документов и деклараций, а также с учетом интересов всех лиц, чье право на здоровье может быть затронуто наркопотреблением. Ниже приводится описание предлагаемого подхода с конкретными ссылками на различные доклады и научную литературу, в которых демонстрируется наличие существенной связи между каждым аспектом права на здоровье и состоянием здоровья лиц, употребляющих наркотики.

Этот подход будет охватывать такие аспекты права на здоровье, как учет социальных детерминант здоровья и благополучия, профилактика наркопотребления, предотвращение негативных последствий употребления наркотиков для здоровья, лечение расстройств на почве употребления наркотиков и создание политического пространства, обеспечивающего право на здоровье всех лиц, употребляющих наркотики.

Эти аспекты взаимосвязаны и могут включать в себя:

- 1) обеспечение доступа к находящимся под международным контролем веществам для использования в медицинских целях, в том числе для обезболивания и паллиативного лечения;
- 2) проведение доступных, приемлемых и качественных мероприятий по наркопрофилактике с учетом возраста и гендерной идентичности, в том числе с учетом основных (социальных и коммерческих) детерминант здоровья и благополучия в контексте наркопотребления и его медико-социальных последствий;
- 3) предоставление доступных, приемлемых, качественных, научно обоснованных услуг по оказанию наркологической помощи и уходу с учетом возраста и гендерной идентичности, включая принятие мер, направленных на сведение к минимуму пагубных медико-социальных последствий наркопотребления;

- 4) обеспечение равенства и исключение дискриминации при осуществлении права на здоровье;
- 5) обеспечение осознанной вовлеченности в принятие всех решений, связанных со здоровьем, для решения проблем, касающихся наркопотребления.

Аспект 1. Обеспечение доступа к находящимся под международным контролем веществам для использования в медицинских целях, в том числе для обезболивания и паллиативного лечения

Одним из ключевых аспектов обеспечения осуществления права людей на здоровье является обеспечение доступа к находящимся под международным контролем веществам для использования в медицинских целях, в том числе для лечения расстройств на почве употребления наркотиков, других психических расстройств, обезболивания и паллиативного лечения.

Боль может существенно повлиять на здоровье человека, приводя к серьезным негативным последствиям, включая замедление излечения или частичное выздоровление после травмы, операции или болезни, а также повлиять на качество жизни и повседневную деятельность. Примерно 75 процентов населения мира лишены доступа к обезболивающим препаратам для снятия острой и хронической боли, в том числе при родах, и паллиативного лечения, что является недостаточным или неудовлетворительным, это причиняет ненужные страдания миллионам людей, тогда как в некоторых странах наблюдается чрезмерное потребление обезболивающих препаратов³⁵.

Существенное неравенство по-прежнему наблюдается в отношении доступности для употребления в медицинских целях опиоидных препаратов. Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, и некоторое сокращение разрыва между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким и средним уровнем дохода, в 2022 году между этими двумя группами стран сохранялась значительная (46-кратная) разница в обеспеченности опиоидами, предназначенными для обезболивания и паллиативного лечения, на душу населения. Если в ряде стран Северной Америки, Океании и Западной Европы уровень доступности опиоидов, предназначенных для использования в медицинских целях, сравнительно высок, то в большинстве других стран, особенно в странах Африки, Азии и Тихоокеанского региона, показатели доступности чрезвычайно низки. Уровень потребления на душу населения в Африке составляет всего 0,4 процента от уровня потребления в Северной Америке, а в Западной и Центральной Африке этот показатель еще ниже (0,06 процента)³⁶.

За последние два десятилетия в целом улучшилась ситуация в мире с обеспеченностью метадоном и бупренорфином — двумя опиоидами, которые применяются не только как анальгетики, но и как агонисты опиоидных рецепторов при лечении расстройств на почве употребления опиоидов. Однако их наличие для медицинского использования остается довольно стабильным на глобальном уровне с 2019 года³⁷.

При ограниченном доступе к контролируемым лекарственным средствам существует риск появления незаконно изготовленных лекарств (некондиционных и фальсифицированных). В материалах недавно проведенного обзора отмечается, что распространенность некондиционных и фальсифицированных лекарств среди проб, проанализированных в странах с низким и средним уровнем дохода, составляет 13,6 процента³⁸, что влечет за собой негативные медицинские и экономические последствия. Возможно, эта проблема стала еще более острой в связи с расширением масштабов продажи лекарств через интернет³⁹.

Важность обеспечения доступа к опиоидам для использования в медицинских и научных целях подтверждается данными передовой практики^{40, 41, 42, 43}. Лечение агонистами опиоидных рецепторов, которое также рассматривается ниже в разделе, посвященном оказанию наркологической помощи, является частью набора основных лекарственных средств, необходимых для эффективного решения проблемы наркотиков.

Аспект 2. Проведение доступных, приемлемых и качественных мероприятий по наркопрофилактике с учетом возраста и гендерной идентичности, в том числе с учетом основных детерминант здоровья и благополучия в контексте наркопотребления

Профилактика приобщения к наркопотреблению и развития наркологических расстройств имеет ключевое значение для достижения положительных результатов в отношении здоровья. Дети и подростки представляют собой особую целевую группу в плане профилактических мероприятий, поскольку подростковый возраст является пиковым периодом приобщения к употреблению психоактивных веществ, когда развитие мозга человека еще продолжается. В ходе исследований было установлено наличие связей между приобщением к употреблению наркотиков в раннем возрасте и интенсивностью потребления и его вредными последствиями для здоровья в более позднем возрасте^{44, 45, 46, 47}. Одним из компонентов мероприятий по профилактике наркомании являются политика и практика, направленные на учет социальных детерминант здоровья и уделение внимания факторам уязвимости (таким как бедность, отсутствие постоянного жилья и так далее), которые повышают вероятность употребления наркотиков молодыми людьми. Другие профилактические мероприятия могут проводиться на индивидуальном, семейном или общинном уровнях. В Международных стандартах по профилактике употребления наркотиков⁴⁸ представлено резюме научно-исследовательской литературы по целому ряду научно обоснованных профилактических мероприятий с учетом возраста и гендерной идентичности. К числу научно обоснованных мероприятий, ориентированных на лиц среднего детского и раннего подросткового возраста, относятся программы по развитию родительских навыков, личностных и социальных качеств и профилактическому просвещению на основе социальной компетентности и социального влияния. Все перечисленные в Стандартах мероприятия, подкреплены данными передовой практики^{49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57}.

Профилактические программы могут быть успешными, если они станут доступными, приемлемыми, качественными и будут предлагаться квалифицированными специалистами⁵⁸. Это означает, что они должны предлагаться в отвечающих требованиям учреждениях без какой-либо дискриминации, быть доступными по цене для членов общины, проводиться квалифицированными специалистами и таким образом, чтобы это было приемлемо для людей и общин, которым они служат. Они также должны соответствовать этическим и культурным нормам, учитывать гендерные и возрастные аспекты и быть подкреплены научными данными, свидетельствующими об их эффективности в плане влияния на показатели здоровья.

Социальные детерминанты здоровья также относятся к числу элементов, имеющих основополагающее значение для достижения положительных результатов в отношении здоровья отдельных лиц, семей и общин⁵⁹. Существует значительный объем научных данных, свидетельствующих о том, что политика и практика, направленные на учет основных детерминант здоровья и обеспечение равноправного доступа к ним, приводят к улучшению состояния здоровья. В одной из брошюр *Всемирного доклада о наркотиках за 2020 год* представлены доказательства связи социально-экономических характеристик с расстройствами на почве употребления наркотиков, а также данные о том, как эти характеристики влияют на обстоятельства на макроуровне и индивидуальном уровне, приводящие к развитию наркологических расстройств, которые, в свою очередь, влияют на социально-экономическое неравенство людей, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков, и доступ к наркологической помощи⁶⁰.

Коммерческие детерминанты здоровья также влияют на его показатели. Коммерческие детерминанты связаны с деятельностью частного сектора, сказывающейся на здоровье, и регулированием оборота сырья, что впоследствии влияет на доступ и использование продуктов^{61, 62}.

Аспект 3. Предоставление доступных, приемлемых, качественных, научно обоснованных услуг по оказанию наркологической помощи и уходу с учетом возраста и гендерной идентичности, включая принятие мер, направленных на сведение к минимуму медико-социальных последствий наркопотребления

Этот аспект относится ко всем услугам здравоохранения и социальной защиты, которые необходимы для содействия обеспечению права на здоровье лиц, употребляющих наркотики, и лиц с расстройствами на почве наркопотребления, а также окружающих их лиц, на которых сказывается наркопотребление в семье, и других людей в общине.

Расстройства на почве наркопотребления являются многофакторными патологиями и нередко протекают как хронические заболевания, имеющие периоды ремиссии и рецидивов и требующие комплекса мер. Доказано, что научно обоснованная наркологическая помощь способствует улучшению состояния здоровья, включая качество жизни. Существует ряд научно обоснованных эффективных методов лечения расстройств, связанных с употреблением наркотиков, включая медикаментозную помощь, например лечение агонистами опиоидных рецепторов лиц, страдающих опиоидными расстройствами^{63, 64, 65, 66, 67}, реабилитацию по месту жительства^{68, 69, 70}, научно обоснованные психосоциальные методы лечения/вмешательства, такие как когнитивно-поведенческая терапия, ситуационное управление (ведение срывов) и мотивационные беседы^{71, 72}, взаимная поддержка^{73, 74, 75}, купирование абстинентного синдрома при употреблении стимуляторов⁷⁶ и лечение неонатального абстинентного синдрома⁷⁷, обеспечение безопасных жилищных и санитарно-гигиенических условий, семейную и социальную поддержку, интеграцию в общество, развитие социальных навыков и образования^{78, 79, 80, 81}. К дополнительным элементам научно обоснованных услуг относятся услуги по снижению порогового уровня и в области просвещения, составляющие часть комплекса услуг по оказанию помощи «скрытым» группам населения, наиболее пострадавшим от употребления наркотиков, лицам, которые могут неохотно обращаться за наркологической помощью, или лицам, у которых наблюдается рецидив после завершения программы лечения. В Международных стандартах лечения расстройств, связанных с употреблением наркотиков, подробно описаны различные имеющиеся научно обоснованные вмешательства и услуги для лиц, страдающих наркологическими расстройствами, и членов их семей⁸².

Устранение вреда, связанного с употреблением наркотиков, предусматривает применение действенных мер, направленных на предотвращение и смягчение неблагоприятных медико-социальных последствий наркопотребления, включая профилактику и лечение передозировки и профилактику инфекционных заболеваний. Лица, употребляющие наркотики путем инъекций, по-прежнему особенно подвержены риску передозировки как с летальным исходом, так и без него⁸³ и заражения вирусами, передающимися через кровь, включая ВИЧ и вирусы гепатита В и С, особенно при совместном использовании инъекционного инструментария⁸⁴. В комплексный пакет научно обоснованных мер по профилактике, лечению и уходу, предназначенных для лиц, употребляющих наркотики путем инъекций⁸⁵, включены девять мер, разработанных на научных данных, свидетельствующих об их действенности и эффективности в плане сокращения распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, и борьбы с ним^{86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94}. В настоящее время среди различных мер основными считаются программы по обеспечению доступа к иглам и шприцам, агонистам опиоидных рецепторов и другим видам лечения наркозависимости, а также по обеспечению общин налоксоном для лечения передозировки⁹⁵.

В ряде мест охват наркологической помощью и/или мер по профилактике неблагоприятных медико-социальных последствий наркопотребления является недостаточным, а некоторые эффективные меры, такие как терапия агонистами опиоидных рецепторов или лечение передозировки с использованием налоксона, запрещены или недоступны^{96, 97, 98}. Это существенно снижает эффективность мер по борьбе с расстройствами на почве наркопотребления и профилактике таких инфекций, как ВИЧ и вирусный гепатит, а также по профилактике и лечению передозировки.

Услуги по оказанию наркологической помощи и уходу положительно сказываются не только на непосредственных получателях, но и на их детях и других членах семьи, а также на общине, в которой они живут. Научные исследования, посвященные влиянию наркологической помощи как на отдельных ее получателей, так и на окружающих их лиц, показали, что она способствует улучшению качества жизни и состояния здоровья лиц, входящих в окружение ее получателя, а также значительному снижению показателей преступности^{99, 100, 101}.

Семейно-ориентированные подходы особенно полезны для просвещения пациентов и их семей по темам природы расстройств на почве наркопотребления и процесса выздоровления. К таким подходам, признанным эффективными при различных наркологических расстройствах, относятся поведенческая терапия для семейных пар, краткосрочная стратегическая семейная терапия, функциональная семейная терапия, мультисистемная терапия и комплексная семейная терапия¹⁰². В случае расстройств на почве наркопотребления выздоровление рассматривается как непрерывный процесс и опыт, в ходе которого отдельные люди, семьи и общины используют свои ресурсы для борьбы с наркологическими расстройствами, активно справляются со своей сохраняющейся уязвимостью перед такими расстройствами и ведут здоровую, продуктивную и осмысленную жизнь¹⁰³. Поэтому предоставление недорогих, доступных, научно обоснованных услуг по оказанию наркологической помощи квалифицированными специалистами может помочь оказать поддержку детям и другим членам семей лиц, употребляющих наркотики, в осуществлении ими своего права на здоровье.

Определенные группы населения с особыми потребностями могут нуждаться в специальном лечении и уходе. Лицам, употребляющим наркотики и имеющим сопутствующие заболевания, в частности лицам с психиатрическими сопутствующими заболеваниями, или лицам, живущим с ВИЧ, требуется комплекс услуг по оказанию помощи, направленный как на борьбу с их наркологическими расстройствами, так и с сопутствующими заболеваниями. Аналогичным образом, женщины, дети и подростки, а также бездомные или социально маргинализированные лица могут нуждаться в дополнительных услугах социальной помощи, в частности в образовании, профессионально-технической подготовке, жилье и других видах общей социальной поддержки¹⁰⁴.

Право на здоровье является неотъемлемым, поэтому обеспечение доступности, дешевизны и наличия услуг по лечению расстройств на почве наркопотребления также означает обеспечение доступа людей к лечению и другим мерам независимо от их обстоятельств или местонахождения. Поэтому лица, находящиеся в местах лишения свободы, имеют право на тот же уровень медицинского обслуживания, что и лица, находящиеся на свободе¹⁰⁵. Переполненность, плохие условия жизни, высокие показатели лишения свободы за употребление и хранение наркотиков в личных целях, а также недостаточное медицинское обслуживание и отсутствие мер профилактики, повышенный уровень стигматизации и дискриминации — все это усугубляет риски для здоровья наркопотребителей или лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, в местах лишения свободы. Большинство заключенных, как ожидается, должны вернуться в общину, и, скорее всего, они будут носителями болезней, которыми заражаются люди в учреждениях закрытого типа или которые усугубляются из-за плохих условий содержания и становятся проблемами общественного здравоохранения¹⁰⁶. Лица, употребляющие наркотики и находящиеся в пенитенциарных учреждениях, должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию и услугам наркологической помощи, включая доступ к общему медицинскому обслуживанию, лечению расстройств на почве употребления наркотиков, мероприятиям по сведению к минимуму и предотвращению неблагоприятных медико-социальных последствий наркопотребления, а также к другим медицинским услугам^{107, 108, 109}. Непрерывность лечения и ухода за лицами, которые переводятся в тюрьму или освобождаются из тюрьмы, является еще одним важнейшим элементом, который должен считаться частью системы здравоохранения. Помимо предоставления доступных и недорогих услуг по наркологической помощи и уходу, обеспечение доступа предполагает выявление и устранение препятствий, включая стигматизацию и дискриминацию, которые мешают людям, особенно женщинам, детям, меньшинствам и сельскому населению, получить доступ к этим услугам^{110, 111, 112, 113}. Устранение препятствий, сужающих доступ к наркологической помощи, имеет жизненно важное значение для обеспечения положительных результатов в области здравоохранения. Исследования показали, что деятельность полиции в отношении лиц, пользующихся услугами по лечению и уходу, удерживает их от обращения за наркологической помощью (путем преследования, арестов, обысков и конфискации инъекционного инструментария), снижает эффективность наркологической помощи и способствует расширению сопряженной с риском практики наркопотребления (такой как совместное использование нестерильных шприцев)^{114, 115}. Кроме того, лицам с расстройствами на почве употребления наркотиков требуется комплекс услуг по оказанию помощи — от базовой поддержки и мер, направленных на снижение

или предотвращение негативных медико-социальных последствий наркопотребления, до лечения и социальной реинтеграции, причем с повсеместным доступом к системе наркологической помощи¹¹⁶.

Одним из важнейших элементов права на здоровье является доступность информации. Она включает в себя право искать, получать и передавать информацию и идеи, касающиеся вопросов здоровья¹¹⁷. В контексте наркопотребления это означает доступ к фактической информации о воздействии наркотиков и его медико-социальных последствиях, эффективных научно обоснованных профилактических и лечебных мероприятиях, а также о наличии лекарственных препаратов и соответствующих медицинских услуг и способах доступа к ним в общине¹¹⁸. В случае лиц, обращающихся за наркологической помощью, это подразумевает доступ к информации о концепции программы лечения, ожиданиях, подходе к лечению и выздоровлению, прохождении курса лечения и его результатах, а также по другим вопросам, которые могут возникнуть у людей или их семей до начала лечения. Важность обеспечения доступа к информации относится и к получению семьями наркопотребителей достоверных сведений о наркологических расстройствах и их лечении, а также о доступе к группам поддержки семей и опекунов и другим социальным ресурсам.

[ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА]

Право на здоровье и принудительное наркологическое лечение

Добровольность (то есть наличие информированного согласия) является обязательным условием оказания любой медицинской помощи, включая лечение расстройств на почве наркопотребления. Принудительное наркологическое лечение можно определить как обязательное включение лиц, зачастую, но не всегда являющихся наркозависимыми, в программу по оказанию наркологической помощи, которое часто не является добровольным, проводится в стационарах, основано на воздержании от употребления наркотиков и входит в состав более широких мер в области уголовного правосудия, направленных на решение проблемы наркотиков^a.

Принудительное лечение отличается от лечения, предлагаемого в качестве альтернативы тюремному заключению или другому уголовному наказанию^a. Когда решение о прохождении лечения принимается под угрозой лишения свободы, такое лечение можно назвать принудительным, однако в данном случае от него сложно, но все же можно отказаться.

Речь также может идти о влиянии давления и убеждения на принятие решения о прохождении лечения в добровольном порядке^b.

В отношении принудительного наркологического лечения существует крайне мало исследований, посвященных его оценке. Однако опубликованные данные в целом не свидетельствуют о высокой эффективности, а некоторые исследования указывают на потенциальный вред таких мер^a.

Принудительное лечение нарушает право на информированное согласие лиц, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков^c, а также на их личную свободу и безопасность.

МККН также отметил, что «несмотря на призыв, с которым в 2012 году выступил ряд учреждений Организации Объединенных Наций, во многих странах мира по-прежнему сохраняется система принудительного лечения лиц с расстройствами, вызванными употреблением наркотиков». Комитет призвал те «государства-члены, которые еще не сделали этого, переключить усилия с обязательно-принудительного лечения употребляющих наркотики лиц на применение альтернативных мер, не связанных с тюремным заключением и наказанием и направленных на оказание наркологической помощи и содействие реабилитации»^d.

^a Dan Werb et al., “The Effectiveness of Compulsory Drug Treatment: A Systematic Review”, *International Journal of Drug Policy*, 28 (February 2016), pp. 1-9.

^b UNODC, *From Coercion to Cohesion: Treating Drug Dependence Through Health Care, Not Punishment. Discussion Paper*, (United Nations, October 2010).

- ^c Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, *Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах: право на наивысший достижимый уровень здоровья* (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*), замечание общего порядка №14, двадцать вторая сессия, пункт 3 повестки дня (Женева: Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, май 2000 года).
- ^d Ежегодный доклад Международного комитета по контролю над наркотиками, 2023 год, E/INCB/2023/1 (Организация Объединенных Наций, март 2024 года).

КОНЕЦ ТЕКСТОВОЙ ВСТАВКИ]

Другим ключевым элементом права на здоровье является право человека на получение медицинской помощи по его согласию¹¹⁹. Для этого необходимо, чтобы человек, страдающий расстройствами на почве употребления наркотиков, дал информированное согласие до начала добровольного лечения и получил гарантию того, что он может отказаться от лечения в любое время¹²⁰. Информированное согласие может быть дано только при получении человеком всей соответствующей информации, как описано выше. Кроме того, конфиденциальность и анонимность данных о здоровье лиц, получающих услуги наркологической помощи, являются частью медицинской этики, которая не может быть нарушена ни на каком этапе, за исключением случаев, когда внешние обстоятельства требуют, при соблюдении надлежащей процедуры и тщательности, частичного разглашения информации о лице, получающем наркологическую помощь.

Аспект 4. Обеспечение равенства и исключение дискриминации при осуществлении права на здоровье

Стигматизация и дискриминация в отношении наркопотребителей и лиц с наркологическими расстройствами широко распространены и представляют собой серьезное препятствие для доступа к медицинским услугам^{121, 122, 123}. Лицам, употребляющим наркотики, может быть отказано в медицинской помощи и других важнейших социальных услугах, они могут получать медицинскую и консультационную помощь ненадлежащего уровня, а также неохотно обращаться за медицинской помощью^{124, 125}, что свидетельствует о наличии очевидной взаимосвязи между дискриминацией и состоянием здоровья, а значит, и правом людей на здоровье.

Стигматизация может привести к общей дегуманизации и очернению людей: на наркопотребителей обычно навешивают ярлыки «моральных уродов», «наркоманов» и «отбросов общества»¹²⁶, в результате чего формируется стереотипный образ лиц, неспособных самостоятельно принимать решения. Стигматизация и дискриминация еще больше маргинализируют наркопотребителей и могут проявляться в том, что эти люди оказываются в социальной изоляции, им отказывают в доступе к медицинскому обслуживанию и услугам наркологической помощи или в том, что с ними вообще плохо обращаются^{127, 128}. Это повышает риск страданий от неблагоприятных медико-социальных последствий, насилия и злоупотреблений, а также жестокого обращения со стороны государственных субъектов и отдельных лиц в их общинах. Стигматизация может усугубляться, когда она пересекается с другими стигматизирующими идентичностями^{129, 130}. По сравнению с мужчинами женщины в большей степени сталкиваются с факторами уязвимости в медико-социальной сфере, что также способствует гендерному неравенству в доступе к услугам наркологической помощи¹³¹. По сообщениям, уровень стигматизации и связанного с ней гендерного насилия, а также физического и сексуального насилия со стороны полиции или других лиц, оказывающих услуги, среди женщин, представителей меньшинств и других групп населения, употребляющего наркотики, является особенно высоким^{132, 133}.

На наркопотребителей могут навешивать различные ярлыки, что усугубляет стигматизацию и снижает их возможности получить медицинскую помощь, поскольку «лица с психическими заболеваниями и психосоциальными расстройствами, как правило, считаются неспособными принимать решения»¹³⁴, «аморальными»¹³⁵.

Аспект 5. Обеспечение осознанной вовлеченности в принятие всех решений, связанных со здоровьем, для решения проблем, касающихся наркопотребления

Согласно разъяснению Комитета по экономическим, социальным и культурным правам¹³⁶, обеспечение права на здоровье для всех лиц, затронутых проблемой наркопотребления, означает обеспечение их участия и права голоса во всех решениях, принимаемых для борьбы с наркопотреблением.

Однако, как отмечается в научной литературе, крайне сложно разработать исследования (например, рандомизированные контролируемые испытания), с помощью которых можно было бы проверить влияние конструктивного участия на последующие показатели здоровья¹³⁷. Это также относится к исследованиям связей между индивидуальными показателями здоровья и вовлеченности самого человека в принятие решений по вопросам медицинской помощи¹³⁸. Несмотря на научные трудности, существуют данные, свидетельствующие о связи вовлеченности с улучшением показателей здоровья конкретных лиц. В ходе одного из систематических обзоров было выявлено множество доказательств того, что участие в общественной жизни положительно сказывается на здоровье¹³⁹. Обзор показал, что участие в общинных инициативах, таких как планирование и проведение мероприятий по охране здоровья, способствует вовлечению целевых групп, а расширение участия общины может в свою очередь способствовать учету социальных детерминант здоровья путем активизации деятельности местных служб занятости¹⁴⁰. Стоит также отметить, что конструктивное участие является важным элементом правозащитного подхода и поощряет вовлеченность, достоинство и уважение.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что вовлечение наркопотребителей, всех лиц, которых затрагивает их наркопотребление, и других заинтересованных сторон в общинах в разработку ориентированных на них политики и программ может снизить вероятность некачественных, в недостаточной степени обоснованных и стигматизированных мер реагирования^{141, 142, 143}. Наркопотребители и лица, затронутые проблемой наркопотребления, порой могут лучше других определить потребности общины и эффективные подходы; их участие может предотвратить стигматизацию или заблуждения в отношении лишенных объективности мер реагирования¹⁴⁴. Их участие также может способствовать сотрудничеству и формированию чувства сопричастности к решениям по вопросам охраны здоровья, что в конечном итоге повышает шансы на успех¹⁴⁵. Привлечение организаций гражданского общества, представляющих местные общины, к разработке национальной политики может помочь обеспечить ее культурную значимость и приемлемость¹⁴⁶.

Разработка поддающихся измерению показателей для оценки правозащитных подходов в отношении здоровья

Предоставление государствам-членам показателей для оценки того, как они обеспечивают осуществление права на здоровье в контексте проблемы наркопотребления, может обеспечить полезный уровень подотчетности и контроля.

Отправной точкой могут стать основные элементы и аспекты, описанные в настоящей главе.

Все соответствующие показатели должны быть конкретными, поддающимися измерению, достижимыми/приемлемыми/предметными, актуальными и привязанными ко времени (SMART).

Дальнейшее обсуждение наиболее подходящих и соответствующих показателей может оказаться полезным, при этом особое внимание следует уделить вопросам своевременности и осуществимости сбора данных для государств-членов.

Примечания и ссылки

- 1 В статье 25 *Всеобщей декларации прав человека* закреплено право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на социальное обеспечение.
- 2 В подпункте (iv) пункта (е) статьи 5 *Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации* гарантируется право на равенство перед законом при осуществлении права на здравоохранение, медицинскую помощь, социальное обеспечение и социальное обслуживание.
- 3 Согласно статье 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах* каждый человек имеет право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.
- 4 Согласно статье 12 *Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин* государства-участники обязаны принимать соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения.
- 5 В статье 24 *Конвенции о правах ребенка* признается право ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья.
- 6 В пункте (е) статьи 43 *Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей* гарантируется их право на пользование равным режимом с гражданами государства работы по найму в отношении доступа к социальному и медицинскому обслуживанию.
- 7 В статье 25 *Конвенции о правах инвалидов* признается право на наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности и содержится ряд обязательств государств-участников по предоставлению недорогих качественных услуг в сфере здравоохранения.
- 8 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)», замечание общего порядка №14, двадцать вторая сессия, пункт 3 повестки дня (Женева: Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, май 2000 года).
- 9 Организация Объединенных Наций, *Всеобщая декларация прав человека*, резолюция 217А Генеральной Ассамблеи (Париж, 10 декабря 1948 года).
- 10 Организация Объединенных Наций, *Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах*, резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи (1966 год); вступил в силу 3 января 1976 года.
- 11 Организация Объединенных Наций, *Международный пакт о гражданских и политических правах*, резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи (1966 год); вступил в силу 23 марта 1976 года.
- 12 Организация Объединенных Наций, *Конвенция о правах ребенка* (1989 год); вступила в силу в 1990 году.
- 13 Всемирная организация здравоохранения, Устав Всемирной организацией здравоохранения, 1946 год.
- 14 Всемирная организация здравоохранения, Алма-Атинская декларация (Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 1978 год).
- 15 World Health Organization, “Human Rights and Health,” n.d.
- 16 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)».
- 17 Организация Объединенных Наций, *Единая конвенция о наркотических средствах* (1961 год) с поправками, внесенными Протоколом 1972 года.
- 18 Организация Объединенных Наций, *Конвенция о психотропных веществах*, 1971 год.
- 19 Одной из основных ценностей всеобщего охвата услугами здравоохранения является то, что здоровье должно обеспечиваться и защищаться без дискриминации, включая различия по возрасту, этнической группе, расе, полу,

гендерной идентичности, сексуальной ориентации, языку, религии, политическим или иным взглядам, национальному или социальному происхождению, экономическому положению, рождению или иному обстоятельству.

- 20 Организация Объединенных Наций, *Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах*.
- 21 Организация Объединенных Наций, *Конвенция о правах ребенка*.
- 22 Организация Объединенных Наций, *Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации*, резолюция 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи (1965 год), 21 декабря 1965 года.
- 23 Организация Объединенных Наций, *Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин*, резолюция 34 (180) Генеральной Ассамблеи (1979 год); вступила в силу 3 сентября 1981 года.
- 24 Государства-участники несут обязанность уважать право на здоровье, в частности воздерживаясь от принятия мер, закрывающих или ограничивающих равный доступ всем, в том числе заключенным или содержащимся под стражей лицам, представителям меньшинств, лицам, просящим убежища, и незаконным иммигрантам, к профилактическим, лечебным и паллиативным услугам здравоохранения, воздерживаясь от возведения дискриминационной практики в ранг государственной политики, а также от дискриминационного отношения к здоровью женщин и их потребностям в этой области (пункт 34 замечания общего порядка №14 (2000 год) Комитета по экономическим, социальным и культурным правам «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья»).
- 25 УНП ООН, брошюра 4 «Наркотики и возраст: наркотики и связанные с ними проблемы среди молодежи и людей старшего возраста», *Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2018 год).
- 26 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год).
- 27 УНП ООН, брошюра 2 «Наркотики: современные проблемы», *Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2023 год).
- 28 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*.
- 29 УНП ООН, брошюра «Основные выводы и заключения», *Всемирный доклад о наркотиках за 2024 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2024 год).
- 30 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом результатов полевых испытаний» (Женева, 2020 год).
- 31 УНП ООН, брошюра 2 «Глобальный обзор спроса на наркотики и их предложения», *Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год*, стр. 43 (текста на англ. яз.), в части, касающейся осуществления 9 мер, включенных в комплексный пакет, разработанный ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС, под названием «Техническое руководство для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков» (Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2012 год).
- 32 WHO and UNODC, “International Standards on Drug Use Prevention - Second Updated Edition” (Vienna, 2018).
- 33 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».
- 34 UNAIDS, “The Path That Ends AIDS: UNAIDS Global AIDS Update 2023” (Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2023).
- 35 World Health Organization, “The Public Health Dimension of the World Drug Problem: How WHO Works to Prevent Drug Misuse, Reduce Harm and Improve Safe Access to Medicine” (Geneva, 2019).
- 36 Расчеты УНП ООН на основе классификации стран по уровням дохода, разработанной Всемирным банком, и следующих докладов МККН: *Narcotic Drugs 2023* (E/INCB/2023/2); и *Psychotropic Substances 2023* (E/INCB/2023/3).
- 37 УНП ООН, брошюра «Основные выводы и заключения», *Всемирный доклад о наркотиках за 2024 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2024 год).

- 38 Sachiko Ozawa et al., "Prevalence and Estimated Economic Burden of Substandard and Falsified Medicines in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis," *JAMA Network Open* 1, no. 4 (August 10, 2018): e181662.
- 39 Jamee Ahmed et al., "A Critical Review on the Availability of Substandard and Falsified Medicines Online: Incidence, Challenges and Perspectives," *The Journal of Medicine Access* 6 (January 2022): 239920262210745.
- 40 Brian T. Bateman and Nitesh K. Choudhry, "Limiting the Duration of Opioid Prescriptions: Balancing Excessive Prescribing and the Effective Treatment of Pain," *JAMA Internal Medicine* 176, no. 5 (May 1, 2016): 583–84.
- 41 Axel Klein, Sudhanshu Patwardhan, and Maria Goretti Ane Loglo, "Divergences and Commonalities between the US Opioid Crisis and Prescription Medicine Mis/Use in West Africa," *International Journal of Drug Policy* 76 (February 1, 2020): 102640.
- 42 Felicia M Knaul et al., "The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief—Findings, Recommendations, and Future Directions," *The Lancet Global Health*, Toronto Global Cancer Control Conference 2018, 6 (March 1, 2018): S5–6.
- 43 Marco Antônio Marchetti Calônego et al., "Spread the Word: There Are Two Opioid Crises!," *Drugs* 80, no. 12 (August 1, 2020): 1147–54.
- 44 Alexandre Arthur Guerin and Jee Hyun Kim, "Age of Onset and Its Related Factors in Cocaine or Methamphetamine Use in Adults from the United States: Results from NHANES 2005-2018," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 22 (November 22, 2021): 12259.
- 45 Ralph W. Hingson, Timothy Heeren, and Michael R. Winter, "Age at Drinking Onset and Alcohol Dependence: Age at Onset, Duration, and Severity," *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine* 160, no. 7 (July 1, 2006): 739–46.
- 46 Leen Naji et al., "The Association between Age of Onset of Opioid Use and Comorbidity among Opioid Dependent Patients Receiving Methadone Maintenance Therapy," *Addiction Science & Clinical Practice* 12, no. 1 (March 28, 2017): 9.
- 47 Emily Stockings et al., "Prevention, Early Intervention, Harm Reduction, and Treatment of Substance Use in Young People," *The Lancet. Psychiatry* 3, no. 3 (March 2016): 280–96.
- 48 WHO and UNODC, "International Standards on Drug Use Prevention - Second Updated Edition."
- 49 При этом отмечается, что некоторые данные касаются профилактики употребления алкоголя и расстройств на почве употребления алкоголя, которые предшествуют наркопотреблению и расстройствам на почве наркопотребления.
- 50 Stockings et al., "Prevention, Early Intervention, Harm Reduction, and Treatment of Substance Use in Young People."
- 51 EMCDDA, "European Prevention Curriculum: A Handbook for Decision-Makers, Opinion-Makers and Policy-Makers in Science-Based Prevention of Substance Use" (Lisbon, 2019).
- 52 Fabrizio Faggiano et al., "Universal School-based Prevention for Illicit Drug Use," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 12 (2014).
- 53 Heng Jiang et al., "Measuring and Preventing Alcohol Use and Related Harm among Young People in Asian Countries: A Thematic Review," *Global Health Research and Policy* 3, no. 1 (May 9, 2018): 14.
- 54 Eileen Fs Kaner et al., "Effectiveness of Brief Alcohol Interventions in Primary Care Populations," *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2, no. 2 (February 24, 2018): CD004148.
- 55 Ogheneochuko Andrew Saba, Corina Weir, and Magaly Aceves-Martins, "Substance Use Prevention Interventions for Children and Young People in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review," *International Journal of Drug Policy* 94 (August 1, 2021): 103251.
- 56 Emily Stockings et al., "Whole-of-Community Interventions to Reduce Population-Level Harms Arising from Alcohol and Other Drug Use: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Addiction* 113, no. 11 (2018): 1984–2018.
- 57 Nicola C. Newton et al., "Universal Cannabis Outcomes from the Climate and Preventure (CAP) Study: A Cluster Randomised Controlled Trial," *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy* 13, no. 1 (December 2018): 34.
- 58 WHO and UNODC, "International Standards on Drug Use Prevention - Second Updated Edition."

- 59 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)», замечание общего порядка №14, двадцать вторая сессия, пункт 3 повестки дня (Женева: Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, май 2000 года).
- 60 УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2020 год* (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год).
- 61 Nason Maani et al., “Bringing the Commercial Determinants of Health out of the Shadows: A Review of How the Commercial Determinants Are Represented in Conceptual Frameworks,” *European Journal of Public Health* 30, no. 4 (August 1, 2020): 660–64.
- 62 World Health Organization, “Commercial Determinants of Health - Global,” 2023.
- 63 Jason Grebely et al., “Association Between Opioid Agonist Therapy and Testing, Treatment Uptake, and Treatment Outcomes for Hepatitis C Infection Among People Who Inject Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Clinical Infectious Diseases* 73, no. 1 (July 1, 2021): e107–18.
- 64 Richard P. Mattick et al., “Methadone Maintenance Therapy Versus No Opioid Replacement Therapy For Opioid Dependence,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 3 (2009).
- 65 Suzanne Nielsen, Wai Chung Tse, and Briony Laranee, “Opioid Agonist Treatment for People Who Are Dependent on Pharmaceutical Opioids,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 9 (2022).
- 66 Thomas Santo Jr et al., “Association of Opioid Agonist Treatment With All-Cause Mortality and Specific Causes of Death Among People With Opioid Dependence: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *JAMA Psychiatry* 78, no. 9 (September 1, 2021): 979–93.
- 67 Michael Fairley et al., “Cost-Effectiveness of Treatments for Opioid Use Disorder,” *JAMA Psychiatry* 78, no. 7 (July 1, 2021): 767.
- 68 Dominique de Andrade et al., “The Effectiveness of Residential Treatment Services for Individuals with Substance Use Disorders: A Systematic Review,” *Drug and Alcohol Dependence* 201 (August 1, 2019): 227–35.
- 69 Lynne Magor-Blatch et al., “A Systematic Review of Studies Examining Effectiveness of Therapeutic Communities,” *Therapeutic Communities* 35, no. 4 (2014): 168–84.
- 70 Lesley A. Smith, Simon Gates, and David Foxcroft, “Therapeutic Communities for Substance Related Disorder,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 1 (2006).
- 71 Rosemarie Schwenker et al., “Motivational Interviewing for Substance Use Reduction,” *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 12, no. 12 (December 12, 2023): CD008063.
- 72 Sonali Jhanjee, “Evidence Based Psychosocial Interventions in Substance Use,” *Indian Journal of Psychological Medicine* 36, no. 2 (2014): 112–18.
- 73 Известны также как программы 12 шагов, такие как программа «Анонимные наркоманы».
- 74 John F. Kelly, Keith Humphreys, and Marica Ferri, “Alcoholics Anonymous and Other 12-step Programs for Alcohol Use Disorder,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 3 (2020).
- 75 John Strang et al., “Drug Policy and the Public Good: Evidence for Effective Interventions,” *The Lancet* 379, no. 9810 (January 7, 2012): 71–83.
- 76 Steven J Shoptaw et al., “Treatment for Amphetamine Withdrawal,” ed. Cochrane Drugs and Alcohol Group, *Cochrane Database of Systematic Reviews*, April 15, 2009.
- 77 Angelika Zankl et al., “Opioid Treatment for Opioid Withdrawal in Newborn Infants,” ed. Cochrane Neonatal Group, *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2021, no. 7 (July 7, 2021).
- 78 Myriam Beaulieu et al., “A Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy of the Long-Term Treatment and Support of Substance Use Disorders,” *Social Science & Medicine* 285 (September 1, 2021): 114289.

- 79 Donna Fitzpatrick-Lewis et al., “Effectiveness of Interventions to Improve the Health and Housing Status of Homeless People: A Rapid Systematic Review,” *BMC Public Health* 11, no. 1 (August 10, 2011): 638.
- 80 Mehrnoosh Inanlou et al., “Addiction Recovery: A Systematized Review,” *Iranian Journal of Psychiatry* 15, no. 2 (April 2020): 172–81.
- 81 Navin Kumar et al., “The Role of Social Network Support in Treatment Outcomes for Medication for Opioid Use Disorder: A Systematic Review,” *Journal of Substance Abuse Treatment* 127 (August 1, 2021): 108367.
- 82 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».
- 83 Samantha Colledge et al., “Frequency of Injecting among People Who Inject Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *International Journal of Drug Policy* 76 (February 1, 2020): 102619.
- 84 Louisa Degenhardt et al., “Global Prevalence of Injecting Drug Use and Sociodemographic Characteristics and Prevalence of HIV, HBV, and HCV in People Who Inject Drugs: A Multistage Systematic Review,” *The Lancet. Global Health* 5, no. 12 (December 2017): e1192–1207.
- 85 ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС, «Техническое руководство для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков».
- 86 Angela K. Clark, Christine M. Wilder, and Erin L. Winstanley, “A Systematic Review of Community Opioid Overdose Prevention and Naloxone Distribution Programs,” *Journal of Addiction Medicine* 8, no. 3 (2014): 153–63.
- 87 Don C. Des Jarlais et al., “High Coverage Needle/Syringe Programs for People Who Inject Drugs in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review,” *BMC Public Health* 13, no. 1 (January 19, 2013): 53.
- 88 Behzad Hajarizadeh et al., “Evaluation of Hepatitis C Treatment-as-Prevention within Australian Prisons (SToP-C): A Prospective Cohort Study,” *The Lancet. Gastroenterology & Hepatology* 6, no. 7 (July 2021): 533–46.
- 89 Brianna Lindsay et al., “Initial Implementation of HIV Pre-Exposure Prophylaxis for People Who Are Incarcerated in Zambia: A Cross-Sectional Observational Study,” *The Lancet HIV* 10, no. 1 (January 1, 2023): e24–32.
- 90 Georgina J. MacArthur et al., “Interventions to Prevent HIV and Hepatitis C in People Who Inject Drugs: A Review of Reviews to Assess Evidence of Effectiveness,” *International Journal of Drug Policy* 25, no. 1 (January 1, 2014): 34–52.
- 91 Eamon O Murchu et al., “Oral Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) to Prevent HIV: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Effectiveness, Safety, Adherence and Risk Compensation in All Populations,” *BMJ Open* 12, no. 5 (May 11, 2022): e048478.
- 92 D. O’Keefe et al., “Injecting Drug Use in Low and Middle-Income Countries: Opportunities to Improve Care and Prevent Harm,” *Journal of Viral Hepatitis* 24, no. 9 (2017): 714–24.
- 93 Charles I. Okwundu, Olalekan A. Uthman, and Christy AN Okoromah, “Antiretroviral Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) for Preventing HIV in High-risk Individuals,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 7 (2012).
- 94 Lucy Platt et al., “Needle Syringe Programmes and Opioid Substitution Therapy for Preventing Hepatitis C Transmission in People Who Inject Drugs,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 9 (2017).
- 95 WHO, “Consolidated Guidelines on HIV, Viral Hepatitis and STI Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations” (World Health Organization, 2022).
- 96 Javier A. Cepeda et al., “Potential Impact of Implementing and Scaling up Harm Reduction and Antiretroviral Therapy on HIV Prevalence and Mortality and Overdose Deaths among People Who Inject Drugs in Two Russian Cities: A Modelling Study,” *The Lancet HIV* 5, no. 10 (October 1, 2018): e578–87.
- 97 Samantha Colledge-Frisby et al., “Global Coverage of Interventions to Prevent and Manage Drug-Related Harms among People Who Inject Drugs: A Systematic Review,” *The Lancet Global Health* 11, no. 5 (May 1, 2023): e673–83.

- 98 Sarah Larney et al., “Global, Regional, and Country-Level Coverage of Interventions to Prevent and Manage HIV and Hepatitis C among People Who Inject Drugs: A Systematic Review,” *The Lancet. Global Health* 5, no. 12 (December 2017): e1208–20.
- 99 Christine E. Grella et al., “Do Drug Treatment Services Predict Reunification Outcomes of Mothers and Their Children in Child Welfare?,” *Journal of Substance Abuse Treatment* 36, no. 3 (April 2009): 278–93.
- 100 Mireia Jofre-Bonet and Jody L. Sindelar, “Drug Treatment as a Crime Fighting Tool,” *The Journal of Mental Health Policy and Economics* 4, no. 4 (December 1, 2001): 175–78.
- 101 Katy R. Holloway, Trevor H. Bennett, and David P. Farrington, “The Effectiveness of Drug Treatment Programs in Reducing Criminal Behavior: A Meta-Analysis,” *Psicothema* 18, no. 3 (August 2006): 620–29.
- 102 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».
- 103 Там же.
- 104 Там же.
- 105 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)».
- 106 Stefan Enggist et al., eds., *Prisons and Health* (Copenhagen: World Health Organization, 2014).
- 107 UNODC and WHO, “Recommended Package of Interventions for HIV, Viral Hepatitis and STI Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for People in Prisons and Other Closed Settings” (World Health Organization, 2023).
- 108 УНП ООН, «Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в местах лишения свободы: техническое руководство» (Организация Объединенных Наций, 2020 год).
- 109 Там же.
- 110 Eugene T Richardson et al., “Gender Inequality and HIV Transmission: A Global Analysis,” *Journal of the International AIDS Society* 17, no. 1 (2014): 19035.
- 111 UNAIDS, “Rights-Based Monitoring and Evaluation of National HIV Responses,” 2019.
- 112 Olivia Silber Ashley, Mary Ellen Marsden, and Thomas M. Brady, “Effectiveness Of Substance Abuse Treatment Programming For Women: A Review,” *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse* 29, no. 1 (January 1, 2003): 19–53.
- 113 Shelly F. Greenfield et al., “Substance Abuse Treatment Entry, Retention, and Outcome in Women: A Review of the Literature,” *Drug and Alcohol Dependence* 86, no. 1 (January 2007): 1–21.
- 114 Pieter Baker et al., “Policing Practices and Risk of HIV Infection Among People Who Inject Drugs,” *Epidemiologic Reviews* 42, no. 1 (November 13, 2020): 27–40.
- 115 Kora DeBeck et al., “HIV and the Criminalisation of Drug Use among People Who Inject Drugs: A Systematic Review,” *The Lancet HIV* 4, no. 8 (August 1, 2017): e357–74.
- 116 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».
- 117 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)».
- 118 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».

- 119 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*: право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 *Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*)».
- 120 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».
- 121 Camila Couto E Cruz et al., “Mental and Physical Health Correlates of Discrimination Against People Who Inject Drugs: A Systematic Review,” *Journal of Studies on Alcohol and Drugs* 79, no. 3 (May 2018): 350–60.
- 122 R. Hammarlund et al., “Review of the Effects of Self-Stigma and Perceived Social Stigma on the Treatment-Seeking Decisions of Individuals with Drug-and Alcohol-Use Disorders,” *Substance Abuse and Rehabilitation* 9 (2018): 115–36.
- 123 Charlie Lloyd, “The Stigmatization of Problem Drug Users: A Narrative Literature Review,” *Drugs: Education, Prevention & Policy* 20, no. 2 (2013): 85–95.
- 124 Jakob Manthey et al., “International Perspectives on Stigma toward People with Substance Use Disorders,” in *The Stigma of Substance Use Disorders*, ed. Georg Schomerus and Patrick William Corrigan, 1st ed. (Cambridge University Press, 2022), 107–43.
- 125 Leonieke C. Van Boekel et al., “Stigma among Health Professionals towards Patients with Substance Use Disorders and Its Consequences for Healthcare Delivery: Systematic Review,” *Drug and Alcohol Dependence* 131, no. 1–2 (July 2013): 23–35.
- 126 Gideon Lasco and Lee Edson Yarcia, “The Politics of Drug Rehabilitation in the Philippines,” *Health and Human Rights* 24, no. 1 (June 2022): 147–58.
- 127 Pranee Liamputtong and Zoe Sanipreeya Rice, “Stigma, Discrimination, and Social Exclusion,” in *Handbook of Social Inclusion: Research and Practices in Health and Social Sciences*, ed. Pranee Liamputtong (Cham: Springer International Publishing, 2020), 1–17.
- 128 Robin Room, “Stigma, Social Inequality and Alcohol and Drug Use,” *Drug and Alcohol Review* 24, no. 2 (2005): 143–55.
- 129 Daniel Dittrich and Georg Schomerus, “Intersectional Stigma in Substance Use Disorders,” in *The Stigma of Substance Use Disorders*, ed. Georg Schomerus and Patrick William Corrigan, 1st ed. (Cambridge University Press, 2022), 88–106.
- 130 Caitlin H. Douglass et al., “Stigma Associated with Alcohol and Other Drug Use Among People from Migrant and Ethnic Minority Groups: Results from a Systematic Review of Qualitative Studies,” *Journal of Immigrant and Minority Health* 25, no. 6 (December 1, 2023): 1402–25.
- 131 Antoinette L. Spector et al., “A Qualitative Examination of Substance Use Disorder Treatment-Seeking among Women with Opioid Use Disorders: The Role of Syndemics and Structural Violence,” *SSM - Qualitative Research in Health* 1 (December 2021): 100014.
- 132 S.A. Meyers et al., “The Intersection of Gender and Drug Use-Related Stigma: A Mixed Methods Systematic Review and Synthesis of the Literature,” *Drug and Alcohol Dependence* 223 (June 2021): 108706.
- 133 UNAIDS, “Do No Harm: Health, Human Rights and People Who Use Drugs.”
- 134 World Health Organization and United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Mental Health, Human Rights and Legislation Guidance and Practice” (World Health Organization and United Nations, 2023).
- 135 ВОЗ и УНП ООН, «Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний».
- 136 В подготовленном Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам замечании общего порядка №14 говорится, что «важным аспектом является участие населения в принятии решений по всем связанным со здоровьем вопросам на общинном, национальном и международном уровнях».
- 137 S. B. Rifkin, “Examining the Links between Community Participation and Health Outcomes: A Review of the Literature,” *Health Policy and Planning* 29, no. suppl. 2 (September 1, 2014): ii98–106.

- 138 Marla L. Clayman et al., “The Impact of Patient Participation in Health Decisions Within Medical Encounters: A Systematic Review,” *Medical Decision Making* 36, no. 4 (May 2016): 427–52.
- 139 Victoria Haldane et al., “Community Participation in Health Services Development, Implementation, and Evaluation: A Systematic Review of Empowerment, Health, Community, and Process Outcomes,” *PLOS ONE* 14, no. 5 (May 10, 2019): e0216112.
- 140 Ibid.
- 141 Scott E. Bernstein et al., “The Regulation Project: Tools for Engaging the Public in the Legal Regulation of Drugs,” *International Journal of Drug Policy* 86 (December 1, 2020): 102949.
- 142 Annie Madden et al., “Making Legitimacy: Drug User Representation in United Nations Drug Policy Settings,” *International Journal of Drug Policy* 87 (January 1, 2021): 103014.
- 143 Alison Ritter, Kari Lancaster, and Rosalyn Diprose, “Improving Drug Policy: The Potential of Broader Democratic Participation,” *International Journal of Drug Policy* 55 (May 1, 2018): 1–7.
- 144 Kari Lancaster, Kate Seear, and Alison Ritter, “Reducing Stigma and Discrimination for People Experiencing Problematic Alcohol and Other Drug Use” (Sydney: Drug Policy Modelling Program and the National Drug and Alcohol Research Centre, UNSW, 2017).
- 145 Flavia Bustreo and Curtis F.J. Doebbler, “The Rights-Based Approach to Health,” in *Foundations of Global Health & Human Rights*, by Flavia Bustreo and Curtis F.J. Doebbler (Oxford University Press, 2020), 89–110.
- 146 Gideon Lasco, “Decolonizing Harm Reduction,” *Harm Reduction Journal* 19, no. 1 (February 3, 2022): 8.

ГЛОССАРИЙ

Стимуляторы амфетаминового ряда — группа веществ, в состав которой входят находящиеся под контролем согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года синтетические стимуляторы, в том числе амфетамин, метамфетамин, меткатинон и вещества группы экстази (3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и его аналоги).

Амфетамины — группа стимуляторов амфетаминового ряда, включающая амфетамин и метамфетамин.

Распространенность потребления в течение года — частное от деления общего числа лиц в определенной возрастной группе, которые употребили определенный наркотик хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев, на численность населения данной возрастной группы, выраженное в процентах.

Кокаиновая паста (или кокаиновое основание) — экстракт листьев кокаинового куста. При очистке кокаиновой пасты получают кокаин (основание и гидрохлорид).

Крэк-кокаин — кокаиновое основание, получаемое из гидрохлорида кокаина путем его переработки в продукт, пригодный для курения.

Кокаиновая соль — гидрохлорид кокаина.

Наркопотребление — потребление находящихся под контролем психоактивных веществ в немедицинских и ненаучных целях, если не указано иное.

Фентанилы — фентанил и его аналоги.

Новые психоактивные вещества — вещества, являющиеся предметом злоупотребления в их чистом виде либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года или Конвенции 1971 года, но которые могут представлять угрозу для здоровья населения. В связи с этим определение «новые» не обязательно указывает на недавно изобретенные вещества, но на те вещества, которые стали доступны в последнее время.

Опиаты — подгруппа опиоидов, в которую входят различные продукты, получаемые из опийного мака, в том числе опий, морфин и героин.

Опиоиды — общий термин, применяемый как к опиатам и их синтетическим аналогам (главным образом опиоидам рецептурного отпуска или опиоидным лекарственным средствам), так и к соединениям, синтезируемым в организме.

Проблемные потребители наркотиков — лица, практикующие потребление наркотиков, которое сопряжено с высокой степенью риска. Например, лица, употребляющие наркотики путем инъекций, лица, употребляющие наркотики ежедневно, и/или лица, у которых диагностированы наркотические расстройства (злоупотребление или наркозависимость) в соответствии с клиническими критериями, перечисленными в *Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам* (пятое издание) Американской психиатрической ассоциации или в *Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем* (десятый пересмотр) ВОЗ.

Лица, страдающие расстройствами на почве наркопотребления/лица с расстройствами на почве наркопотребления — подгруппа лиц, употребляющих наркотики. Характерными особенностями расстройств на почве наркопотребления являются пагубное потребление веществ и зависимость от них. Лица с расстройствами на почве наркопотребления нуждаются в лечении, медицинской и социальной помощи и реабилитации.

Пагубное потребление веществ — в *Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем* (десятый пересмотр), определяется как модель потребления, наносящего ущерб физическому или психическому здоровью.

Зависимость — в *Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем* (десятый пересмотр), определяется как комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных симптомов, который возникает после многократного потребления вещества и обычно включает сильное желание принять его; трудности в контроле его употребления; упорное продолжение его потребления, несмотря на пагубные последствия; предпочтение употребления психоактивного вещества в ущерб другим видам деятельности и выполнению обязанностей; возрастание допустимых пределов употребления и иногда состояние абстиненции.

Расстройства на почве употребления веществ или наркотиков — согласно *Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам* (пятое издание), это повторяющиеся симптомы, вызванные употреблением веществ вопреки наличию проблем или затруднений в повседневной жизни, обусловленных их употреблением. В зависимости от количества выявленных симптомов степень расстройства на почве употребления вещества может быть легкой, средней или тяжелой.

Профилактика наркопотребления и лечение вызванных им расстройств — целью «профилактики наркопотребления» является предотвращение или отсрочка приобщения к наркотикам и развития расстройств на почве наркопотребления. При развитии у человека расстройства на почве наркопотребления необходимы лечение, помощь и реабилитация.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Во *Всемирном докладе о наркотиках* используется ряд обозначений регионов и субрегионов. Они не являются официальными и определяются следующим образом:

АФРИКА

- > Восточная Африка: Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар, Майотта, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда, Эритрея, Эфиопия и Южный Судан
- > Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан и Тунис
- > Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Реюньон, Эсватини и Южная Африка
- > Западная и Центральная Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, остров Святой Елены, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

- > Карибский бассейн: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бонайре (Нидерланды (Королевство)), Британские Виргинские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Гаити, Гваделупа, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Куба, Кюрасао, Мартиника, Монтсеррат, острова Кайман, острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Саба (Нидерланды (Королевство)), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус (Нидерланды (Королевство)), Тринидад и Тобаго и Ямайка
- > Центральная Америка: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор
- > Северная Америка: Бермудские острова, Гренландия, Канада, Мексика, Сен-Пьер и Микелон, Соединенные Штаты Америки
- > Южная Америка: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Фолклендские (Мальвинские) острова, Чили и Эквадор

АЗИЯ

- > Центральная Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
- > Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Камбоджа, Китай, китайская провинция Тайвань, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Макао (Китай), Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины и Япония
- > Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Государство Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика
- > Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланка
- > Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран (Исламская Республика) и Пакистан

ЕВРОПА

- > Восточная Европа: Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина
- > Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Косово¹, Румыния, Северная Македония, Сербия, Турция, Хорватия и Черногория
- > Западная и Центральная Европа: Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Гибралтар, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды (Королевство), Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Святой Престол, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония

ОКЕАНИЯ

- > Австралия и Новая Зеландия: Австралия и Новая Зеландия
- > Полинезия: Ниуэ, Острова Кука, острова Уоллис и Футуна, Самоа, Токелау, Тонга, Тувалу и Французская Полинезия
- > Меланезия: Вануату, Новая Каледония, Папуа — Новая Гвинея, Соломоновы Острова и Фиджи
- > Микронезия: Гуам и Северные Марианские острова, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру и Палау

¹ Упоминания о Косово следует трактовать в соответствии с положениями резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Тел.: +(43) (1) 26060-0, факс: +(43) (1) 26060-5866, www.unodc.org

Всемирный доклад о наркотиках как справочное издание по мировым рынкам наркотиков, тенденциям и изменениям в наркополитике, содержащее множество данных и аналитических материалов, в 2024 году был разбит на несколько частей, ориентированных на различную аудиторию. В веб-модуле «Закономерности и тенденции наркорынка» в удобном для пользователя интерактивном формате представлен последний анализ общемировых, региональных и субрегиональных оценочных данных и тенденций, характеризующих спрос и предложение наркотиков, сопровождаемый диаграммами, инфографикой и картами. В брошюре «Основные выводы и заключения» содержится обзор отдельных выводов, вытекающих из анализа, представленного в модуле «Закономерности и тенденции наркорынка» и тематической брошюре «Наркотики: современные проблемы», тогда как в отдельной брошюре «Вопросы, представляющие особый интерес» систематизированы основные тезисы доклада, а также выводы, имеющие значение для выработки политики, которые можно сделать на их основе.

Помимо углубленного анализа основных событий и новых тенденций на отдельных рынках наркотиков в брошюре «Наркотики: современные проблемы» рассматриваются и другие события, имеющие важное политическое значение. Брошюра открывается обзором введенного в 2022 году движением «Талибан» запрета на культивирование наркосодержащих растений, производство и незаконный оборот наркотиков в Афганистане и его последствий как для этой страны, так и для рынков в других странах транзита и назначения. Далее следует глава, в которой рассматривается слияние незаконного оборота наркотиков и других видов деятельности и то, как они сказываются на природных экосистемах и общинах в «Золотом треугольнике» в Юго-Восточной Азии. В этой главе также оценивается, насколько производство и незаконный оборот наркотиков связаны с другими видами незаконной экономики, которые бросают вызов верховенству права и способствуют разжиганию конфликтов. В другой главе анализируется, как динамика спроса и предложения синтетических наркотиков варьирует в зависимости от гендерной принадлежности и возраста участников рынка. Далее в брошюре представлены обновленная информация о подходах к регулированию и воздействию легализации на рынок каннабиса, используемого в немедицинских целях, в разных странах, а также обзор благоприятной среды, обеспечивающей широкий доступ к неконтролируемому, «квазипсихотропному» использованию психоделиков и их применению в немедицинских целях. В заключительной части брошюры предлагается многоаспектный подход к обеспечению осуществления права на здоровье в контексте проблемы употребления наркотиков; к этим аспектам относятся наличие, доступность, приемлемость, качество, исключение дискриминации, отсутствие стигматизации и вовлеченность.

Предназначение *Всемирного доклада о наркотиках за 2024 год* заключается не только в поощрении международного сотрудничества в целях противодействия влиянию мировой проблемы наркотиков на здоровье, управление и безопасность, но и в том, чтобы помочь государствам-членам предвидеть и устранять угрозы, которые несет с собой наркоторговля, смягчая ее последствия.

Всемирный доклад о наркотиках за 2024 год опубликован на веб-сайте УНП ООН
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>